Optimal Untuk Negeri

Optimal

Buku Ajar
KEPERAWATAN ANAK

Ethyca Sari • Dorce Sisfiani Sarimin • Budiyati
Siti Robi'atus Sholiha • Sitti Herliyanti Rambu

Editor : Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Ajar :

Keperawatan Anak

Penulis:
Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Budiyati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.
Siti Robi'atus Sholiha, S.Tr.Kep., Ns., M.Tr.Kep.
Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor :
Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:
Keperawatan Anak

Penulis:
Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.
Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
Budiyati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.
Siti Robi'atus Sholiha, S.Tr.Kep., Ns., M.Tr.Kep.
Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes.

Editor : Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-17-0

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar berjudul "Buku Ajar Keperawatan Anak" ini dapat disusun dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan praktik dasar keperawatan anak secara komprehensif, sistematis, dan aplikatif.

Keperawatan anak merupakan salah satu bidang keilmuan yang memiliki karakteristik khusus karena anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, serta tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda pada setiap rentang usia. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memahami kondisi anak secara holistik serta mampu memberikan asuhan keperawatan yang aman, tepat, berpusat pada anak, dan melibatkan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perawatan.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami dasar-dasar keperawatan anak, mulai dari konsep pelayanan hingga pengkajian dan masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak. Materi dalam buku ini disajikan secara bertahap agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh, baik dari aspek teori maupun penerapannya dalam praktik keperawatan.

Pada Bab 1, pembahasan diawali dengan konsep dasar keperawatan anak dan pendekatan *family-centered care*. Bab ini menekankan pentingnya peran keluarga dalam proses perawatan anak serta bagaimana perawat membangun hubungan terapeutik dengan anak dan keluarganya. Bab 2 membahas pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0–18 tahun, yang menjadi dasar penting dalam menilai kondisi anak sesuai tahap usianya. Pemahaman ini diperlukan agar perawat mampu mengenali perkembangan normal maupun kemungkinan adanya penyimpangan perkembangan.

Selanjutnya, Bab 3 menguraikan pengkajian komprehensif pada anak, meliputi pengumpulan data biologis, psikologis, sosial, perkembangan, serta kebutuhan keluarga. Pengkajian yang tepat menjadi dasar dalam menentukan masalah keperawatan dan merencanakan intervensi yang sesuai. Bab 4 membahas nutrisi anak dan masalah pemberian makan, termasuk kebutuhan gizi sesuai usia, hambatan pemberian makan, serta peran perawat dalam edukasi nutrisi kepada keluarga. Adapun Bab 5 membahas gangguan sistem kardiovaskular pada anak, mencakup konsep dasar, manifestasi klinis, pengkajian, dan prinsip asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kardiovaskular.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa keperawatan, khususnya dalam mata kuliah Keperawatan Anak. Buku ini juga diharapkan dapat membantu dosen, pendidik klinik, dan praktisi keperawatan dalam memberikan pemahaman yang lebih terarah mengenai pelayanan keperawatan anak yang profesional, humanis, dan berbasis kebutuhan anak serta keluarga.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman materi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu keperawatan, khususnya keperawatan anak.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK DAN FAMILY-CENTERED CARE .. **1**
A. Definisi dan Prinsip-prinsip Keperawatan Anak 5
B. Falsafah Paradigma keperawatan Anak 5
C. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Anak 7
D. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Anak 10
E. Asuhan Keperawatan Berbasis Kebutuhan Anak 10
F. Family-Centered Care dalam Keperawatan Anak 10
G. Komunikasi dengan Keluarga sebagai Mitra dalam Keperawatan 15
H. Contoh Implementasi Prinsip Family-Centered Care 16
I. RINGKASAN 38
Referensi **42**

BAB 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA (0-18 TAHUN) **44**
A. Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia (0-18 Tahun) 48
B. Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan 50
C. Prinsip-Prinsip Tumbuh Kembang (12) 55
D. Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang 57
E. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (0–18 Tahun) 60
F. Deteksi Dini Tumbuh Kembang 65
G. Peran Perawat dalam Tumbuh Kembang Anak 68
H. Aktivitas Belajar Terstruktur 72
I. RINGKASAN 95
Referensi **100**

BAB 3 PENGKAJIAN KOMPREHENSIF ANAK **102**
A. Konsep Dasar dan Komunikasi dalam Pengkajian Anak 108
B. Pengkajian Riwayat Kesehatan Anak secara Holistik 112
C. Pengukuran Antropometri dan Tanda-Tanda Vital 118
D. Pemeriksaan Fisik Head-to-Toe pada Anak 122
E. Skrining Perkembangan dan Fungsi Neurologis 127
F. RINGKASAN 158
G. Rangkuman Materi 167
Glosarium **168**

Referensi **169**

BAB 4 NUTRISI ANAK DAN MASALAH PEMBERIAN MAKAN **173**
A. NUTRISI 176
B. Penilaian Status Gizi 176
C. Pola Pemberian Makan Sesuai Perkembangan 178
D. Masalah Pemberian Makan 179
E. RINGKASAN 205
Referensi **209**

BAB 5 GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULAR PADA ANAK **210**
A. Definisi 214
B. Etiologi 215
C. Faktor Risiko 218
D. Patofisiologi 221
E. Klasifikasi 234
F. Manifestasi Klinis 237
G. Pemeriksaan Penunjang 240
H. Komplikasi 241
I. Penatalaksanaan 242
J. Pengkajian Keperawatan 244
K. Diagnosis Keperawatan 247
L. Luaran Keperawatan (SLKI) 250
M. Intervensi Keperawatan (SIKI) 253
N. IMPLEMENTASI 255
O. Evaluasi Keperawatan 265
P. Edukasi, Dokumentasi, dan Discharge Planning 267
Referensi **274**

Profil Penulis **275**

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN ANAK DAN FAMILY-CENTERED CARE

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Keperawatan Anak dan Family-Centered Care	1.1 Menjelaskan ruang lingkup keperawatan anak dan prinsip family-centered care dalam kemitraan keluarga.	1.2 Mengidentifikasi prinsip hak anak, etika, dan keselamatan dalam konteks asuhan berpusat keluarga.	CPMK-1	CPMK-6; CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Skor ketepatan konsep inti (persentase jawaban benar) dan konsistensi penggunaan terminologi kunci.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-6	Role play komunikasi + penilaian kinerja	Penerapan teknik komunikasi terapeutik dan kejelasan koordinasi kolaborasi/rujukan (struktur komunikasi).	15	Video/rekaman role play; lembar penilaian
CPMK-7	Portofolio evaluasi luaran + refleksi terstruktur	Kualitas evaluasi berbasis data (indikator luaran) dan spesifikasi rencana perbaikan yang dapat diukur.	15	Portofolio; jurnal refleksi

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi data (akurasi & sistematika)	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

Konsep Dasar Keperawatan Anak dan Family-Centered Care
Teori Dasar

A. Definisi dan Prinsip-prinsip Keperawatan Anak

Keperawatan anak adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pemberian asuhan kepada anak-anak dari berbagai usia, mulai dari bayi hingga remaja. Prinsip-prinsip dalam keperawatan anak mencakup pendekatan yang holistik, melibatkan keluarga, dan mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosional, sosial, serta psikologis anak. Hal ini mencakup juga pentingnya pemberian asuhan yang sesuai dengan perkembangan usia anak (Potts & Sills, 2020)

B. Falsafah Paradigma keperawatan Anak

Falsafah dan Paradigma Keperawatan Anak, merupakan pendekatan holistik dalam perawatan anak, dengan empat elemen yang saling terkait, seperti gambar berikut :



Gambar 1. 1 Diagram 1 :Falsafah & Paradigma Keperawatan Anak (Alligood, 2017)

1. Manusia

   Elemen ini mencerminkan pemahaman tentang manusia, dalam hal ini adalah anak, sebagai individu yang unik dengan kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan psikologis yang perlu dipenuhi dalam perawatan. Dalam paradigma ini, anak dipandang tidak hanya sebagai penerima layanan kesehatan tetapi juga sebagai individu dengan hak untuk berpartisipasi dalam proses perawatan mereka sendiri. Manusia, terutama anak, adalah pusat dari semua upaya keperawatan. Keperawatan anak bertujuan untuk merawat anak dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan setiap aspek kesejahteraan mereka,

termasuk kebutuhan emosional dan sosial, yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka (Potts, & Sills, 2020).

2. Keperawatan

   Keperawatan anak berfokus pada penyediaan asuhan medis yang berpusat pada anak, yang memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental anak. Prinsip keperawatan anak melibatkan penerapan pengetahuan medis, keterampilan teknis, serta pendekatan yang bersifat empatik, menjaga hubungan terapeutik yang kuat antara perawat, anak, dan keluarga. Keperawatan dalam paradigma ini mengutamakan pemberian asuhan yang sesuai dengan perkembangan anak, mulai dari bayi hingga remaja. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan keluarga dan memberikan perawatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak pada setiap tahap kehidupannya (Aydin & Bilgin, 2020).

3. Kesehatan

   Kesehatan dalam paradigma keperawatan anak mengacu pada pemahaman bahwa kesehatan anak mencakup lebih dari sekadar kondisi fisik. Ini melibatkan kesejahteraan mental, sosial, dan emosional yang saling terkait. Menjaga kesehatan anak berarti memperhatikan semua aspek perkembangan mereka. (World Health Organization, 2021). Kesehatan anak memerlukan pendekatan yang mencakup pencegahan, diagnosis dini, pengobatan, dan rehabilitasi. Hal ini melibatkan pemantauan perkembangan fisik dan psikologis anak, serta menangani masalah kesehatan dengan pendekatan yang berbasis pada kebutuhan anak, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan mereka (Shields, & Tanner, 2019).

4. Lingkungan

   Lingkungan berperan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan anak, mencakup faktor-faktor fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Keperawatan anak memandang bahwa lingkungan, baik itu di rumah sakit maupun di rumah, harus mendukung proses pemulihan dan perkembangan anak(Lessa, et al. 2026). Lingkungan yang mendukung perawatan anak termasuk faktor seperti tempat tinggal, akses ke perawatan kesehatan, kualitas udara, serta pengaruh sosial yang bisa mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental anak. Ini juga mencakup peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan anak (McQueen, 2020).

   Keempat elemen dalam diagram ini Manusia**,** Keperawatan**,** Kesehatan**,** dan Lingkungan berinteraksi secara dinamis. Keperawatan yang efektif tidak hanya mengandalkan pengetahuan medis, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan mental dan emosional anak (Manusia), serta mempertimbangkan

faktor eksternal seperti lingkungan (Lingkungan) dan konsep kesehatan yang lebih luas. Semua elemen ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan sistem perawatan yang holistik dan efektif bagi anak. Semua elemen ini bersifat saling mendukung dan berkesinambungan dalam menciptakan perawatan yang komprehensif dan berpusat pada anak. Paradigma ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan keluarga dan perhatian terhadap semua aspek kehidupan anak dalam memberikan perawatan yang optimal.

C. Peran Perawat dalam Asuhan Keperawatan Anak

Perawat memiliki peran penting dalam memberikan asuhan keperawatan anak, yang meliputi penilaian kesehatan anak, pengelolaan perawatan medis, serta memberikan dukungan emosional bagi anak dan keluarganya. Perawat juga berperan dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat anak dengan kondisi kesehatan tertentu, serta memberikan konseling terkait perkembangan anak (Hall & Lindell, 2019).

1. Penilaian Kesehatan Anak

   Penilaian kesehatan anak merupakan langkah pertama yang harus dilakukan perawat untuk mengetahui kondisi fisik dan perkembangan anak secara menyeluruh. Perawat melakukan pemeriksaan fisik, pengamatan terhadap perkembangan anak, serta evaluasi status kesehatan secara terperinci. Penilaian ini mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, pemeriksaan organ tubuh, serta melakukan skrining untuk kondisi-kondisi medis yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, seperti gangguan gizi atau penyakit kronis. Penilaian dilakukan dengan metode yang sesuai dengan usia anak, misalnya dengan menggunakan *growth charts* untuk anak-anak usia dini. Perawat juga mengidentifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi kesehatan anak di masa depan (Hall & Lindell, 2019).

2. Pengelolaan Perawatan Medis

   Perawat memiliki tanggung jawab untuk mengelola perawatan medis anak, yang mencakup pemberian obat-obatan, perawatan luka, pemantauan kondisi medis, serta administrasi terapi lainnya. Perawat bekerja sama dengan tim medis untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan standar medis dan kebutuhan anak. Pengelolaan medis juga mencakup penyesuaian pengobatan berdasarkan kondisi medis tertentu anak, seperti asma, diabetes, atau infeksi. Perawat berperan dalam monitoring tanda vital seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan frekuensi napas yang penting untuk menilai respons anak terhadap perawatan medis. Dalam perawatan medis, perawat juga harus

mematuhi prosedur aseptik dan memastikan anak merasa nyaman selama prosedur medis dilakukan (Potts, & Sills, 2020). .

3. Dukungan Emosional untuk Anak dan Keluarga

   Perawat tidak hanya bertugas memberikan perawatan medis, tetapi juga harus memberikan dukungan emosional yang sangat penting bagi anak dan keluarganya. Proses perawatan medis dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, atau stres bagi anak dan keluarga. Oleh karena itu, perawat bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, memberikan dukungan psikologis, serta membantu keluarga dalam mengatasi kekhawatiran yang mereka miliki terkait kondisi anak. Perawat harus mendengarkan dengan empati terhadap keluhan dan kekhawatiran yang diungkapkan oleh keluarga. Memberikan dukungan emosional kepada anak untuk membantu mereka merasa lebih nyaman dengan prosedur medis yang dilakukan. Perawat juga dapat membantu keluarga memahami bagaimana mendukung anak secara emosional selama perawatan (Rivas, 2021).

4. Edukasi Keluarga tentang Perawatan Anak

   Edukasi merupakan peran utama perawat dalam memastikan keberlanjutan perawatan di rumah. Perawat memberikan informasi mengenai cara merawat anak dengan kondisi medis tertentu, termasuk cara pemberian obat, pemantauan gejala, serta menangani keadaan darurat yang mungkin terjadi. Edukasi juga mencakup pemberian informasi tentang perawatan kesehatan preventif, seperti imunisasi, pola makan sehat, dan kebersihan. Perawat memberikan informasi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga, baik dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau visualisasi. Edukasi juga mencakup latihan praktis kepada keluarga, misalnya bagaimana memantau suhu tubuh anak atau mengatur jadwal pemberian obat (Hall & Lindell, 2019).

5. Konseling Terkait Perkembangan Anak

   Perawat juga berperan dalam memberikan konseling kepada keluarga mengenai perkembangan anak. Hal ini mencakup pemberian informasi tentang tahap perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak, serta cara mengidentifikasi tanda-tanda permasalahan perkembangan atau keterlambatan. Perawat membantu keluarga untuk memahami kebutuhan perkembangan anak sesuai dengan usia dan memberikan strategi pengasuhan yang tepat. Perawat memberikan informasi mengenai perkembangan anak yang sehat, seperti pertumbuhan fisik, perkembangan motorik, kognitif, dan bahasa, serta aspek sosial dan emosional. Perawat juga mengedukasi keluarga tentang tanda-tanda peringatan masalah perkembangan yang memerlukan intervensi lebih lanjut (Shields, & Tanner, 2019).

Secara keseluruhan, peran perawat dalam asuhan keperawatan anak sangatlah luas, mencakup penilaian kesehatan, pengelolaan perawatan medis, dukungan emosional, edukasi keluarga, serta konseling perkembangan anak. Semua aspek ini bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa anak menerima perawatan yang komprehensif, tidak hanya dari segi medis tetapi juga dari segi emosional dan psikologis, yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan keluarga mereka.

Contoh Kasus

Di ruang rawat anak sebuah rumah sakit daerah, dirawat seorang anak laki-laki bernama Arka (6 tahun) dengan diagnosis pneumonia Arka tampak lemah, mengalami sesak napas, dan rewel saat dilakukan tindakan keperawatan seperti pemasangan oksigen dan pemberian obat. Arka dirawat dijaga ibunya, Ny. Sinta (32 tahun), yang terlihat cemas, sering bertanya tentang kondisi anaknya, dan beberapa kali menangis saat melihat Arka kesulitan bernapas. Namun, dalam praktiknya, beberapa tindakan keperawatan masih dilakukan tanpa melibatkan ibu secara aktif. Edukasi yang diberikan kepada keluarga juga masih terbatas pada instruksi singkat tanpa memastikan pemahaman ibu secara menyeluruh. Di sisi lain, ibu Arka sebenarnya ingin dilibatkan lebih dalam, seperti membantu perawatan dasar, memahami kondisi penyakit anaknya, dan mengetahui cara merawat Arka setelah pulang dari rumah sakit.

a. Identifikasi Masalah:
   1) Ibu cemas dan tidak memahami secara menyeluruh kondisi anaknya.
   2) Ibu tidak terlibat aktif dalam proses perawatan anak, yang berkontribusi pada kecemasan.
   3) Edukasi terbatas dan tidak memastikan pemahaman ibu mengenai kondisi anak dan perawatan lanjutan.
b. Penyelidikan dan Pengumpulan Data:
   1) Menilai tingkat kecemasan ibu melalui wawancara, seperti pertanyaan tentang pemahaman ibu tentang pneumonia dan cara perawatan anak.
   2) Menilai apakah ibu merasa siap atau tidak siap dalam merawat Arka setelah pulang dari rumah sakit.
   3) Memastikan apakah ibu sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perawatan dasar seperti pemberian obat, penggunaan oksigen, atau teknik perawatan lainnya.
c. Analisis Data:
   1) Kecemasan ibu dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang kondisi penyakit anaknya.

2) Keterlibatan ibu dalam perawatan dapat mengurangi rasa cemas dan meningkatkan rasa kontrol atas situasi.
3) Kurangnya edukasi yang menyeluruh tentang pneumonia dapat meningkatkan ketidakpastian ibu dan memperburuk kecemasan.

d. Diagnosa Keperawatan SDKI
Cemas berhubungan dengan ketidakpastian kondisi anak, ketidakmampuan untuk merawat anak secara maksimal, dan kurangnya pemahaman terhadap kondisi penyakit anak.

e. Intervensi Keperawatan (SIKI)
1) Lakukan edukasi pada keluarga
2) Dengarkan dan berikan dukungan emosional
3) Libatkan keluarga dalam proses keperawatan
4) Identifikasi dan kelola faktor resiko kecemasan
5) Evaluasi pemahaman keluarga tentang kondisi anak

f. Luaran Keperawatan (SLKI)
1) Pemulihan kecemasan
2) Keterlibatan keluarga dalam perawatan
3) Pemahaman keluarga tentang penyakit dan perawatan

D. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Anak

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan anak antara lain lingkungan keluarga, status gizi, akses ke perawatan kesehatan, dan pengaruh sosial budaya. Selain itu, faktor genetik dan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan juga memainkan peran penting dalam perkembangan anak (WHO, 2021)

E. Asuhan Keperawatan Berbasis Kebutuhan Anak

Asuhan keperawatan berbasis kebutuhan anak mengutamakan penilaian yang menyeluruh terhadap kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Pendekatan ini menyesuaikan perawatan dengan usia, kondisi medis, serta perkembangan anak untuk memastikan hasil yang optimal (Aydin & Bilgin 2020).

F. Family-Centered Care dalam Keperawatan Anak

1. Definisi Family-Centered Care

Family-Centered Care (FCC) adalah suatu model perawatan yang menganggap keluarga sebagai mitra dalam perawatan anak, dengan memberikan mereka peran aktif dalam keputusan medis dan perawatan anak. FCC bertujuan untuk meningkatkan pengalaman perawatan baik bagi anak

maupun keluarganya, dengan pendekatan yang berbasis pada komunikasi yang terbuka dan kolaborasi (O'Brien & O'Keefe 2017).

2. Prinsip-Prinsip Family-Centered Care

   Prinsip-prinsip FCC meliputi keterlibatan keluarga dalam setiap tahap perawatan, komunikasi yang efektif antara perawat dan keluarga, serta pengakuan terhadap kebutuhan dan keinginan keluarga. FCC juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap peran penting keluarga dalam proses penyembuhan anak (Shields & Tanner, 2019).

3. Kemitraan dengan Keluarga dalam Proses Perawatan

   Dalam FCC, keluarga dianggap sebagai sumber daya yang sangat penting dalam proses perawatan anak. Keluarga berperan dalam membantu perawat dalam mengambil keputusan perawatan, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan untuk anak selama perawatan. Kemitraan ini juga termasuk pemberian informasi yang relevan dan pembelajaran mengenai kondisi kesehatan anak (Rivas, 2018).

4. Proses Family-Centered Care

   Proses FCC berpusat pada keluarga sebagai mitra yang aktif dalam perawatan anak. Ini bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang terbaik dengan melibatkan keluarga dalam setiap langkahnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mendukung anak secara emosional dan sosial. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang saling berhubungan satu sama lain.



Gambar 1. 2 Diagram Proses FCC : (Shields & Tanner 2019).

5. Tahapan-Tahapan dalam Proses FCC
   a. *Respect and Dignity* (Hormati dan Jaga Martabat)

      Tahap pertama dalam FCC adalah memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam perawatan, termasuk anak dan keluarganya, diperlakukan dengan hormat dan martabat. Ini melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai keluarga, keyakinan, dan kebiasaan mereka. Perawat harus menjaga etika dan sikap profesional yang menciptakan lingkungan yang penuh penghormatan, yang membantu keluarga merasa dihargai dan diterima (Lessa, Machado, Costa, & Latour, 2026)
   b. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

      Berbagi informasi yang jelas dan transparan adalah tahap yang sangat penting dalam FCC. Keluarga perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan medis dengan memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi kesehatan anak dan pilihan perawatan yang tersedia. Ini menciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka antara tenaga medis dan keluarga. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memastikan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami oleh keluarga (Cetintas, Kostak, Semerci & Kocaaslan, 2021).
   c. *Collaboration* (Kolaborasi)

      Kolaborasi adalah kunci dalam FCC, di mana tenaga medis, keluarga, dan anak (jika memungkinkan) bekerja sama untuk merencanakan dan memberikan perawatan. Kolaborasi ini tidak hanya berlaku antara tenaga medis dan keluarga, tetapi juga antar anggota tim kesehatan untuk memastikan pendekatan yang terpadu dan komprehensif dalam perawatan. Keluarga harus dilibatkan dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak mereka (Kuo, Houtrow, Arango, Kuhlthau, Simmons, Neff, 2011).
   d. *Emotional & Social Support* (Dukungan Emosional dan Sosial)

      Dukungan emosional dan sosial merupakan elemen vital dalam FCC. Keluarga harus diberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi stres emosional yang mungkin mereka alami selama perawatan anak mereka. Ini bisa melibatkan konseling, dukungan kelompok, atau bahkan sekadar mendengarkan kebutuhan keluarga dengan empati. Dukungan sosial juga melibatkan bantuan dari komunitas yang lebih luas untuk menjaga kesejahteraan anak dan keluarga (Aljawad, Miraj, Alameri & Alzayer, 2025).
   e. *Family Participation in Care* (Partisipasi Keluarga dalam Perawatan)

      Keluarga merupakan mitra yang sangat penting dalam perawatan anak. Mereka tidak hanya menjadi pendukung moral, tetapi juga berperan aktif dalam perawatan anak. Partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan perawatan anak sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut

sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan keluarga. Ini dapat mencakup keterlibatan keluarga dalam kegiatan sehari-hari perawatan anak di rumah sakit atau dalam memilih terapi dan perawatan alternatif (Sinaga, 2025).

f. *Negotiation & Partnership* (Negosiasi & Kemitraan)

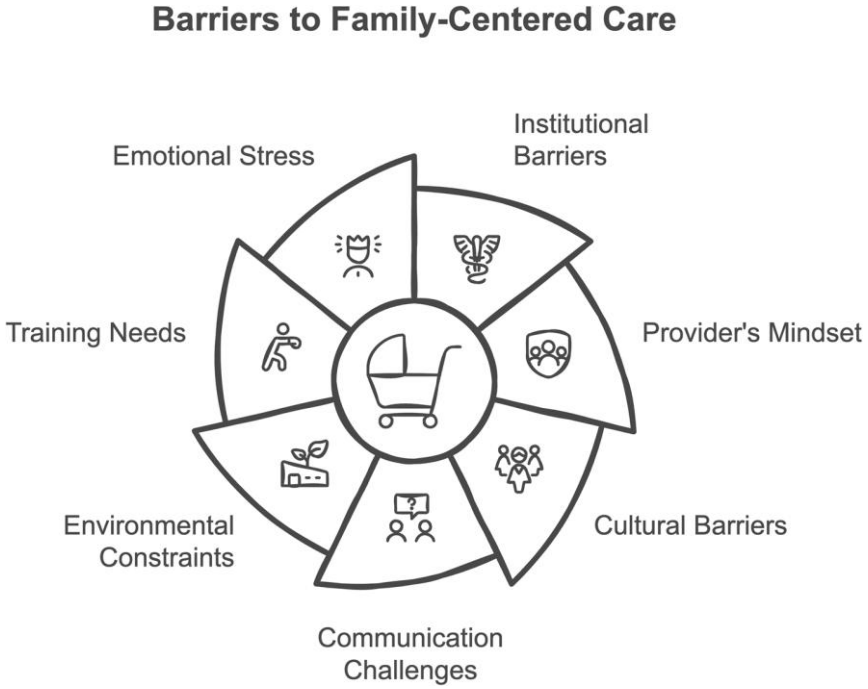
Dalam FCC, negosiasi dan kemitraan antara keluarga dan tenaga medis sangat penting. Keluarga dan tim medis harus bekerja bersama untuk menciptakan rencana perawatan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan anak. Proses ini melibatkan diskusi terbuka mengenai berbagai opsi perawatan, serta kompromi di mana diperlukan, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil terbaik bagi anak dan keluarga (Latour, Rennick, Hoogen, 2024).

6. Hubungan Antar Tahapan

Semua tahapan ini saling terkait satu sama lain, membentuk suatu proses yang berkesinambungan. Keberhasilan FCC bergantung pada sejauh mana tiap tahapan diterapkan dengan baik, menciptakan hubungan yang positif antara keluarga, anak, dan tim medis. *Respect and Dignity* menjadi dasar untuk terciptanya hubungan yang saling percaya, yang memungkinkan terjadinya *Information Sharing* yang jujur dan terbuka. *Kolaborasi* yang terjadi antara keluarga dan tim medis akan mengarah pada partisipasi aktif keluarga dalam perawatan anak, yang pada gilirannya memperkuat *Emotional & Social Support***.** *Negotiation & Partnership* terjadi ketika keluarga terlibat dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan perawatan, menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung antara keluarga dan tenaga medis.

7. Barrier dalam FCC

Meskipun FCC sangat dibutuhkan dalam perawatan kesehatan anak namun terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan *Family-Centered Care* **(**FCC)**,** yang mencakup berbagai faktor yang dapat menghalangi keberhasilan FCC dalam praktik keperawatan.



Gambar 1. 3 Diagram Hambatan dalam FCC (Aljawad et all, 2025)

a. *Emotional Stress* (Stres Emosional)

Stres emosional yang dialami oleh keluarga dan tenaga medis adalah salah satu hambatan utama dalam FCC. Keluarga seringkali mengalami stres akibat kondisi kesehatan anak yang membutuhkan perawatan intensif atau jangka panjang. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses perawatan. Tenaga medis juga dapat merasakan stres karena tuntutan untuk memberikan perawatan yang holistik dan melibatkan keluarga dalam setiap keputusan medis. Studi dari Murphy et al menunjukkan bagaimana stres emosional yang dialami keluarga dapat menghambat partisipasi mereka dalam perawatan anak, dan pentingnya dukungan emosional untuk mengurangi stres tersebut (Murphy,et al. 2020).

b. *Training Needs* (Kebutuhan Pelatihan)

Tenaga medis seringkali membutuhkan pelatihan khusus untuk memahami dan menerapkan prinsip FCC dengan efektif. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dan keluarga serta untuk mengatasi tantangan-tantangan lainnya, seperti hambatan budaya dan komunikasi yang pada akhirnya meningkatkan kualitas perawatan dan kepuasan keluarga. (Heller, & Penner, 2021)

c. *Institutional Barriers* (Hambatan Institusional)

Hambatan institusional termasuk kebijakan, prosedur, atau sistem yang ada dalam organisasi atau lembaga kesehatan yang tidak mendukung penerapan FCC. Hal ini bisa berupa jadwal yang kaku, batasan waktu

perawatan, atau kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung peran keluarga dalam perawatan (Shields, & Tanner, 2019).

d. Provider's Mindset (Pola Pikir Penyedia Layanan Kesehatan)

Pola pikir atau sikap dari penyedia layanan kesehatan (perawat, dokter, dsb.) juga dapat menjadi hambatan dalam FCC. Beberapa tenaga medis mungkin merasa bahwa mereka lebih tahu mengenai perawatan anak daripada keluarga, sehingga enggan untuk melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan medis (Aydin, & Bilgin, 2020).

e. Cultural Barriers (Hambatan Budaya)

Hambatan budaya mencakup perbedaan nilai, norma, dan praktik keluarga yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan tenaga medis dan menerima perawatan. Beberapa keluarga mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang perawatan medis, atau ada ketidaknyamanan dengan keterlibatan keluarga dalam keputusan medis (Rivas, 2021).

f. Communication Challenges (Tantangan Komunikasi)

Komunikasi yang buruk antara tenaga medis dan keluarga adalah hambatan utama dalam FCC. Tantangan ini bisa berupa kesulitan dalam menyampaikan informasi medis dengan cara yang mudah dipahami keluarga, atau kesulitan dalam mendengarkan kebutuhan dan preferensi keluarga (Tomasello, & McDonald, 2020).

Hambatan-hambatan dalam FCC mencakup faktor-faktor emosional, pelatihan, institusional, budaya, serta tantangan komunikasi. Semua hambatan ini dapat diatasi melalui pelatihan yang tepat, perubahan dalam kebijakan institusional, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya FCC dalam perawatan anak. Dukungan dari semua pihak, termasuk tim medis, keluarga, dan lembaga kesehatan, sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan menerapkan FCC dengan efektif.

G. Komunikasi dengan Keluarga sebagai Mitra dalam Keperawatan

Komunikasi yang terbuka dan jujur antara perawat dan keluarga merupakan salah satu elemen penting dalam FCC. Komunikasi yang efektif memungkinkan keluarga untuk merasa dihargai, dipahami, dan diberdayakan dalam perawatan anak. Selain itu, perawat harus mampu menjelaskan informasi medis dengan cara yang mudah dimengerti oleh keluarga (Fagan & Fagan 2020).

H. Contoh Implementasi Prinsip Family-Centered Care

Contoh Kasus

Di ruang rawat anak sebuah rumah sakit daerah, dirawat seorang anak laki-laki bernama Arka (6 tahun) dengan diagnosis pneumonia Arka tampak lemah, mengalami sesak napas, dan rewel saat dilakukan tindakan keperawatan seperti pemasangan oksigen dan pemberian obat. Arka dirawat dijaga ibunya, Ny. Sinta (32 tahun), yang terlihat cemas, sering bertanya tentang kondisi anaknya, dan beberapa kali menangis saat melihat Arka kesulitan bernapas. Namun, dalam praktiknya, beberapa tindakan keperawatan masih dilakukan tanpa melibatkan ibu secara aktif. Edukasi yang diberikan kepada keluarga juga masih terbatas pada instruksi singkat tanpa memastikan pemahaman ibu secara menyeluruh. Di sisi lain, ibu Arka sebenarnya ingin dilibatkan lebih dalam, seperti membantu perawatan dasar, memahami kondisi penyakit anaknya, dan mengetahui cara merawat Arka setelah pulang dari rumah sakit.

1. Penghargaan terhadap Keluarga sebagai Mitra dalam Perawatan
   a. Mendengarkan dan Menghargai Keinginan Keluarga: Ibu Arka merasa cemas dan ingin dilibatkan lebih aktif dalam perawatan anaknya. Perawat perlu menghargai keinginan ini dengan melibatkan ibu dalam perawatan, memberikan kesempatan kepada ibu untuk bertanya, dan merespons pertanyaan serta kekhawatirannya dengan cara yang empatik dan profesional.
   b. Memberikan Waktu untuk Berbicara**:** Perawat dapat menyediakan waktu khusus untuk berbicara dengan ibu Arka tentang kondisi anak, prognosis, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perawatan, sehingga ibu merasa dihargai dan terlibat.
2. Menyediakan Edukasi yang Komprehensif
   a. Edukasi yang Jelas dan Komprehensif: Memberikan informasi yang jelas mengenai pneumonia, gejala-gejala yang harus diwaspadai, dan bagaimana cara merawat Arka baik selama perawatan di rumah sakit maupun setelah pulang. Edukasi ini harus disesuaikan dengan pemahaman ibu, menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari istilah medis yang membingungkan.
   b. Menggunakan Media Edukasi: Selain memberikan penjelasan verbal, perawat dapat menggunakan media visual seperti gambar atau video untuk menjelaskan proses perawatan anak, teknik pemberian obat, dan tanda-tanda kondisi yang memburuk.
3. Meningkatkan Keterlibatan Keluarga dalam Proses Perawatan
   a. Mengajak Ibu dalam Proses Perawatan: Memberikan kesempatan kepada ibu untuk terlibat langsung dalam tindakan perawatan dasar seperti pemberian obat atau pemasangan oksigen (dengan supervisi). Misalnya, ibu dapat diberi instruksi tentang bagaimana cara memberikan obat atau menggunakan nebulizer jika diperlukan.

b. Partisipasi dalam Pengawasan Tanda-Tanda Vital: Ibu Arka dapat diajak untuk memonitor tanda-tanda vital anak seperti suhu tubuh, laju pernapasan, atau saturasi oksigen dengan bantuan alat yang ada, sehingga ia merasa lebih berdaya dalam merawat anak.

4. Dukungan Emosional untuk Keluarga
   a. Memberikan Dukungan Emosional: Mengingat ibu Arka terlihat cemas dan menangis melihat anaknya kesulitan bernapas, perawat perlu memberikan dukungan emosional untuk menenangkan ibu. Ini bisa dilakukan dengan berbicara empatik, memberikan informasi yang menenangkan, dan menunjukkan empati terhadap perasaan ibu.
   b. Memberikan Ruang untuk Ekspresi Perasaan: Memberikan ibu ruang untuk berbicara tentang perasaannya dan kekhawatirannya akan kondisi anaknya. Hal ini dapat membantu ibu merasa lebih nyaman dan mengurangi tingkat kecemasan.
5. Penghargaan terhadap Keputusan dan Preferensi Keluarga
   a. Mendengarkan Preferensi Ibu: Ny. Sinta ingin dilibatkan dalam merawat anaknya. Oleh karena itu, perawat harus berusaha untuk memberikan kesempatan kepada ibu untuk membantu dalam perawatan sesuai dengan preferensinya, seperti mengajarkan ibu cara merawat Arka setelah pulang dari rumah sakit.
   b. Pengambilan Keputusan Bersama: Setiap keputusan yang diambil terkait dengan perawatan Arka sebaiknya melibatkan ibu. Misalnya, dalam pemilihan jenis obat atau metode perawatan tertentu, ibu perlu diberikan penjelasan dan diberi pilihan yang jelas mengenai tindakan yang akan dilakukan.
6. Penguatan Komunikasi yang Terbuka dan Transparan
   a. Memberikan Informasi yang Terbuka: Perawat dan dokter harus berkomunikasi secara terbuka dengan ibu mengenai kondisi anak dan rencana perawatan. Ini termasuk penjelasan tentang apa yang terjadi pada Arka, bagaimana perawatan dilakukan, dan kapan ibu dapat mengharapkan perubahan.
   b. Mendengarkan Kebutuhan dan Kekhawatiran Ibu: Mengingat ibu Arka cemas dan sering bertanya tentang kondisi anaknya, penting untuk memastikan bahwa ibu merasa didengar. Menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan ibu secara rinci dan mengatasi kekhawatirannya dengan informasi yang berbasis fakta.

7. Menyediakan Perawatan yang Responsif dan Berkelanjutan
   a. Tindak Lanjut setelah Perawatan Rumah Sakit: Setelah Arka pulang dari rumah sakit, penting untuk memastikan bahwa ibu memiliki akses untuk mendapatkan informasi lanjutan terkait perawatan anak. Ini bisa mencakup pemberian panduan tertulis, nomor kontak untuk pertanyaan lebih lanjut, serta tindak lanjut dari klinik untuk memastikan perawatan berjalan baik di rumah.
   b. Penyuluhan tentang Tanda Bahaya Kembali: Edukasi kepada ibu mengenai tanda-tanda kondisi yang memburuk setelah pulang rumah sakit, serta apa yang harus dilakukan jika anak kembali menunjukkan gejala seperti sesak napas, demam tinggi, atau penurunan kondisi.

Aktifitas 1 – Knows How

Kasus :

Di ruang rawat anak sebuah rumah sakit daerah, dirawat seorang anak laki-laki bernama Arka (6 tahun) dengan diagnosis pneumonia Arka tampak lemah, mengalami sesak napas, dan rewel saat dilakukan tindakan keperawatan seperti pemasangan oksigen dan pemberian obat. Arka dirawat dijaga ibunya, Ny. Sinta (32 tahun), yang terlihat cemas, sering bertanya tentang kondisi anaknya, dan beberapa kali menangis saat melihat Arka kesulitan bernapas. Namun, dalam praktiknya, beberapa tindakan keperawatan masih dilakukan tanpa melibatkan ibu secara aktif. Edukasi yang diberikan kepada keluarga juga masih terbatas pada instruksi singkat tanpa memastikan pemahaman ibu secara menyeluruh. Di sisi lain, ibu Arka sebenarnya ingin dilibatkan lebih dalam, seperti membantu perawatan dasar, memahami kondisi penyakit anaknya, dan mengetahui cara merawat Arka setelah pulang dari rumah sakit.

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Apa saja kebutuhan dasar anak (fisik, psikologis, sosial, dan perkembangan) yang belum terpenuhi secara optimal?
2. Identifikasi prinsip-prinsip family-centered care yang belum diterapkan secara optimal dalam kasus ini.
3. Rancang intervensi keperawatan yang dapat mengurangi kecemasan Arka selama perawatan di rumah sakit.

Aktifitas 2 – Shows How

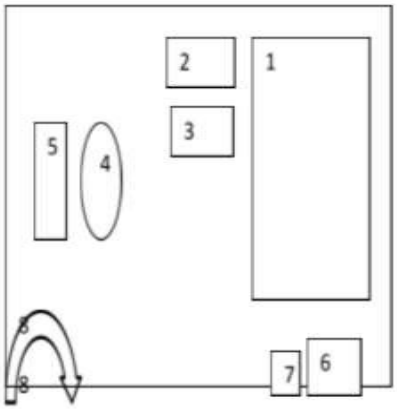
1. Kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi secara optimal:
   - Fisik: Kebutuhan akan kenyamanan, tidur yang cukup, dan pengelolaan rasa sakit mungkin belum optimal.
   - Psikologis: Kecemasan Arka dan ibu belum sepenuhnya ditangani, menyebabkan rasa takut dan ketidakpastian.
   - Sosial: Anak-anak membutuhkan interaksi sosial yang mendukung, yang mungkin terbatas di rumah sakit.
   - Perkembangan: Aktivitas yang sesuai dengan usia, seperti bermain atau berinteraksi dengan teman sebaya, mungkin terbatas
2. Prinsip-prinsip family-centered care yang belum diterapkan secara optimal:
   - Keterlibatan aktif keluarga: Ibu belum dilibatkan sepenuhnya dalam perawatan anak.
   - Edukasi keluarga: Edukasi yang diberikan kepada ibu masih terbatas dan kurang mendalam.
   - Penghargaan terhadap kebutuhan keluarga: Ibu menginginkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi anak, yang belum sepenuhnya dipenuhi.

3. Rancang intervensi keperawatan yang dapat mengurangi kecemasan Arka selama perawatan di rumah sakit:
   - Menyediakan waktu untuk bermain dan interaksi sosial yang sesuai dengan usia.
   - Memberikan penjelasan sederhana dan menenangkan tentang prosedur yang akan dilakukan.
   - Menciptakan lingkungan yang nyaman dengan benda-benda familiar dari rumah, seperti selimut atau mainan.

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Penerapan Family-Centered Care pada Anak dengan Pneumonia
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, komunikasi , serta edukasi kelurga terkait perawatan anak dengan pneonia
5	Kompetensi	**1. Komunikasi, edukasi, dan konseling** **2. Pengkajian** 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi **6. Perilaku professional**
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman **5. Psikososial**
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki, Arka (6 tahun)**,** dirawat dengan diagnosis **pneumonia**. Saat ini, anak tampak sesak napas ringan, batuk, dan terlihat cemas. Anak ditemani oleh ibunya. Ibu pasien tampak khawatir dan mengatakan: "Anak saya dari tadi rewel dan takut kalau dipasang alat. Saya juga belum terlalu paham penyakitnya, ini berbahaya tidak ya, perawat?" TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Berikan edukasi sederhana tentang kondisi anak dan perawatan yang diperlukan.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki, **Arka (6 tahun)**, dirawat dengan diagnosis **pneumonia**. Saat ini, anak tampak sesak napas ringan, batuk, dan terlihat cemas. Anak ditemani oleh ibunya. Ibu pasien tampak khawatir dan mengatakan: "Anak saya dari tadi rewel dan takut kalau dipasang alat. Saya juga belum terlalu paham penyakitnya, ini berbahaya tidak ya, perawat?" TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Berikan edukasi sederhana tentang kondisi anak dan perawatan yang diperlukan.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, frekuensi nafas, saturasi oksigen, tanda gawat napas 2. Menilai ketepatn peserta dalam berkomunikasi dan memberikan edukasi kepada keluarga. 3. Monitor perilaku profesional peserta. 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: anak laki-laki usia 6 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat penyakit sekarang: batuk, sesak nafas 3. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama. 4. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 5. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas, anak rewel, dan belum nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 6. Harapan terhadap penyakit: ibu berharap anak segera membaik, tidak rewel, dan ibu dapat mengerti dan memahami penyakit naknya 7. ibu : Tunjukkan ekspresi cemas (gelisah, sering bertanya), Jika tidak dijelaskan, tetap terlihat bingung, Jika dijelaskan dengan baik, mulai tampak lebih tenang, Bersedia dilibatkan jika perawat mengajak 9. KS duduk di samping tempat tidur anak dengan raut wajah cemas. Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran

No.	Komponen	Isi
		Setting ruang rawat inap - Tempat tidur klien - Klien simulasi Keterangan: 1 : Bed Pasien 2 : Meja Pasien 3 : Trolley 4 : Meja Penguji 5 : Kursi Penguji 6 : Washtafel 7 : Tempat Sampah 8 : Pintu masuk 
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. alat tulis untuk pengkajian.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP Edukasi Pada Orang Tua Dengan Anak Pnemonia

No	Tahapan Kegiatan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A.	Tahap Pra Interaksi				
1.	Persiapkan materi edukasi: Menyusun materi yang relevan tentang pneumonia pada anak, termasuk penyebab, gejala, pengobatan, dan perawatan lanjutan.				
2.	Pahami kondisi orang tua: Perhatikan tanda-tanda kecemasan atau ketegangan orang tua untuk dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi.				
3.	Periksa data medis anak: Pastikan informasi terkait kondisi medis anak terkini agar dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.				
B.	Tahap Orientasi				
4.	Memberikan salam terapeutik kepada pasien				
5.	Memperkenalkan diri dan peran perawat				
6.	Jelaskan tujuan edukasi: Informasikan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi anak, perawatan yang diperlukan, dan cara melanjutkan perawatan setelah pulang dari rumah sakit.				
C.	Tahap Kerja				

7.	Berikan informasi yang sesuai: • Penyebab pneumonia: Jelaskan bakteri atau virus yang dapat menyebabkan pneumonia pada anak. • Gejala pneumonia: Berikan penjelasan tentang gejala yang harus diperhatikan orang tua, seperti batuk, sesak napas, dan demam. • Pengobatan: Edukasi tentang obat-obatan yang digunakan untuk mengobati pneumonia dan bagaimana cara pemberiannya. • Perawatan di rumah: Jelaskan langkah-langkah perawatan yang perlu dilakukan di rumah setelah keluar dari rumah sakit. • Tanda-tanda bahaya: Informasikan tanda-tanda komplikasi yang memerlukan perhatian medis segera, seperti kesulitan bernapas yang semakin parah.				
8.	Gunakan bahasa yang mudah dimengerti: Pastikan orang tua memahami informasi yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh konkret.				
9	Libatkan orang tua: Berikan kesempatan bagi orang tua untuk bertanya dan berinteraksi				

	selama sesi edukasi.				
D	*Tahap Terminasi*				
10	Tanya jawab: Pastikan orang tua memiliki kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang belum jelas.				
11	Konfirmasi pemahaman: Minta orang tua untuk merangkum informasi yang telah diberikan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami.				
12.	Berikan dukungan lebih lanjut: Informasikan orang tua tentang sumber daya atau kontak untuk pertanyaan lanjutan, seperti klinik atau nomor perawat yang dapat dihubungi.				
13	Akhiri dengan empati: Selesaikan sesi dengan memberikan dukungan emosional, seperti mengatakan bahwa Anda akan terus mendampingi mereka dalam perawatan anak.				
E	Tahap Dokumentasi				
14	Catat edukasi yang diberikan: Dokumentasikan materi yang telah dijelaskan, serta setiap pertanyaan atau kekhawatiran yang disampaikan orang tua.				
15	Tulis respons orang tua: Catat apakah orang tua menunjukkan pemahaman yang baik atau membutuhkan informasi tambahan.				

16	erbarui catatan medis: Tambahkan informasi terkait pemahaman orang tua dalam catatan medis anak untuk referensi tim medis berikutnya.				
F	Tahap Penampilan Profesional				
17	Berpenampilan rapi dan profesional: Pastikan pakaian dan penampilan Anda sesuai dengan standar profesional untuk memberikan kesan yang positif kepada orang tua.				
18	Gunakan bahasa yang sopan dan empatik: Berbicara dengan penuh perhatian, menjaga nada suara yang tenang dan percaya diri untuk mengurangi kecemasan orang tua.				
19	Bersikap sabar dan terbuka: Tunjukkan kesabaran, terutama jika orang tua cemas atau memiliki banyak pertanyaan.				
20	aga privasi dan kerahasiaan: Pastikan bahwa semua informasi yang dibagikan terkait kondisi anak tetap dijaga kerahasiaannya sesuai dengan prinsip etika medis.				
G	Evaluasi dan Tindak Lanjut				
21	Evaluasi pemahaman orang tua: Lakukan evaluasi berkala, baik selama rawat inap maupun saat kunjungan rumah, untuk memastikan orang tua tetap mengingat dan mengaplikasikan informasi yang telah diberikan.				

22	Follow-up: Jika diperlukan, jadwalkan pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan kondisi anak dan memastikan orang tua menerima dukungan yang berkelanjutan.				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEMONIA

I. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Komunikasi	membuka komunikasi, Empati dan respons emosional, komunikasi 2 arah, Mendengarkan aktif (kontak mata, anggukan, tidak memotong)					2	
2	Pengkajian Keperawatan	Menggali frekuensi nafas, pola nafas, saturasi oksigen					1	
3	Implementasi keperawatan: edukasi	Menjelaskan penyakit dan perawatan anak dengan Pnemonia dan melakukan konseling					5	
4	Perilaku profesional	menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA ANAK DENGAN PNEMONIA

Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1 Komunikasi : aspek ini menilai kemampuan peserta membuka komunikasi, Empati dan respons emosional, komunikasi 2 arah, Mendengarkan aktif (kontak mata, anggukan, tidak memotong)					1	
2. . Pengkajian KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menggali data fokus pada anak dengan pnemonia meliputi frekuensi nafas, bunyi nafas, pola nafas, saturasi oksigen. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					2	
3. Implementasi: KeperawatanAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah edukasi dan konseling kepada keluarga . Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5	
4. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Komunikasi	Tidak melakukan komunikasi	melakukan komunikasi hanya terbatas dilakukan membuka komunikasi, Empati dan respons emosional, komunikasi 2 arah, Mendengarkan aktif (kontak mata,	melakukan komunikasi cukup baik namun tidak sistematis dilakukan seperti membuka komunikasi, Empati dan respons emosional, komunikasi 2 arah, Mendengarkan aktif (kontak mata,	melakukan komunikasi secara lengkap dan sistematis dilakukan seperti membuka komunikasi, Empati dan respons emosional, komunikasi 2 arah, Mendengarkan aktif (kontak mata,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		anggukan, tidak memotong)	anggukan, tidak memotong)	anggukan, tidak memotong)
2. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus anak pnemonia	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda bahaya gawat nafas.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti frekuensi frekuensi nafas, pola nafas, bunyi nafas, satirasi oksigen tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi frekuensi nafas, pola nafas, bunyi nafas, satirasi oksigen, serta respons anak dan ibu, kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi dan dan konseling tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi dan konseling secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dan konseling dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik konseling	Melakukan edukasi dan konseling. langkah sudah lengkap dan benar, penjelasan, atau teknik konseling
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
			sistematika tindakan.	responsif, dan etis selama tindakan.

Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore
Nilai akhir = ---------- x 100 =
30
(Kota), ...

Penerapan Direct Observation of Procedural Skill (DOPS) pada kasus Pnemonia

Komponen	**Deskripsi**	**Kasus *Penmonia dengan prinsip FCC***
Metode penilaian	Mini –CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan Edukasi dan konseling pada orang tua
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang penmothoraks tetapi juga dari kemampuan mahasiswa untuk melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi pasien dan menyampaikan rencana asuhan kepada keluarga.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi	Seorang anak laki-laki, **Arka (6 tahun)**, dirawat dengan diagnosis **pneumonia**. Saat ini, anak tampak sesak napas ringan, batuk, dan terlihat cemas. Anak ditemani oleh ibunya. Ibu pasien tampak khawatir dan mengatakan: "Anak saya dari tadi rewel dan takut kalau dipasang alat. Saya juga belum terlalu paham penyakitnya, ini berbahaya tidak ya, perawat?"

Aktifitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan edukasi dan konseling pada orang tua, kontak mata, sikap bahasa non verbal
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi, komunikasi terapeutik, profesionalisme dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerspkan prinsip prinsip edukasi dan konseling pada orang tua

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

a. OSCE + DOPS

b. Catatan kasus singkat

c. Refleksi patient safety

d. Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

a. Bukan sekali ujian

b. Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1. 1 Portolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus dengan Penmonia dengan pronsip FCC
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan pasien dengan *pnemonia*, portofolio memuat bukti mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan intervensi keperawatan secara cepat dan tepat, menjaga keselamatan pasien serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.

Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa harus menunjukkan bahwa mahasiswa pernah merawat pasien dan *penmonia* dan juga mahasiswa harus mampu menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pemberian edukasi dan konseling) sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan edukasi dan konseling
Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus dengan pnemonia
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus pasien dengan pnemonia dimana orang tua membutuhkan edukasi dan konseling .
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali resiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya edukasi dan konseling yang diberikan benar dan tepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) dan mengenali tanda bahaya yanng membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instruktor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian

	kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	dalam pengkajian kegawatan pernafasan dan dokumentasi evaluasi hasil dari tindakan yang telah diberikan kepada pasien
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus kegawatan pernafasan tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa mahasiswa konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien secara aman, tepat dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan khusus, refleksi dan umpan balik, terlihat mahasiswa secara konsisten mampu melakukan edukasi dan konseling dan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan dengan pnemonia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep pnemonia saja tetapi juga harus konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 1. 2 Refleksi Patient Safety

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus pasien dengan *Pnemonia dengan prinsip FCC***
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah dan merencanakan	Pada kasus dengan Pnemonia mahasiswa merefleksikan bahwa Pemberian edukasi yang jelas dan terstruktur kepada keluarga dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang kondisi anak, sehingga mereka dapat mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengurangi risiko komplikasi.

	tindakan pencegahan.	
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa Memberdayakan keluarga**:** M**e**mberikan edukasi kepada orang tua agar mereka bisa merawat anak dengan baik setelah pulang dari rumah sakit, serta mengenali tanda-tanda komplikasi yang membutuhkan perawatan medis lebih lanjut. pada keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan dan pembelajaran yang diproleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa resiko utama pada pasien ini adalah Anak yang dirawat di rumah sakit berisiko terpapar infeksi rumah sakit lainnya, yang dapat memperburuk kondisi pneumonia. Pencagahan Mengimplementasikan langkah-langkah kebersihan dan sterilisasi yang ketat di rumah sakit untuk mencegah infeksi rumah sakit lainnya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Resiko yang dapat diidentifikasi Penerapan prinsip keselamatan pasien dalam praktik nyata**:** Pengalaman klinik memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami dan mempraktikkan protokol keselamatan pasien, menghindari kesalahan medis, dan mengurangi risiko bagi pasien anak.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko keselamatan pasien.	Mahasiswa belajar untuk mengedukasi keluarga dengan cara yang efektif, meningkatkan komunikasi untuk memastikan keluarga memahami kondisi anak dan perawatan yang perlu dilakukan di rumah.
Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus pasien dengan Penmonia
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pentingnya kolaborasi dengan tim medis lainnya untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien dan menghindari kesalahan akibat komunikasi yang buruk atau keterlambatan dalam tindakan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya melakukan tindakan tetapi juga mampu mengevaluasi resiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan pasien secara berkelanjutan.

I. RINGKASAN

Keperawatan anak merupakan cabang keperawatan yang fokus pada perawatan kesehatan anak, yang mencakup pengelolaan masalah kesehatan dari bayi, balita, hingga remaja. Keperawatan anak tidak hanya memperhatikan kondisi fisik anak, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak.

Anak-anak memiliki karakteristik unik dalam proses penyembuhan yang berbeda dari orang dewasa. Mereka cenderung lebih rentan terhadap infeksi, membutuhkan perawatan yang lebih sensitif, dan sering kali merasa takut atau bingung dalam lingkungan rumah sakit. Oleh karena itu, pendekatan dalam keperawatan anak harus disesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, dan tingkat kecemasan anak. Perawat perlu berinteraksi secara empatik, menggunakan komunikasi yang sesuai dengan usia anak, serta menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak.

Kebutuhan Dasar anak Fisik: Anak membutuhkan kenyamanan fisik melalui pengelolaan nyeri, tidur yang cukup, serta perawatan yang sesuai dengan usianya. Psikologis: Anak-anak memerlukan perhatian psikologis untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut, terutama dalam menghadapi prosedur medis. Sosial: Anak memerlukan interaksi sosial yang mendukung, seperti bermain dengan teman sebaya atau berkomunikasi dengan keluarga. Perkembangan: Anak harus diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan tahap perkembangannya, seperti bermain dan belajar.

Family-Centered Care adalah pendekatan keperawatan yang mengutamakan keluarga dalam proses perawatan anak. Dalam FCC, keluarga dipandang sebagai sumber daya utama yang mendukung kesembuhan anak dan terlibat aktif dalam perawatan dan pengambilan keputusan medis. Prinsip-prinsip Family-Centered Care : Menghargai Keluarga: Keluarga dipandang sebagai mitra penting dalam proses perawatan. Mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan dirangkul sebagai bagian integral dari perawatan anak., Komunikasi yang Terbuka dan Transparan: Perawat dan tim medis berkomunikasi dengan jelas, memberikan informasi yang cukup kepada keluarga, serta mendengarkan kekhawatiran dan kebutuhan mereka., Mendukung Kesejahteraan Keluarga: FCC tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga memberi perhatian pada kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial keluarga., Kolaborasi dalam Perawatan: Perawat bekerja bersama keluarga dan tim medis untuk merencanakan dan melaksanakan perawatan, serta memastikan keluarga diberdayakan dalam merawat anak mereka di rumah.

Keperawatan anak dan Family-Centered Care merupakan pendekatan yang saling melengkapi dalam memberikan perawatan yang optimal kepada anak.

Dengan memahami kebutuhan dasar anak dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan, perawat dapat memberikan layanan yang holistik, meningkatkan proses penyembuhan anak, serta memperkuat dukungan keluarga dalam merawat anak baik di rumah sakit maupun di rumah.

Tabel 1. 3 Red Flags dan Eskalasi Keperawatan anak dan Family-Centered Care (kasus pnemonia)

Red Flags	Makna	Tindakan Eskalasi
Kesulitan bernapas atau sesak napas	Anak mengalami kesulitan bernapas, yang bisa menjadi tanda pneumonia berat atau gagal pernapasan.	Segera lakukan pemantauan oksigenasi (menggunakan pulse oximeter). Berikan oksigen dan segera konsultasikan dengan dokter.
Penurunan saturasi oksigen	Penurunan kadar oksigen dalam darah yang mengindikasikan perburukan kondisi pernapasan.	Tingkatkan aliran oksigen, monitor dengan ketat. Jika saturasi tidak membaik, lakukan intubasi atau resusitasi sesuai pedoman medis.
Demam tinggi yang tidak terkendali	Demam yang terus meningkat meskipun sudah diberikan obat penurun panas, dapat mengindikasikan infeksi berat.	Berikan obat penurun panas sesuai dosis. Jika tidak menurun, evaluasi ulang terapi antibiotik dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Keterlambatan reaksi atau lethargy	Anak menunjukkan penurunan kesadaran atau respons, yang bisa mengindikasikan kelelahan ekstrem atau keracunan obat.	Segera laporkan ke dokter dan evaluasi kembali status neurologis dan metabolik anak.
Tanda-tanda dehidrasi (mulut kering, urine sedikit)	Kekurangan cairan tubuh yang mengarah pada dehidrasi, terutama jika anak tidak dapat minum atau makan dengan baik.	Berikan cairan intravena (IV) segera, pantau keseimbangan cairan dan elektrolit, serta segera komunikasikan kepada dokter.
Nyeri dada atau perut	Bisa menunjukkan masalah jantung atau komplikasi dari pneumonia.	Lakukan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam, termasuk EKG jika diperlukan. Hubungi dokter

		untuk evaluasi lebih lanjut.
Peningkatan batuk dengan darah	Batuk berdarah bisa menjadi tanda pneumonia parah atau komplikasi lainnya.	Lakukan pemeriksaan lanjutan (seperti rontgen dada atau tes darah), evaluasi status medis dan sesuaikan terapi antibiotik.
Tanda-tanda syok (denyut nadi cepat, tekanan darah rendah)	Menunjukkan kegagalan sirkulasi yang mengancam jiwa.	Segera lakukan resusitasi cairan dan obat vasopressor jika diperlukan. Rujuk ke unit perawatan intensif atau dokter spesialis.
Gejala gangguan sistem saraf (kejang, kebingungan)	Tanda komplikasi serius yang mempengaruhi sistem saraf, bisa terkait dengan hipoksia atau infeksi yang meluas.	Segera evaluasi dengan CT scan atau MRI otak, beri terapi antikonvulsan, dan konsultasikan ke spesialis neurologi.
Kecemasan berlebihan pada orang tua	Kecemasan orang tua yang sangat tinggi dapat mempengaruhi keputusan medis dan perawatan anak.	Lakukan komunikasi yang efektif dan empatik dengan orang tua. Sediakan informasi yang jelas dan ajak mereka untuk berpartisipasi dalam perawatan anak.
Penyakit kronis atau komorbiditas yang tidak dikelola	Kondisi seperti asma atau penyakit jantung yang bisa memperburuk pneumonia.	Pastikan kondisi komorbid dikelola dengan baik, sesuaikan terapi untuk mengelola kedua kondisi dan evaluasi kebutuhan untuk rujukan spesialis.

Form Checklist "Saya sudah bisa."
Keperawatan anak dan Family-Centered Care (kasus pnemonia)

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik/Skill Lab : _____

Petunjuk : Beri tanda centang (√) pada kolom yang sesuai

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1.	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Keperawatan anak dan FCC kasus pnemonia secara sederhana	☐	☐	
2.	Saya sudah bisa menjelaskan tentang prinsip FCC	☐	☐	
3.	Saya sudah bisa mengidentifikasi data fokus pasien dengan pnemonia dengan pendekatan FCC	☐	☐	
4.	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pasien dengan Pnemonia pada edukasi dan konseling	☐	☐	
5.	Saya sudah bisa menyusun rencana keperawatan pasien dengan Penmonia	☐	☐	
6.	Saya sudah bisa memberikan edukasi dan konseling orang tua pasien anak dengan pnemonia	☐	☐	
7.	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik pada orang tua dan anak dengan pnemonia	☐	☐	

Referensi

Aljawad, B., Miraj, S. A., Alameri, F., & Alzayer, H. (2025). Family-centered care in neonatal and pediatric critical care units: A scoping review of interventions, barriers, and facilitators. *BMC Pediatrics, 25*, 291. https://doi.org/10.1186/s12887-025-05620-w

Alligood, M. R. (2017). *Nursing theorists and their work* (9th ed.). Elsevier.

Aydin, G., & Bilgin, N. (2020). *Child health nursing: A holistic approach*. Springer Publishing.

Aydin, G., & Bilgin, N. (2020). Provider's mindset in pediatric care: Barriers to family-centered practice. *Journal of Nursing Research*.

Cetintas, I., Kostak, M. A., Semerci, R., & Kocaaslan, E. N. (2021). The relationship between parents' perceptions of family-centered care and their healthcare satisfaction. *Eurasian Journal of Family Medicine, 10*(3), 125–134. https://doi.org/10.33880/ejfm.2021100303

Fagan, E., & Fagan, L. (2020). *Effective communication in pediatric nursing*. Springer.

Hall, C. S., & Lindell, D. R. (2019). *Pediatric nursing and care of the childbearing family*. McGraw-Hill Education.

Heller, M., & Penner, L. A. (2021). Training healthcare providers in family-centered communication. *Journal of Family Nursing*.

Kuo, D. Z., Houtrow, A. J., Arango, P., Kuhlthau, K. A., Simmons, J. M., & Neff, J. M. (2011). Family-centered care: Current applications and future directions in pediatric healthcare. *Maternal and Child Health Journal, 16*(2), 297–305. https://doi.org/10.1007/s10995-011-0751-7

Latour, J. M., Rennick, J. E., & Hoogen, A. V. D. (2024). Family-centered care in pediatric and neonatal critical care settings. *Frontiers in Pediatrics, 12*. https://doi.org/10.3389/fped.2024.1402948

Lessa, A. R. D., Machado, C. R., Costa, C. A. D., & Latour, J. (2026). Parents' perception of family-centered care in the pediatric intensive care unit: A systematic review of qualitative studies. *Intensive and Critical Care Nursing, 93*, 104338.

McQueen, R. (2020). *Environmental factors affecting child health*. Springer.

Murphy, S. S., et al. (2020). The role of family-centered care in reducing parental stress. *Journal of Pediatric Nursing*.

O'Brien, M., & O'Keefe, J. (2017). *Family-centered care: A guide for health professionals*. Springer Publishing.

Potts, M. D., & Sills, M. R. (2020). *Pediatric nursing: Principles and practice* (7th ed.). Elsevier Health Sciences.

Rivas, A. (2021). *Collaborative care with families in pediatric nursing*. Wiley-Blackwell.

Rivas, A. (2021). Cultural barriers to family-centered care: A global perspective. *Journal of Cultural Diversity in Healthcare*.

Shields, L., & Tanner, A. (2019). Barriers to family-centered care in pediatric settings. *Pediatrics Journal*.

Shields, L., & Tanner, A. (2019). *Family-centered care: Theory and practice*. Routledge.

Sinaga, D. (2025). Relationship between family-centered care and the impact of hospitalization on preschool children. *Univ Batam e-Journal*.

Tomasello, R., & McDonald, E. (2020). Overcoming communication barriers in family-centered care. *Pediatric Nursing Review*.

World Health Organization. (2021). *Child health and development*. World Health Organization.

BAB 2

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK USIA (0-18 TAHUN)

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2.Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (0–18 Tahun)	2.1 Menginterpretasi indikator pertumbuhan dan tahap perkembangan anak 0–18 tahun sesuai usia.	2.2 Menentukan implikasi variasi/penyimpangan pertumbuhan–perkembangan terhadap kebutuhan asuhan dan promosi kesehatan.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-3

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Skor ketepatan konsep inti (persentase jawaban benar) dan konsistensi penggunaan terminologi kunci.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	OSCE pengkajian pediatrik + checklist	Persentase ketercapaian item checklist pengkajian dan akurasi pengisian format dokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Lembar checklist OSCE; dokumentasi pengkajian
CPMK-3	Analisis kasus tertulis (case-based)	Ketepatan penetapan prioritas masalah/diagnosis yang didukung data serta rasional berbasis sumber kredibel.	15	Laporan analisis kasus

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi data (akurasi & sistematika)	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

A. Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia (0-18 Tahun)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan aspek fundamental dalam keperawatan anak karena keduanya menjadi indikator utama status kesehatan anak secara menyeluruh. Dalam praktik keperawatan pediatrik, pemahaman tentang tumbuh kembang bukan sekadar pengetahuan teoritis, tetapi menjadi dasar dalam pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Anak bukanlah "miniatur orang dewasa." Pernyataan ini secara konseptual ditegaskan dalam literatur keperawatan anak modern. (1), dalam *Wong's Nursing Care of Infants and Children* menyatakan bahwa anak memiliki pola pertumbuhan, respons fisiologis, kebutuhan psikososial, serta mekanisme koping yang berbeda secara signifikan dari orang dewasa. Perbedaan tersebut menuntut pendekatan asuhan yang spesifik, berbasis tahap perkembangan (*developmentally appropriate care*).

Secara definisi, pertumbuhan (growth) adalah peningkatan ukuran fisik dan jumlah sel yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala (2). Sementara itu, perkembangan (development) adalah proses peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, mencakup aspek motorik, bahasa, kognitif, emosional, dan sosial yang bersifat kualitatif (3). Menurut teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erik Erikson (1963), setiap tahap usia anak memiliki tugas perkembangan psikososial yang harus dicapai. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas perkembangan pada satu tahap dapat memengaruhi tahap berikutnya. Misalnya, pada masa toddler (1–3 tahun), anak berada pada tahap *autonomy vs shame and doubt*. Dukungan lingkungan yang tepat akan membentuk rasa percaya diri dan kemandirian, sedangkan pola asuh yang terlalu membatasi dapat menimbulkan rasa ragu dan ketergantungan.

Selain itu, Jean Piaget (1952) menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak berlangsung melalui tahapan yang sistematis, mulai dari tahap sensori-motor (0–2 tahun), praoperasional (2–7 tahun), operasional konkret (7–11 tahun), hingga operasional formal (≥12 tahun). Pemahaman tahap ini penting bagi perawat dalam menentukan metode komunikasi, edukasi kesehatan, serta pendekatan intervensi yang sesuai dengan kemampuan berpikir anak

Implikasi klinik dalam keperawatan anak berdasarkan tahap perkembangan meliputi: (4)

1. Tahap sensori-motor (0–2 tahun)
   a. Perawat menggunakan stimulasi sensorik dan sentuhan terapeutik untuk meningkatkan rasa aman.
   b. Prosedur keperawatan dilakukan dengan melibatkan orang tua untuk mengurangi kecemasan bayi.

2. Tahap praoperasional (2–7 tahun)
   a. Anak membutuhkan komunikasi konkret, sederhana, dan menggunakan media visual atau permainan terapeutik.
   b. Penjelasan prosedur sebaiknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak abstrak.
3. Tahap operasional konkret (7–11 tahun)
   a. Anak mulai mampu memahami hubungan sebab-akibat sehingga edukasi kesehatan dapat diberikan secara lebih logis dan bertahap.
   b. Perawat dapat melibatkan anak dalam pengambilan keputusan sederhana terkait perawatannya.
4. Tahap operasional formal (≥12 tahun)
   a. Remaja mampu berpikir abstrak sehingga komunikasi dapat dilakukan secara lebih terbuka dan rasional.
   b. Perawat perlu memperhatikan kebutuhan privasi, identitas diri, dan dukungan psikososial remaja.
5. Tahap toddler (1–3 tahun)
   a. Anak memerlukan *autonomy support*, seperti memberikan pilihan sederhana (misalnya memilih warna plester atau posisi pemeriksaan).
   b. Pembatasan yang berlebihan perlu dihindari agar anak tidak mengalami rasa malu dan ragu terhadap kemampuannya sendiri.

Perspektif kesehatan masyarakat, World Health Organization (5), menegaskan bahwa pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala merupakan strategi utama dalam mencegah stunting, wasting, keterlambatan perkembangan, serta gangguan neurodevelopmental. Standar pertumbuhan WHO digunakan secara global untuk menilai status gizi dan pertumbuhan anak berdasarkan kurva antropometri. Dalam konteks nasional, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program SDIDTK (Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) menekankan pentingnya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan sejak usia bayi hingga remaja. Perawat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan skrining, edukasi keluarga, serta rujukan dini apabila ditemukan penyimpangan.

Pemahaman tumbuh kembang membantu (3) :

1. Mengidentifikasi kondisi normal dan penyimpangan
   Perawat harus mampu membedakan variasi normal dengan tanda keterlambatan atau gangguan perkembangan. Misalnya, keterlambatan bicara pada usia 2 tahun memerlukan evaluasi lebih lanjut.
2. Memberikan edukasi yang tepat kepada orang tua
   Edukasi mengenai nutrisi, imunisasi, stimulasi perkembangan, dan pola asuh harus disesuaikan dengan tahap usia anak dan tingkat pemahaman keluarga.
3. Melakukan deteksi dini gangguan perkembangan
   Penggunaan alat skrining seperti KPSP atau DDST membantu perawat mengidentifikasi risiko sejak dini sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum gangguan menjadi permanen.

4. Memberikan asuhan berbasis *Family-Centered Care* (FCC)
   Menurut American Academy of Pediatrics (AAP, 2018), FCC adalah pendekatan yang mengakui keluarga sebagai mitra utama dalam perawatan anak. Anak tidak dapat dipisahkan dari konteks keluarga, sehingga pengambilan keputusan, edukasi, dan intervensi harus melibatkan orang tua secara aktif.

Secara filosofis, keperawatan anak berlandaskan prinsip holistik, yaitu memandang anak sebagai individu yang utuh (bio-psiko-sosial-spiritual-kultural). Perubahan pada satu aspek perkembangan dapat memengaruhi aspek lainnya. Misalnya, gangguan nutrisi (biologis) dapat berdampak pada keterlambatan kognitif dan sosial. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pertumbuhan dan perkembangan menjadi landasan utama dalam praktik keperawatan anak. Bab ini akan membahas konsep dasar, prinsip, faktor yang memengaruhi, tahapan perkembangan usia 0–18 tahun, serta implikasinya dalam asuhan keperawatan profesional berbasis *evidence-based practice* dan *family-*(6)

B. Konsep Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Pengertian Pertumbuhan

   Pertumbuhan (*growth*) merupakan salah satu indikator utama kesehatan anak yang menggambarkan perubahan fisik sebagai hasil dari peningkatan jumlah dan ukuran sel tubuh. Dalam konteks keperawatan anak, pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur secara objektif menggunakan parameter (4)

   Menurut Hockenberry dan Wilson (2021), pertumbuhan adalah peningkatan ukuran tubuh dan organ akibat multiplikasi sel dan pembesaran sel yang terjadi secara bertahap sejak masa konsepsi hingga dewasa. Definisi serupa dikemukakan oleh Kyle dan Carman (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan mencerminkan perubahan fisik yang dapat diukur, seperti berat badan dan tinggi badan, serta merupakan indikator status nutrisi dan kesehatan secara umum.

   Soetjiningsih (2018) mendefinisikan pertumbuhan sebagai bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan berat badan, tetapi juga mencakup perubahan dimensi tubuh lainnya.

   Parameter Pertumbuhan (7)

   Dalam praktik keperawatan dan kesehatan anak, pertumbuhan dinilai melalui pengukuran antropometri, antara lain:

a. Berat Badan (BB)
   Berat badan merupakan indikator sensitif terhadap perubahan status gizi dan kondisi kesehatan akut. Penurunan berat badan dapat mengindikasikan infeksi, malnutrisi, atau gangguan metabolik. WHO (2022) menyatakan bahwa berat badan adalah parameter yang paling cepat berubah akibat gangguan asupan nutrisi.
b. Tinggi Badan/Panjang Badan (TB/PB)
   Tinggi badan mencerminkan pertumbuhan jangka panjang dan status gizi kronis. Gangguan tinggi badan yang menetap dapat mengarah pada kondisi stunting.
c. Lingkar Kepala (LK)
   Lingkar kepala menggambarkan pertumbuhan otak, terutama pada dua tahun pertama kehidupan. Peningkatan atau perlambatan yang abnormal dapat mengindikasikan gangguan neurologis seperti hidrosefalus atau mikrosefali.
d. Lingkar Lengan Atas (LILA)
   Digunakan terutama untuk menilai status gizi, khususnya pada anak dengan risiko malnutrisi.

Penilaian parameter tersebut dibandingkan dengan kurva pertumbuhan standar WHO berdasarkan usia dan jenis kelamin untuk menentukan apakah anak berada pada kategori normal, kurang, atau lebih.

Proses Biologis Pertumbuhan (8)

Secara fisiologis, pertumbuhan terjadi melalui tiga proses utama:

a. Hiperplasia – peningkatan jumlah sel
b. Hipertrofi – peningkatan ukuran sel
c. Akresi – peningkatan substansi interseluler

Proses ini dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan (*growth hormone*), hormon tiroid, insulin, dan hormon seks, terutama pada masa pubertas ((8). Pada masa remaja, terjadi percepatan pertumbuhan yang dikenal sebagai *growth spurt*, yang dipengaruhi oleh peningkatan hormon estrogen dan testosteron.

Ciri-Ciri Pertumbuhan

Pertumbuhan memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

a. Bersifat Kuantitatif dan Objektif
   Pertumbuhan dapat diukur dengan alat seperti timbangan, microtoise, pita ukur lingkar kepala, dan pita LILA.
b. Dapat Diukur dan Dibandingkan dengan Standar
   Hasil pengukuran dibandingkan dengan kurva pertumbuhan WHO atau CDC untuk menentukan status gizi dan pertumbuhan anak.
c. Dipengaruhi Faktor Genetik dan Lingkungan
   Menurut WHO (2022), meskipun faktor genetik menentukan potensi maksimal tinggi badan, faktor lingkungan seperti nutrisi, penyakit, dan stimulasi berperan besar dalam pencapaian potensi tersebut.

d. Bersifat Irreversible
   Pertumbuhan yang telah terjadi tidak dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Misalnya, tinggi badan yang tidak optimal akibat stunting pada masa balita umumnya tidak dapat sepenuhnya diperbaiki pada usia dewasa.

Pola dan Kecepatan Pertumbuhan

Pertumbuhan tidak berlangsung dengan kecepatan yang sama sepanjang kehidupan. Terdapat periode tertentu yang mengalami percepatan, yaitu:

a. Masa prenatal
b. Dua tahun pertama kehidupan
c. Masa pubertas

Kyle dan Carman (2020) menjelaskan bahwa tahun pertama kehidupan merupakan periode pertumbuhan tercepat setelah masa intrauterin. Berat badan bayi dapat meningkat dua kali lipat pada usia 5–6 bulan dan tiga kali lipat pada usia 1 tahun.

Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan (9)

a. Faktor Internal
   1) Genetik
   2) Jenis kelamin
   3) Ras/etnis
   4) Kelainan kongenital
b. Faktor Eksternal
   1) Nutrisi
   2) Status Kesehatan
   3) Lingkungan sosial ekonomi
   4) Stimulasi
   5) Paparan penyakit kronis

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020), kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan berisiko menyebabkan stunting yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Implikasi dalam Keperawatan Anak

Bagi perawat, pemahaman konsep pertumbuhan penting untuk:

a. Melakukan pengkajian antropometri secara akurat
b. Menginterpretasikan grafik pertumbuhan
c. Mengidentifikasi penyimpangan sejak dini
d. Memberikan edukasi nutrisi dan pola asuh
e. Melakukan rujukan tepat waktu

Pendekatan ini merupakan bagian dari praktik keperawatan *berbasis evidence-based* dan *family-centered care*(1)

2. Pengertian Perkembangan

Perkembangan (*development*) merupakan proses perubahan fungsi dan kemampuan individu menuju tingkat kematangan yang lebih kompleks. Berbeda dengan pertumbuhan yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur secara fisik, perkembangan bersifat kualitatif, artinya berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan yang tidak selalu dapat diukur dengan alat ukur fisik, tetapi dapat diamati melalui perilaku dan pencapaian tugas perkembangan.

Menurut Hockenberry dan Wilson (2021), perkembangan adalah perubahan progresif dan berkesinambungan dalam fungsi psikologis dan biologis yang terjadi seiring waktu sebagai hasil dari proses maturasi dan pengalaman belajar. Definisi ini menekankan bahwa perkembangan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kematangan sistem saraf (maturasi) dan stimulasi lingkungan.

Kyle dan Carman (2020) mendefinisikan perkembangan sebagai peningkatan kapasitas individu untuk berfungsi secara lebih kompleks dalam aspek motorik, bahasa, kognitif, dan sosial-emosional. Sementara itu, Soetjiningsih (2018) menyatakan bahwa perkembangan adalah proses diferensiasi dan integrasi fungsi tubuh yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan, dimulai sejak konsepsi hingga dewasa. Dengan demikian, perkembangan mencerminkan perubahan kualitas fungsi yang memungkinkan anak melakukan aktivitas yang semakin kompleks sesuai tahap usianya.

Domain Perkembangan Anak (10)

Perkembangan anak secara umum dibagi dalam beberapa domain utama:

a. Perkembangan Motorik Kasar

Perkembangan motorik kasar berkaitan dengan kemampuan menggerakkan otot-otot besar tubuh. Contohnya meliputi:

1) Bayi tengkurap
2) Duduk tanpa bantuan
3) Berdiri dan berjalan
4) Berlari dan melompat

Perkembangan ini mengikuti prinsip cephalocaudal (dari kepala ke kaki) dan proximodistal (dari pusat tubuh ke arah perifer). Artinya, bayi mampu mengontrol kepala terlebih dahulu sebelum mampu mengontrol kaki (Hockenberry & Wilson, 2021).

Contoh urutan perkembangan motorik kasar:

- Bayi belajar tengkurap → duduk → merangkak → berdiri → berjalan.

b. Perkembangan Motorik Halus

Motorik halus melibatkan koordinasi otot-otot kecil, terutama tangan dan jari, serta koordinasi mata dan tangan. Contohnya:

1) Menggenggam benda
2) Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain
3) Mencoret-coret
4) Mengancingkan baju

Perkembangan motorik halus erat kaitannya dengan kematangan sistem saraf pusat dan stimulasi lingkungan.

c. Perkembangan Bahasa

Perkembangan bahasa mencakup kemampuan memahami (reseptif) dan mengekspresikan (ekspresif) komunikasi.

Contohnya:

1) Bayi mengoceh (babbling)
2) Mengucapkan kata pertama
3) Menyusun kalimat sederhana
4) Mengembangkan kemampuan membaca dan menulis

Menurut teori perkembangan bahasa, interaksi dengan lingkungan sangat menentukan kecepatan dan kualitas perkembangan bahasa anak (Kyle & Carman, 2020).

d. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan.

Jean Piaget (1952) menjelaskan perkembangan kognitif dalam empat tahap:

1) Sensori-motor (0–2 tahun)
   Anak belajar melalui pengalaman sensorik dan aktivitas motorik.
2) Praoperasional (2–7 tahun)
   Anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi masih berpikir egosentris.
3) Operasional konkret (7–11 tahun)
   Anak mampu berpikir logis terhadap objek konkret.
4) Operasional formal (≥12 tahun)
   Remaja mulai mampu berpikir abstrak dan hipotetis.

Contoh perkembangan kognitif:

- Anak belajar berbicara → membaca → memahami konsep abstrak.

e. Perkembangan Sosial- Emosional

Perkembangan sosial-emosional berkaitan dengan kemampuan membentuk hubungan, mengelola emosi, dan mengembangkan identitas diri. Erikson (1963) mengemukakan delapan tahap perkembangan psikososial, beberapa di antaranya relevan pada masa anak:

1) Trust vs Mistrust (0–1 tahun)

2) Autonomy vs Shame and Doubt (1–3 tahun)
3) Initiative vs Guilt (3–6 tahun)
4) Industry vs Inferiority (6–12 tahun)
5) Identity vs Role Confusion (remaja)

Keberhasilan pada setiap tahap akan membentuk kepribadian yang sehat di masa depan.

3. Perbedaan Pertumbuhan dan Perkembangan

Dalam ilmu keperawatan anak, istilah *pertumbuhan* dan *perkembangan* sering digunakan secara bersamaan karena keduanya berlangsung simultan sejak masa konsepsi hingga dewasa. Namun, secara konseptual keduanya memiliki makna yang berbeda. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan ini sangat penting bagi perawat agar mampu melakukan pengkajian secara komprehensif dan tidak menyamakan gangguan pertumbuhan dengan gangguan perkembangan. (11)

Menurut Soetjiningsih (2018), pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan anak. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan ukuran fisik, sedangkan perkembangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan fungsi tubuh yang lebih kompleks.

Hockenberry dan Wilson (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan merupakan perubahan fisik yang dapat diukur secara objektif, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kemampuan dan keterampilan yang terjadi akibat maturasi sistem saraf dan pengalaman belajar.

Tabel 2. 1 Perbedaan Pertumbuhan Dan Perkembangan

Aspek	**Pertumbuhan**	**Perkembangan**
Sifat	Kuantitatif	Kualitatif
Ukuran	Fisik	Fungsi
Alat ukur	Timbangan, meteran	Observasi, skrining perkembangan
Contoh	BB naik 2 kg	Anak bisa menyebut warna

C. Prinsip-Prinsip Tumbuh Kembang (12)

Tumbuh kembang anak adalah proses perubahan fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi sepanjang hidup manusia. Untuk memahami proses ini secara utuh, penting mengetahui prinsip-prinsip dasar tumbuh kembang. Prinsip-

prinsip ini membantu orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

1. Berlangsung terus menerus sejak konsepsi hingga dewasa (9)
   Proses tumbuh kembang dimulai sejak konsepsi (pembuahan sel telur oleh sperma) dan berlangsung secara bertahap hingga dewasa. Tidak ada periode di mana tumbuh kembang berhenti sepenuhnya. Misalnya:
   a. Masa prenatal (sebelum lahir): Organ vital terbentuk, otak mulai berkembang, indera mulai berfungsi.
   b. Masa bayi dan balita: Pertumbuhan fisik cepat, kemampuan motorik dasar (merangkak, berjalan) mulai muncul, kemampuan bahasa berkembang.
   c. Masa anak sekolah: Perkembangan kognitif dan sosial semakin kompleks, anak mulai memahami aturan dan bekerja sama.
   d. Masa remaja: Pubertas memicu perubahan fisik dan hormonal yang signifikan, identitas diri mulai terbentuk.
   e. Masa dewasa: Pertumbuhan fisik relatif stabil, tetapi perkembangan psikologis dan sosial tetap berlangsung.
2. Memiliki pola yang teratur (cephalocaudal & proximodistal)
   Tumbuh kembang tidak terjadi secara acak, tetapi mengikuti pola tertentu:
   a. Pola Cephalocaudal (dari kepala ke kaki)
      Perkembangan dimulai dari bagian tubuh yang paling dekat dengan kepala ke bagian yang lebih jauh. Contohnya:
      1) Bayi pertama-tama mengontrol kepala, kemudian leher, bahu, tangan, dan akhirnya kaki.
      2) Kemampuan motorik halus tangan berkembang setelah kontrol motorik kepala dan lengan.
   b. Pola Proximodistal (dari tengah tubuh ke luar)
      Perkembangan bergerak dari bagian tubuh yang lebih dekat dengan pusat tubuh ke bagian yang lebih jauh. Contohnya:
      1) Gerakan lengan berkembang sebelum jari-jari.
      2) Kemampuan duduk dan menyeimbangkan tubuh berkembang sebelum memegang benda kecil dengan jari.
3. Dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan
   Perkembangan anak adalah hasil interaksi antara faktor bawaan (genetik) dan faktor lingkungan.
   a. Faktor genetik: Mewarisi sifat fisik, kemampuan intelektual, dan kecenderungan kesehatan dari orang tua. Misalnya tinggi badan, warna mata, atau kecenderungan alergi.
   b. Faktor lingkungan: Meliputi nutrisi, stimulasi, pendidikan, interaksi sosial, dan kondisi psikologis. Lingkungan yang kaya stimulasi mendukung kemampuan bahasa, kreativitas, dan keterampilan sosial.

4. Setiap anak unik
   Setiap anak memiliki karakteristik, kecepatan, dan gaya tumbuh kembang yang berbeda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh:
   a. Bakat dan minat individual
   b. Temperamen (misalnya pemalu, aktif, atau mudah bergaul)
   c. Respons terhadap stimulasi dan pembelajaran

   Implikasi praktis: Tidak semua anak harus mencapai tonggak perkembangan pada waktu yang sama. Misalnya, ada anak yang berjalan pada usia 10 bulan, ada yang baru pada 15 bulan. Perbedaan ini normal, selama perkembangan secara umum masih sesuai tahapannya.
5. Perkembangan satu aspek memengaruhi aspek lain
   Tumbuh kembang bersifat terintegrasi, artinya perubahan atau keterlambatan pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya. Contohnya:
   a. Keterlambatan motorik (misal tidak bisa duduk atau merangkak) bisa mempengaruhi kemampuan eksplorasi lingkungan, sehingga berdampak pada perkembangan kognitif.
   b. Kemampuan bahasa yang baik membantu perkembangan sosial dan emosional anak.
   c. Kesehatan fisik yang baik mendukung kemampuan belajar dan interaksi sosial.

D. Faktor yang Mempengaruhi Tumbuh Kembang

Tumbuh kembang merupakan proses berkesinambungan yang dialami setiap individu sejak masa konsepsi hingga dewasa. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang dapat diukur, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran organ tubuh. Sementara itu, perkembangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan fungsi tubuh, seperti kemampuan motorik, bahasa, emosi, sosial, dan kognitif. Proses ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Secara umum, faktor yang memengaruhi tumbuh kembang dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal(13)

1. Faktor Internal
   Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan telah ada sejak masa konsepsi. Faktor-faktor ini umumnya bersifat bawaan dan sulit diubah, namun tetap dapat dipengaruhi oleh lingkungan dalam batas tertentu. ((14)
   a. Genetik

      Genetik merupakan faktor utama yang menentukan potensi dasar pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Setiap individu mewarisi sifat-sifat tertentu dari kedua orang tuanya melalui gen. Potensi tinggi badan, warna kulit, bentuk wajah, kecerdasan dasar, hingga risiko penyakit tertentu

ditentukan oleh faktor genetik. Sebagai contoh, anak yang berasal dari orang tua dengan postur tinggi cenderung memiliki potensi tinggi badan yang lebih besar dibandingkan anak dari orang tua bertubuh pendek. Namun, potensi genetik tersebut tetap memerlukan dukungan lingkungan yang baik, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang terjaga, agar dapat berkembang secara optimal.

b. Ras/Etnis

Ras atau etnis juga memengaruhi karakteristik fisik maupun beberapa aspek perkembangan. Perbedaan ras dapat terlihat dari warna kulit, bentuk rambut, struktur wajah, serta kecenderungan tinggi badan. Selain aspek fisik, latar belakang etnis juga sering berkaitan dengan kebiasaan budaya yang secara tidak langsung memengaruhi pola makan, pola asuh, serta stimulasi perkembangan anak.

Perbedaan ini bukan menunjukkan kelebihan atau kekurangan, melainkan variasi alami yang dipengaruhi oleh faktor keturunan dan adaptasi lingkungan selama bertahun-tahun.

c. Jenis Kelamin

Jenis kelamin berperan dalam menentukan pola pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, anak laki-laki dan perempuan memiliki pola pertumbuhan yang berbeda. Misalnya, anak perempuan biasanya mengalami masa pubertas lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Selain itu, terdapat perbedaan dalam perkembangan kemampuan tertentu, seperti kekuatan fisik yang cenderung lebih menonjol pada laki-laki, serta perkembangan bahasa yang pada beberapa kasus lebih cepat pada perempuan.

Perbedaan ini bersifat alami dan dipengaruhi oleh hormon serta faktor biologis lainnya.

d. Kelainan Kongenital

Kelainan kongenital adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir, baik akibat faktor genetik maupun gangguan selama masa kehamilan. Kelainan ini dapat berupa kelainan fisik, gangguan metabolisme, atau gangguan perkembangan organ tertentu.

Contohnya adalah kelainan jantung bawaan, gangguan pendengaran sejak lahir, atau sindrom genetik tertentu yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi ini sering memerlukan penanganan medis dan stimulasi khusus agar anak tetap dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai kemampuannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu dan sangat memengaruhi optimal atau tidaknya potensi yang telah ditentukan oleh faktor internal. Faktor ini umumnya dapat dimodifikasi atau diperbaiki.

a. Nutrisi

Nutrisi merupakan salah satu faktor paling penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Asupan gizi yang cukup dan seimbang sangat dibutuhkan untuk pembentukan jaringan tubuh, perkembangan otak, serta daya tahan tubuh.

Kekurangan nutrisi, terutama pada masa awal kehidupan, dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting (pertumbuhan tinggi badan terhambat), berat badan kurang, atau gangguan perkembangan kognitif. Sebaliknya, kelebihan nutrisi juga dapat menimbulkan masalah seperti obesitas dan gangguan metabolik. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang sesuai usia sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang optimal.

b. Stimulasi

Stimulasi adalah rangsangan yang diberikan kepada anak untuk membantu perkembangan kemampuan motorik, bahasa, sosial, dan kognitif. Stimulasi dapat berupa ajakan berbicara, bermain, membaca buku, bernyanyi, maupun interaksi sosial lainnya.

Kurangnya stimulasi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan, terutama pada aspek bahasa dan sosial. Sebaliknya, stimulasi yang tepat dan konsisten akan membantu anak mengembangkan potensi secara maksimal.

Stimulasi harus disesuaikan dengan tahap usia dan kemampuan anak agar efektif dan tidak menimbulkan tekanan berlebihan.

c. Pola Asuh

Pola asuh orang tua sangat memengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan kepribadian anak. Pola asuh yang penuh kasih sayang, konsisten, dan mendukung akan membentuk rasa percaya diri serta kemandirian anak.

Sebaliknya, pola asuh yang terlalu otoriter, permisif berlebihan, atau kurang perhatian dapat berdampak pada masalah perilaku dan kesulitan dalam penyesuaian sosial. Hubungan yang hangat antara orang tua dan anak menjadi fondasi penting dalam perkembangan mental dan emosional(15).

d. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial mencakup keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat sekitar. Lingkungan yang aman, suportif, dan positif akan mendukung proses belajar serta pembentukan karakter anak.

Sebaliknya, lingkungan yang penuh konflik, kekerasan, atau kurang dukungan dapat menghambat perkembangan dan memicu masalah psikologis. Interaksi sosial yang sehat membantu anak belajar bekerja sama, berempati, dan mengembangkan kemampuan komunikasi.

e. Status Ekonomi

Status ekonomi keluarga berpengaruh terhadap akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal yang layak. Keluarga dengan status ekonomi baik cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Namun, bukan berarti anak dari keluarga dengan status ekonomi rendah tidak dapat berkembang optimal. Dengan pengelolaan yang baik, dukungan sosial, serta pola asuh yang tepat, tumbuh kembang anak tetap dapat berlangsung dengan baik.

E. Tahap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (0–18 Tahun)

Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara bertahap, berurutan, dan berkesinambungan sejak lahir hingga usia 18 tahun. Setiap tahap memiliki karakteristik fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional yang khas. Meskipun terdapat variasi antar individu, secara umum pola perkembangan anak mengikuti urutan yang sama(16)

1. Neonatus (0–28 Hari)

Masa neonatus adalah periode sejak bayi lahir hingga usia 28 hari. Ini merupakan masa adaptasi penting dari kehidupan intrauterin (di dalam rahim) menuju kehidupan ekstrauterin (di luar rahim).

a. Refleks Primitif

Pada masa ini, bayi memiliki refleks bawaan yang disebut refleks primitif. Refleks ini penting untuk kelangsungan hidup dan menunjukkan fungsi sistem saraf yang normal.

Beberapa refleks utama antara lain:

1) Refleks Moro (startle reflex)

Terjadi ketika bayi merasa terkejut (misalnya oleh suara keras). Bayi akan merentangkan kedua tangan dan kaki, kemudian menariknya kembali. Refleks ini biasanya menghilang pada usia 3–4 bulan.

2) Refleks Rooting (mencari puting)

Jika pipi bayi disentuh, ia akan menoleh ke arah sentuhan dan membuka mulut. Refleks ini membantu bayi menemukan puting saat menyusu.

3) Refleks Sucking (mengisap)

Ketika sesuatu menyentuh langit-langit mulutnya, bayi secara otomatis akan mengisap. Refleks ini sangat penting untuk proses menyusu.

Refleks-refleks ini akan menghilang seiring maturasi sistem saraf pusat.

b. Adaptasi Pernapasan dan Sirkulasi (6)

Setelah lahir, bayi harus segera bernapas sendiri. Paru-paru yang sebelumnya berisi cairan mulai terisi udara. Tangisan pertama bayi membantu mengembangkan paru-paru.

Sistem sirkulasi juga mengalami perubahan besar. Saat masih di dalam rahim, aliran darah bayi berbeda karena mendapat oksigen dari plasenta. Setelah lahir, terjadi penyesuaian sehingga darah mengalir ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen secara langsung.

Masa neonatus merupakan periode yang sangat rentan, sehingga memerlukan pengawasan ketat terhadap suhu tubuh, pernapasan, serta kemampuan menyusu.

2. Bayi (1–12 Bulan)

Masa bayi ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sangat pesat serta perkembangan motorik dan sensorik yang signifikan.

Perkembangan Motorik Kasar

a. 3 bulan: Tengkurap

Bayi mulai mampu mengangkat kepala saat tengkurap dan menahan kepala lebih stabil.

b. 6 bulan: Duduk

Bayi mulai dapat duduk dengan bantuan, kemudian duduk tanpa bantuan dalam waktu singkat.

c. 9 bulan: Berdiri

Bayi mulai berdiri dengan berpegangan pada benda di sekitarnya.

d. 12 bulan: Berjalan

Sebagian besar bayi mulai berjalan sendiri atau dengan sedikit bantuan.

Perkembangan ini mengikuti prinsip dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari pusat ke tepi (proximodistal).

Perkembangan Bahasa

Pada awalnya bayi hanya menangis sebagai bentuk komunikasi. Kemudian berkembang menjadi:

a. Mengeluarkan suara seperti “aa”, “ba”
b. Babbling (mengulang suku kata seperti “ma-ma”, “ba-ba”).
c. Sekitar usia 12 bulan mulai mengucapkan 1–2 kata sederhana yang bermakna, seperti “mama” atau “papa”.

Perkembangan Sosial dan Emosional

a. Tersenyum sosial (sekitar 2 bulan)
b. Mengenali orang tua
c. Mulai mengalami kecemasan terhadap orang asing (stranger anxiety)

3. Toddler (1–3 Tahun)

Masa toddler adalah masa eksplorasi aktif. Anak mulai berjalan dan menjelajahi lingkungan sekitarnya.

a. Berjalan Lancar

Pada usia ini, anak sudah dapat berjalan tanpa bantuan, bahkan mulai:

1) Berlari
2) Naik turun tangga
3) Menendang bola

Koordinasi motorik semakin baik.

b. Mulai Toilet Training

Sekitar usia 2–3 tahun, anak mulai menunjukkan kesiapan untuk toilet training, seperti:

1) Menyadari saat ingin buang air
2) Mampu melepas pakaian sendiri
3) Mengikuti instruksi sederhana

Keberhasilan toilet training sangat dipengaruhi oleh kesiapan fisik dan psikologis.

c. Bahasa Berkembang Cepat

Kosakata berkembang pesat. Anak mulai:

1) Menggabungkan dua kata ("mau susu")
2) Mengajukan banyak pertanyaan
3) Meniru kata-kata orang dewasa

d. Egosentris

Anak usia toddler cenderung egosentris, artinya melihat dunia hanya dari sudut pandangnya sendiri. Mereka sulit memahami perspektif orang lain dan sering mengatakan "punyaku" atau "tidak mau".

4. Prasekolah (3–6 Tahun)

Masa ini disebut juga masa bermain. Perkembangan kognitif dan sosial semakin kompleks.

a. Motorik Halus Meningkat

Anak mulai mampu:

1) Menggambar lingkaran dan bentuk sederhana
2) Menggunting
3) Memegang pensil dengan lebih baik
4) Memakai baju sendiri

b. Imajinasi Tinggi
   Anak memiliki daya imajinasi yang kuat. Mereka senang:
   1) Bermain peran (dokter-dokteran, rumah-rumahan)
   2) Berfantasi
   3) Membuat cerita sendiri
   Namun, kadang sulit membedakan antara realitas dan imajinasi.
c. Mulai Bermain Kooperatif
   Jika sebelumnya bermain sendiri (parallel play), kini anak mulai:
   1) Bermain bersama teman
   2) Berbagi mainan
   3) Mengikuti aturan sederhana dalam permainan
   Perkembangan sosial semakin matang.

5. Usia Sekolah (6–12 Tahun)
   Masa usia sekolah ditandai dengan perkembangan kognitif dan sosial yang signifikan.
   a. Berpikir Logis Konkret
      Anak mulai mampu:
      1) Memahami sebab-akibat
      2) Mengelompokkan benda
      3) Menghitung dan memecahkan masalah sederhana
      Namun, pemikirannya masih konkret dan belum abstrak.
   b. Kemandirian Meningkat
      Anak mulai:
      1) Mengerjakan tugas sekolah sendiri
      2) Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah
      3) Mengatur waktu bermain dan belajar
      Rasa percaya diri berkembang melalui pencapaian akademik dan sosial.
   c. Interaksi Sosial Luas
      Lingkup pertemanan semakin luas. Anak mulai:
      1) Memiliki sahabat
      2) Memahami kerja sama tim
      3) Menghargai aturan kelompok
      Pengaruh teman sebaya menjadi semakin besar.
6. Remaja (12–18 Tahun)
   Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, ditandai perubahan fisik, hormonal, dan psikososial yang signifikan.

a. Pubertas
   Terjadi kematangan organ reproduksi.
   Pada perempuan:
   1) Menstruasi pertama (menarche)
   2) Perkembangan payudara
   Pada laki-laki:
   1) Perubahan suara
   2) Pertumbuhan jakun
   3) Mimpi basah
b. Perubahan Hormonal
   Peningkatan hormon estrogen dan testosteron menyebabkan:
   1) Pertumbuhan pesat (growth spurt)
   2) Perubahan emosi yang fluktuatif
   3) Meningkatnya ketertarikan terhadap lawan jenis
c. Pencarian Identitas
   Remaja mulai bertanya:
   1) "Siapa saya?"
   2) "Apa tujuan hidup saya?"
   Mereka mencoba berbagai peran sosial, nilai, dan minat untuk menemukan jati diri.
d. Berpikir Abstrak
   Kemampuan berpikir berkembang menjadi lebih kompleks. Remaja mulai mampu:
   1) Berpikir abstrak
   2) Menganalisis masalah secara kritis
   3) Mempertimbangkan masa depan
   4) Membentuk opini sendiri

Kesimpulan

Tahap pertumbuhan dan perkembangan anak dari usia 0–18 tahun berlangsung secara bertahap dan saling berkaitan.

1. Masa neonatus berfokus pada adaptasi kehidupan.
2. Masa bayi ditandai perkembangan motorik dan bahasa yang pesat.
3. Masa toddler adalah fase eksplorasi dan kemandirian awal.
4. Masa prasekolah dipenuhi imajinasi dan perkembangan sosial.
5. Usia sekolah memperkuat kemampuan logis dan tanggung jawab.
6. Masa remaja adalah periode perubahan besar dan pencarian identitas.

Memahami setiap tahap ini sangat penting bagi orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan agar dapat memberikan stimulasi, dukungan, serta pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak pada setiap fase kehidupannya.

F. Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Deteksi dini tumbuh kembang adalah upaya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala guna mengetahui apakah anak berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan utama deteksi dini adalah menemukan sedini mungkin adanya penyimpangan pertumbuhan maupun keterlambatan perkembangan sehingga dapat segera dilakukan intervensi yang tepat.

Deteksi dini sangat penting karena gangguan tumbuh kembang yang ditemukan lebih awal umumnya memiliki peluang perbaikan yang lebih baik dibandingkan jika ditemukan pada usia yang lebih lanjut. (17)

1. Alat yang Digunakan dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang

   Dalam praktik pelayanan kesehatan, terdapat beberapa alat yang umum digunakan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

   a. KMS (Kartu Menuju Sehat)

      Kartu Menuju Sehat (KMS) adalah kartu yang digunakan untuk memantau pertumbuhan anak, terutama berat badan berdasarkan umur. KMS biasanya digunakan di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

      Fungsi KMS:

      1) Mencatat berat badan anak setiap bulan.
      2) Memantau kenaikan berat badan sesuai kurva pertumbuhan.
      3) Mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan seperti gizi kurang atau gizi buruk.
      4) Menjadi media edukasi bagi orang tua mengenai status gizi anak.

      Pada KMS terdapat grafik pertumbuhan yang menunjukkan apakah berat badan anak berada pada jalur normal (garis hijau) atau mengalami penyimpangan. Jika berat badan tidak naik dalam dua kali penimbangan berturut-turut, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut. (10)

   b. Grafik WHO

      WHO Child Growth Standards adalah standar pertumbuhan anak yang dikembangkan oleh World Health Organization (WHO). Grafik ini digunakan secara internasional untuk menilai pertumbuhan anak usia 0–5 tahun.

      Grafik WHO menilai beberapa parameter, antara lain:

      1) Berat badan menurut umur (BB/U)
      2) Tinggi badan menurut umur (TB/U)
      3) Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

4) Indeks Massa Tubuh menurut umur (IMT/U)
5) Lingkar kepala menurut umur

Dengan grafik WHO, tenaga kesehatan dapat menentukan apakah anak termasuk kategori:

1) Normal
2) Gizi kurang
3) Gizi buruk
4) Stunting (pendek)
5) Overweight atau obesitas

Grafik ini lebih komprehensif karena mempertimbangkan standar pertumbuhan anak sehat dari berbagai negara. (5)

c. Denver Developmental Screening Test (DDST)

Denver Developmental Screening Test (DDST) adalah alat skrining perkembangan untuk anak usia 0–6 tahun. DDST digunakan untuk mendeteksi keterlambatan perkembangan dalam empat aspek utama (18)

Personal-sosial

1) Motorik halus
2) Bahasa
3) Motorik kasar

Contohnya:

1) Apakah anak dapat duduk tanpa bantuan?
2) Apakah anak dapat menyebutkan dua kata bermakna?
3) Apakah anak dapat menggambar garis?

Hasil DDST dikategorikan sebagai:

1) Normal
2) Suspect (dicurigai ada keterlambatan)
3) Untestable

DDST bukan alat diagnosis, melainkan alat skrining. Jika ditemukan hasil yang mencurigakan, anak perlu dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan.

d. KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)

Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) adalah alat skrining perkembangan yang digunakan di Indonesia untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun.

KPSP berbentuk kuesioner yang diisi oleh orang tua atau dilakukan bersama tenaga kesehatan. Pertanyaan disesuaikan dengan kelompok umur anak.

Contoh pertanyaan:

1) Apakah anak dapat berdiri sendiri?
2) Apakah anak dapat menyebutkan nama benda?

3) Apakah anak dapat bermain bersama teman?

Hasil KPSP dibagi menjadi:

1) Sesuai (perkembangan normal)
2) Meragukan (perlu pemantauan ulang)
3) Penyimpangan (perlu rujukan)

KPSP sangat praktis dan mudah digunakan di pelayanan primer.

2. Peran Perawat dalam Deteksi Dini Tumbuh Kembang

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya deteksi dini tumbuh kembang, terutama di pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas, posyandu, klinik, dan rumah sakit. (19)

a. Monitoring Rutin

Perawat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala, meliputi:

1) Penimbangan berat badan
2) Pengukuran tinggi badan
3) Pengukuran lingkar kepala
4) Pengisian grafik pertumbuhan
5) Observasi kemampuan perkembangan sesuai usia

Monitoring rutin memungkinkan perawat mendeteksi penyimpangan sejak dini sebelum menjadi masalah yang lebih serius.

b. Edukasi Orang Tua

Perawat berperan sebagai edukator bagi orang tua mengenai:

1) Pentingnya gizi seimbang
2) Pentingnya imunisasi
3) Cara memberikan stimulasi sesuai usia
4) Tanda-tanda keterlambatan perkembangan
5) Jadwal pemeriksaan rutin

Edukasi ini penting karena orang tua adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan anak dan menjadi pengamat utama perkembangan anak sehari-hari.

c. Identifikasi Red Flag (Tanda Bahaya Perkembangan)

Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda keterlambatan perkembangan (red flag), seperti:

1) Tidak dapat mengangkat kepala pada usia 3 bulan
2) Tidak bisa duduk pada usia 9 bulan
3) Tidak bisa berdiri pada usia 12 bulan
4) Belum berjalan pada usia 18 bulan
5) Belum bisa mengucapkan kata bermakna pada usia 2 tahun

6) Kehilangan kemampuan yang sebelumnya sudah dimiliki (regresi perkembangan)

Jika ditemukan tanda bahaya tersebut, diperlukan evaluasi lebih lanjut. (15)

d. Rujukan Bila Perlu

Apabila hasil skrining menunjukkan adanya keterlambatan atau penyimpangan, perawat harus:

1) Mendokumentasikan hasil pemeriksaan
2) Memberikan penjelasan kepada orang tua
3) Melakukan rujukan ke dokter anak, klinik tumbuh kembang, atau spesialis terkait (misalnya fisioterapi, terapi wicara, psikolog)

Rujukan yang cepat dan tepat dapat mencegah gangguan menjadi lebih berat.

Kesimpulan

Deteksi dini tumbuh kembang merupakan langkah penting dalam menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Penggunaan alat seperti KMS, Grafik WHO, DDST, dan KPSP membantu tenaga kesehatan dalam melakukan skrining secara sistematis.

Perawat memiliki peran strategis dalam monitoring rutin, edukasi orang tua, identifikasi tanda bahaya, serta melakukan rujukan bila diperlukan. Dengan deteksi dini yang baik, gangguan pertumbuhan dan perkembangan dapat segera ditangani sehingga kualitas hidup anak di masa depan dapat terjaga dengan optimal.

G. Peran Perawat dalam Tumbuh Kembang Anak

Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak lahir hingga remaja. Dalam praktik keperawatan anak, perawat tidak hanya berfokus pada kondisi sakit, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya.

Peran perawat dalam tumbuh kembang anak bersifat holistik, artinya mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Berikut adalah peran-peran utama perawat dalam mendukung tumbuh kembang anak: (11)

1. Caregiver (Pemberi Asuhan)

   Sebagai caregiver, perawat memberikan asuhan langsung kepada anak sekaligus melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala.

   a. Pemantauan Pertumbuhan

      Perawat bertanggung jawab untuk memantau parameter pertumbuhan seperti:

      1) Berat badan (BB)

2) Tinggi badan (TB)
3) Lingkar kepala
4) Indeks massa tubuh (IMT)

Data tersebut kemudian dicatat dalam kurva pertumbuhan seperti Kartu Menuju Sehat atau grafik standar dari World Health Organization.

Melalui pemantauan ini, perawat dapat mendeteksi:

1) Gizi kurang
2) Stunting
3) Obesitas
4) Gangguan pertumbuhan lainnya

b. Pemantauan Milestone Perkembangan

Selain pertumbuhan fisik, perawat juga memantau milestone (tahapan perkembangan) seperti:

1) Kemampuan duduk, berdiri, berjalan
2) Perkembangan bahasa
3) Interaksi sosial
4) Respons emosional

Jika ditemukan keterlambatan, perawat dapat segera melakukan intervensi awal atau merujuk ke tenaga kesehatan lain.

Sebagai caregiver, perawat juga memberikan perawatan saat anak sakit, memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

2. Educator (Pendidik)

Perawat berperan sebagai educator dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua dan keluarga.

a. Edukasi Stimulasi Sesuai Usia

Perawat mengajarkan cara memberikan stimulasi perkembangan sesuai tahap usia anak, misalnya:

1) Bayi: tummy time, mengajak berbicara, kontak mata
2) Toddler: bermain menyusun balok, membaca buku cerita
3) Prasekolah: menggambar, bermain peran
4) Usia sekolah: diskusi, latihan tanggung jawab
5) Remaja: edukasi kesehatan reproduksi dan manajemen emosi

Stimulasi yang tepat membantu mengoptimalkan potensi perkembangan anak.

b. Edukasi Nutrisi dan Pola Asuh
   Perawat juga memberikan informasi tentang:
   1) ASI eksklusif
   2) MP-ASI yang tepat
   3) Gizi seimbang
   4) Pola asuh positif
   5) Pentingnya imunisasi dan pemeriksaan rutin

   Edukasi ini membantu orang tua memahami kebutuhan anak secara menyeluruh.

3. Advocate (Advokat)
   Sebagai advocate, perawat bertindak untuk melindungi dan memperjuangkan hak anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.
   a. Mendorong Skrining Rutin
      Perawat menganjurkan orang tua untuk:
      1) Melakukan pemeriksaan rutin di posyandu atau puskesmas
      2) Mengikuti skrining perkembangan
      3) Mematuhi jadwal imunisasi

      Jika orang tua kurang memahami pentingnya skrining, perawat memberikan penjelasan mengenai manfaat deteksi dini.
   b. Membela Kepentingan Anak
      Dalam kondisi tertentu, perawat dapat:
      1) Mengingatkan orang tua tentang pentingnya terapi lanjutan
      2) Mengupayakan rujukan bila ditemukan gangguan perkembangan
      3) Mengadvokasi anak dengan kebutuhan khusus agar mendapatkan layanan yang sesuai

      Perawat memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

4. Collaborator (Kolaborator)
   Tumbuh kembang anak tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Oleh karena itu, perawat harus bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan, seperti:
   a. Dokter anak
   b. Bidan
   c. Ahli gizi
   d. Fisioterapis
   e. Terapis wicara
   f. Psikolog

Sebagai collaborator, perawat:

a. Melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
b. Berpartisipasi dalam perencanaan intervensi
c. Mengikuti tindak lanjut terapi

Kolaborasi ini penting terutama pada anak dengan keterlambatan perkembangan, gangguan nutrisi, atau kondisi medis kronis.

5. Counselor (Konselor)

Ketika ditemukan keterlambatan perkembangan atau gangguan pertumbuhan, orang tua sering merasa cemas, sedih, bahkan menyalahkan diri sendiri. Di sinilah peran perawat sebagai counselor menjadi sangat penting.

a. Memberikan Dukungan Emosional
   Perawat membantu orang tua:
   1) Memahami kondisi anak secara objektif
   2) Mengurangi rasa bersalah
   3) Tetap optimis dan fokus pada Solusi
b. Memberikan Informasi yang Jelas
   Perawat menjelaskan:
   1) Kondisi anak dengan bahasa sederhana
   2) Langkah yang perlu dilakukan
   3) Pentingnya terapi dan intervensi dini

   Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi sangat penting dalam proses konseling.

Pendekatan Utama: Family-Centered Care

Pendekatan utama dalam keperawatan anak adalah *Family-Centered Care (FCC). Family-Centered Care* adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari perawatan anak. Anak tidak dipandang sebagai individu terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem keluarga. (1)

Prinsip Family-Centered Care:

1. Menghargai peran keluarga dalam kehidupan anak.
2. Melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan.
3. Memberikan informasi yang transparan dan jujur.
4. Menghormati nilai, budaya, dan kepercayaan keluarga.
5. Membangun kemitraan antara tenaga kesehatan dan keluarga.

Dalam pendekatan ini:

a. Orang tua dianggap sebagai mitra, bukan hanya penerima informasi.
b. Perawat mendengarkan kekhawatiran keluarga.
c. Keputusan perawatan dibuat bersama.

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan keluarga, mempercepat pemulihan, serta mendukung perkembangan anak secara optimal.

Kesimpulan

Peran perawat dalam tumbuh kembang anak sangat luas dan kompleks. Perawat bertindak sebagai:

a. Caregiver yang memantau pertumbuhan dan milestone perkembangan.
b. Educator yang memberikan edukasi stimulasi dan kesehatan.
c. Advocate yang memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan layanan terbaik.
d. Collaborator yang bekerja sama dengan berbagai tenaga kesehatan.
e. Counselor yang mendampingi orang tua secara emosional.

Dengan menerapkan pendekatan *Family-Centered Care*, perawat mampu memberikan asuhan yang holistik, komprehensif, dan berfokus pada kebutuhan anak serta keluarganya. Peran ini sangat penting dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya.**Aktivitas Belajar Terstruktur**

Aktivitas belajar terstruktur merupakan metode pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu mahasiswa memahami konsep tumbuh kembang anak secara teoritis maupun praktis. Melalui aktivitas ini, mahasiswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga mengasah kemampuan analisis, komunikasi, serta keterampilan klinis yang akan dibutuhkan dalam praktik keperawatan anak.

Aktivitas belajar terstruktur biasanya melibatkan diskusi, studi kasus, simulasi, dan role play agar mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan situasi nyata di lapangan.

AKTIVITAS 1 – *KNOWS HOW*

KASUS ;

Seorang ibu membawa anaknya, Ananda R, laki-laki usia **3 tahun**, ke posyandu karena khawatir dengan perkembangan anaknya. Ibu mengatakan bahwa berat badan anaknya terlihat lebih kecil dibandingkan teman seusianya.

Hasil pemeriksaan didapatkan:

- Berat badan: **11 kg**
- Tinggi badan**: 88 cm**
- Lingkar kepala: **48 cm**

Menurut ibunya, anak tersebut:

- Sudah bisa berjalan sejak usia **18 bulan**
- Saat ini dapat **berlari dan naik tangga dengan bantuan**
- Mengucapkan sekitar **10–15 kata,** tetapi belum bisa menyusun kalimat sederhana
- Sering bermain sendiri dan jarang berinteraksi dengan anak lain
- Riwayat kehamilan dan persalinan normal.
- Anak mendapat imunisasi dasar lengkap.
- Pola makan anak cenderung pilih-pilih makanan dan lebih sering mengonsumsi susu.

Petugas kesehatan kemudian melakukan penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mengetahui apakah kondisi anak masih dalam batas normal atau terdapat keterlambatan perkembangan.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi Kelompok

1. Identifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada anak.
2. Bagaimana interpretasi status pertumbuhan anak tersebut?
3. Identifikasi kemampuan motorik anak sesuai dengan tahapan perkembangan usia 3 tahun.
4. Tentukan penilaian perkembangan bahasa dan sosial anak pada kasus tersebut?
5. Identifikasi Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini?
6. Jelaskan tindakan atau intervensi yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau orang tua pada kasus tersebut?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

AKTIVITAS 2 — *SHOWS HOW*

1. Deskripsi Aktivitas

   Kegiatan ini bertujuan melatih mahasiswa untuk menunjukkan keterampilan (shows how) dalam melakukan penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak melalui simulasi di skill laboratory. Mahasiswa melakukan pengukuran parameter pertumbuhan, melakukan skrining perkembangan sesuai usia anak, serta melakukan komunikasi edukatif kepada orang tua dengan memperhatikan prinsip keselamatan dan kenyamanan anak. Aktivitas ini merupakan tahap latihan keterampilan sebelum mahasiswa mengikuti penilaian keterampilan klinik.

2. Capaian Pembelajaran

   Setelah mengikuti aktivitas ini mahasiswa mampu:

   a. Melakukan pengukuran pertumbuhan anak (berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala) secara benar.
   b. Melakukan skrining perkembangan anak sesuai usia.
   c. Melakukan komunikasi efektif dengan orang tua terkait hasil pemeriksaan.
   d. Menerapkan prinsip keselamatan dan kenyamanan anak selama pemeriksaan

3. Metode Pembelajaran

   Simulasi / Skill lab melalui:

   a. Demonstrasi oleh instruktur
   b. Latihan praktik mahasiswa secara berkelompok
   c. Role play antara mahasiswa sebagai petugas kesehatan dan orang tua anak

4. Skenario Simulasi

   Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 3 tahun ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan rutin pertumbuhan dan perkembangan. Mahasiswa berperan sebagai petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan skrining perkembangan anak serta memberikan edukasi kepada orang tua.

5. Alat dan Bahan

   a. Timbangan berat badan anak
   b. Alat ukur tinggi badan (stadiometer/microtoise)
   c. Pita ukur lingkar kepala
   d. Kartu Menuju Sehat (KMS) atau grafik pertumbuhan
   e. Form skrining perkembangan anak
   f. Alat tulis

6. Prosedur Simulasi

No	Tahapan	Kegiatan
1	Persiapan	1. Mencuci tangan sesuai prosedur. 2. Menyiapkan alat pemeriksaan. 3. Memastikan alat berfungsi dengan baik dan aman digunakan.
2	Komunikasi Awal	1. Menyapa ibu dan anak dengan ramah. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menjelaskan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan
3	Identifikasi Anak	1. Menanyakan identitas anak (nama dan usia). 2. Mengonfirmasi data dengan orang tua.
4	Pengukuran Pertumbuhan	1. Mengukur berat badan anak menggunakan timbangan. 2. Mengukur tinggi badan anak dengan posisi berdiri tegak. 3. Mengukur lingkar kepala menggunakan pita ukur. 4. Mencatat hasil pengukuran.
5	Skrining Perkembangan	Mahasiswa menanyakan kemampuan anak sesuai usia, seperti: 1. kemampuan motorik kasar 2. kemampuan bahasa 3. interaksi sosial anak
6	Pencatatan Hasil	Mahasiswa mencatat hasil pemeriksaan pada **KMS atau grafik pertumbuhan anak.**
7	Edukasi kepada Orang Tua	Mahasiswa memberikan edukasi mengenai: 1. pentingnya gizi seimbang 2. stimulasi perkembangan anak 3. pemantauan pertumbuhan secara berkala
8	Penutup	1. Menyampaikan hasil pemeriksaan secara singkat. 2. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk bertanya. 3. Mengucapkan terima kasih dan melakukan cuci tangan kembali.
9	Aspek Keselamatan	Mahasiswa harus memperhatikan: 1. Kebersihan Tangan Sebelum Dan Sesudah Pemeriksaan 2. Penggunaan Alat Yang Aman Dan Bersih 3. Menjaga Kenyamanan Anak Selama Pemeriksaan 4. menghindari tindakan yang dapat menyebabkan cedera pada anak
10	Refleksi Pembelajaran	Mahasiswa mendiskusikan hasil simulasi bersama dosen atau instruktur untuk mengidentifikasi: 1. kesesuaian urutan tindakan

		2. efektivitas komunikasi dengan orang tua 3. aspek keselamatan yang telah diterapkan

SOAL OSCE

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Pemeriksaan Pertumbuhan dan Skrining Perkembangan Anak (0–18 Tahun)
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian pertumbuhan dan perkembangan anak, interpretasi data antropometri, skrining perkembangan sesuai usia, penentuan status pertumbuhan & perkembangan, serta edukasi kepada orang tua.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian dan pemeriksaan fisik 3. Analisis dan interpretasi data 4. Perencanaan asuhan 5. Implementasi edukasi & konseling 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Pertumbuhan & gizi 2. Perkembangan anak 3. Komunikasi dan edukasi keluarga 4. Keselamatan dan kenyamanan 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa oleh ibu ke poliklinik. Ibu menyatakan anak makan sedikit, jarang minum susu, tampak malas bergerak, belum bisa mengucapkan beberapa kata sederhana sesuai usia, dan belum bisa berdiri sendiri dengan mantap. Riwayat imunisasi lengkap, lahir cukup bulan, BB lahir 3 kg. Hasil pengukuran: BB 9 kg, TB 81 cm, LK 45 cm, LILA 13 cm.

		TUGAS: 1..Lakukan pengkajian pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai usia. 2. Ukur dan interpretasikan BB, TB/PB, LK, LILA sesuai standar. 3. Plot hasil ke kurva pertumbuhan WHO/CDC. 4. Tentukan status pertumbuhan dan perkembangan (normal / deviasi / stunting / gizi kurang / keterlambatan perkembangan). 5. Edukasi orang tua terkait status pertumbuhan, stimulasi perkembangan, dan nutrisi.
8	Instruksi untuk penguji	**SKENARIO KLINIK:** Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa oleh ibu ke poliklinik. Ibu menyatakan anak makan sedikit, jarang minum susu, tampak malas bergerak, belum bisa mengucapkan beberapa kata sederhana sesuai usia, dan belum bisa berdiri sendiri dengan mantap. Riwayat imunisasi lengkap, lahir cukup bulan, BB lahir 3 kg. Hasil pengukuran: BB 9 kg, TB 81 cm, LK 45 cm, LILA 13 cm. **INSTRUKSI PENGUJI:** 1. Menilai ketepatan pengkajian riwayat nutrisi, imunisasi, milestone perkembangan, dan tanda masalah gizi. 2. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengukuran antropometri sesuai standar dan membaca hasil kurva pertumbuhan. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menentukan status pertumbuhan & perkembangan. 4. Menilai kemampuan peserta dalam memberikan edukasi nutrisi dan stimulasi perkembangan kepada orang tua.

		5. Menilai perilaku profesional peserta: komunikasi, sikap aman, teliti, empatik. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi selain instruksi yang diberikan.
9	Instruksi untuk klien standar (KS)	1. Anak berusia 2 tahun, laki-laki. KS berperan sebagai ibu. 2. Riwayat penyakit sekarang: makan sedikit, minum susu jarang, malas bergerak. 3. Riwayat imunisasi lengkap, lahir cukup bulan, BB lahir 3 kg. 4. Perilaku anak: rewel, sulit digendong, belum nyaman di lingkungan klinik. 5. Bila peserta menanyakan kemampuan bicara atau motorik, jawaban KS sesuai milestone tertunda (belum bicara beberapa kata, belum berdiri mantap). 6. 6. KS duduk di samping kursi anak/manekin dengan ekspresi cemas.
10	Setting station	Ruang Poliklinik/Skill Lab: 1. Meja pemeriksaan 2. Manekin anak 3. KS berperan sebagai orang tua 4. Penguji 5. Laboran 6. Troli alat
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Timbangan anak 2. Stadiometer / pengukur tinggi badan 3. Pita pengukur lingkar kepala dan lengan atas 4. Kurva pertumbuhan WHO / CDC 5. Alat tulis dan lembar jawaban peserta 6. Handrub / sabun cuci tangan 7. Gelas ukur untuk contoh makanan / minum 8. Troli alat **Peran laboran:**

		merapikan alat setelah peserta selesai, memastikan kesiapan alat untuk peserta berikutnya.
12	Penulis	Dr, Ethyca Sari S.Kep.Ns.M.Kes STIKES William Booth
13	Referensi	1. Tim Pokja SPO Keperawatan DPP PPNI (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI. 2. Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. 3. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. 4. WHO (2006). Child Growth Standards.

SOP PEMERIKSAAN PERTUMBUHAN DAN SKRINING PERKEMBANGAN ANAK USIA 0-18 TAHUN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Mengecek rekam medis dan catatan keperawatan anak (riwayat pertumbuhan, imunisasi, penyakit)				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: 1. Timbangan bayi/anak 2.Alat ukur panjang badan/tinggi badan (infantometer/microtoise) 3. Pita ukur lingkar kepala dan lengan 4. Grafik pertumbuhan (KMS/WHO growth chart) 5. Formulir skrining perkembangan (misal KPSP) 6 .Alat tulis 7. Mainan sesuai usia untuk stimulasi/observasi 7. Handrub/sabun cuci tangan				
3	Mencuci tangan				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran petugas				
6	Mengecek identitas anak (nama, tanggal lahir/umur)				
7	Menjelaskan tujuan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan				
8	Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				

9	Memberi kesempatan orang tua bertanya				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta orang tua				
C	**Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)**				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menimbang berat badan anak sesuai prosedur				
13	Mengukur panjang badan/tinggi badan sesuai usia				
14	Mengukur lingkar kepala (terutama usia <5 tahun)				
15	Mengukur lingkar lengan atas (bila diperlukan)				
16	Memplot hasil pengukuran pada grafik pertumbuhan (BB/U, TB/U, BB/TB, IMT/U)				
17	Menilai status gizi dan pertumbuhan anak				
18	Melakukan skrining perkembangan menggunakan alat (misal KPSP) sesuai usia				
19	Mengobservasi kemampuan perkembangan (motorik kasar, halus, bahasa, sosial)				
20	Menanyakan riwayat perkembangan dan stimulasi di rumah				
21	Mengidentifikasi adanya keterlambatan atau penyimpangan perkembangan				
22	Memberikan stimulasi sederhana sesuai usia anak				
23	Menjelaskan hasil pemeriksaan pertumbuhan kepada orang tua				
24	Menjelaskan hasil skrining perkembangan anak				
25	Memberikan edukasi tentang stimulasi tumbuh kembang sesuai usia				
26	Menjelaskan tanda bahaya keterlambatan perkembangan yang perlu diwaspadai				

27	Memberikan rencana tindak lanjut (kontrol ulang/rujukan bila perlu)				
28	Merapikan alat dan melakukan kebersihan tangan				
D	**Tahap Terminasi**				
29	Menyimpulkan hasil kegiatan				
30	Mengevaluasi pemahaman orang tua				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak kunjungan berikutnya				
33	Mengakhiri interaksi dengan baik				
E	**Tahap Dokumentasi**				
34	Mencatat hasil pengukuran, interpretasi pertumbuhan, hasil skrining perkembangan, edukasi, dan rencana tindak lanjut				
F	**Penampilan Profesional**				
35	Berpenampilan Bersih, rapi dan sopan				
36	Berkomunikasi efektif, empatik, dan ramah anak				
37	Menjaga keselamatan dan kenyamanan anak				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: PEMERIKSAAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Anamnesis dan komunikasi dengan orang tua/pengasuh	Menanyakan identitas, riwayat kehamilan/kelahiran, pola makan, imunisasi, riwayat tumbuh kembang, keluhan orang tua					1	
2	Pemeriksaan fisik dan antropometri	Mengukur BB, TB/PB, LK, LILA dengan alat sesuai usia dan standar SPO					2	
3	Penilaian tumbuh kembang	Memasukkan hasil ke kurva pertumbuhan (WHO/CDC) dan menafsirkan hasil					4	
4	Interpretasi hasil pemeriksaan	Menilai motorik halus, kasar, bahasa, sosial, sesuai usia dan Menentukan status pertumbuhan & perkembangan (normal / deviasi / stunting / gizi kurang)					2	
5	EdukasI dan tatalaksana awal	Menjelaskan hasil, memberi saran nutrisi, stimulasi, dan rujukan bila perlu					1	

6	Perilaku profesional dan etika	Kesopanan, penampilan, dan etika profesi					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PEMERIKSAAN PERTUMBUHAN DAN
ANAK USIA 0-18 TAHUN

I.RUBRIK

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Anamnesis dan komunikasi dengan orang tua/pengasuh **:** Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan anamnesis secara sistematis dan komunikasi terapeutik dengan orang tua/pengasuh, meliputi identitas anak, riwayat kehamilan dan kelahiran, pola makan, riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, serta keluhan utama					1	
2. Pemeriksaan fisik dan antropometri : Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengukuran antropometri meliputi berat badan (BB), tinggi/panjang badan (TB/PB), lingkar kepala (LK), dan lingkar lengan atas (LILA) dengan teknik yang benar sesuai usia dan standar prosedur operasional (SPO)					2	
3. Penilaian tumbuh kembang : Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam memplot hasil pengukuran ke dalam kurva					3	

pertumbuhan (WHO/CDC) dan melakukan skrining perkembangan sesuai usia menggunakan alat yang sesuai (misalnya KPSP).						
4. Interpretasi hasil pemeriksaan : Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menilai hasil pemeriksaan meliputi perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan sosial, serta menentukan status pertumbuhan dan perkembangan (normal, deviasi, stunting, gizi kurang, atau gangguan perkembangan).					2	
5. Edukasi dan tatalaksana awal : Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menjelaskan hasil pemeriksaan kepada orang tua, memberikan edukasi terkait nutrisi, stimulasi tumbuh kembang sesuai usia, serta menyarankan tindak lanjut atau rujukan bila diperlukan.					1	
6. Perilaku profesional dan etika : Aspek ini menilai sikap profesional peserta selama tindakan, meliputi kesopanan, komunikasi terapeutik, empati, menjaga privasi, serta penampilan dan etika profesi.					1	
Jumlah					10	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1.Anamnesis dan komunikasi dengan orang tua/pengasuh	Tidak melakukan anamnesis atau tidak relevan dengan pemeriksaan tumbuh kembang.	Anamnesis sangat terbatas, hanya menanyakan sebagian kecil data, tidak sistematis, dan komunikasi	Anamnesis cukup lengkap meliputi sebagian besar aspek penting, namun masih ada data yang terlewat atau komunikasi kurang optimal.	Anamnesis lengkap, sistematis, dan relevan meliputi identitas, riwayat kehamilan/kelahiran, nutrisi, imunisasi, tumbuh kembang, dan keluhan, serta komunikasi terapeutik baik

		kurang efektif.		
2. Pemeriksaan fisik dan antropometri	Tidak melakukan pemeriksaan atau teknik salah dan berisiko.	Melakukan pemeriksaan tetapi banyak kesalahan teknik atau alat tidak sesuai usia	Melakukan pemeriksaan cukup baik, sebagian besar teknik benar, namun masih ada kekurangan kecil.	Melakukan pengukuran BB, TB/PB, LK, dan LILA dengan teknik yang benar, alat sesuai usia, sistematis, dan akurat.
3. Penilaian tumbuh kembang	Tidak melakukan plotting atau skrining perkembangan.	Melakukan plotting atau skrining tetapi tidak tepat atau tidak lengkap.	Melakukan plotting dan skrining cukup baik, namun masih ada kesalahan interpretasi atau langkah kurang lengkap.	Melakukan plotting pada kurva pertumbuhan dengan tepat dan melakukan skrining perkembangan sesuai usia secara lengkap dan sistematis.
4. Interpretasi hasil pemeriksaan	Tidak mampu menginterpretasikan hasil atau salah total.	Interpretasi kurang tepat dan tidak sesuai dengan data.	Interpretasi cukup tepat namun belum lengkap atau kurang spesifik	Interpretasi tepat dan lengkap meliputi status pertumbuhan (normal/stunting/gizi kurang/lebih) dan perkembangan (sesuai/deviasi).
5. Edukasi dan tatalaksana awal	Tidak memberikan edukasi atau edukasi tidak sesuai.	Edukasi sangat terbatas dan tidak	Edukasi cukup sesuai namun kurang lengkap atau kurang spesifik.	Edukasi jelas, lengkap, dan sesuai meliputi hasil pemeriksaan, nutrisi, stimulasi perkembangan, dan rencana tindak lanjut/rujukan.
6. Perilaku profesional dan etika	Tidak menunjukkan sikap profesional, komunikasi buruk, tidak menjaga privasi.	Sikap profesional kurang, komunikasi terbatas, kurang empati.	Sikap profesional cukup baik, komunikasi jelas, namun masih ada kekurangan kecil.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten: sopan, empatik, komunikatif, menjaga privasi, dan beretika.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOES /DOPS (Direct Observation of Procedural Skills)
Deskripsi Umum DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada tindakan pemeriksaan pertumbuhan dan skrining perkembangan anak
2. Menggunakan checklist + umpan balik singkat
3. Keputusan akhir: Kompeten / Perlu Supervisi / Remedial

Catatan:

1. Simulasi (OSCE) → praktik nyata (klinik)
2. Menilai bukti performa sesungguhnya (level DOES dalam OBE)

Penerapan DOES /DOPS

K**omponen**	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Tumbuh Kembang Anak**
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata di lahan praktik.	Pembimbing klinik mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan pengukuran antropometri dan skrining perkembangan pada anak di poli anak/posyandu/ruang rawat.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur pemeriksaan pertumbuhan dan skrining perkembangan secara benar, sistematis, aman, serta mampu menginterpretasikan dan mengkomunikasikan hasil kepada orang tua.	Mahasiswa dinilai tidak hanya mampu mengukur BB dan TB, tetapi juga mampu menafsirkan kurva pertumbuhan, melakukan skrining perkembangan, dan memberikan edukasi kepada orang tua.
Kasus klinik	Kasus diambil dari kondisi nyata anak di lahan praktik sesuai kompetensi yang harus dicapai.	Seorang anak usia 2 tahun datang ke posyandu untuk pemantauan rutin. Orang tua mengeluhkan anak belum bisa menyusun 2 kata dan tampak lebih kecil dibanding teman seusianya.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan prosedur secara utuh mulai dari persiapan, interaksi dengan pasien, pemeriksaan, hingga edukasi dan penutupan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan anamnesis singkat, mengukur BB, TB, dan LK, memplot hasil pada grafik, melakukan skrining

		perkembangan (misalnya KPSP), menjelaskan hasil, serta memberikan saran stimulasi.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis, penalaran klinik, komunikasi, dan profesionalisme dalam tindakan prosedural.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam teknik pengukuran yang benar, ketepatan plotting grafik, kemampuan mengidentifikasi keterlambatan perkembangan, serta komunikasi dengan orang tua.
Fokus observasi pembimbing	Menilai ketepatan langkah prosedur, keselamatan pasien, serta integrasi antara keterampilan teknis dan komunikasi klinik.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa menggunakan alat dengan benar, membaca kurva pertumbuhan secara tepat, serta mampu menjelaskan hasil dengan bahasa yang mudah dipahami.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat singkat, spesifik, dan konstruktif untuk perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa teknik pengukuran sudah baik, namun mahasiswa perlu meningkatkan ketepatan interpretasi grafik dan memperjelas edukasi stimulasi perkembangan.
Keputusan penilaian	Menentukan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan performa langsung di lapangan.	Kompeten: mampu melakukan pemeriksaan secara lengkap, tepat, dan komunikatif

PORTOFOLIO

Bukti yang dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat
3. Refleksi patient safety
4. Feedback CI/dosen

Tabel 2. 2 Portofolio pada Pemeriksaan Pertumbuhan Dan Perkembangan Usia Anak 0-18 tahun

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Tumbuh Kembang Anak
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pengukuran antropometri, skrining perkembangan, interpretasi hasil, edukasi, serta meningkatkan performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan pemeriksaan tumbuh kembang, tetapi juga menunjukkan perkembangan kemampuannya dalam melakukan pengukuran, interpretasi, dan edukasi setelah mendapatkan masukan dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan pengukuran antropometri dan skrining perkembangan, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pemeriksaan pada anak di posyandu, poli anak, atau ruang rawat.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, meliputi data penting, hasil	Mahasiswa menuliskan kasus anak usia 2 tahun dengan berat badan di bawah kurva normal dan keterlambatan bicara,

	pemeriksaan, interpretasi, intervensi, dan evaluasi.	termasuk hasil pengukuran BB/TB/LK, hasil skrining perkembangan, interpretasi (gizi kurang dan perkembangan meragukan), edukasi nutrisi dan stimulasi, serta rencana tindak lanjut.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan merencanakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya akurasi pengukuran antropometri, penggunaan alat sesuai standar, ketepatan plotting grafik, serta komunikasi yang jelas agar orang tua memahami kondisi anak dan tidak terjadi kesalahan persepsi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam teknik pengukuran dan komunikasi dengan orang tua, namun perlu meningkatkan ketepatan interpretasi kurva pertumbuhan dan skrining perkembangan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan dengan penekanan pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman pemeriksaan tumbuh kembang, sehingga terlihat konsistensi dalam melakukan pengukuran, skrining, interpretasi, dan edukasi secara benar.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback, terlihat mahasiswa konsisten mampu melakukan pemeriksaan antropometri, membaca kurva pertumbuhan, dan memberikan edukasi stimulasi perkembangan.

Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio menjadi bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dipahami secara teori, tetapi ditunjukkan dalam performa nyata yang berulang dan berkembang.	Pada pemeriksaan tumbuh kembang, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten, tepat, dan profesional dalam praktik klinik.

Tabel 2. 3 Case Report Pemeriksaan Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia 0-18 tahun.

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Tumbuh Kembang Anak**
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang anak usia 2 tahun yang datang untuk pemantauan tumbuh kembang dengan keluhan belum bisa berbicara dua kata dan berat badan tampak kurang dibanding usia.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, analisis masalah, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa tidak hanya mencatat hasil pengukuran, tetapi juga menjelaskan status pertumbuhan, hasil skrining perkembangan, masalah yang ditemukan, intervensi, dan perkembangan anak setelah edukasi.
Isi laporan	Isi case report meliputi identitas pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, hasil pemeriksaan antropometri, hasil skrining perkembangan,	Mahasiswa menuliskan BB di bawah standar, TB sesuai usia, hasil kurva menunjukkan gizi kurang, hasil skrining perkembangan meragukan pada aspek bahasa,

	analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran.	diagnosis ketidakseimbangan nutrisi dan keterlambatan perkembangan, intervensi edukasi nutrisi dan stimulasi, serta evaluasi tindak lanjut.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, akurasi pengukuran, ketepatan interpretasi kurva pertumbuhan dan perkembangan, logika penalaran klinik, serta kesesuaian intervensi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data antropometri dengan status gizi, mengenali keterlambatan perkembangan, serta memberikan intervensi edukasi yang tepat.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan refleksi praktik berbasis kasus nyata.	Mahasiswa belajar pentingnya ketepatan pengukuran, interpretasi grafik pertumbuhan, deteksi dini keterlambatan perkembangan, dan edukasi orang tua sebagai bagian utama asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis, logis, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh dan aplikatif di lahan praktik.

Tabel 2. 4 Refleksi Patient Safety pada Pemeriksaan Pertumbuhan Dan Perkembangan anak usia 0-18 tahun

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Tumbuh Kembang Anak**
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Pada pemeriksaan tumbuh kembang, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan dalam pengukuran antropometri atau interpretasi kurva pertumbuhan dapat

	masalah, serta merencanakan tindakan pencegahan dalam praktik klinik.	menyebabkan salah diagnosis status gizi atau keterlambatan deteksi gangguan perkembangan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari setiap tindakan keperawatan, termasuk tindakan pemeriksaan dasar.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil seperti teknik pengukuran yang tidak tepat atau salah membaca grafik dapat berdampak pada keputusan klinik dan tindak lanjut anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman praktik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah kesalahan pengukuran, kesalahan plotting grafik, dan kurangnya edukasi kepada orang tua terkait hasil pemeriksaan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam mengenali kondisi atau tindakan yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain: kesalahan mengukur BB/TB/LK, penggunaan alat tidak sesuai usia, kesalahan membaca kurva pertumbuhan, keterlambatan mendeteksi stunting atau keterlambatan perkembangan, serta miskomunikasi dengan orang tua.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk meminimalkan risiko keselamatan pasien selama dan setelah tindakan.	Mahasiswa menuliskan pentingnya menggunakan alat yang terstandar, melakukan pengukuran sesuai prosedur, melakukan verifikasi hasil, memplot grafik dengan benar, serta memberikan edukasi yang jelas kepada orang tua.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi menunjukkan insight atau pembelajaran yang	Mahasiswa menyadari bahwa ketelitian dalam pengukuran

	didapat mahasiswa serta dampaknya terhadap praktik selanjutnya.	dan interpretasi sangat penting, serta komunikasi yang jelas kepada orang tua membantu mencegah kesalahan persepsi dan meningkatkan tindak lanjut yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menjadi bukti perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya melakukan pemeriksaan tumbuh kembang, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik secara berkelanjutan dalam pelayanan anak.

I. RINGKASAN

Bab Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia 0-18 tahun

Tumbuh kembang anak merupakan proses yang berlangsung secara bertahap, berkesinambungan, dan saling berkaitan sejak lahir hingga remaja. Dalam konsep dasar, pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur secara fisik, seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan ukuran organ tubuh. Pertumbuhan menunjukkan perubahan ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Sementara itu, perkembangan bersifat kualitatif, yaitu peningkatan kemampuan fungsi tubuh yang meliputi aspek motorik, bahasa, kognitif, sosial, dan emosional. Perkembangan tidak selalu dapat diukur dengan angka, tetapi dapat diamati melalui pencapaian kemampuan tertentu sesuai usia.

Proses tumbuh kembang dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik, ras atau etnis, jenis kelamin, serta kelainan kongenital yang sudah ada sejak lahir. Faktor-faktor ini menentukan potensi dasar yang dimiliki anak. Sementara itu, faktor eksternal seperti nutrisi, stimulasi, pola asuh, lingkungan sosial, dan status ekonomi sangat menentukan apakah potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. Interaksi antara faktor internal dan eksternal inilah yang membentuk hasil akhir tumbuh kembang seorang anak.

Setiap tahap usia memiliki ciri dan milestone perkembangan yang khas. Pada masa neonatus, bayi beradaptasi dengan lingkungan luar dan menunjukkan refleks primitif. Masa bayi ditandai dengan perkembangan motorik seperti tengkurap,

duduk, berdiri, dan berjalan, serta mulai munculnya kata-kata sederhana. Masa toddler ditandai dengan eksplorasi aktif, perkembangan bahasa yang pesat, dan sikap egosentris. Pada usia prasekolah, kemampuan motorik halus dan imajinasi berkembang pesat serta mulai bermain secara kooperatif. Usia sekolah ditandai dengan kemampuan berpikir logis konkret dan meningkatnya kemandirian. Sementara itu, masa remaja merupakan fase perubahan besar yang meliputi pubertas, perubahan hormonal, pencarian identitas diri, dan kemampuan berpikir abstrak.

Deteksi dini tumbuh kembang merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya keterlambatan yang bersifat permanen. Melalui pemantauan rutin menggunakan alat seperti Kartu Menuju Sehat dan standar pertumbuhan dari World Health Organization, serta skrining perkembangan seperti Denver Developmental Screening Test dan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi penyimpangan sejak dini. Penemuan awal memungkinkan intervensi yang cepat dan tepat sehingga peluang keberhasilan terapi menjadi lebih besar. Dalam keseluruhan proses ini, perawat memiliki peran yang sangat penting.

Perawat berperan sebagai caregiver yang memantau pertumbuhan dan milestone perkembangan, sebagai educator yang memberikan edukasi kepada orang tua tentang nutrisi dan stimulasi sesuai usia, sebagai advocate yang mendorong skrining rutin dan perlindungan hak anak, serta sebagai counselor yang mendampingi keluarga ketika ditemukan masalah perkembangan. Dengan pendekatan yang berpusat pada keluarga, perawat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaiknya. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik tentang konsep pertumbuhan, perkembangan, faktor yang memengaruhi, tahapan usia, serta pentingnya deteksi dini menjadi dasar utama dalam upaya menjaga kualitas generasi masa depan.

Tabel 2. 5 Red Flags & Eskalasi pada Pemeriksaan Pertumbuhan Dan Perkembangan Usia Anak 0-18 tahun

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Berat badan tidak naik atau turun signifikan	Indikasi gangguan pertumbuhan, kemungkinan gizi kurang atau penyakit kronis	Laporkan ke perawat penanggung jawab/dokter, lakukan pemantauan lanjutan dan evaluasi status gizi
Berat badan sangat rendah (gizi buruk)	Risiko malnutrisi berat yang dapat memengaruhi	Segera eskalasi untuk penanganan gizi dan kemungkinan rujukan

	tumbuh kembang dan imunitas	
Tinggi badan jauh di bawah standar (stunting)	Gangguan pertumbuhan kronis akibat malnutrisi jangka panjang atau faktor lain	Laporkan dan rencanakan intervensi nutrisi serta pemantauan berkala
Lingkar kepala terlalu kecil (mikrosefali) atau terlalu besar (makrosefali)	Kemungkinan gangguan perkembangan otak atau kondisi neurologis	Segera eskalasi untuk evaluasi lebih lanjut oleh dokter
Tidak mencapai milestone perkembangan sesuai usia	Indikasi keterlambatan perkembangan (motorik, bahasa, sosial)	Laporkan, lakukan skrining lanjutan, dan pertimbangkan rujukan ke layanan tumbuh kembang
Kehilangan kemampuan yang sudah dimiliki (regresi perkembangan)	Tanda gangguan neurologis serius	Eskalasi segera, perlu evaluasi medis lebih lanjut
Anak tidak merespons suara atau tidak kontak mata	Kemungkinan gangguan pendengaran	

Form Checklist "Saya sudah bisa…"

Pemeriksaan Pertumbuhan dan Skrining Perkembangan Anak (0–18 Tahun)

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan anak secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terkait tumbuh kembang anak	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menanyakan riwayat kehamilan, kelahiran, dan nutrisi anak	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menanyakan riwayat imunisasi dan perkembangan anak	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengukur berat badan anak dengan teknik yang benar	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengukur tinggi/panjang badan sesuai usia	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengukur lingkar kepala dengan benar	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengukur lingkar lengan atas (LILA) bila diperlukan	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memplot hasil pengukuran ke kurva pertumbuhan (WHO/KMS)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menginterpretasikan status pertumbuhan anak	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan skrining perkembangan sesuai usia (misalnya KPSP)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menilai perkembangan motorik kasar, halus, bahasa, dan sosial	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa mengenali tanda keterlambatan perkembangan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan masalah keperawatan terkait tumbuh kembang	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang nutrisi sesuai usia anak	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa memberikan edukasi stimulasi perkembangan anak	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjelaskan hasil pemeriksaan kepada orang tua dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____

18	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya terkait tumbuh kembang anak	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa menentukan kapan perlu rujukan atau eskalasi	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan tumbuh kembang	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, teliti, aman, dan empatik	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Pediatrics. AA of. Family-centered care and the pediatrician's role. American Academy of Pediatrics.; 2018.

Erikson EH. Childhood and society (2nd ed.). W. W. Norton & Company.; 1963.

Soetjiningsih. Tumbuh kembang anak. EGC; 2018.

Hockenberry, M. J., & Wilson D. Wong's nursing care of infants and children (11th ed.). Elsevier.; 2021.

Organization WH. WHO child growth standards. WHO; 2022.

Purnamasari, N., & Rahmawati EA. Memahami Proses Tumbuh Kembang Anak Usia Prasekolah: Informasi Esensial bagi Orang Tua. Jakarta: Mega Press Nusantara; 2023.

Windiani, I. G. A. T., & Soetjiningsih S. Ilmu Kesehatan Anak: Tumbuh Kembang & Perilaku. Jakarta: EGC; 2023.

Guyton, A. C., & Hall JE. Textbook of medical physiology (14th ed.). Elsevier; 2021.

Elfira D, Ramadhanti P, Ningsih SA. Deteksi Tumbuh Kembang Anak Menggunakan KPSP. 2022;4:2530–8.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK). Kemenkes RI; 2020.

Kyle, T., & Carman S. Essentials of pediatric nursing (3rd ed.). Wolters Kluwer.; 2020.

Ulfiana E. Tumbuh Kembang dan Stimulasi untuk Orangtua Anak PAUD/TPA. Jakarta: Pustaka Panasea; 2018.

Piaget J. he origins of intelligence in children. International Universities Press.; 1952.

Adhia Garina, L., Nurlaili Wangi & YK. Serba-Serbi Tumbuh Kembang Anak. Jakarta: BITREAD; 2018.

Emi susilowati. STIMULASI, DETEKSI DAN INTERVENSI DINI TUMBUH KEMBANG (SDIDTK) ANAK PADA POSYANDU KELURAHAN PENGGILINGAN JAKARTA TIMUR. 2019;1(2).

Melia A, Kuku P, Libunelo S, Taha SM, Pakaya I. Studi Literatur Tentang Perkembangan dan Karakteristik Anak Usia Dini. 2025;490.

Delfina R. UPAYA PENGUATAN PROGRAM STIMULASI , DETEKSI DAN USIA PRA SEKOLAH DENGAN METODE KPSP DAN PEMERIKSAAN. 2023;4(5):10806–9.

Padila. HASIL SKRINING PERKEMBANGAN ANAK USIA TODDLER ANTARA DDST DENGAN SDIDTK. 2019;3:244–56.

Sari E, Kebidanan PDIII, Palembang IM. ANALISIS DETEKSI DINI TUMBUH KEMBANG

PADA BALITA DENGAN KUESIONER PRA SKRINING PERKEMBANGAN (KPSP) PENDAHULUAN Permasalahan tumbuh kembang anak akibat masih menjadi problem di Indonesia , hal juga ini dipengaruhi oleh asupan gizi . Berdasarkan prevalensi data kurang Riskesdas gizi di Indonesia Anak yang memiliki awal tumbuh kembang yang baik akan menghasilkan anak yang sehat dan cerdas (Bryant et al ., upaya dini dengan yang dilakukan satunya untuk dapat mendeteksi dilakukan salah program stimulasi balita menggalami gangguan deteksi dini tumbuh kembang (SDIDTK). SDITTK merupakan program pembinaan tumbuh kembang dan anak berkualitas secara melalui perkembangan motorik serta 1 : 100 anak mempunyai keterlambatan kecerdasan Hal dan tentu komprehensif kegiatan stimulasi , deteksi dan intervensi (Kemkes , 2016). Masa Balita atau bayi / anak dibawah lima tahun merupakan " masa keemasan " karena pada masa ini otak anak berkaitan dengan permasalahan gizi buruk dan masalah stunting (Fauziah , Mariana , dan Saputra , 2020). Data Kementrian kesehatan mengungkap prevalensi nasional gizi buruk di Indonesia tahun 2010 pada balita adalah 4 . 9 % dan gizi kurang pada dapat turun menjadi 3 . 6 %. Berdasarkan Riskesdas tahun 2013 prevalensi kurang gizi di Indonesia menunjukan peningkatan Berdasarkan indeks perkembangan anak pada umur 36-59 bulan di Indonesia adalah 69 . 9 %, hal merupakan gambaran perkembangan anak Indonesia , maka berkembang sangat cepat sehingga disebut juga " masa kritis " (Chamidah , 2013 ; Diana FM , 2010). Pada masa ini perlu dilakukan kegiatan stimulasi / rangsangan agar tumbuh kembang anak berkualitas dan tidak terdapat penyimpangan (Sutiari N & Wulandari D , 2011). Kenyataan yang ditemukan dilapangan bahwa orang tua khusunya ibu tidak anak tahu dan apa itu perkembangan bagaimana menilainya . Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan merupakan masalah yang sering dijumpai di masyarakat , tetapi terkadang kurang mendapatkan dibutuhkan sedini mungkin cara agar anak dapat terdeteksi tumbuh kembang terhadap kelainan yang terjadi pada anak tersebut dan menstimulasi tumbuh kembang anak (Rikesda , 2018). Banyak orang tua yang menunda penanganan keterlambatan perkembangan mengakibatkan prognosis yang kurang baik . Hal ini sejalan dengan hasil penelitian. 2021;6:334–42.

BAB 3

PENGKAJIAN KOMPREHENSIF ANAK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Pengkajian Komprehensif Anak	3.1 Melakukan pengkajian komprehensif (anamnesis, pemeriksaan fisik, perkembangan, keluarga) secara terstruktur.	3.2 Menyusun dokumentasi data dan memvalidasi temuan penting untuk penetapan prioritas masalah.	CPMK-2	CPMK-3; CPMK-6

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian pediatrik + checklist	Persentase ketercapaian item checklist pengkajian dan akurasi pengisian format dokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Lembar checklist OSCE; dokumentasi pengkajian
CPMK-3	Analisis kasus tertulis (case-based)	Ketepatan penetapan prioritas masalah/diagnosis yang didukung data serta rasional berbasis sumber kredibel.	15	Laporan analisis kasus
CPMK-6	Role play komunikasi + penilaian kinerja	Penerapan teknik komunikasi terapeutik dan kejelasan koordinasi kolaborasi/rujukan (struktur komunikasi).	15	Video/rekaman role play; lembar penilaian

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi data (akurasi & sistematika)	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

Pendahuluan

Memasuki dunia pengkajian pediatrik menuntut perawat untuk melampaui sekadar penguasaan teknik pemeriksaan fisik. Dunia ini adalah sebuah arena dinamis tempat ilmu klinis berpadu dengan seni memahami manusia dalam fase pertumbuhannya yang paling krusial. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Fisiologi, psikologi, dan respons mereka terhadap penyakit serta lingkungan pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kegagalan untuk mengenali perbedaan fundamental ini dapat berakibat pada pengkajian yang tidak akurat, diagnosis yang tertunda, hingga trauma psikologis yang dapat membekas seumur hidup bagi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, penguasaan materi dalam bab ini menjadi fondasi yang tidak dapat ditawar bagi setiap perawat yang berdedikasi pada kesehatan anak.

Tantangan utama dalam pengkajian anak terletak pada spektrum tumbuh kembang yang sangat luas, mulai dari neonatus yang belum mampu berkomunikasi secara verbal hingga remaja yang sedang mencari identitas diri. Setiap tahap perkembangan ini memerlukan strategi pendekatan, komunikasi, dan pemeriksaan yang berbeda. Seorang perawat harus mampu beradaptasi dengan cepat, mengubah perannya dari seorang pengamat yang lembut bagi seorang bayi, menjadi seorang pendongeng yang kreatif bagi seorang anak prasekolah, hingga menjadi seorang pendengar yang empatik bagi seorang remaja. Kemampuan adaptasi ini merupakan inti dari kompetensi keperawatan pediatrik.

Bab ini akan mengupas secara mendalam berbagai dimensi pengkajian keperawatan anak. Pembahasan akan dimulai dari fondasi filosofis yang paling penting, yaitu *atraumatic care* atau asuhan atraumatik, yang menjadi bintang penuntun dalam setiap interaksi dengan pasien anak. Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarga selama proses perawatan (Goddard et al., 2021). Selanjutnya, kita akan menyelami teknik komunikasi terapeutik yang disesuaikan untuk anak dan strategi melakukan anamnesis melalui orang tua atau pengasuh *(alloanamnesis)*.

Setelah fondasi komunikasi dan pendekatan terbangun, pembahasan akan beralih ke aspek-aspek yang lebih teknis. Pengukuran antropometri dan interpretasi grafik pertumbuhan akan dibahas sebagai indikator objektif status nutrisi dan kesehatan fisik anak. Pengukuran tanda-tanda vital, yang seringkali dianggap sebagai tugas rutin, akan ditelaah kembali dengan penekanan pada teknik yang benar dan nilai normal yang spesifik sesuai usia. Keterampilan ini, meskipun mendasar, merupakan komponen vital dalam deteksi dini masalah kesehatan (Hampl et al., 2023).

Puncak dari bab ini adalah pembahasan mengenai pemeriksaan fisik sistematis dari kepala hingga ujung kaki. Setiap sistem tubuh akan dijelaskan dengan mempertimbangkan anatomi dan fisiologi unik pada anak. Teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi akan diuraikan dengan contoh-contoh temuan normal dan abnormal yang sering dijumpai dalam praktik klinis. Pengetahuan yang solid mengenai teknik pemeriksaan fisik adalah kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat (Tan et al., 2021).

Sebagai pelengkap, bab ini juga akan memperkenalkan instrumen skrining perkembangan seperti Denver II dan KPSP. Skrining ini merupakan alat penting untuk memantau pencapaian tonggak-tonggak perkembangan anak dan mengidentifikasi potensi keterlambatan secara dini. Pemahaman fungsi neurologis dasar dan refleks primitif juga akan menjadi bagian dari pembahasan untuk melengkapi gambaran pengkajian yang holistik.

Pada akhirnya, seluruh data yang terkumpul melalui wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan fisik harus dianalisis dan didokumentasikan secara sistematis. Dokumentasi yang baik bukan hanya sekadar catatan administratif, melainkan sebuah alat komunikasi profesional yang esensial untuk memastikan kontinuitas dan kualitas asuhan. Bab ini akan memberikan panduan mengenai cara menyusun dokumentasi yang efektif dan informatif.

Dengan menguasai seluruh materi dalam bab ini, pembaca diharapkan tidak hanya mampu melakukan pengkajian fisik pada anak secara kompeten, tetapi juga mampu melakukannya dengan cara yang penuh empati, menghargai, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Inilah esensi dari menjadi seorang perawat anak yang profesional dan berdedikasi, yang mampu melihat jauh melampaui data klinis dan menyentuh kehidupan pasiennya secara utuh.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Selamat mempelajari Bab 3 tentang Pengkajian Komprehensif Anak. Sebelum mempelajari Bab ini silahkan Anda membaca tujuan instruksional dan capaian pembelajaran dari bab ini:

Tujuan Intruksional:

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep fundamental dalam pengkajian keperawatan anak dengan pendekatan *atraumatic care*.
2. Menerapkan teknik komunikasi dan anamnesis yang efektif pada orang tua dan pasien anak.
3. Menguraikan prinsip etika dan legal dalam pengkajian anak.
4. Melakukan pengukuran antropometri dan tanda-tanda vital pada anak.

5. Mendemonstrasikan langkah-langkah pemeriksaan fisik pada anak.
6. Menggunakan instrumen standar seperti Denver II atau KPSP untuk skrining perkembangan anak.
7. Mendokumentasikan data hasil pengkajian keperawatan anak yang komprehensif.

Uraian Materi

Pada Bab 3 ini akan diuraikan tentang: Konsep dasar dan komunikasi dalam pengkajian anak; Pengkajian riwayat kesehatan anak secara holistik; Pengukuran antropometri dan tanda-tanda vital; Pemeriksaan fisik *head-to-toe* pada anak; Skrining perkembangan dan fungsi neurologis; *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) dan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pengkajian komprehensif anak.

A. Konsep Dasar dan Komunikasi dalam Pengkajian Anak

Interaksi pertama dengan pasien anak dan keluarganya seringkali menentukan arah dan kualitas seluruh proses asuhan keperawatan. Sebuah sambutan yang hangat, lingkungan yang mendukung, dan komunikasi yang terbuka dapat meruntuhkan tembok kecemasan dan membangun jembatan kepercayaan. Sebaliknya, pendekatan yang kaku, terburu-buru, atau tidak peka dapat menciptakan pengalaman negatif yang menyulitkan pengumpulan data akurat dan pelaksanaan intervensi. Oleh karena itu, memahami konsep dasar dan menguasai seni komunikasi adalah prasyarat mutlak sebelum menyentuh aspek teknis pemeriksaan fisik. Bagian ini akan membahas pilar-pilar fundamental yang menopang keberhasilan pengkajian anak, mulai dari filosofi asuhan, teknik wawancara, strategi membangun hubungan, hingga pertimbangan etis dan persiapan lingkungan.

Konsep-konsep ini bukanlah sekadar teori, melainkan perangkat praktis yang harus terinternalisasi dalam diri setiap perawat. Atraumatic care, misalnya, bukan hanya tentang menggunakan jarum yang lebih kecil, tetapi tentang sebuah pola pikir untuk secara proaktif mengidentifikasi dan meminimalkan semua potensi sumber stres bagi anak (Goddard et al., 2021). Komunikasi yang efektif juga bukan hanya tentang bertanya, tetapi tentang mendengar dengan saksama, mengobservasi bahasa tubuh, dan menyesuaikan pilihan kata sesuai tingkat pemahaman anak (Sabetsarvestani & Geçkil, 2024). Penguasaan konsep ini membedakan antara perawat yang hanya menjalankan prosedur dengan perawat yang memberikan asuhan secara holistik.

Kepercayaan *(trust)* adalah mata uang utama dalam keperawatan pediatrik. Kepercayaan ini tidak datang secara otomatis, melainkan harus dibangun secara

perlahan melalui konsistensi, kejujuran, dan empati. Ketika seorang anak percaya bahwa perawat tidak akan menyakitinya tanpa alasan dan akan selalu jujur, ia akan lebih kooperatif. Demikian pula, ketika orang tua percaya bahwa perawat memiliki kompetensi dan kepedulian tulus terhadap anak mereka, mereka akan lebih terbuka dalam memberikan informasi riwayat kesehatan yang krusial. Proses membangun kepercayaan ini seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran (Mackay et al., 2024).

Pertimbangan etika dan legalitas juga membingkai setiap tindakan dalam pengkajian anak. Prinsip otonomi, beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), dan keadilan harus selalu menjadi panduan. Dalam konteks pediatrik, prinsip ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan hak anak dan hak orang tua. Mendapatkan informed consent (persetujuan setelah penjelasan) dari orang tua sambil tetap melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan sesuai usianya (assent) adalah contoh penerapan prinsip etika yang seimbang.

Persiapan lingkungan dan alat juga memegang peranan penting. Ruang pemeriksaan yang dihias dengan warna-warna ceria, keberadaan mainan, dan alat-alat medis yang disajikan dengan cara yang tidak mengancam dapat secara signifikan mengurangi kecemasan anak. Sebuah stetoskop dapat diperkenalkan sebagai "telepon untuk mendengarkan jantung" atau sebuah otoskop sebagai "teropong untuk melihat ke dalam telinga". Kreativitas dalam memodifikasi lingkungan dan pendekatan dapat mengubah pengalaman pemeriksaan yang menakutkan menjadi sebuah petualangan yang menarik bagi anak.

Keterampilan komunikasi dan interpersonal seringkali dianggap sebagai soft skills, namun dalam keperawatan anak, keterampilan ini memiliki dampak yang sangat nyata *(hard impact)* terhadap hasil klinis. Kemampuan untuk menenangkan seorang balita yang menangis histeris agar pemeriksaan auskultasi jantung dapat dilakukan dengan akurat adalah contoh nyata bagaimana komunikasi secara langsung memengaruhi kualitas data pengkajian.

Pada akhirnya, fondasi yang kokoh dalam konsep-konsep dasar ini akan memungkinkan perawat untuk melakukan pengkajian yang lebih dari sekadar pengumpulan data. Perawat akan mampu menciptakan sebuah pengalaman terapeutik, di mana anak dan keluarga merasa didengar, dihargai, dan diberdayakan sebagai mitra dalam perawatan kesehatan mereka. Ini adalah tujuan akhir dari pengkajian yang berpusat pada pasien dan keluarga.

1. Pendekatan Sesuai Tahap Tumbuh Kembang (*Atraumatic Care*)

   Atraumatic care adalah sebuah filosofi dan kerangka kerja yang memandu seluruh praktik keperawatan pediatrik, bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarganya dalam sistem pelayanan kesehatan. Pendekatan ini didasarkan pada

tiga prinsip utama: pertama, mencegah atau meminimalkan pemisahan anak dari keluarganya; kedua, meningkatkan rasa kendali anak; dan ketiga, mencegah atau meminimalkan cedera tubuh dan rasa nyeri (Goddard et al., 2021). Implementasi prinsip ini menuntut perawat untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi pemicu stres dalam setiap prosedur dan memodifikasi pendekatannya untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dalam konteks pengkajian fisik, atraumatic care terwujud dalam berbagai strategi praktis. Misalnya, untuk mencegah pemisahan, pemeriksaan pada bayi dan balita sebaiknya dilakukan di pangkuan orang tua. Untuk meningkatkan rasa kendali, anak usia prasekolah atau sekolah dapat diberikan pilihan sederhana, seperti, "Kamu mau aku periksa telinga kanan atau kiri dulu?" atau diizinkan untuk memegang stetoskop sebelum digunakan. Untuk meminimalkan nyeri dan ketakutan, prosedur yang paling invasif atau tidak nyaman, seperti pemeriksaan tenggorokan atau telinga, harus selalu dilakukan di akhir. Pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada anak ini terbukti mampu meningkatkan kerja sama dan mengurangi pengalaman traumatis (Goddard et al., 2021).

2. Teknik Wawancara dan Anamnesis pada Orang Tua (*Alloanamnesis*)

   Alloanamnesis, atau pengumpulan riwayat kesehatan dari pihak ketiga (dalam hal ini orang tua atau pengasuh), merupakan komponen sentral dalam pengkajian pediatrik. Kualitas informasi yang diperoleh sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan menggunakan teknik wawancara yang efektif. Wawancara harus dimulai dengan pertanyaan terbuka untuk memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menceritakan kekhawatiran mereka dengan kata-kata mereka sendiri, seperti, "Apa yang membawa Ibu dan ananda ke sini hari ini?". Pertanyaan ini menunjukkan rasa hormat dan memvalidasi perspektif orang tua sebagai sumber informasi yang paling penting (Butcher & Jones, 2021).

   Setelah keluhan utama tergali, perawat kemudian dapat menggunakan pertanyaan tertutup atau lebih spesifik untuk mengklarifikasi detail, seperti durasi gejala, faktor yang memperburuk atau meringankan, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Penting untuk menghindari penggunaan jargon medis yang dapat membingungkan orang tua dan menghindari sikap menghakimi. Menggunakan teknik parafrase atau mengulangi kembali informasi yang diberikan orang tua dapat membantu memastikan pemahaman yang benar dan menunjukkan bahwa perawat mendengarkan secara aktif. Komunikasi yang empatik dan suportif akan mendorong orang tua untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat, yang krusial untuk penegakan diagnosis dan perencanaan asuhan (Sabetsarvestani & Geçkil, 2024).



Gambar 3. 1 Allo dan auto anamnesis

3. Strategi Membangun *Trust* dan *Rapport* dengan Pasien Anak

   Membangun kepercayaan *(trust)* dan hubungan baik *(rapport)* dengan pasien anak adalah sebuah proses aktif yang memerlukan strategi yang disesuaikan dengan usia. Pada bayi, rapport dibangun melalui sentuhan yang lembut, suara yang tenang, dan kontak mata yang hangat. Pada balita, perawat dapat memulai interaksi dengan bermain boneka atau balok terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan, serta memuji perilaku kooperatif mereka. Komunikasi pada tingkat ini seringkali lebih banyak bersifat nonverbal (Appiah et al., 2022).

   Untuk anak usia prasekolah, penggunaan bahasa yang konkret dan penjelasan sederhana sangatlah penting. Mereka merespons baik terhadap permainan peran, misalnya dengan membiarkan mereka "memeriksa" boneka terlebih dahulu. Pada anak usia sekolah, kejujuran adalah kunci. Menjelaskan setiap langkah pemeriksaan dengan bahasa yang mereka pahami dan menjawab pertanyaan mereka dengan jujur akan membangun kepercayaan. Remaja, di sisi lain, menghargai privasi dan rasa hormat. Memberikan kesempatan untuk berbicara tanpa kehadiran orang tua (jika sesuai) dan menunjukkan minat pada kehidupan mereka di luar penyakit dapat membangun *rapport* yang kuat. Membangun hubungan ini adalah investasi waktu yang akan mempermudah seluruh proses perawatan di masa depan (Mackay et al., 2024).

4. Etika dan Legalitas dalam Pengkajian Kesehatan Anak

   Pengkajian kesehatan anak dibingkai oleh prinsip-prinsip etika dan peraturan legal yang kompleks, yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak sebagai populasi rentan. Prinsip utama adalah informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis yang harus diperoleh dari orang tua atau wali sah setelah mereka menerima penjelasan yang lengkap mengenai prosedur, manfaat, risiko, dan alternatifnya. Meskipun orang tua yang memberikan persetujuan legal, anak yang sudah cukup umur dan matang secara kognitif (biasanya di atas 7 tahun) harus dilibatkan dalam proses melalui assent, yaitu persetujuan afirmatif anak untuk berpartisipasi (Barber et al., 2025).

Kerahasiaan atau konfidensialitas adalah pilar etis lainnya. Informasi kesehatan anak harus dijaga kerahasiaannya dan hanya dibagikan kepada tim kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatannya. Isu ini menjadi sangat relevan pada pasien remaja yang mungkin membagikan informasi sensitif terkait kesehatan seksual atau penggunaan zat. Perawat harus memahami batasan kerahasiaan, terutama jika ada risiko bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain, dan harus transparan kepada remaja mengenai batasan ini sejak awal interaksi. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya melindungi pasien secara hukum tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik yang didasarkan pada kepercayaan (Walter et al., 2022).

5. Persiapan Lingkungan dan Alat Pemeriksaan yang Ramah Anak

Lingkungan fisik ruang pemeriksaan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kecemasan dan kerja sama anak. Ruangan yang ideal harus terasa aman, nyaman, dan tidak mengintimidasi. Penggunaan warna-warna cerah, poster atau stiker dinding bertema anak-anak, serta ketersediaan mainan yang sesuai dengan usia dapat membantu menciptakan suasana yang positif. Memastikan suhu ruangan nyaman dan pencahayaan cukup juga merupakan bagian dari persiapan lingkungan yang baik (Veena, 2025).

Alat-alat pemeriksaan harus disiapkan dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak langsung terlihat menakutkan bagi anak. Beberapa alat dapat dimodifikasi atau diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, meminta anak untuk "meniup lilin ulang tahun" dapat digunakan untuk mengobservasi pola pernapasan atau "meniup baling-baling" untuk menilai kapasitas paru. Stetoskop dapat dihangatkan terlebih dahulu dengan tangan sebelum menyentuh kulit anak. Persiapan yang cermat ini menunjukkan perhatian terhadap detail dan kenyamanan pasien, yang merupakan elemen penting dalam memberikan asuhan berkualitas tinggi dan mengurangi potensi trauma (Oommen & Menon, 2024).

B. Pengkajian Riwayat Kesehatan Anak secara Holistik

Pengkajian riwayat kesehatan yang komprehensif adalah proses investigasi mendalam yang melampaui keluhan utama saat ini. Ini adalah upaya untuk menyusun narasi kesehatan seorang anak secara utuh, mulai dari masa konsepsi hingga kondisinya sekarang. Pendekatan holistik ini mengakui bahwa status kesehatan seorang anak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor biologis, genetik, perkembangan, nutrisi, psikososial, dan lingkungan. Mengabaikan salah satu dari domain ini dapat menyebabkan gambaran klinis yang tidak lengkap dan berpotensi mengarah pada kesalahan diagnosis atau perencanaan asuhan yang

tidak optimal. Pengkajian ini tidak hanya fokus pada penyakit tetapi juga pada pengalaman sakit *(illness)* dan dampaknya terhadap anak dan keluarga.

Pentingnya pengkajian holistik ini ditekankan dalam berbagai model keperawatan, seperti Pola Kesehatan Fungsional Gordon, yang mendorong pengumpulan data secara sistematis di berbagai area fungsional kehidupan pasien (Butcher & Jones, 2021). Dengan menggali informasi secara menyeluruh, perawat dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu, faktor risiko, serta kekuatan dan sumber daya yang dimiliki keluarga. Informasi mengenai riwayat prenatal dan kelahiran, misalnya, dapat memberikan petunjuk penting mengenai potensi masalah neurologis atau perkembangan di kemudian hari (Cioffredi et al., 2024). Demikian pula, riwayat imunisasi yang tidak lengkap merupakan faktor risiko kritis untuk berbagai penyakit infeksi yang dapat dicegah.

Proses pengumpulan riwayat ini juga merupakan kesempatan emas untuk memberikan edukasi kesehatan kepada orang tua. Saat bertanya tentang riwayat nutrisi, perawat dapat sekaligus memberikan informasi tentang gizi seimbang. Ketika membahas pola kebiasaan, perawat dapat mempromosikan praktik keamanan seperti penggunaan kursi mobil *(car seat)* atau penyimpanan bahan kimia berbahaya di rumah. Dengan demikian, pengkajian menjadi sebuah intervensi proaktif, bukan sekadar pengumpulan data pasif.

Menggali riwayat psikososial dan perkembangan emosional anak juga sama pentingnya dengan mengumpulkan data fisik. Stres dalam keluarga, perubahan struktur keluarga, atau kesulitan di sekolah dapat bermanifestasi sebagai keluhan fisik seperti sakit perut atau sakit kepala berulang. Memahami konteks sosial dan emosional anak membantu perawat untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang lebih akurat dan merancang intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan anak secara keseluruhan (Smart et al., 2025).

Riwayat penyakit dalam keluarga juga memberikan informasi tak ternilai mengenai predisposisi genetik terhadap kondisi tertentu, seperti asma, alergi, atau penyakit jantung. Informasi ini memungkinkan perawat untuk lebih waspada terhadap tanda dan gejala awal dari kondisi-kondisi tersebut pada anak. Selain itu, mengeksplorasi lingkungan tempat tinggal dapat mengungkap paparan terhadap toksin lingkungan, kualitas sanitasi, atau bahkan faktor keamanan di lingkungan sekitar yang semuanya berpengaruh terhadap kesehatan anak (Knapp et al., 2023). Pengkajian holistik membutuhkan keterampilan investigasi yang baik, kesabaran, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan keluarga. Informasi yang dikumpulkan harus diorganisir secara sistematis untuk memudahkan analisis.

Kesimpulannya, pengkajian riwayat kesehatan holistik adalah fondasi dari asuhan keperawatan pediatrik yang berkualitas. Ini adalah proses dinamis yang memberikan gambaran tiga dimensi mengenai seorang anak, memungkinkan perawat untuk memahami tidak hanya "apa" masalahnya, tetapi juga "mengapa" masalah itu terjadi dan "bagaimana" dampaknya terhadap kehidupan anak dan keluarga.

Contoh Kasus: Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dibawa ke klinik dengan keluhan sakit perut berulang setiap pagi hari sekolah selama sebulan terakhir. Pengkajian fisik tidak menunjukkan kelainan signifikan. Melalui pengkajian riwayat holistik, perawat menemukan bahwa orang tua anak baru saja bercerai dua bulan yang lalu, dan anak tersebut baru pindah ke sekolah baru. Selain itu, diketahui bahwa kakek dari pihak ibu memiliki riwayat penyakit celiac. Tanpa pendekatan holistik, fokus mungkin hanya pada penyebab gastrointestinal. Namun, data baru ini membuka kemungkinan diagnosis banding lain, seperti kecemasan terkait sekolah *(school anxiety)* atau manifestasi stres, sambil tetap waspada terhadap kemungkinan adanya kondisi medis organik yang dipicu oleh faktor genetik. Intervensi yang direncanakan pun menjadi lebih komprehensif, mencakup rujukan konseling psikologis selain pemeriksaan medis lebih lanjut.

***Problem-based* dan *clinical reasoning* berdasarkan skenario di atas.**

Diagnosa Keperawatan Prioritas:

"Ansietas b/d stres adaptasi (perubahan lingkungan sekolah & perceraian orang tua) ditandai dengan sakit perut berulang"

Rencana Tujuan (SLKI):

"Anak akan menunjukkan penurunan ansietas (skala 2→0) dalam 1 minggu"

Rencana Intervensi (SIKI):

1. Manajemen Ansietas (I.0201):
   a. Kaji tingkat ansietas (skala 0-10)
   b. Dorong ekspresi perasaan anak
   c. Ajarkan teknik relaksasi (nafas dalam, imajinasi)
   d. Identifikasi & modifikasi pikiran negatif
2. Dukungan Psikologis (I.0103):
   a. Dampingi anak saat bicara tentang perasaannya
   b. Libatkan ibu dalam proses terapi
   c. Rujuk ke konselor psikolog anak

3. Edukasi (I.0102):
   a. Edukasi ibu tentang school anxiety
   b. Ajarkan strategi coping adaptif (misal: jadwal belajar santai)
   c. Pastikan anak paham bahwa perceraian orangtua bukan salahnya
4. Kolaborasi Medis (I.0301):
   a. Rujuk dokter untuk cek celiac (riwayat genetik)
   b. Pantau gejala fisik sambil evaluasi psikis

SOAP Keperawatan:

S (Subjektif):

   a. Ibu: "Belakangan anak sakit perut tiap pagi mau sekolah. Baru pindah sekolah dan orang tua pisah.
   b. "Anak: "Gak enak perut... takut sekolah."

O (Objektif):

   a. Pemeriksaan fisik: Dalam batas normal
   b. Riwayat psikososial: Perceraian orang tua 2 bulan lalu, pindah sekolah baru
   c. Kakek ibu: Riwayat celiac

A (Asesmen):

   a. Diagnosa: Ansietas b/d stres adaptasi

   Tujuan:

   a. Ansietas turun dalam 1 minggu

P (Plan/Intervensi):

   a. Manajemen ansietas dan dukungan psikologis
   b. Edukasi dan kolaborasi medis

Evaluasi:

   a. 3 hari post-intervensi: Anak lebih ceria, sakit perut turun.
   b. Ibu ikut terapi keluarga.
   c. Rencana: Kontrol psikolog dan cek lab celiac.

1. Riwayat Prenatal, Natal, dan Postnatal (Neonatus)

   Pengkajian riwayat kesehatan anak selalu dimulai bahkan sebelum anak itu lahir. Riwayat prenatal mencakup informasi krusial mengenai kesehatan ibu selama kehamilan, seperti adanya penyakit kronis (misalnya, diabetes, hipertensi), infeksi (TORCH), penggunaan obat-obatan, alkohol, atau rokok, serta status nutrisi dan perawatan antenatal yang diterima. Faktor-faktor ini secara langsung memengaruhi perkembangan janin dan dapat menjadi predisposisi berbagai kondisi saat lahir (Cioffredi et al., 2024). Kelengkapan dan kualitas perawatan antenatal seringkali berkorelasi dengan luaran kesehatan bayi yang lebih baik. Riwayat natal berfokus pada detail proses persalinan, termasuk usia gestasi saat lahir (prematur, aterm, atau postmatur), jenis persalinan (spontan, induksi, atau bedah sesar), durasi persalinan, dan adanya komplikasi seperti gawat janin atau lilitan tali pusat. Skor APGAR pada menit pertama dan kelima memberikan gambaran cepat mengenai adaptasi neonatus terhadap kehidupan di luar rahim.

Riwayat postnatal mencakup kondisi bayi segera setelah lahir, seperti berat dan panjang badan lahir, adanya anomali kongenital, kebutuhan resusitasi, serta masalah-masalah awal seperti ikterus (kuning), kesulitan menyusu, atau infeksi (Sartika et al., 2021). Menggali riwayat ini secara detail memberikan dasar untuk memahami status kesehatan awal anak.

2. Evaluasi Riwayat Imunisasi dan Nutrisi Anak

   Riwayat imunisasi adalah komponen vital dalam pengkajian kesehatan preventif. Perawat harus menanyakan dan memverifikasi status imunisasi anak berdasarkan jadwal yang direkomendasikan secara nasional, seperti program dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Penting untuk mencatat tanggal setiap vaksin yang diberikan dan mengidentifikasi jika ada imunisasi yang terlewat. Selain itu, reaksi yang pernah terjadi setelah imunisasi sebelumnya juga perlu didokumentasikan. Evaluasi ini penting untuk melindungi anak dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (Barber et al., 2025).

   Pengkajian riwayat nutrisi harus disesuaikan dengan usia anak. Untuk bayi, fokusnya adalah pada pemberian ASI eksklusif atau susu formula, frekuensi dan durasi menyusu, serta waktu pengenalan Makanan Pendamping ASI (MPASI). Untuk anak yang lebih besar, perlu digali pola makan harian (dietary recall 24 jam), jenis makanan yang disukai dan tidak disukai, adanya alergi makanan, serta kebiasaan jajan. Data ini, jika digabungkan dengan pengukuran antropometri, akan memberikan gambaran komprehensif mengenai status gizi anak dan membantu mengidentifikasi risiko malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi (Hampl et al., 2023).

3. Pengkajian Pola Kebiasaan Sehari-hari dan Pola Tidur

   Memahami rutinitas harian anak memberikan wawasan tentang gaya hidup dan potensi masalah perilaku atau perkembangan. Pengkajian ini mencakup pola bermain, aktivitas fisik, waktu yang dihabiskan di depan layar (screen time), serta interaksi sosial dengan teman sebaya. Perawat juga perlu menanyakan tentang kebiasaan eliminasi (buang air besar dan kecil), termasuk frekuensi, konsistensi, dan ada tidaknya masalah seperti konstipasi atau mengompol. Pelatihan toilet (toilet training) juga menjadi topik penting untuk anak usia balita (Butcher & Jones, 2021).

   Pola tidur merupakan indikator penting dari kesehatan fisik dan emosional anak. Perawat harus menanyakan total durasi tidur dalam 24 jam (termasuk tidur siang), rutinitas sebelum tidur, dan adanya gangguan tidur seperti kesulitan memulai tidur, sering terbangun di malam hari, mimpi buruk, atau berjalan sambil tidur (sleepwalking). Kualitas dan kuantitas tidur yang tidak adekuat dapat memengaruhi suasana hati, perilaku, dan kemampuan belajar anak. Informasi ini

membantu dalam mengidentifikasi masalah tidur primer atau tidur yang terganggu akibat kondisi medis atau psikologis lain (Walter et al., 2022).

4. Riwayat Penyakit Keluarga dan Lingkungan Tempat Tinggal

   Riwayat penyakit keluarga, atau genogram, adalah alat yang ampuh untuk mengidentifikasi risiko penyakit genetik atau familial. Perawat perlu menanyakan secara spesifik tentang riwayat penyakit pada keluarga inti dan kerabat tingkat pertama (orang tua, saudara kandung, kakek-nenek), terutama untuk kondisi-kondisi seperti asma, alergi, eksim, diabetes, penyakit jantung bawaan, kanker pada anak, dan gangguan kesehatan mental. Mengetahui adanya riwayat keluarga yang positif memungkinkan dilakukannya skrining lebih dini dan edukasi preventif yang lebih terarah (Knapp et al., 2023).

   Kondisi lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan anak. Pengkajian ini mencakup aspek fisik dan sosial dari lingkungan rumah dan komunitas. Pertanyaan yang relevan meliputi tipe tempat tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah, sumber air minum, sistem sanitasi, paparan terhadap asap rokok, hewan peliharaan, atau polutan lain di sekitar rumah. Aspek keamanan lingkungan juga perlu dinilai, seperti keberadaan detektor asap, penyimpanan bahan beracun yang aman, dan keamanan area bermain. Lingkungan yang tidak aman atau tidak sehat merupakan faktor risiko signifikan untuk cedera dan penyakit pada anak (Knapp et al., 2023).

5. Penilaian Riwayat Psikososial dan Perkembangan Emosional

   Pengkajian riwayat psikososial bertujuan untuk memahami anak dalam konteks keluarga, sekolah, dan komunitasnya. Ini mencakup informasi tentang struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, sistem pendukung yang dimiliki keluarga, dan stresor-stresor yang mungkin sedang dihadapi (misalnya, masalah finansial, perceraian, atau penyakit kronis pada anggota keluarga). Untuk anak usia sekolah, penting untuk menanyakan tentang pengalaman di sekolah, prestasi akademik, hubungan dengan guru dan teman, serta ada tidaknya perundungan (bullying) (Lobo et al., 2024).

   Perkembangan emosional dinilai dengan mengobservasi perilaku anak selama interaksi dan menanyakan kepada orang tua tentang temperamen umum anak, cara mengekspresikan emosi, dan kemampuannya dalam mengatasi frustrasi. Perawat perlu waspada terhadap tanda-tanda masalah kesehatan mental, seperti kecemasan berlebihan, kesedihan yang berkepanjangan, penarikan diri dari sosial, atau perubahan perilaku yang drastis. Penilaian ini penting untuk identifikasi dini dan intervensi masalah kesehatan jiwa pada anak, yang seringkali terabaikan namun memiliki dampak jangka panjang yang signifikan (Smart et al., 2025).

C. Pengukuran Antropometri dan Tanda-Tanda Vital

Pengukuran antropometri dan tanda-tanda vital merupakan metode objektif untuk menilai status kesehatan fisik, pertumbuhan, dan fungsi fisiologis dasar seorang anak. Data ini sering dianggap sebagai "bahasa" tubuh anak, yang memberikan petunjuk-petunjuk kuantitatif mengenai kondisi internal mereka. Berbeda dengan orang dewasa yang nilai normalnya relatif statis, pada anak-anak, nilai-nilai ini sangat dinamis dan harus selalu diinterpretasikan dalam konteks usia, jenis kelamin, dan kurva pertumbuhan standar. Kesalahan kecil dalam teknik pengukuran atau penggunaan alat yang tidak tepat dapat menyebabkan interpretasi yang keliru, yang berpotensi menutupi masalah serius atau sebaliknya, menimbulkan kecemasan yang tidak perlu pada orang tua.

Setiap parameter, mulai dari berat badan hingga tekanan darah, menceritakan bagian dari kisah kesehatan anak. Berat badan adalah indikator yang paling sensitif terhadap perubahan status gizi jangka pendek. Panjang atau tinggi badan merefleksikan pertumbuhan linier dan status gizi jangka panjang. Lingkar kepala merupakan proksi penting dari pertumbuhan otak, terutama selama dua tahun pertama kehidupan. Kombinasi dari pengukuran-pengukuran ini, ketika diplot pada grafik pertumbuhan, memungkinkan perawat untuk memvisualisasikan pola pertumbuhan anak dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan standar populasi. Deteksi dini penyimpangan dari pola normal, seperti failure to thrive (gagal tumbuh) atau percepatan pertumbuhan yang tidak wajar, adalah salah satu intervensi keperawatan yang paling berdampak.

Tanda-tanda vital, suhu, frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, dan tekanan darah, adalah jendela menuju fungsi sistem kardiovaskular, pernapasan, dan metabolisme. Peningkatan frekuensi nadi dan pernapasan bisa menjadi tanda awal dari demam, dehidrasi, atau distres pernapasan. Suhu tubuh yang abnormal dapat mengindikasikan adanya infeksi atau masalah termoregulasi. Tekanan darah, yang seringkali terlewatkan dalam pemeriksaan rutin pada anak, merupakan parameter penting untuk menilai fungsi kardiovaskular dan ginjal (Hampl et al., 2023). Pengukuran yang akurat memerlukan pemilihan ukuran manset yang benar, sebuah detail yang sering diabaikan namun sangat krusial.

Penting untuk diingat bahwa kondisi anak saat pengukuran dapat sangat memengaruhi hasilnya. Anak yang sedang menangis atau aktif bergerak akan memiliki frekuensi nadi, pernapasan, dan tekanan darah yang lebih tinggi dari nilai istirahatnya. Oleh karena itu, perawat harus berusaha menciptakan kondisi yang tenang dan nyaman sebelum melakukan pengukuran. Melakukan pengukuran saat

anak tidur atau tenang di pangkuan orang tua seringkali memberikan hasil yang paling akurat.

Bagian ini akan menguraikan secara rinci teknik yang benar untuk setiap pengukuran, cara memilih alat yang sesuai, dan yang terpenting, bagaimana menginterpretasikan hasilnya menggunakan alat bantu seperti grafik pertumbuhan dari WHO atau CDC. Penguasaan keterampilan ini akan membekali perawat dengan kemampuan untuk mengubah angka-angka mentah menjadi penilaian klinis yang bermakna, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan keperawatan selanjutnya.

1. Teknik Pengukuran Berat Badan dan Tinggi/Panjang Badan

   Pengukuran berat badan pada bayi dan balita yang belum dapat berdiri harus menggunakan timbangan bayi (tipe nampan) yang diletakkan di permukaan datar dan stabil. Bayi harus ditimbang tanpa busana atau hanya dengan popok kering untuk akurasi maksimal, dan timbangan harus dikalibrasi ke angka nol sebelum setiap penggunaan. Untuk anak yang sudah bisa berdiri, digunakan timbangan berdiri. Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang sama setiap hari, idealnya sebelum makan, untuk konsistensi (Hampl et al., 2023).

   Pengukuran panjang badan dilakukan pada anak di bawah usia dua tahun atau yang belum bisa berdiri tegak, menggunakan alat ukur panjang *(infantometer)*. Diperlukan dua orang untuk prosedur ini: satu orang memegang kepala anak agar tetap lurus dengan puncak kepala menyentuh papan kepala, sementara orang kedua meluruskan kaki anak dan menggeser papan kaki hingga menyentuh tumit. Untuk anak yang lebih tua, pengukuran tinggi badan dilakukan dengan stadiometer. Anak berdiri tegak tanpa alas kaki, tumit, bokong, dan bahu menempel di dinding, dengan pandangan lurus ke depan. Alat ukur kemudian diturunkan hingga menyentuh puncak kepala (Hampl et al., 2023).

2. Pengukuran Lingkar Kepala, Lingkar Lengan Atas, dan Lingkar Dada

   Pengukuran lingkar kepala *(occipitofrontal circumference)* adalah prosedur standar untuk anak hingga usia 2-3 tahun untuk memantau pertumbuhan otak. Pita ukur yang fleksibel dan tidak elastis dilingkarkan di kepala pada bagian yang paling menonjol di belakang (protuberansia oksipital) dan tepat di atas alis (supraorbital ridge) di depan untuk mendapatkan lingkar maksimal. Pengukuran yang diulang harus konsisten untuk melacak pertumbuhan secara akurat (Veena, 2025).

   Lingkar Lengan Atas (LILA) (lihat gambar 3.3 Langkah-langkah pemeriksaan LILA anak) digunakan sebagai indikator cepat status gizi, terutama di komunitas atau situasi darurat untuk menyaring malnutrisi akut. Pengukuran dilakukan pada titik tengah antara ujung akromion (bahu) dan olekranon (siku) pada lengan kiri

yang tidak dominan dan dalam keadaan rileks. Lingkar dada biasanya diukur pada tingkat puting susu saat bayi dalam posisi telentang. Pada bayi baru lahir, lingkar dada normalnya sedikit lebih kecil dari lingkar kepala. Kedua lingkar ini menjadi sama ukurannya sekitar usia satu tahun (Oommen & Menon, 2024).



Gambar 3. 2 Langkah-langkah pemeriksaan LILA

3. Interpretasi Grafik Pertumbuhan *(WHO Chart & CDC Curve)*

Grafik pertumbuhan adalah alat esensial untuk mengevaluasi data antropometri dalam konteks usia dan jenis kelamin. WHO *growth charts* direkomendasikan untuk anak usia 0-2 tahun karena didasarkan pada studi pertumbuhan bayi yang diberi ASI sebagai standar normatif. CDC *growth charts* digunakan untuk anak usia 2 tahun ke atas. Grafik ini tersedia untuk berbagai parameter, termasuk berat badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat badan menurut tinggi badan, dan Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut usia (Hampl et al., 2023).

Interpretasi tidak hanya melihat satu titik data (satu pengukuran), tetapi yang lebih penting adalah melihat tren atau pola pertumbuhan dari waktu ke waktu. Seorang anak yang secara konsisten tumbuh di persentil ke-10 mungkin memiliki perawakan kecil yang normal secara genetik. Namun, seorang anak yang

sebelumnya berada di persentil ke-50 dan kemudian turun melintasi dua garis persentil utama (misalnya, ke persentil ke-10) memerlukan evaluasi lebih lanjut karena ini menandakan adanya gangguan pertumbuhan. Persentil di bawah 5 atau di atas 95 sering dianggap sebagai tanda waspada (red flag) yang memerlukan investigasi lebih mendalam (Hampl et al., 2023).

4. Prosedur Pengukuran Suhu, Nadi, dan Frekuensi Pernapasan Anak

   Pengukuran suhu pada anak dapat dilakukan melalui beberapa rute. Pengukuran rektal dianggap paling akurat untuk bayi, namun jarang dilakukan karena invasif. Suhu aksila (ketiak) adalah metode yang paling umum, aman, dan non-invasif, meskipun kurang akurat. Pengukuran suhu oral dapat dilakukan pada anak di atas 4-5 tahun yang kooperatif. Termometer timpani (telinga) dan arteri temporal (dahi) juga cepat dan mudah digunakan, tetapi teknik yang benar sangat penting untuk akurasi (Oommen & Menon, 2024).

   Frekuensi nadi pada bayi dan anak kecil paling baik diukur dengan metode auskultasi menggunakan stetoskop di apeks jantung (nadi apikal) selama satu menit penuh. Nadi radialis atau brakialis juga bisa digunakan pada anak yang lebih besar. Frekuensi pernapasan harus dihitung saat anak dalam keadaan tenang atau tidur dengan mengobservasi naik turunnya perut atau dada selama satu menit penuh. Penting untuk menghitung tanpa diketahui anak, karena kesadaran sedang diobservasi dapat mengubah pola napas mereka (Veena, 2025). Nilai normal untuk nadi dan pernapasan menurun seiring bertambahnya usia anak.

5. Teknik Pengukuran Tekanan Darah Berdasarkan Ukuran Manset

   Pengukuran tekanan darah yang akurat pada anak sangat bergantung pada pemilihan ukuran manset yang benar. Lebar manset harus sekitar 40% dari lingkar lengan atas, dan panjang kantung udara *(bladder)* di dalam manset harus melingkupi 80-100% lingkar lengan atas. Manset yang terlalu kecil akan memberikan hasil yang tinggi palsu, sedangkan manset yang terlalu besar akan memberikan hasil yang rendah palsu. Pengukuran sebaiknya dilakukan di lengan kanan pada posisi sejajar jantung setelah anak beristirahat selama beberapa menit (Hampl et al., 2023).

   Prosedur pengukuran sama seperti pada orang dewasa, menggunakan metode auskultasi atau osilometri (alat digital). Nilai normal tekanan darah pada anak bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan persentil tinggi badan. Tabel normatif tersedia untuk menentukan apakah tekanan darah seorang anak berada dalam rentang normal, prehipertensi, atau hipertensi. Pengukuran tekanan darah harus menjadi bagian rutin dari pemeriksaan pada anak di atas usia tiga tahun (Hampl et al., 2023).

D. Pemeriksaan Fisik *Head-to-Toe* pada Anak

Pemeriksaan fisik sistematis dari kepala hingga ujung kaki *(head-to-toe)* adalah puncak dari proses pengumpulan data objektif. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada sistem tubuh yang terlewatkan dan memungkinkan perawat untuk membangun gambaran klinis yang komprehensif. Urutan pemeriksaan pada anak seringkali perlu dimodifikasi berdasarkan usia, tingkat kerja sama, dan kondisi klinis. Prinsip atraumatic care tetap menjadi panduan utama: lakukan prosedur yang paling tidak mengganggu terlebih dahulu (misalnya, auskultasi jantung dan paru saat anak tenang) dan simpan prosedur yang paling mungkin menyebabkan penolakan (seperti pemeriksaan telinga dan tenggorokan) di bagian akhir.

Setiap langkah pemeriksaan melibatkan empat teknik dasar: inspeksi (melihat), auskultasi (mendengar dengan stetoskop), palpasi (meraba), dan perkusi (mengetuk). Namun, urutannya dapat bervariasi. Misalnya, pada pemeriksaan abdomen, auskultasi dilakukan sebelum palpasi dan perkusi untuk menghindari perubahan suara bising usus akibat manipulasi. Keberhasilan pemeriksaan fisik pada anak tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis, tetapi juga pada kemampuan perawat untuk mengubah proses tersebut menjadi permainan, memberikan distraksi, dan terus berkomunikasi dengan anak dan orang tua (Fontenot et al., 2022).

Inspeksi dimulai sejak saat pertama kali perawat bertemu dengan anak. Mengamati bagaimana anak bermain, berinteraksi dengan orang tua, pola pernapasan, warna kulit, dan postur tubuh dapat memberikan banyak informasi bahkan sebelum pemeriksaan formal dimulai. Penilaian status hidrasi, misalnya, dapat dimulai dengan menginspeksi membran mukosa, ada tidaknya air mata, dan turgor kulit. Pengetahuan mendalam tentang anatomi dan fisiologi pediatrik sangat penting. Batas-batas organ seperti hati dan limpa berbeda pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa, dan suara jantung serta paru memiliki karakteristik yang unik (Tan et al., 2021).

Pemeriksaan genitalia dan anus, meskipun penting, adalah area yang sangat sensitif dan memerlukan pendekatan yang profesional dan penuh hormat. Penjelasan yang jelas harus diberikan kepada orang tua dan anak (sesuai usia) mengenai tujuan pemeriksaan ini sebelum dilakukan. Selama seluruh proses, perawat harus terus mengamati respons anak, baik verbal maupun nonverbal, dan siap untuk berhenti sejenak atau mengubah pendekatan jika anak menunjukkan tanda-tanda distres yang signifikan.

Pada akhirnya, temuan-temuan dari pemeriksaan fisik tidak berdiri sendiri. Temuan tersebut harus diintegrasikan dengan data dari riwayat kesehatan dan

pengukuran antropometri untuk membentuk diagnosis keperawatan yang akurat. Sebuah bising jantung yang baru ditemukan, misalnya, harus dianalisis dalam konteks riwayat toleransi aktivitas anak dan data saturasi oksigen. Dengan demikian, pemeriksaan *head-to-toe* bukan hanya daftar periksa prosedur, melainkan proses analisis klinis yang dinamis.

Contoh Kasus: Seorang balita berusia 18 bulan datang dengan keluhan demam dan rewel. Selama inspeksi awal, perawat mengamati anak tersebut terus menerus menarik-narik telinga kanannya. Auskultasi paru-paru dan jantung, yang dilakukan saat anak berada di pangkuan ibunya, menunjukkan hasil dalam batas normal. Palpasi abdomen juga tidak menunjukkan nyeri tekan. Berdasarkan petunjuk dari inspeksi awal, perawat memutuskan untuk memeriksa telinga sebagai salah satu langkah terakhir. Dengan bantuan ibu untuk memegang anak, pemeriksaan otoskop menunjukkan membran timpani yang merah dan menonjol, sebuah tanda klasik otitis media akut (infeksi telinga tengah). Pendekatan yang fleksibel, dimulai dengan observasi tajam dan memprioritaskan prosedur non-invasif, memungkinkan diagnosis ditegakkan dengan distres minimal pada anak.

***Problem-based* dan *clinical reasoning* berdasarkan skenario di atas.**

Diagnosa Keperawatan Prioritas (SDKI):

"Nyeri Akut b/d agen injuri (infeksi telinga tengah) ditandai dengan menarik-narik telinga, demam, rewel."

Rencana Tujuan (SLKI):

"Anak akan menunjukkan penurunan intensitas nyeri dalam 1 jam setelah intervensi."

Rencana Intervensi (SIKI):

1. Manajemen Nyeri (I.0202)
   a. Kaji intensitas nyeri (skala FLACC untuk balita)
   b. Berikan posisi nyaman (dipeluk ibu)
   c. Aplikasikan kompres hangat di telinga (jika tidak ada kontraindikasi)
   d. Kolaborasi pemberian analgetik (parasetamol sesuai dosis pediatrik)
2. Manajemen Injeksi (I.0207)
   a. Kolaborasi pemberian antibiotik jika diresepkan dokter (amoksisilin)
3. Edukasi (I.0102)
   a. Ajarkan ibu cara meneteskan obat tetes telinga jika diresepkan
   b. Edukasi tanda bahaya (demam tinggi, nyeri hebat, keluar nanah)
4. Dukungan Emosional (I.0103)
   a. Dampingi ibu dan anak selama prosedur
   b. Ajarkan teknik distraksi (mainan, lagu)

Rasional:

1. Prioritas nyeri, karena anak rewel dan menarik telinga.
2. Tujuan spesifik: nyeri berkurang dalam 1 jam
3. Intervensi non-invasif dulu (kompres hangat, pelukan ibu) sebelum medikasi
4. Kolaborasi dengan dokter untuk terapi antibiotik

Evaluasi (SOAP Keperawatan):

S (Subjektif):

a. Ibu pasien: "Anak saya rewel terus, terus tarik-tarik telinganya, dan badannya panas.
b. "Anak 18 bulan, tidak bisa bicara tapi terlihat tidak nyaman.

O (Objektif):

a. Temperatur: 38,5°C
b. Inspeksi: Anak menarik-narik telinga kanan terus-menerusAuskultasi paru dan jantung: Dalam batas normal
c. Palpasi abdomen: Tidak ada nyeri tekan
d. Otoskop: Membran timpani kanan merah dan menonjol (tanda otitis media akut)

A (Asesmen):

a. Diagnosa Keperawatan Prioritas: Nyeri Akut b/d agen injuri (infeksi telinga tengah) ditandai dengan menarik-narik telinga, demam, rewel.
b. Tujuan: Anak akan menunjukkan penurunan intensitas nyeri dalam 1 jam setelah intervensi.

P (Plan/Intervensi):

Manajemen Nyeri (I.0202):

a. Kaji intensitas nyeri (skala FLACC)
b. Berikan posisi nyaman (dipeluk ibu)
c. Aplikasikan kompres hangat di telinga
d. Kolaborasi pemberian parasetamol 15mg/kgBB

Manajemen Injeksi (I.0207):

a. Kolaborasi pemberian amoksisilin 50mg/kgBB/8jam (jika diresepkan dokter)

Edukasi (I.0102):

a. Ajarkan ibu cara meneteskan obat tetes telinga (jika diresepkan)
b. Edukasi tanda bahaya (demam tinggi, nyeri hebat, keluar nanah)

Dukungan Emosional (I.0103):

a. Dampingi ibu dan anak selama prosedur
b. Ajarkan teknik distraksi (mainan, lagu)

Evaluasi (Tambahan):

a. 1 jam post-intervensi: Nyeri berkurang (FLACC 3→1), anak lebih tenang saat dipeluk ibu.
b. Rencana lanjutan: Kontrol ke dokter 2 hari lagi untuk evaluasi terapi antibiotik.

5. Inspeksi Kulit, Rambut, Kuku, dan Penilaian Dehidrasi

   Pemeriksaan dimulai dengan inspeksi umum terhadap kulit untuk warna (pucat, sianosis, ikterus, kemerahan), lesi (ruam, memar, bekas luka), dan kelembapan. Distribusi lesi seringkali memberikan petunjuk diagnosis, misalnya ruam vesikular pada tangan, kaki, dan mulut khas untuk *Hand, Foot, and Mouth Disease*. Rambut diperiksa untuk tekstur, distribusi, dan kebersihan. Kuku diperiksa untuk bentuk (*clubbing fingers* bisa menandakan hipoksia kronis) dan kebersihan (Lu et al., 2022).

   Penilaian dehidrasi adalah komponen kritis, terutama pada anak dengan demam, muntah, atau diare. Tanda-tanda dehidrasi meliputi membran mukosa yang kering, penurunan produksi air mata, mata cekung, dan ubun-ubun besar yang cekung (pada bayi). Turgor kulit dinilai dengan mencubit kulit secara perlahan di area perut atau dada; pada dehidrasi, kulit akan kembali dengan lambat. Tingkat dehidrasi (ringan, sedang, berat) dinilai berdasarkan kombinasi tanda-tanda ini dan persentase penurunan berat badan (Oommen & Menon, 2024).

6. Pemeriksaan Kepala, Mata, Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT)

   Pemeriksaan kepala mencakup palpasi sutura dan fontanel (ubun-ubun) pada bayi. Fontanel anterior normalnya lunak dan datar, dan menutup pada usia sekitar 9-18 bulan. Fontanel yang menonjol dapat mengindikasikan peningkatan tekanan intrakranial. Bentuk dan simetri kepala juga dinilai. Mata diperiksa untuk kesimetrisan, pergerakan bola mata (uji saraf kranial III, IV, VI), konjungtiva (anemia atau infeksi), dan refleks cahaya pupil (Morrell et al., 2021).

   Pemeriksaan telinga dengan otoskop memerlukan teknik yang benar untuk meluruskan liang telinga (pada anak di bawah 3 tahun, daun telinga ditarik ke bawah dan ke belakang). Hidung diperiksa untuk adanya sekret atau sumbatan. Tenggorokan dan mulut diperiksa terakhir menggunakan penekan lidah dan senter, untuk menilai kondisi tonsil, faring, dan gigi. Pemeriksaan ini seringkali memicu protes, sehingga harus dilakukan dengan cepat dan efisien (Lu et al., 2022).

7. Auskultasi Jantung dan Paru-paru Sesuai Batas Anatomi Anak

   Auskultasi jantung dan paru harus dilakukan di ruangan yang tenang. Pada anak, laju jantung dan pernapasan lebih cepat, dan dinding dada lebih tipis, sehingga suara dapat terdengar lebih jelas dan mudah menjalar. Auskultasi jantung dilakukan di empat area katup utama (aorta, pulmonal, trikuspid, mitral/apeks) untuk menilai bunyi jantung S1 dan S2, irama, dan adanya bunyi tambahan seperti murmur (bising) atau S3/S4 (Fontenot et al., 2022).

Auskultasi paru dilakukan secara sistematis, membandingkan sisi kanan dan kiri pada setiap tingkat interkostal, dari apeks hingga basis paru, baik di bagian depan maupun belakang. Perawat mendengarkan kualitas suara napas (misalnya, vesikuler), dan adanya suara napas tambahan seperti mengi (wheezing), ronki, atau rales/krepitasi. Penting untuk meminta anak menarik napas dalam (jika memungkinkan) untuk mendengar suara napas dengan lebih jelas (Tan et al., 2021).

8. Palpasi Perkusi Abdomen dan Pemeriksaan Genitalia/Anus

   Pemeriksaan abdomen dimulai dengan inspeksi kontur dan auskultasi bising usus di keempat kuadran. Palpasi dilakukan setelahnya, dimulai dengan palpasi ringan untuk menilai adanya nyeri tekan atau rigiditas otot, diikuti dengan palpasi dalam untuk mengidentifikasi massa atau organomegali (pembesaran hati atau limpa). Perkusi dapat membantu menentukan batas organ dan mendeteksi adanya cairan atau udara berlebih (Höhne et al., 2022).

   Pemeriksaan genitalia dan anus memerlukan sensitivitas tinggi. Pada anak laki-laki, penis dan skrotum diinspeksi, dan testis dipalpasi untuk memastikan keduanya telah turun. Pada anak perempuan, labia mayora dan minora serta klitoris diinspeksi. Anus diperiksa untuk adanya fisura atau iritasi. Pemeriksaan ini juga merupakan kesempatan untuk menilai kebersihan dan memberikan edukasi tentang higiene, serta waspada terhadap tanda-tanda pelecehan anak (Oommen & Menon, 2024).

9. Evaluasi Sistem Muskuloskeletal dan Kekuatan Otot Anak

   Pemeriksaan muskuloskeletal mencakup inspeksi postur, simetri tubuh, dan rentang gerak *(range of motion)* sendi. Tulang belakang diperiksa untuk adanya kelainan kurvatura seperti skoliosis (terutama pada remaja). Gaya berjalan *(gait)* dan koordinasi diobservasi saat anak berjalan atau berlari. Perawat juga memeriksa adanya pembengkakan, kemerahan, atau nyeri pada sendi-sendi (Moore et al., 2022).

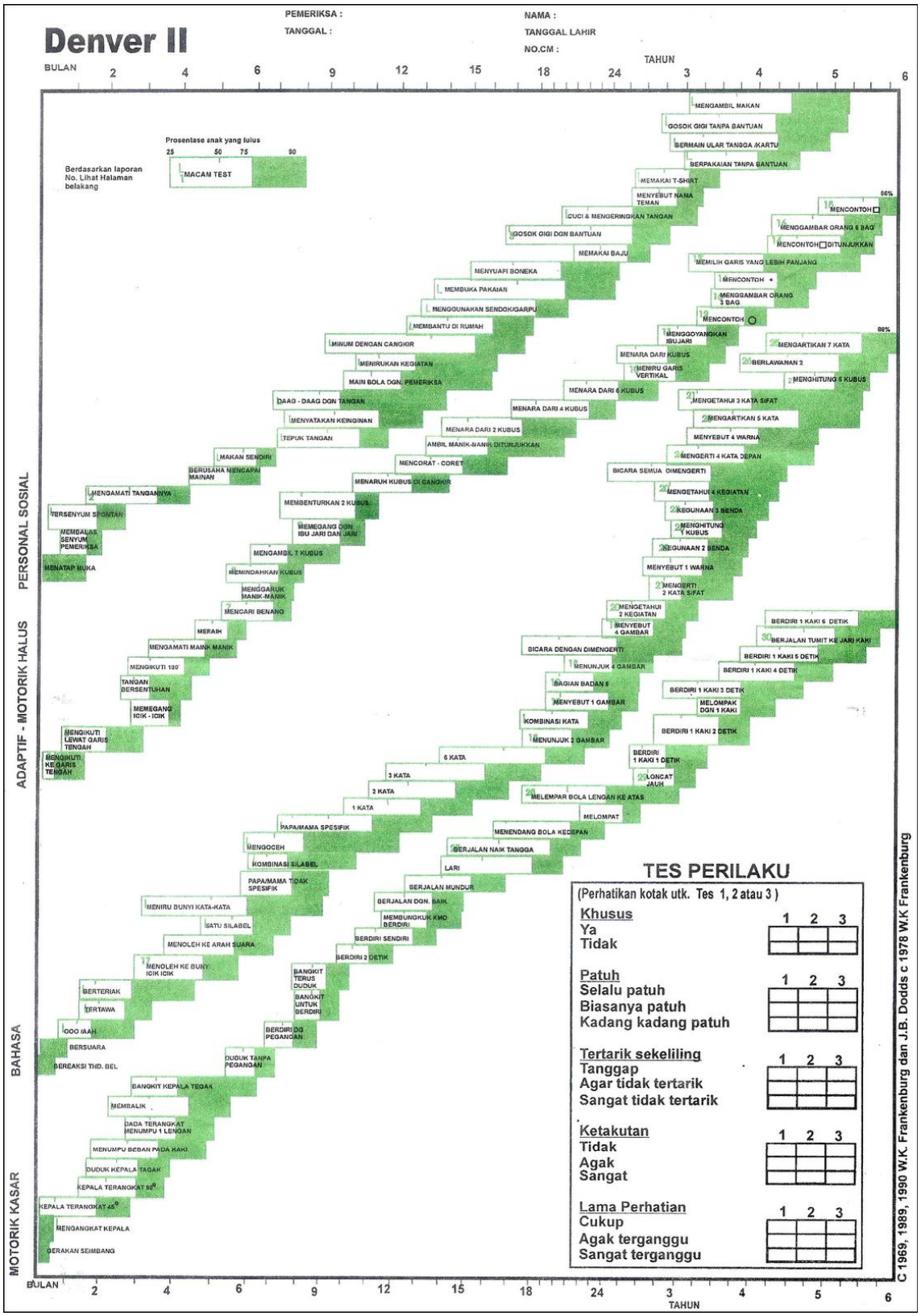
   Kekuatan otot dinilai dengan meminta anak untuk melakukan gerakan melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Misalnya, meminta anak untuk mendorong atau menarik tangan pemeriksa. Tonus otot dievaluasi dengan menggerakkan ekstremitas secara pasif untuk merasakan tingkat resistensinya. Pada bayi, tonus otot dinilai melalui observasi postur dan gerakan spontan. Penilaian ini penting untuk mengidentifikasi masalah neurologis atau perkembangan (Mayer et al., 2025).

E. Skrining Perkembangan dan Fungsi Neurologis

Pengkajian perkembangan dan fungsi neurologis adalah komponen esensial dari pemeriksaan pediatrik yang komprehensif. Berbeda dengan sistem organ lain yang perubahannya relatif lambat setelah lahir, sistem saraf anak mengalami maturasi yang sangat pesat dan dinamis, terutama dalam beberapa tahun pertama kehidupan. Oleh karena itu, pengkajian ini bukan hanya tentang mencari ada atau tidaknya kelainan, tetapi juga tentang memastikan bahwa anak mencapai tonggak-tonggak perkembangannya *(milestones)* sesuai dengan jadwal waktu yang diharapkan. Keterlambatan dalam satu domain perkembangan, seperti motorik kasar atau bahasa, bisa menjadi indikator awal dari masalah neurologis, genetik, atau lingkungan yang lebih signifikan.

Tujuan utama dari skrining perkembangan adalah identifikasi dini. Semakin dini keterlambatan atau gangguan perkembangan terdeteksi, semakin cepat intervensi dapat dimulai, dan semakin baik prognosis jangka panjangnya. Instrumen skrining terstandardisasi seperti Denver II (lihat gambar 3.2) atau Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) yang digunakan di Indonesia, bukanlah alat diagnostik. Sebaliknya, instrumen ini berfungsi sebagai jaring untuk "menangkap" anak-anak yang mungkin berisiko dan memerlukan evaluasi lebih lanjut oleh spesialis. Penggunaan alat skrining yang valid dan reliabel membantu menyingkirkan subjektivitas dan memberikan metode yang objektif untuk memantau kemajuan anak dari waktu ke waktu (Price et al., 2025).

Selain skrining perkembangan umum, pengkajian neurologis dasar juga penting dilakukan. Ini mencakup penilaian tingkat kesadaran, yang pada anak dapat lebih sulit dinilai dibandingkan orang dewasa. Skala Koma Glasgow Pediatrik *(Pediatric Glasgow Coma Scale)* (Lihat gambar 3.2) merupakan modifikasi dari skala dewasa yang disesuaikan untuk respons verbal dan motorik pada anak yang belum bisa berbicara. Pemeriksaan saraf kranial memberikan informasi mengenai fungsi batang otak, sementara evaluasi refleks, tonus otot, dan koordinasi memberikan gambaran tentang integritas sistem saraf pusat dan perifer (Abdeljelil et al., 2023).



Gambar 3. 3 Denver II

Pada bayi, pemeriksaan refleks primitif (seperti Moro, mengisap, dan menggenggam) sangat penting. Kehadiran refleks ini pada usia yang sesuai dan hilangnya refleks tersebut pada waktunya adalah indikator maturasi neurologis yang

normal. Persistensi refleks primitif melebihi usia yang seharusnya dapat menandakan adanya disfungsi serebral.

Akhirnya, semua data yang terkumpul, baik dari skrining perkembangan maupun pemeriksaan neurologis, harus didokumentasikan dengan cermat dan dianalisis secara kritis. Temuan harus dikomunikasikan secara jelas dan empatik kepada orang tua, dengan memberikan penjelasan mengenai langkah selanjutnya jika ditemukan adanya masalah. Peran perawat dalam domain ini sangat krusial, tidak hanya sebagai pelaksana skrining, tetapi juga sebagai edukator dan advokat bagi anak dan keluarga.

1. Penilaian Tingkat Kesadaran (Pediatric Glasgow Coma Scale)

   Penilaian tingkat kesadaran pada anak yang sakit kritis atau mengalami cedera kepala sangat penting untuk deteksi dini perburukan neurologis. *Pediatric Glasgow Coma Scale* (pGCS) (Tabel: 3.1) adalah adaptasi dari GCS dewasa, yang dimodifikasi terutama pada komponen respons verbal untuk mengakomodasi anak-anak preverbal. Skala ini menilai tiga kategori: pembukaan mata (skor 1-4), respons verbal (skor 1-5), dan respons motorik (skor 1-6). Skor total berkisar dari 3 (koma dalam) hingga 15 (sadar penuh) (Abdeljelil et al., 2023).

   Untuk respons verbal pada bayi, skor 5 diberikan untuk senyum atau ocehan yang sesuai, sementara skor 2 diberikan untuk rintihan kesakitan. Penilaian respons motorik juga disesuaikan, misalnya dengan mengobservasi gerakan spontan atau penarikan terhadap rangsang nyeri. Penggunaan pGCS memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan terstandardisasi, serta memfasilitasi komunikasi yang konsisten antar tenaga kesehatan mengenai status neurologis pasien (Abdeljelil et al., 2023).

Tingkat Kesadaran Kuantitatif (Abdeljelil et al., 2023).

Tabel 3. 1 Glasgow Coma Scale Anak

AKTIVITAS	RESPON		NILAI
	GCS (4 – 15 tahun)	GCS (<4 tahun)	
BUKA MATA	Spontan	Spontan	4
	Dengan perintah	Reaksi pada suara	3
	Dengan nyeri	Dengan nyeri	2
	Tidak ada respon	Tidak ada respon	1
VERBAL	Terorientasi	Terorientasi pada suara, senyum, mengikuti obyek, dapat berinteraksi	5

	Kacau/bingung	Menangis (mudah ditenangkan), interaksi tidak tepat	4
	Kata-kata tidak tepat	Menangis (sulit ditenangkan), merintih	3
	Suara	Menangis (tidak bisa ditenangkan), agitasi	2
	Tidak ada respon	Tidak ada respon	1
MOTORIK	Menurut perintah	Spontan/menurut perintah	6
	Lokalisasi nyeri	Lokalisasi nyeri	5
	Menarik karena nyeri	Menarik karena nyeri	4
	Dekortikasi	Dekortikasi	3
	Deserebrasi	Deserebrasi	2
	Tidak ada respon	Tidak ada respon	1

2. Pemeriksaan Saraf Kranial dan Refleks Primitif pada Bayi

   Pemeriksaan 12 saraf kranial pada anak, terutama bayi, seringkali dilakukan melalui observasi fungsi-fungsi alamiah. Misalnya, fungsi saraf optik (II) dinilai dengan melihat apakah bayi dapat mengikuti objek dengan matanya. Fungsi saraf fasialis (VII) dinilai dengan mengobservasi kesimetrisan wajah saat menangis atau tersenyum. Fungsi saraf glosofaringeal (IX) dan vagus (X) dinilai dari kemampuan menelan dan adanya refleks muntah *(gag reflex)* (Moore et al., 2022).

   Refleks primitif adalah refleks involunter yang penting untuk kelangsungan hidup bayi dan merupakan indikator fungsi batang otak dan sistem saraf yang belum matang. Contohnya termasuk refleks Moro (terkejut), refleks mengisap *(sucking)*, refleks mencari *(rooting)*, dan refleks genggam palmar dan plantar. Perawat harus memeriksa keberadaan dan kekuatan refleks ini. Yang sama pentingnya adalah mendokumentasikan kapan refleks ini menghilang, karena persistensi setelah usia tertentu dapat mengindikasikan patologi neurologis (Oommen & Menon, 2024).

3. Uji Koordinasi, Keseimbangan, dan Fungsi Sensorik-Motorik

   Pada anak yang lebih besar dan kooperatif, koordinasi dan keseimbangan dapat diuji dengan berbagai manuver. Uji jari ke hidung atau tumit ke tulang kering menilai fungsi serebelum. Meminta anak untuk berdiri dengan satu kaki, berjalan di atas garis lurus, atau melompat juga dapat digunakan untuk menilai keseimbangan. Kemampuan melakukan gerakan bolak-balik yang cepat, seperti

membolak-balikkan telapak tangan di paha, juga merupakan uji fungsi serebelum (Mayer et al., 2025).

Fungsi sensorik diuji dengan kemampuan anak untuk merasakan sentuhan ringan, nyeri (menggunakan benda tumpul dan tajam secara bergantian), atau getaran di berbagai bagian tubuh. Fungsi motorik dinilai melalui observasi gaya berjalan, tonus dan kekuatan otot, serta ada tidaknya gerakan involunter seperti tremor atau tic. Penilaian ini memberikan gambaran tentang integritas jalur sensorik dan motorik di sistem saraf (Mayer et al., 2025).

4. Pelaksanaan Skrining Denver II atau KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan)

   Denver II adalah salah satu alat skrining perkembangan yang paling banyak digunakan secara internasional untuk anak usia 0-6 tahun. Alat ini menilai perkembangan dalam empat sektor: personal sosial, motorik halus-adaptif, bahasa, dan motorik kasar. Prosedurnya melibatkan observasi langsung anak saat melakukan serangkaian tugas yang sesuai dengan usianya. Hasilnya tidak memberikan "skor" perkembangan, melainkan mengklasifikasikan performa pada setiap item sebagai normal, *caution* (peringatan), atau delayed (terlambat) (Price et al., 2025).

   Di Indonesia, Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) adalah alat skrining yang lebih sederhana dan umum digunakan di layanan kesehatan primer seperti Posyandu dan Puskesmas. KPSP terdiri dari serangkaian pertanyaan (ya/tidak) yang diajukan kepada orang tua atau pengasuh mengenai kemampuan yang telah dicapai oleh anak pada usia tertentu. Alat ini dirancang untuk dapat digunakan oleh kader kesehatan atau perawat dengan pelatihan minimal. Baik Denver II maupun KPSP bertujuan sama: identifikasi dini anak dengan kemungkinan penyimpangan perkembangan untuk dirujuk ke fasilitas evaluasi lebih lanjut (Bussard et al., 2023).

5. Dokumentasi dan Analisis Data Hasil Pengkajian Keperawatan

   Setelah seluruh data pengkajian terkumpul, langkah krusial berikutnya adalah dokumentasi yang akurat, lengkap, dan sistematis. Dokumentasi bukan hanya catatan, melainkan bukti legal dari asuhan yang diberikan dan alat komunikasi utama antar tim kesehatan. Data harus dicatat secara objektif, menggunakan terminologi medis yang standar, dan menghindari interpretasi atau opini subjektif. Temuan abnormal harus dideskripsikan secara rinci, termasuk lokasi, ukuran, bentuk, dan karakteristik lainnya (Wiseman et al., 2023).

   Analisis data adalah proses berpikir kritis di mana perawat mengelompokkan data-data yang signifikan (misalnya, data subjektif dan objektif yang saling berhubungan), mengidentifikasi pola, dan membandingkannya dengan standar atau nilai normal. Dari analisis inilah diagnosis keperawatan dapat

dirumuskan. Misalnya, data berupa membran mukosa kering, turgor kulit buruk, dan penurunan frekuensi buang air kecil dianalisis dan disintesis menjadi diagnosis keperawatan "Kekurangan Volume Cairan". Dokumentasi yang baik akan mencerminkan alur pikir klinis ini, menghubungkan antara data pengkajian dengan masalah yang diidentifikasi dan rencana intervensi yang akan dibuat (Cachata et al., 2025).

Aktivitas 1 *(Knows How)*

Mini-case tertulis

Kasus:

Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diantar ke klinik oleh ibunya dengan keluhan demam dan batuk selama 3 hari. Orang tua pasien ingin anaknya diperiksa secara komprehensif.

Tugas Anda:

Lakukan diskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis skenario pada kasus tersebut. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas. Data apa saja yang harus Anda kaji pada ibu dan anaknya? Dan susun rencana asuhan keperawatan yang terdiri dari diagnosa keperawatan prioritas, rencana tujuan dan intervensi, serta evaluasi (SOAP) berdasarkan SDKI, SLKI, dan SIKI.

Aktivitas 2 (*Shows How*)

Simulasi/skill lab pemeriksaan komprehensif pada anak.

Lakukan pemeriksaan fisik komprehensif pada ibu dan anak berdasarkan scenario pada poin F, mulai dari pengenalan diri, pengamatan umum, hingga pemeriksaan sistemik.

Waktu: 15 menit

Penilaian:

1. Pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien/orang tua (15%)
2. Pengamatan umum (15%)
3. Pemeriksaan sistemik (30%)
4. Keseluruhan proses pemeriksaan (20%)
5. Keselamatan pasien (20%)

Pemeriksaan yang harus dilakukan:

1. Pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien/orang tua
2. Pengamatan umum (tanda vital, keadaan umum, nutrisi)
3. Pemeriksaan kepala dan leher
4. Pemeriksaan thoraks (jantung, paru-paru)
5. Pemeriksaan abdomen
6. Pemeriksaan ekstremitas
7. Pemeriksaan neurologis (reflex, kekuatan otot)

Instruksi:

1. Lakukan pemeriksaan dengan sopan dan ramah
2. Jelaskan setiap langkah pemeriksaan kepada pasien/orang tua
3. Gunakan bahasa yang mudah dipahami
4. Catat hasil pemeriksaan di lembar jawaban yang disediakan

Kunci jawaban Aktivitas 1 (Poin F: *Knows How*):

Data yang Harus Dikaji:

1. Anamnesa (Ibu/Pasien):
   a. Keluhan utama: Demam dan batuk 3 hari
   b. Riwayat penyakit sekarang:
      1) Kapan mulai?
      2) Apakah ada kontak dengan orang sakit?
      3) Sifat demam (tinggi/rendah, kontinu/intermiten)
      4) Karakter batuk (kering/basah, warna dahak)
   c. Riwayat imunisasi: Lengkap/tidak (khususnya DPT, Influenza, Pneumokok)
   d. Riwayat alergi: Ada obat/bahan makanan?
   e. Pola makan dan minum: Apakah anak mau makan/minum?
   f. Riwayat pengobatan: Apakah sudah minum obat?
2. Pemeriksaan Fisik Anak:
   a. Tanda vital: Suhu, N, RR, SpO2
   b. Status gizi: Berat badan, tinggi badan
   c. Pemeriksaan fisik:
   d. Kepala: Apakah ada tanda dehidrasi?
   e. Tenggorokan: Apakah ada hiperemi faring?
   f. Paru: Apakah ada wheezing/ronkhi?
   g. Jantung: Batas jantung & suara jantung
   h. Abdomen: Nyeri tekan?
3. Psikososial:
   a. Bagaimana interaksi anak dengan ibu?
   b. Apakah anak rewel/tangisan?

Rencana Asuhan Keperawatan:

S (Subjektif):

a. Ibu: "Anak saya demam dan batuk 3 hari, awalnya cuma hidung berair, sekarang batuknya kenceng.
b. "Anak 5 tahun, masih mau main tapi lemas.

O (Objektif):

a. T: 38°C, N: 110x/mnt, RR: 28x/mnt, SpO2: 98%
b. Pemeriksaan: Hiperemi faring (+), paru vesikuler (+), tidak ada wheezing/ronkhi.
c. Status gizi: Dalam batas normal.

A (Asesmen):

Diagnosa Keperawatan Prioritas: Hipertermia b/d proses infeksi (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) ditandai dengan demam 38°C, batuk, dan lemas.

Tujuan:

Anak akan menunjukkan suhu tubuh normal dalam 24 jam.

P (Plan/Intervensi):

Manajemen Hipertermia (I.0205):

a. Monitor T & RR tiap 4 jam
b. Kompres hangat di aksila/inguinal
c. Kolaborasi parasetamol 15mg/kgBB jika T>38,5°C

Manajemen Cairan (I.0203):

a. Anjurkan minum banyak (minimal 8 gelas/hari)
b. Monitor input-output

Edukasi (I.0102):

a. Ajarkan ibu tanda bahaya (sesak napas, demam >39°C, muntah)
b. Edukasi hygiene tangan dan etika batuk

Dukungan Nutrisi (I.0104):

a. Anjurkan makanan lunak dan porsi kecil tapi sering

Evaluasi (SOAP):

a. 2 jam post-intervensi: T↓ 37,5°C, anak lebih aktif, batuk masih ada tapi tidak kenceng.
b. Rencana lanjutan: Kontrol ke dokter 2 hari lagi jika tidak ada perbaikan.

SOAL OSCE PENGKAJIAN KOMPREHENSIF ANAK

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	.....
2	Judul station	Pengkajian Komprehensif pada Anak dengan Demam dan Batuk
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian komprehensif pada anak dan ibunya.
5	Kompetensi	1. Pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien/orang tua 2. Pengamatan umum (tanda vital, keadaan umum, nutrisi) 3. Pemeriksaan kepala dan leher 4. Pemeriksaan thoraks (jantung, paru-paru) 5. Pemeriksaan abdomen 6. Pemeriksaan ekstremitas 7. Pemeriksaan neurologis (reflex, kekuatan otot)
6	Kategori	1. Aman dan nyaman 2. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diantar ke klinik oleh ibunya dengan keluhan demam dan batuk selama 3 hari. Orang tua pasien ingin anaknya diperiksa secara komprehensif. TUGAS: 1. Lakukan pemeriksaan dengan sopan dan ramah 2. Jelaskan setiap langkah pemeriksaan kepada pasien/orang tua 3. Gunakan bahasa yang mudah dipahami 4. Catat hasil pemeriksaan di lembar jawaban yang disediakan
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun diantar ke klinik oleh ibunya dengan keluhan demam dan batuk selama 3 hari. Orang tua pasien ingin anaknya diperiksa secara komprehensif.

No.	Komponen	Isi
		TUGAS: 1. Lakukan pemeriksaan dengan sopan dan ramah 2. Jelaskan setiap langkah pemeriksaan kepada pasien/orang tua 3. Gunakan bahasa yang mudah dipahami 4. Catat hasil pemeriksaan di lembar jawaban yang disediakan INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pemeriksaan dengan sopan dan ramah 2. Menilai kemampuan peserta dalam Jelaskan setiap langkah pemeriksaan kepada pasien/orang tua 3. Menilai kemampuan peserta dalam menggunakan bahasa yang mudah dipahami 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam mencatat hasil pemeriksaan di lembar jawaban yang disediakan. 5. Monitor perilaku profesional peserta. 6. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Identitas pasien sesuai kasus: anak laki-laki usia 5 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. 2. Riwayat keperawatan sekarang: anak mengalami demam dan batuk selama 3 hari. 3. Riwayat penyakit keluarga: di keluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. 4. Riwayat kebiasaan sosial: ibu tampak cemas, anak rewel, lebih sering ingin digendong, dan belum nyaman dengan lingkungan rumah sakit. 5. Bila peserta menanyakan sejak kapan demam dan batuk, jawaban KS: sejak 3 hari yang lalu. 6. Bila peserta menanyakan apa yang sudah dilakukan pada anak, jawaban KS: memberikan kompres dingin, dan tidak diberi obat apapun. 7. KS duduk di samping tempat tidur anak dengan raut wajah cemas. Anak dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu

No.	Komponen	Isi
		pasien anak. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Jalan Penyakit Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1.Tempat tidur dan manekin anak 2.Kursi KS 3.Meja penguji 4.Kursi penguji 5.Pintu masuk 6.Troli alat 7.Wastafel/handrub 8.Tempat sampah 9.Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Alcohol base handrub/hand sanitizer 3. Tisu 4. Bengkok 5. Tensimeter anak 6. Stetostkop 7. Termometer anak 8. Jam tangan 9. Metlen 10. Penlight 11. Timbangan BB 12. Denver II Chart 13. Lembar jawaban peserta. Peran laboran:

No.	Komponen	Isi
		merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Budiyati, SKp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.
13	Referensi	Cioffredi, L., Yerby, L., Burris, H., Cole, K., Engel, S., Murray, T., Slopen, N., Volk, H., & Acheson, A. (2024). Assessing prenatal and early childhood social and environmental determinants of health in the HEALthy Brain and Child Development Study (HBCD). Developmental Cognitive Neuroscience, 69. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101429 Fontenot, N., Hamlin, S., Hooker, S., Vazquez, T., & Chen, H. (2022). Physical assessment competencies for nurses: A quality improvement initiative. Nursing Forum, 57, 710-716. https://doi.org/10.1111/nuf.12725 PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP PENGKAJIAN KOMPREHENSIF ANAK

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih b. Alcohol base handrub/hand sanitizer c. Tisu d. Bengkok e. Tensimeter anak f. Stetostkop g. Termometer anak h. Jam tangan i. Metlen j. Penlight k. Timbangan BB l. Denver II Chart m. Lembar jawaban peserta.				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Pengenalan Diri dan Komunikasi: a. Perkenalkan diri kepada pasien/orang tua b. Pastikan pasien/orang tua setuju untuk dilakukan pengkajian				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama anak dan tanggal lahir secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan pengkajian komprehensif serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 24: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih sebagai tindakan kewaspadaan standar (standart precaution).				
13	Melakukan Pengumpulan Data: a. Identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll) b. Keluhan utama c. Riwayat kesehatan d. Riwayat imunisasi e. Riwayat keluarga				
14	Melakukan Pengamatan Umum: a. Tanda vital (suhu, tekanan darah, nadi, respirasi) b. Keadaan umum (kesadaran, nutrisi, hidrasi)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	c. Pengamatan fisik (bentuk tubuh, postur, gerakan)				
15	Melakukan Pemeriksaan Sistemik: a. Pemeriksaan kepala dan leher b. Pemeriksaan thoraks (jantung, paru-paru) c. Pemeriksaan abdomen d. Pemeriksaan ekstremitas e. Pemeriksaan neurologis (reflex, kekuatan otot)				
16	Melakukan Pemeriksaan Khusus: a. Pemeriksaan mata b. Pemeriksaan telinga c. Pemeriksaan hidung d. Pemeriksaan mulut dan tenggorokan				
17	Melakukan Dokumentasi: a. Catat hasil pengkajian b. Catat rencana asuhan keperawatan c. Berikan instruksi kepada pasien/orang tua				
18	Merapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
19	Melepaskan sarung tangan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				
20	Menyimpulkan kegiatan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
21	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
22	Memberikan reinforcement positif				
23	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
24	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
25	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian komprehensif, respons ibu dan anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
26	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENGKAJIAN KOMPREHENSIF PADA ANAK

II. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien/orang tua	Menyampaikan salam, melakukan pengumpulan data yang meliputi: Identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll), Keluhan utama, Riwayat kesehatan, Riwayat imunisasi, dan Riwayat keluarga					1	
2	Pengamatan umum (tanda vital, keadaan umum, nutrisi)	Menjelaskan tujuan tindakan pengamatan umum yang meliputi: Tanda vital (suhu, tekanan darah, nadi, respirasi), Keadaan umum (kesadaran, nutrisi, hidrasi), dan pengamatan fisik (bentuk tubuh, postur, gerakan).					2	
3	Pemeriksaan sistemik	Menjelaskan tujuan melakukan pemeriksaan sistemik: Pemeriksaan kepala dan leher, Pemeriksaan thoraks (jantung, paru-paru), Pemeriksaan abdomen, Pemeriksaan ekstremitas, dan Pemeriksaan neurologis (reflex, kekuatan otot).					2	
4	Pemeriksaan khusus	Menjelaskan tujuan pemeriksaan khusus: Pemeriksaan mata, Pemeriksaan telinga, Pemeriksaan hidung, dan Pemeriksaan mulut dan tenggorokan					2	
5	Melakukan dokumentasi	Menjelaskan tujuan melakukan dokumentasi: Catat hasil pengkajian, Catat rencana asuhan					2	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		keperawatan, dan berikan instruksi kepada pasien/orang tua						
8	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENGKAJIAN KOMPREHENSIF ANAK

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien/orang tua: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menyampaikan salam, melakukan pengumpulan data yang meliputi: Identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll), Keluhan utama, Riwayat kesehatan, Riwayat imunisasi, dan Riwayat keluarga, kemampuan melakukan komunikasi atraumatik pada anak.					1	
2. Pengamatan umum (tanda vital, keadaan umum, nutrisi): Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengukuran tanda-tanda vital, keadaan umum, dan status nutrisi pasien. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
3. Pemeriksaan sistemik: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pemeriksaan kepala dan leher, thoraks, abdomen, ekstremitas, dan neurologis. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
4.Pemeriksaan khusus: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut dan tenggorokan. Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
5. Melakukan dokumentasi: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan dokumentasi: Catat hasil pengkajian, Catat rencana asuhan keperawatan, dan berikan instruksi kepada pasien/orang tua. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	
6. Perilaku Profesional: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan ibu/pengasuh, menjaga kenyamanan dan keamanan anak, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					1	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengenalan diri dan komunikasi dengan	Tidak melakukan pengenalan diri dan komunikasi	Melakukan pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien dan orangtua	Melakukan pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien	Melakukan pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien dan orangtua

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
pasien/orang tua	dengan pasien dan orangtua.	sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mengidentifikasi keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat imunisasi, dan riwayat keluarga secara tepat.	dan orangtua cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti: salam, melakukan pengumpulan data identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll), keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat imunisasi, dan riwayat keluarga, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi menyampaikan salam, melakukan pengumpulan data yang meliputi: identitas pasien (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dll), keluhan utama, riwayat kesehatan, riwayat imunisasi, dan riwayat keluarga, kemampuan melakukan komunikasi atraumatik pada anak.
2. Pengamatan umum (tanda vital, keadaan umum, nutrisi)	Tidak melakukan pengamatan umum yang meliputi pengukuran	Melakukan pengamatan umum yang meliputi pengukuran tanda-tanda vital,	Melakukan pengamatan umum yang meliputi pengukuran tanda-tanda	Melakukan pengamatan umum yang meliputi pengukuran tanda-tanda

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	tanda-tanda vital, keadaan umum, dan status nutrisi pasien	keadaan umum, dan status nutrisi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	vital, keadaan umum, dan status nutrisi pasien cukup baik dan cukup sistematis.	vital, keadaan umum, dan status nutrisi pasien dengan lengkap, relevan, dan sistematis.
3. Pemeriksaan sistemik	Tidak melakukan pemeriksaan sistemik, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan pemeriksaan sistemik secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan pemeriksaan sistemik: pemeriksaan kepala dan leher, thoraks, abdomen, ekstremitas, dan neurologis dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan pemeriksaan sistemik: pemeriksaan kepala dan leher, thoraks, abdomen, ekstremitas, dan neurologis dengan lengkap, relevan, dan sistematis.
4. Pemeriksaan khusus	Tidak melakukan pemeriksaan khusus yang	Melakukan pemeriksaan khusus yang meliputi	Melakukan pemeriksaan khusus yang meliputi	Melakukan pemeriksaan khusus yang meliputi

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	meliputi pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut dan tenggorokan, atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut dan tenggorokan secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut dan tenggorokan dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	pemeriksaan mata, telinga, hidung, dan mulut dan tenggorokan dengan lengkap, relevan, dan sistematis.
5. Melakukan dokumentasi	Tidak melakukan dokumentasi/ mencatat hasil pengkajian, komprehensif pada pasien dan orangtua.	Melakukan dokumentasi secara terbatas, banyak hasil pengkajian penting yang tidak didokumentasikan.	Melakukan dokumentasi hasil pengkajian dengan cukup baik, sebagian besar catatan sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam kelengkapan dokumen.	Melakukan dokumentasi/ mencatat hasil pengkajian, komprehensif pada pasien dan orangtua secara tepat, sistematis, dan lengkap.
6. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik,	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

Nama Kota, tanggal, bulan, dan tahun
Tanda tangan penguji
(Nama Penguji)

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS/Does)
DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pengkajian komprehensif anak
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi menuju praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Pengkajian Komprehensif Anak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan melakukan pengkajian komprehensif pada ibu dan anak yang mengalami demam dan batuk di poli rawat jalan anak.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian,	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang pengkajian komprehensif pada ibu dan anak yang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	mengalami demam dan batuk di poli rawat jalan anak, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan kondisi anak, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu pasien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang anak usia 5 tahun dibawa ibu ke poli rawat jalan karena mengalami demam dan batuk sejak tiga hari yang lalu.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian sistemik singkat namun terarah terkait demam dan batuk, memeriksa tanda-tanda vital, menyampaikan rencana pemantauan asuhan keperawatan selanjutnya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali masalah demam dan batuk dengan bahasa sederhana menggunakan teknik non traumatik, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu pasien.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya hipertermi dan bersihan jalan napas tidak efektik, serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada keluarga.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	komunikasi dan identifikasi tanda gejala berupa demam dan batuk, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian seperti penyebab batuk dan demam pada anak.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan demam dan batuk, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan pengkajian komprehensif yang aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan oleh peserta didik:

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3. 2 Portofolio pada Pengkajian Komprehensif Anak

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada pengkajian komprehensif anak dengan demam dan batuk selama tiga hari, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian komprehensif secara tepat, menetapkan masalah keperawatan, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mengkaji dan merawat anak dengan demam dan batuk, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan pengkajian komprehensif, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian komprehensif pada anak dengan demam dan batuk di unit rawat jalan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus anak usia 5 tahun dengan demam dan batuk sejak 3 hari sebelum dibawa ke rumah sakit, pengkajian sistemik, diagnosis keperawatan prioritas, dan evaluasi respons anak dan ibu.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau demam dan batuk, penyebab dalam pengkajian sistemik yang komprehensif, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari *Clinical Instructor* (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu dan anak selama pengkajian komprehensif, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian dan dokumentasi hasil pengkajian.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus demam dan batuk, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian sistemik yang komprehensif, dan komunikasi terapeutik dengan ibu dan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada pengkajian komprehensif anak dengan demam dan batuk, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep mengkaji pada anak dengan demam dan batuk, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 3. 3 Case Report pada Pengkajian Komprehensif Anak dengan Demam dan Batuk

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami,	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang hasil pengkajian komprehensif pada seorang anak usia 5 tahun yang diantar ibunya ke poli

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	rawat jalan dengan demam dan batuk yang telah dialami 3 hari yang lalu.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi anak setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada pengkajian komprehensif anak dengan demam dan batuk, mahasiswa menuliskan hasil pengkajian, masalah prioritas dan rencana tindak lanjut.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data hasil pengkajian anak dengan demam dan batuk dengan masalah utama, dan merencanakan tindakan selanjutnya.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari hasil pengkajian anak dengan demam dan batuk, mahasiswa belajar bahwa pengkajian sistemik yang tepat merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan anak.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pengkajian komprehensif anak dengan demam dan batuk, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 3. 4 Refleksi Patient Safety pada Pengkajian Komprehensif Anak dengan Demam dan Batuk

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah,	Pada pengkajian komprehensif anak dengan demam dan batuk, mahasiswa merefleksikan bahwa pengkajian yang tepat akan membantu menentukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
	dan merencanakan tindakan pencegahan.	masalah keperawatan dan rencana tindakan yang tepat pula.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti dalam melakukan pengkajian komprehensif anak dapat berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pengkajian komprehensif pada pasien anak adalah trauma yang menyebabkan anak takut pada petugas, sehingga perlu pendekatan *atraumatic care* selama melakukan pengkajian.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kesalahan teknik pengkajian, data yang diperoleh tidak relevan, dan trauma pada anak.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya menggunakan pendekatan *atraumatic care* selama melakukan pengkajian pada anak.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian pada anak dengan demam dan batuk butuh ketelitian, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan klarifikasi ulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan pengkajian komprehensif pada anak, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak secara berkelanjutan.

F. RINGKASAN

Pengkajian Komprehensif Anak

Bab ini menekankan Pendekatan Fundamental: Pengkajian anak harus selalu didasarkan pada filosofi atraumatic care yang bertujuan meminimalkan stres fisik dan psikologis bagi anak dan keluarga. Komunikasi sebagai Kunci: Keberhasilan pengkajian sangat bergantung pada kemampuan membangun rapport dan kepercayaan, serta menggunakan teknik komunikasi dan alloanamnesis yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang. Pengkajian Holistik: Riwayat kesehatan yang komprehensif harus mencakup domain prenatal, natal, postnatal, imunisasi, nutrisi, pola kebiasaan, psikososial, dan lingkungan untuk mendapatkan gambaran utuh.

Data Objektif Pertumbuhan: Pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala) dan interpretasinya menggunakan grafik pertumbuhan WHO/CDC adalah alat vital untuk memantau pertumbuhan fisik anak. Penilaian Fisiologis: Pengukuran tanda-tanda vital (suhu, nadi, pernapasan, tekanan darah) harus dilakukan dengan teknik yang benar dan alat yang sesuai ukuran untuk mendapatkan data fisiologis yang akurat. Pemeriksaan Sistematis: Pemeriksaan fisik head-to-toe harus dilakukan secara sistematis namun fleksibel, dengan memprioritaskan prosedur non-invasif terlebih dahulu untuk menjaga kerja sama anak. Skrining Perkembangan: Penggunaan instrumen skrining terstandardisasi (misalnya, Denver II atau KPSP) sangat penting untuk identifikasi dini keterlambatan perkembangan. Dokumentasi dan Analisis: Seluruh data hasil pengkajian harus didokumentasikan secara akurat dan dianalisis secara kritis untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat.

Tabel 3. 5 Red Flags dan Eskalasi: Pengkajian Komprehensif Anak

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Anak dengan riwayat demam sudah 3 hari	Kondisi demam disertai batuk dapat disebabkan oleh kondisi, seperti: ISPA, infeksi bakteri, alergi, atau infeksi virus lain.	Tindakan ekskalasi perawat pada anak dengan riwayat demam disertai batuk selama 3 hari dapat meliputi: Pemeriksaan Awal: Mengukur tanda vital (suhu, tekanan darah, nadi, respirasi), Mengamati keadaan umum anak (kesadaran, nutrisi, hidrasi), Mengidentifikasi gejala-gejala yang menyertai (batuk, sesak napas), pengumpulan Data: dengan mengkaji riwayat kesehatan anak, mengidentifikasi faktor risiko (seperti riwayat alergi, penyakit kronis), mengamati pola batuk dan demam. Tindakan Keperawatan: memberikan obat antipiretik sesuai order dokter (seperti

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		paracetamol) untuk menurunkan demam, memberikan obat ekspektoran (seperti salbutamol) untuk membantu mengeluarkan dahak, memberikan terapi oksigen (jika diperlukan). Mengajarkan orang tua cara mengukur suhu dan memberikan obat. Edukasi orang tua, monitoring dan evaluasi, kolaborasi dengan dokter.
Anak dengan riwayat batuk sudah 3 hari	Makna klinis anak dengan riwayat batuk sudah 3 hari dapat menunjukkan beberapa kemungkinan, antara lain: Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA), seperti: Influenza, Bronchitis, Pneumonia, dan Sinusitis; Infeksi Bakteri: Batuk yang berlangsung selama 3 hari juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti: Pneumonia bakteri, Bronchitis bakteri, Sinusitis bakteri; Alergi: Batuk yang berlangsung selama 3 hari dapat menjadi gejala alergi, seperti: Alergi debu, polen, makanan; Penyakit Kronis: Batuk yang berlangsung selama 3 hari juga dapat menjadi gejala penyakit kronis, seperti: Asthma, Bronchitis kronis, Penyakit paru-paru kronis. Namun, perlu diingat bahwa batuk yang berlangsung selama 3 hari juga dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius, seperti: Pneumonia yang tidak diobati, Tuberculosis, atau Kanker paru-paru.	Tindakan ekskalasi keperawatan pada anak dengan riwayat batuk sudah 3 hari dapat meliputi: Pemeriksaan Awal: Mengukur tanda vital (suhu, tekanan darah, nadi, respirasi), Mengamati keadaan umum anak (kesadaran, nutrisi, hidrasi), Mengidentifikasi gejala-gejala yang menyertai (batuk, sesak napas, dll); Pengumpulan Data: Mengambil riwayat kesehatan anak, Mengidentifikasi faktor risiko (seperti riwayat alergi, penyakit kronis, dll), Mengamati pola batuk dan gejala-gejala lain; Tindakan Keperawatan: Memberikan obat ekspektoran (seperti salbutamol) untuk membantu mengeluarkan dahak, Memberikan terapi oksigen (jika diperlukan), Mengajarkan orang tua cara mengukur suhu dan memberikan obat, Mengajarkan orang tua cara merawat anak dengan batuk; Edukasi Orang Tua: Mengingatkan orang tua untuk memantau keadaan anak dan menghubungi dokter jika gejala memburuk, Memberikan informasi tentang pentingnya imunisasi dan pencegahan penyakit, Mengajarkan orang tua cara mengenali gejala-gejala yang memerlukan perhatian medis segera; Monitoring dan Evaluasi: Memantau keadaan anak secara teratur, Mengukur tanda vital dan mengamati gejala-gejala, Mengevaluasi efektivitas tindakan keperawatan dan membuat penyesuaian jika diperlukan; Kolaborasi dengan Dokter: Menginformasikan dokter tentang keadaan anak dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan, Meminta instruksi dokter tentang pengobatan dan perawatan lanjutan.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab Pengkajian Komprehensif Anak

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah dapat menjelaskan pengertian pengkajian komprehensif pada anak dengan demam dan batuk yang datang di poli rawat jalan	☐	☐	_____
2	Saya sudah dapat melakukan pengenalan diri dan komunikasi dengan pasien anak dan orang tua	☐	☐	_____
3	Saya sudah dapat melakukan pengamatan umum yang meliputi pemeriksaan tanda vital, keadaan umum, nutrisi	☐	☐	_____
4	Saya sudah dapat melakukan pemeriksaan sistemik (sistem pernapasan dan termoregulasi) pada anak dengan demam dan batuk 3 hari	☐	☐	_____
5	Saya sudah dapat melakukan pemeriksaan khusus yang meliputi pemeriksaan mata, telinga, hidung, mulut dan tenggorokan pada anak dengan demam dan batuk 3 hari	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat hasil pengkajian komprehensif anak dengan riwayat demam dan batuk 3 hari	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat mengkaji anak dengan riwayat demam dan batuk 3 hari	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Latihan Soal

Setelah menyelesaikan pembelajaran Bab 3, silahkan kerjakan soal latihan berikut dengan memilih satu jawaban yang benar untuk mengukur pemahaman Anda tentang Pemeriksaan komprehensif anak.

1. Prinsip melakukan prosedur yang paling tidak nyaman di akhir pemeriksaan pada anak adalah implementasi dari konsep ...
   A. Alloanamnesis
   B. Antropometri
   C. Atraumatic Care
   D. Tanda-tanda Vital
   E. Autoanamnesis

2. Saat melakukan pemeriksaan telinga dengan otoskop pada anak berusia 2 tahun, teknik yang benar untuk meluruskan liang telinga adalah...
   A. Menarik daun telinga ke atas dan ke belakang
   B. Menarik daun telinga ke bawah dan ke belakang
   C. Menarik daun telinga lurus ke belakang
   D. Menekan tragus dengan lembut
   E. Menarik daun telinga lurus ke atas

3. Grafik pertumbuhan yang direkomendasikan oleh WHO untuk memantau pertumbuhan anak dari lahir hingga usia 2 tahun didasarkan pada standar...
   A. Anak yang diberi susu formula
   B. Anak dari negara maju
   C. Rata-rata pertumbuhan anak secara global
   D. Anak yang diberi ASI eksklusif
   E. Anak yang lahir tanpa cacat fisik

4. Seorang perawat mengukur lingkar kepala bayi dan membandingkannya dengan lingkar dada. Pada bayi baru lahir yang sehat, perbandingan yang normal adalah...
   A. Lingkar kepala lebih besar dari lingkar dada
   B. Lingkar dada lebih besar dari lingkar kepala
   C. Lingkar kepala dan lingkar dada sama besar
   D. Lingkar dada dua kali lebih besar dari lingkar kepala
   E. Lingkar kepala dua kali lebih besar dari lingkar dada

5. Refleks primitif pada bayi yang ditandai dengan reaksi terkejut saat ada stimulus tiba-tiba, di mana bayi merentangkan lengan dan kakinya lalu menariknya kembali, disebut refleks...
   A. Mengisap (Sucking)
   B. Genggam (Grasping)
   C. Moro
   D. Babinski
   E. Chadoks

6. Skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pada anak yang mengalami cedera kepala, yang telah dimodifikasi untuk populasi preverbal, adalah...
   A. Skala Nyeri FLACC
   B. Skor APGAR
   C. Skala Koma Glasgow Pediatrik
   D. Skrining Denver II
   E. Skala Nyeri PQRST

7. Seorang anak memiliki berat badan di persentil ke-75, artinya...
   A. Anak tersebut mengalami obesitas
   B. 75% anak seusianya memiliki berat badan lebih rendah darinya
   C. Anak tersebut kekurangan gizi
   D. 75% anak seusianya memiliki berat badan lebih tinggi darinya
   E. 25% anak seusianya memiliki berat badan lebih rendah darinya

8. Saat melakukan auskultasi abdomen, urutan pemeriksaan yang benar adalah...
   A. Palpasi, Auskultasi, Perkusi, Inspeksi
   B. Inspeksi, Palpasi, Perkusi, Auskultasi
   C. Inspeksi, Auskultasi, Perkusi, Palpasi
   D. Perkusi, Palpasi, Inspeksi, Auskultasi
   E. Inspeksi, Palpasi, Auskultasi, Perkusi

9. Bunyi napas tambahan bernada tinggi yang terdengar seperti siulan, terutama saat ekspirasi, dan sering dikaitkan dengan penyempitan jalan napas seperti pada asma, disebut...
   A. Ronki
   B. Rales
   C. Krepitasi
   D. Mengi
   E. Vesikuler

10. Assent dalam konteks etika keperawatan anak merujuk pada...
    A. Persetujuan tindakan medis dari orang tua atau wali sah
    B. Penolakan tindakan medis oleh anak
    C. Persetujuan afirmatif dari anak yang sudah mampu memahami untuk berpartisipasi dalam prosedur
    D. Catatan medis elektronik yang terenkripsi
    E. Persetujuan orang tua anak

Kunci Jawaban:

1. C. Menerapkan konsep atraumatic care saat melakukan prosedur yang tidak nyaman pada anak sangat penting karena beberapa alasan: Mengurangi stres dan trauma: a. Anak-anak lebih rentan terhadap stres dan trauma akibat prosedur medis yang tidak nyaman. Atraumatic care membantu mengurangi stres dan trauma tersebut. b. Meningkatkan kepercayaan, dengan menerapkan atraumatic care, anak-anak dan orang tua mereka akan merasa lebih nyaman dan percaya pada perawat. c. Mengurangi rasa sakit: Atraumatic care dapat membantu mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakan anak. d. Meningkatkan kerjasama: Anak-anak yang merasa nyaman dan tidak stres lebih cenderung untuk bekerja sama dengan perawat.
2. B. Saat melakukan pemeriksaan telinga dengan otoskop pada anak berusia 2 tahun, daun telinga ditarik ke bawah dan ke belakang untuk beberapa alasan meluruskan saluran telinga: Saluran telinga anak-anak lebih pendek dan lebih horizontal dibandingkan dengan orang dewasa. Menarik daun telinga ke bawah dan ke belakang membantu meluruskan saluran telinga, sehingga dapat melihat lebih jelas ke dalam telinga.
3. D. Grafik pertumbuhan yang direkomendasikan oleh WHO untuk memantau pertumbuhan anak dari lahir hingga usia 2 tahun didasarkan pada standar anak yang diberi ASI eksklusif karena beberapa alasan: 1. ASI dianggap sebagai standar nutrisi optimal untuk bayi, karena mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat; 2. Anak yang diberi ASI eksklusif cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih alami dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti susu formula atau makanan tambahan; 3. WHO menggunakan data dari beberapa negara untuk membuat standar pertumbuhan anak yang diberi ASI eksklusif, sehingga dapat digunakan sebagai referensi internasional; 4. Grafik pertumbuhan yang didasarkan pada standar anak yang diberi ASI eksklusif dapat membantu mengidentifikasi masalah pertumbuhan pada anak, seperti kekurangan gizi atau gangguan pertumbuhan lainnya; 5. Meningkatkan promosi ASI.
4. A. Pada bayi baru lahir yang sehat, perbandingan normal adalah lingkar kepala lebih besar dari lingkar dada karena beberapa alasan: 1. Otak bayi berkembang sangat cepat selama kehamilan dan terus berkembang setelah lahir. Oleh karena itu, lingkar kepala bayi baru lahir lebih besar untuk menampung otak yang sedang

berkembang; 2. Otak bayi baru lahir sudah cukup matang untuk mengatur fungsi-fungsi dasar seperti bernapas, makan, dan mengatur suhu tubuh; 3. Pada bayi baru lahir, proporsi tubuh berbeda dengan anak yang lebih besar atau orang dewasa. Kepala bayi baru lahir lebih besar dibandingkan dengan ukuran tubuh untuk memungkinkan otak berkembang dengan baik.

5. C. Refleks Moro merupakan refleks primitif pada bayi yang ditandai dengan reaksi terkejut saat ada stimulus tiba-tiba, seperti suara keras atau gerakan mendadak. Refleks ini terjadi karena beberapa alasan: 1. Bayi baru lahir memiliki sistem saraf yang belum matang, sehingga mereka tidak dapat mengontrol reaksi mereka terhadap stimulus; 2. Refleks Moro dianggap sebagai reaksi pertahanan primitif yang membantu bayi untuk melindungi diri dari bahaya; 3. Refleks Moro juga terkait dengan pengembangan otak bayi, khususnya bagian otak yang mengatur reaksi emosi dan respons terhadap stimulus.
6. C. Skala Koma Glasgow Pediatrik (Pediatric Glasgow Coma Scale, PGCS) digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pada anak yang mengalami cedera kepala karena beberapa alasan: 1. Anak-anak memiliki anatomi dan fisiologi yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga skala kesadaran yang digunakan pada orang dewasa tidak dapat diterapkan secara langsung pada anak-anak; 2. Anak-anak memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga skala kesadaran harus disesuaikan dengan kemampuan mereka; 3. Otak anak-anak masih dalam proses perkembangan, sehingga skala kesadaran harus mempertimbangkan faktor-faktor perkembangan ini; 4. Anak-anak memiliki kebutuhan spesifik dalam hal penilaian dan pengelolaan cedera kepala, sehingga skala kesadaran yang digunakan harus dapat memenuhi kebutuhan ini.
7. B. Jika seorang anak memiliki berat badan di persentil ke-75, artinya 75% anak seusianya memiliki berat badan lebih rendah darinya, karena interpretasi persentil: Jika seorang anak memiliki berat badan di persentil ke-75, artinya 75% anak seusianya memiliki berat badan lebih rendah darinya, dan 25% anak seusianya memiliki berat badan lebih tinggi darinya.
8. C. Urutan pemeriksaan abdomen yang benar adalah Inspeksi, Auskultasi, Perkusi, Palpasi karena beberapa alasan: Auskultasi dilakukan setelah inspeksi untuk mendengarkan suara-suara abdomen, seperti suara peristaltik, bruits, atau suara lainnya. Jika palpasi atau perkusi dilakukan sebelum auskultasi, maka suara-suara abdomen dapat terganggu. Jika palpasi dan perkusi dilakukan sebelum auskultasi, maka suara-suara abdomen dapat terganggu, sehingga hasil auskultasi tidak akurat.
9. D. Terdengar suara wheezing pada anak dengan asma karena beberapa alasan: 1. Otot bronkial (saluran napas) mengalami kontraksi, sehingga saluran napas menjadi sempit; 2. Inflamasi dan edema (pembengkakan) pada dinding bronkial juga terjadi, sehingga saluran napas menjadi lebih sempit; 3. Mukosa bronkial (lapisan dalam saluran napas) menjadi lebih tebal dan menghasilkan lebih banyak lendir, sehingga saluran napas menjadi lebih sempit; 4. Ketika udara melewati

saluran napas yang sempit, maka akan terjadi turbulensi aliran udara, sehingga terdengar suara wheezing.

10. C. Assent dalam konteks etika keperawatan anak merujuk pada persetujuan afirmatif dari anak yang sudah mampu memahami untuk berpartisipasi dalam prosedur karena beberapa alasan: 1. Assent mengakui bahwa anak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri, meskipun mereka belum dewasa; 2. Assent memungkinkan anak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab; 3. Assent dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan anak karena mereka tahu apa yang akan terjadi dan dapat membuat keputusan tentang diri mereka sendiri; 4. Assent dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara anak dan perawat, karena anak merasa bahwa pendapat mereka dihargai.

G. Rangkuman Materi

1. Pendekatan Fundamental: Pengkajian anak harus selalu didasarkan pada filosofi atraumatic care yang bertujuan meminimalkan stres fisik dan psikologis bagi anak dan keluarga.
2. Komunikasi sebagai Kunci: Keberhasilan pengkajian sangat bergantung pada kemampuan membangun rapport dan kepercayaan, serta menggunakan teknik komunikasi dan alloanamnesis yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang.
3. Pengkajian Holistik: Riwayat kesehatan yang komprehensif harus mencakup domain prenatal, natal, postnatal, imunisasi, nutrisi, pola kebiasaan, psikososial, dan lingkungan untuk mendapatkan gambaran utuh.
4. Data Objektif Pertumbuhan: Pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar kepala) dan interpretasinya menggunakan grafik pertumbuhan WHO/CDC adalah alat vital untuk memantau pertumbuhan fisik anak.
5. Penilaian Fisiologis: Pengukuran tanda-tanda vital (suhu, nadi, pernapasan, tekanan darah) harus dilakukan dengan teknik yang benar dan alat yang sesuai ukuran untuk mendapatkan data fisiologis yang akurat.
6. Pemeriksaan Sistematis: Pemeriksaan fisik head-to-toe harus dilakukan secara sistematis namun fleksibel, dengan memprioritaskan prosedur non-invasif terlebih dahulu untuk menjaga kerja sama anak.
7. Skrining Perkembangan: Penggunaan instrumen skrining terstandardisasi (misalnya, Denver II atau KPSP) sangat penting untuk identifikasi dini keterlambatan perkembangan.
8. Dokumentasi dan Analisis: Seluruh data hasil pengkajian harus didokumentasikan secara akurat dan dianalisis secara kritis untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat.

Glosarium

Alloanamnesis : Proses pengumpulan data atau riwayat kesehatan pasien yang diperoleh dari orang lain selain pasien itu sendiri, biasanya dari orang tua atau pengasuh dalam konteks pediatrik.

Assent : Persetujuan afirmatif yang diberikan oleh seorang anak untuk berpartisipasi dalam sebuah prosedur atau penelitian, setelah diberikan penjelasan yang sesuai dengan tingkat pemahamannya. Ini berbeda dari consent yang memiliki kekuatan hukum dan diberikan oleh orang tua.

Atraumatic Care: Filosofi perawatan yang berfokus pada penggunaan intervensi yang dapat menghilangkan atau meminimalkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak dan keluarganya dalam sistem pelayanan kesehatan.

Denver II : Sebuah instrumen skrining perkembangan terstandardisasi yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan anak dari lahir hingga usia 6 tahun dalam empat domain: personal sosial, motorik halus-adaptif, bahasa, dan motorik kasar.

Fontanel : Celah di antara tulang-tulang tengkorak bayi yang belum menyatu, tertutup oleh membran yang kuat. Disebut juga sebagai ubun-ubun.

Grafik Pertumbuhan: Alat visual berupa kurva yang digunakan untuk memplot pengukuran antropometri anak (seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala) dari waktu ke waktu untuk dibandingkan dengan standar populasi berdasarkan usia dan jenis kelamin.

KPSP : Kuesioner Pra Skrining Perkembangan yaitu alat skrining perkembangan yang digunakan di Indonesia, berupa daftar pertanyaan untuk orang tua guna mendeteksi dini penyimpangan perkembangan pada anak usia 0-6 tahun.

Rapport : Hubungan yang harmonis dan saling percaya antara perawat dengan pasien dan keluarganya, yang menjadi dasar komunikasi dan interaksi terapeutik yang efektif.

Turgor Kulit : Elastisitas kulit, yang digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai status hidrasi. Turgor yang buruk (kulit kembali lambat setelah dicubit) dapat menandakan dehidrasi.

Referensi

Abdeljelil, A., Freire, G., Yanchar, N., Turgeon, A., Beno, S., Bérubé, M., Stang, A., Stelfox, T., Zemek, R., Beaulieu, E., Gagnon, I., Gabbe, B., Lauzier, F., Labrosse, M., Tardif, P., Deshommes, T., Gnanvi, J., & Moore, L. (2023). Pediatric Moderate and Severe Traumatic Brain Injury: A Systematic Review of Clinical Practice Guideline Recommendations. Journal of Neurotrauma, 40, 2270-2281. https://doi.org/10.1089/neu.2023.0149

Appiah, E., Appiah, S., Kontoha, S., Mensah, S., Awuah, D., Menlah, A., & Baidoo, M. (2022). Pediatric nurse-patient communication practices at Pentecost Hospital, Madina: A qualitative study. International Journal of Nursing Sciences, 9, 481-489. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2022.09.009

Barber, B., Elliott-Rose, A., Higgins, A., Hancock, K., Mireault, A., McDonald, K., Burgess, S., Larocque, L., & Cassidy, C. (2025). Standards of care for pediatric clinical service delivery: A rapid scoping review. Journal of child health care, 13674935251355056. https://doi.org/10.1177/13674935251355056

Bussard, M., Jessee, M., El-Banna, M., Cantrell, M., Alrimawi, I., Marchi, N., Gonzalez, L., Rischer, K., Coy, M., Poledna, M., & Lavoie, P. (2023). Current practices for assessing clinical judgment in nursing students and new graduates: A scoping review. Nurse education today, 134, 106078. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.106078

Butcher, R., & Jones, D. (2021). An integrative review of comprehensive nursing assessment tools developed based on Gordon's Eleven Functional Health Patterns. International journal of nursing knowledge. https://doi.org/10.1111/2047-3095.12321

Cachata, D., Costa, M., Magalhães, T., Lucas, P., & Gaspar, F. (2025). Information Technology in Nursing Practice: A Scoping Review of Assessment Tools for Evaluating Nurses' Competencies. Journal of Healthcare Leadership, 17, 211-223. https://doi.org/10.2147/jhl.s509955

Cioffredi, L., Yerby, L., Burris, H., Cole, K., Engel, S., Murray, T., Slopen, N., Volk, H., & Acheson, A. (2024). Assessing prenatal and early childhood social and environmental determinants of health in the HEALthy Brain and Child Development Study (HBCD). Developmental Cognitive Neuroscience, 69. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101429

Fontenot, N., Hamlin, S., Hooker, S., Vazquez, T., & Chen, H. (2022). Physical assessment competencies for nurses: A quality improvement initiative. Nursing Forum, 57, 710-716. https://doi.org/10.1111/nuf.12725

Goddard, A., Janicek, E., & Etcher, L. (2021). Trauma-informed care for the pediatric nurse. Journal of Pediatric Nursing, 62, 1-9.

https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.11.003

Hampl, S., Hassink, S., Skinner, A., Armstrong, S., Barlow, S., Bolling, C., Edwards, K., Eneli, I., Hamre, R., Joseph, M., Lunsford, D., Mendonca, E., Michalsky, M., Mirza, N., Ochoa, E., Sharifi, M., Staiano, A., Weedn, A., Flinn, S., Lindros, J., & Okechukwu, K. (2023). Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. Pediatrics. https://doi.org/10.1542/peds.2022-060640

Höhne, E., Recker, F., Dietrich, C., & Schäfer, V. (2022). Assessment Methods in Medical Ultrasound Education. Frontiers in Medicine, 9. https://doi.org/10.3389/fmed.2022.871957

Knapp, E., Kress, A., Parker, C., Page, G., McArthur, K., Gachigi, K., Alshawabkeh, A., Aschner, J., Bastain, T., Breton, C., Bendixsen, C., Brennan, P., Bush, N., Buss, C., Camargo, C., Catellier, D., Cordero, J., Croen, L., Dabelea, D., Deoni, S., D'Sa, V., Duarte, C., Dunlop, A., Elliott, A., Farzan, S., Ferrara, A., Ganiban, J., Gern, J., Giardino, A., Towe-Goodman, N., Gold, D., Habre, R., Hamra, G., Hartert, T., Herbstman, J., Hertz-Picciotto, I., Hipwell, A., Karagas, M., Karr, C., Keenan, K., Kerver, J., Koinis-Mitchell, D., Lau, B., Lester, B., Leve, L., Leventhal, B., LeWinn, K., Lewis, J., Litonjua, A., Lyall, K., Madan, J., McEvoy, C., McGrath, M., Meeker, J., Miller, R., Morello-Frosch, R., Neiderhiser, J., O'Connor, T., Oken, E., O'Shea, M., Paneth, N., Porucznik, C., Sathyanarayana, S., Schantz, S., Spindel, E., Stanford, J., Stroustrup, A., Teitelbaum, S., Trasande, L., Volk, H., Wadhwa, P., Weiss, S., Woodruff, T., Wright, R., Zhao, Q., & Jacobson, L. (2023). The Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO)-Wide Cohort. American Journal of Epidemiology, 192, 1249-1263. https://doi.org/10.1093/aje/kwad071

Lobo, E., R., D., Mandal, S., Menon, J., Roy, A., Dixit, S., Gupta, R., Swaminathan, S., Thankachan, P., Bhavnani, S., Divan, G., Prabhakaran, P., Van Schayck, O., Babu, G., Srinivas, P., & Mukherjee, D. (2024). Protocol of the Nutritional, Psychosocial, and Environmental Determinants of Neurodevelopment and Child Mental Health (COINCIDE) study. Wellcome Open Research, 9. https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.22817.2

Lu, A., Veet, C., Aljundi, O., Whitaker, E., Smith, W., & Smith, J. (2022). A Systematic Review of Physical Examination Components Adapted for Telemedicine. Telemedicine and e-Health, 28, 1764-1785. https://doi.org/10.1089/tmj.2021.0602

Mackay, L., Chang, U., Kreiter, E., Nickel, E., Kamke, J., Bahia, R., Shantz, S., & Meyerhoff, H. (2024). Exploration of trust between pediatric nurses and children with a medical diagnosis and their caregivers on inpatient care units: A scoping review. Journal of pediatric nursing. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.05.030

Mayer, K., Johnson, A., Smith, D., Crandall, C., Johnson, M., E, L., Robinson, C.,

Robinson, L., Kaplan, S., Kumble, S., & Norris, T. (2025). A Core Set of Outcome Measures to Assess Physical Function for Adults Participating in Physical Therapist Treatment in the Hospital: A Clinical Practice Guideline. Physical therapy. https://doi.org/10.1093/ptj/pzaf076

Moore, L., Freire, G., Abdeljelil, A., Bérubé, M., Tardif, P., Gnanvi, E., Stelfox, H., Beaudin, M., Carsen, S., Stang, A., Beno, S., Weiss, M., Labrosse, M., Zemek, R., Gagnon, I., Beaulieu, E., Berthelot, S., Klassen, T., Turgeon, A., Lauzier, F., Pike, I., Macpherson, A., Gabbe, B., & Yanchar, N. (2022). Clinical practice guideline recommendations for pediatric injury care: protocol for a systematic review. BMJ Open, 12. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060054

Morrell, S., Giannotti, N., Pittman, G., & Mulcaster, A. (2021). Physical assessment skills taught in nursing curricula: a scoping review. JBI evidence synthesis. https://doi.org/10.11124/jbies-20-00086

Oommen, S., & Menon, U. (2024). Therapeutic Procedures and Care of a Child Nursing Considerations. International Journal of Pediatric Nursing. https://doi.org/10.21088/ijpen.2454.9126.10124.3

Price, J., Marsac, M., Ridings, L., Axtmayer, C., James, R., Stroud, M., Durand, M., Longshore, S., Freeman, J., Nickoles, T., Mitchell, I., Yang, C., & Kassam-Adams, N. (2025). Screening for mental health symptoms following pediatric traumatic injury: A practice management guideline. The Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 98, 973-983. https://doi.org/10.1097/ta.0000000000004578

Sabetsarvestani, R., & Geçkil, E. (2024). A meta-synthesis of the experience of paediatric nurses in communication with children. Journal of advanced nursing. https://doi.org/10.1111/jan.16072

Sartika, A., Khoirunnisa, M., Meiyetriani, E., Ermayani, E., Pramesthi, I., & Ananda, A. (2021). Prenatal and postnatal determinants of stunting at age 0–11 months: A cross-sectional study in Indonesia. PLOS ONE, 16. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254662

Smart, G., Fleming, C., Healy, K., & Brocque, L. (2025). Accounting for the Psychosocial in Children's Neurodevelopment Diagnostic Assessments: A Scoping Review. Clinical Social Work Journal. https://doi.org/10.1007/s10615-025-00995-w

Tan, M., Lim, F., Siew, A., Levett-Jones, T., Chua, W., & Liaw, S. (2021). Why are physical assessment skills not practiced? A systematic review with implications for nursing education. Nurse education today, 99, 104759. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104759

Veena, M. (2025). Caring for Children: A Review of Pediatric Nursing. International Journal of Nursing and Medical Investigation.

https://doi.org/10.31690/ijnmi.2025.v010i03.005

Walter, M., Abright, M., Bukstein, M., Diamond, M., Keable, M., Ripperger-Suhler, M., & Rockhill, M. (2022). Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and Adolescents With Major and Persistent Depressive Disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.10.001

Wiseman, T., Kourouche, S., Jones, T., Kennedy, B., & Curtis, K. (2023). The impact of whole of patient nursing assessment frameworks on hospital inpatients: A scoping literature review. Journal of advanced nursing. https://doi.org/10.1111/jan.16025

BAB 4

NUTRISI ANAK DAN MASALAH PEMBERIAN MAKAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Nutrisi Anak dan Masalah Pemberian Makan	4.1 Menilai status gizi dan pola pemberian makan sesuai kebutuhan perkembangan.	4.2 Merancang intervensi keperawatan dan edukasi keluarga untuk masalah pemberian makan yang umum.	CPMK-4	CPMK-2; CPMK-6

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	OSCE pengkajian pediatrik + checklist	Persentase ketercapaian item checklist pengkajian dan akurasi pengisian format dokumentasi (tanpa kesalahan kritis).	15	Lembar checklist OSCE; dokumentasi pengkajian
CPMK-4	Penugasan rencana asuhan + rencana edukasi	Kesesuaian tujuan SMART dan intervensi prioritas yang aman serta kelengkapan rencana edukasi (teach-back/indikator pemahaman).	15	Care plan; materi edukasi
CPMK-6	Role play komunikasi + penilaian kinerja	Penerapan teknik komunikasi terapeutik dan kejelasan koordinasi kolaborasi/rujukan (struktur komunikasi).	15	Video/rekaman role play; lembar penilaian

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi data (akurasi & sistematika)	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

A. NUTRISI

Nutrisi anak merupakan aspek fundamental dalam mendukung tumbuh kembang optimal. Nutrisi tidak hanya mencakup asupan makanan, tetapi juga melibatkan interaksi bio-psiko-sosial yang kompleks. Kebutuhan nutrisi anak berbeda sesuai dengan tahapan perkembangan, mulai dari bayi, balita, hingga usia sekolah. Penilaian status gizi dilakukan melalui pendekatan antropometri, klinis, biokimia, dan riwayat diet.

B. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi anak dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
- Antropometri: Berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), BB/TB, dan IMT/U.

Berdasarkan Indikator Pertumbuhan (Antropometri)

Penentuan status gizi wajib menggunakan nilai *Z-Score* (simpangan baku) pada kurva pertumbuhan:

Indikator	Klasifikasi	Ambang Batas (*Z-Score*)	Implikasi Klinis
Berat Badan menurut Umur (BB/U)	Berat Badan Sangat Kurang (*Severely Underweight*)	< -3 SD	Risiko tinggi mortalitas; indikasi malnutrisi akut/kronis.
	Berat Badan Kurang (*Underweight*)	-3 SD s/d < -2 SD	Memerlukan pelacakan penyebab (penyakit penyerta).
Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U)	Sangat Pendek (*Severely Stunted*)	< -3 SD	Malnutrisi kronis berkepanjangan; risiko gangguan kognitif.
	Pendek (*Stunting*)	-3 SD s/d < -2 SD	Hambatan pertumbuhan linear akibat asupan protein rendah.
BB menurut PB atau TB (BB/PB atau BB/TB)	Gizi Buruk (*Severely Wasted*)	< -3 SD	**Emergency!** Lemak subkutan habis; risiko kegagalan organ.
	Gizi Kurang (*Wasted*)	-3 SD s/d < -2 SD	Penurunan berat badan akut (misal karena diare/infeksi).
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U)	Gizi Lebih / Obesitas	> +2 SD	Kelebihan energi kronis; risiko penyakit metabolik dini.

1. Gizi Kurang (*Underweight*): Indikator BB/U berada di antara -2 SD sampai dengan -3 SD. Menunjukkan adanya masalah nutrisi akut maupun kronis.
2. Gizi Buruk (*Severe Underweight/Wasting*): Indikator BB/TB atau BB/PB berada di bawah -3 SD. Ini merupakan kondisi darurat medis yang memerlukan rawat inap atau pemantauan ketat.
3. Stunting (Pendek): Indikator TB/U atau PB/U berada di bawah -2 SD. Ini merepresentasikan malnutrisi kronis yang berlangsung lama, seringkali disertai gangguan perkembangan kognitif (Lestari et al., 2022).
   a. Pemeriksaan klinis: Tanda-tanda defisiensi gizi seperti rambut tipis, kulit kering, dan edema.
   b. Riwayat diet: 24-hour dietary recall dan food frequency questionnaire.
   c. Pemeriksaan biokimia: Kadar hemoglobin, albumin, dan gula darah sewaktu.

- Kadar Albumin Darah: Indikator protein visceral. Kadar <2,5 g/dL pada anak dengan edema menunjukkan Kwashiorkor dan risiko tinggi kebocoran cairan ke jaringan (anasarka).
- Hemoglobin (Hb): Skrining anemia defisiensi besi. Sekitar 50-60% anak stunting di Indonesia mengalami anemia yang memperburuk nafsu makan.
- Gula Darah Sewaktu (GDS): Skrining Hipoglikemia. Anak gizi buruk memiliki cadangan glikogen yang sangat tipis; GDS <54 mg/dL (3 mmol/L) adalah kondisi gawat darurat.

C. Pola Pemberian Makan Sesuai Perkembangan

Pola pemberian makan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pada usia 0–6 bulan, ASI eksklusif sangat dianjurkan. Setelah usia 6 bulan, MP-ASI harus diberikan dengan tekstur dan frekuensi yang sesuai. Penting untuk memperhatikan sinyal lapar dan kenyang anak serta menghindari distraksi saat makan.

1. Usia 0–6 Bulan
   ASI eksklusif sebagai standar emas nutrisi bayi.
   Mengandung zat gizi makro dan mikro lengkap.
   Memberikan perlindungan imun dan mendukung perkembangan otak.
   Tidak membutuhkan makanan/minuman lain kecuali indikasi medis.
2. Usia 6–12 Bulan
   MP-ASI mulai diberikan sejak usia 6 bulan.
   Tekstur bertahap: bubur halus (6–8 bulan), cincang/lembek (9–11 bulan), makanan keluarga (12 bulan).
   Frekuensi: 2–3 kali makanan utama + 1–2 kali selingan.
   Kaya energi, protein, zat besi, dan variasi bahan makanan.
3. Usia 1–3 Tahun (Balita)
   Makan makanan keluarga dengan porsi kecil.
   Frekuensi: 3 kali makan utama + 2 kali selingan.
   Variasi makanan penting untuk mencegah defisiensi mikronutrien.
   Hindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak trans.
4. Usia Prasekolah dan Sekolah
   Anak mampu makan sendiri dengan keterampilan motorik halus.
   Pola makan mengikuti konsep 'Isi Piringku'.
   Edukasi kebiasaan makan sehat termasuk sarapan teratur.
   Hindari distraksi saat makan agar anak mengenali sinyal lapar/kenyang.

5. Prinsip Umum
   Responsif feeding: orang tua merespons sinyal lapar/kenyang anak.
   Durasi makan maksimal 30 menit.
   Lingkungan makan tenang, positif, tanpa distraksi.
   Variasi makanan mencegah hidden hunger.

D. Masalah Pemberian Makan

Masalah pemberian makan pada anak merupakan tantangan umum yang dihadapi oleh orang tua dan tenaga kesehatan. Masalah ini dapat memengaruhi status gizi, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Empat masalah yang sering dijumpai adalah picky eater, small eater, food phobia, dan distracted feeder. Faktor penyebabnya dapat bersifat organik seperti gangguan oromotor dan GERD, maupun non-organik seperti pola asuh yang tidak tepat, stres keluarga, dan sanitasi lingkungan yang buruk.

1. Jenis Masalah Umum Pemberian Makan
   a. Picky Eater
      Picky eater adalah kondisi di mana anak menolak makanan tertentu atau hanya mau makan jenis makanan tertentu. Picky eating merupakan perilaku umum pada anak usia 2–6 tahun dan dapat menyebabkan kekurangan mikronutrien seperti zat besi dan seng. Faktor risiko termasuk paparan makanan terbatas, tekanan saat makan, dan gangguan perkembangan seperti ADHD atau SPD.
   b. Small Eater
      Small eater adalah anak yang memiliki nafsu makan rendah dan cepat merasa kenyang. Anak dengan kondisi ini sering tidak mencapai kebutuhan kalori harian. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan gastrointestinal ringan atau stres psikososial dapat menyebabkan penurunan nafsu makan.
   c. Food Phobia
      Food phobia adalah ketakutan ekstrem terhadap makanan, sering kali disebabkan oleh pengalaman traumatis seperti tersedak atau muntah. Kondisi ini dapat berkembang menjadi Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID). ARFID sering dikaitkan dengan gangguan neuropsikiatri seperti autisme dan gangguan sensorik.
   d. Distracted Feeder
      Distracted feeder adalah anak yang hanya mau makan jika ada distraksi seperti gadget atau televisi. Hal ini mengganggu kemampuan anak mengenali sinyal lapar dan kenyang. Kebiasaan makan sambil menonton layar dapat menurunkan kualitas asupan makanan dan meningkatkan risiko obesitas atau malnutrisi tersembunyi.

2. Faktor Penyebab Masalah Pemberian Makan
   a. Faktor Organik (Penyebab Medis/Biologis)
      Faktor ini melibatkan gangguan pada sistem tubuh yang menghambat asupan, penyerapan, atau meningkatkan kebutuhan metabolisme.
      Gangguan Oromotor: Kelemahan otot pengunyah atau gangguan koordinasi isap-telan, sering ditemukan pada anak dengan Cerebral Palsy atau kelainan kongenital seperti Cleft Lip/Palate (bibir sumbing).
      Penyakit Jantung Bawaan (PJB): Anak dengan PJB mengalami kondisi hypermetabolic state. Jantung bekerja lebih keras sehingga membakar kalori lebih cepat, sementara anak cepat lelah saat menyusui.
      Masalah Gastrointestinal: Kondisi seperti Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) atau alergi protein susu sapi menyebabkan rasa nyeri saat makan, sehingga anak secara tidak sadar mengaitkan makanan dengan rasa sakit (feeding fear).
      Penyakit Infeksi Kronis: Tuberkulosis (TB) paru dan infeksi saluran kemih (ISK) yang tidak terdiagnosis sering menjadi penyebab utama "berat badan sulit naik" pada balita di Indonesia.
   b. Faktor Non-Organik (Penyebab Perilaku & Lingkungan)
      Faktor ini lebih dominan (sekitar 80% kasus) dan berkaitan erat dengan peran perawat dalam edukasi pola asuh.
      Miskonsepsi Pengasuhan (Inappropriate Feeding Practice):
      Penggunaan distraksi (gadget, menonton TV, atau makan sambil bermain) yang menghambat anak mengenali sinyal rasa kenyang dan lapar di otaknya (satiety signaling).
      Pemberian makan paksa (force feeding) yang memicu trauma psikologis.
      Kurangnya Pengetahuan Ibu:
      merupakan ketidaktahuan tentang transisi tekstur MPASI (misal: terlambat memberikan makanan kasar) menyebabkan anak mengalami gangguan oromotor fungsional di usia yang lebih tua.
      Psikososial Keluarga:
      Stres pada ibu atau depresi pascapersalinan berkorelasi kuat dengan kegagalan pemberian makan. Ibu yang stres cenderung tidak responsif terhadap isyarat lapar anak (unresponsive feeding).
      Lingkungan & Sanitasi:
      Paparan kronis terhadap lingkungan yang tidak higienis memicu Environmental Enteric Dysfunction (EED), di mana dinding usus mengalami peradangan kronis sehingga tidak mampu menyerap nutrisi secara optimal meskipun makanan yang diberikan sudah cukup.

3. Intervensi Keperawatan
   Intervensi keperawatan meliputi:
   a. Pengkajian menyeluruh status gizi dan perilaku makan.
   b. Edukasi Feeding Rules: jadwal makan, durasi maksimal 30 menit, tanpa distraksi.
   c. Pemberian makanan tinggi kalori dan protein.
   d. Monitoring berat badan dan asupan makanan.
   e. Kolaborasi dengan keluarga dan tim kesehatan.
4. Edukasi Keluarga
   Edukasi keluarga mencakup:
   a. Pentingnya Gizi Seimbang dan Variasi Makanan
      Gizi seimbang mencakup pemenuhan kebutuhan makronutrien (karbohidrat, protein, lemak) dan mikronutrien (vitamin dan mineral) sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Pengenalan variasi makanan sejak dini penting untuk mencegah picky eating dan defisiensi mikronutrien tersembunyi (hidden hunger). Variasi makanan yang cukup berkontribusi terhadap perkembangan kognitif dan perilaku anak. Pentingnya penerapan prinsip 'Isi Piringku' sebagai panduan konsumsi makanan seimbang bagi anak-anak.
   b. Teknik Pemberian Makan yang Menyenangkan
      Teknik pemberian makan yang menyenangkan melibatkan suasana makan yang positif, tanpa tekanan, dan bebas dari distraksi seperti televisi atau gadget. Feeding rules yang direkomendasikan meliputi jadwal makan teratur (3 kali makan utama dan 2 kali camilan), durasi makan maksimal 30 menit, serta pemberian makanan dalam porsi kecil namun sering. Pendekatan responsif terhadap sinyal lapar dan kenyang anak dapat meningkatkan asupan nutrisi dan mengurangi stres makan. Pemberian makan paksa sebaiknya dihindari karena dapat memicu trauma psikologis dan gangguan perilaku makan.
   c. Tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai
      Keluarga perlu dikenalkan pada tanda-tanda bahaya yang menunjukkan adanya masalah nutrisi serius pada anak. Tanda-tanda tersebut meliputi penurunan berat badan atau stagnasi pertumbuhan, edema, muntah berulang, gerakan tutup mulut (GTM), dan durasi makan yang melebihi 30 menit tanpa peningkatan asupan. Keterlambatan dalam mengenali tanda-tanda ini dapat menyebabkan malnutrisi kronis dan gangguan perkembangan kognitif. Oleh karena itu, edukasi yang tepat kepada keluarga sangat penting untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi.
   d. Peran Keluarga dalam Menciptakan Lingkungan Makan yang Positif
      Lingkungan makan yang positif ditandai dengan adanya interaksi yang hangat, bebas tekanan, dan mendukung eksplorasi makanan oleh anak. Keluarga

berperan sebagai role model dalam menunjukkan kebiasaan makan sehat dan memberikan dukungan emosional selama proses makan. Keterlibatan keluarga dalam pemberian makan anak secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pola makan sehat dan mencegah masalah makan. Pentingnya peran ibu dalam menciptakan suasana makan yang nyaman dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis

Seorang anak perempuan berusia 18 bulan dibawa ibunya ke poliklinik anak dengan keluhan sulit makan sejak 3 bulan terakhir. Ibu mengatakan anak sering menolak makanan padat, hanya mau minum susu, dan berat badan tidak naik sesuai grafik pertumbuhan. Anak juga kadang muntah setelah makan. Ibu tampak cemas karena anak terlihat kurus dan rewel.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Berat badan anak stagnan dalam 3 bulan terakhir (BB 8 kg, TB 75 cm).
- Riwayat pemberian ASI hanya sampai usia 4 bulan, kemudian diganti susu formula.
- Anak sering makan sambil menonton gadget.
- Riwayat keluarga: tidak ada penyakit kronis.
- Pemeriksaan fisik: anak tampak kurus, rambut tipis dan kusam, kulit kering, tidak ada edema.

Pertanyaan Diskusi :

1. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan anak mengalami masalah nutrisi dan pemberian makan.
2. Tentukan klasifikasi status gizi anak berdasarkan data antropometri (BB/TB).
3. Identifikasi faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi anak (misalnya riwayat ASI, pola makan, lingkungan).
4. Jelaskan diagnosis keperawatan prioritas yang sesuai dengan kasus ini.
5. Susun rencana intervensi keperawatan berbasis OBE yang mencakup:
   a. Pengkajian lanjutan
   b. Edukasi Feeding Rules (jadwal makan, durasi, lingkungan tanpa distraksi)
   c. Strategi pemberian makan kecil tapi sering dengan variasi nutrisi
   d. Edukasi tanda bahaya yang harus segera dilaporkan
6. Diskusikan bagaimana perawat dapat melibatkan ibu dalam proses edukasi agar terjadi perubahan perilaku makan anak.

   Instruksi Aktivitas :

   a. Mahasiswa berdiskusi dalam kelompok kecil (3–5 orang).
   b. Analisis kasus secara sistematis menggunakan pendekatan SDKI, SLKI, dan SIKI.
   c. Presentasikan hasil diskusi di kelas dengan menekankan aspek penalaran klinik, edukasi keluarga, dan keselamatan pasien.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pengkajian Pediatrik

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
  OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Pengkajian Pediatrik + Checklist

- Indikator: Persentase ketercapaian item checklist pengkajian dan akurasi dokumentasi.
- Bobot: 15%
- Bukti: Lembar checklist OSCE; dokumentasi pengkajian.

Cuplikan rubrik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kelengkapan langkah pengkajian	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
Kualitas dokumentasi data	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Checklist OSCE Pengkajian Nutrisi Anak

Komponen Pengkajian	Dilakukan (✓/X)
Menanyakan riwayat ASI dan MP-ASI	
Menilai pola makan harian dan variasi makanan	
Mengobservasi perilaku makan anak (distraksi, durasi, GTM)	
Mengukur berat badan dan tinggi badan	
Mengukur lingkar lengan atas (LiLA)	
Mengobservasi tanda klinis malnutrisi (rambut, kulit, edema)	
Mengkaji status psikososial keluarga	
Mengkaji lingkungan makan (distraksi, kebersihan)	
Mendokumentasikan data secara sistematis	

Penugasan Rencana Asuhan + Rencana Edukasi

- Indikator: Kesesuaian tujuan SMART, intervensi prioritas aman, kelengkapan rencana edukasi.
- Bobot: 15%
- Bukti: Care plan; materi edukasi.

Cuplikan Rubrik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
Ketepatan intervensi & edukasi	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi

				efektif (teach-back)

Role Play Komunikasi + Penilaian Kinerja

- Indikator: Penerapan komunikasi terapeutik, koordinasi kolaborasi/rujukan.
- Bobot: 15%
- Bukti: Video/rekaman role play; lembar penilaian.

Cuplikan Rubrik

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Kualitas komunikasi terapeutik	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Anak dengan Masalah Nutrisi dan Pemberian Makan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus nutrisi, penegakan diagnosis keperawatan, perencanaan intervensi, edukasi kepada orang tua, serta evaluasi asuhan keperawatan anak dengan masalah pemberian makan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling; 2. Pengkajian; 3. Diagnosa dan perencanaan; 4. Implementasi; 5. Evaluasi; 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Nutrisi; 2. Aman dan nyaman; 3. Psikososial; 4. Pertumbuhan dan perkembangan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ibunya ke ruang rawat anak dengan keluhan sulit makan sejak 3 bulan terakhir. Anak sering menolak makanan padat, hanya mau minum susu, berat badan tidak naik sesuai grafik pertumbuhan, dan kadang muntah setelah makan. Ibu tampak cemas karena anak terlihat kurus dan rewel. TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus nutrisi dan masalah pemberian makan berdasarkan skenario pada KS. 2. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan hasil pengkajian. 3. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab. 4. Lakukan edukasi kepada ibu mengenai strategi pemberian makan yang tepat dan pentingnya variasi nutrisi. 5. Sampaikan evaluasi asuhan keperawatan yang diharapkan.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang anak perempuan usia 2 tahun dibawa ibunya ke ruang rawat anak dengan keluhan sulit makan sejak 3 bulan terakhir. Anak sering menolak makanan padat, hanya mau minum susu, berat badan tidak naik sesuai grafik pertumbuhan, dan kadang muntah setelah makan. Ibu tampak cemas karena anak terlihat kurus dan rewel.

No.	Komponen	Isi
		INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai ketepatan peserta dalam melakukan pengkajian fokus tambahan: riwayat pemberian ASI/MP-ASI, pola makan sehari-hari, preferensi makanan, riwayat pertumbuhan, tanda klinis malnutrisi, perilaku makan anak. 2. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan diagnosis keperawatan: misalnya Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh ditandai dengan berat badan tidak naik, anak menolak makanan padat, hanya minum susu, tampak kurus, dan rewel. 3. Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan: memonitor status gizi, memonitor perilaku makan, memberikan edukasi tentang variasi makanan, melibatkan ibu dalam strategi pemberian makan, serta memantau grafik pertumbuhan. 4. Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi: menjelaskan pentingnya variasi nutrisi, cara pemberian makan yang menyenangkan, frekuensi makan kecil tapi sering, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. 5. Menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan evaluasi: anak diharapkan mampu menerima makanan padat secara bertahap, berat badan meningkat sesuai grafik pertumbuhan, dan ibu memahami strategi pemberian makan. 6. Monitor perilaku profesional peserta. 7. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	- Identitas: anak perempuan usia 2 tahun. KS berperan sebagai ibu pasien. - Riwayat penyakit sekarang: anak sulit makan sejak 3 bulan, hanya mau minum susu, kadang muntah setelah makan, berat badan tidak naik. - Riwayat tumbuh kembang: berat badan stagnan, tinggi badan sesuai usia. - Riwayat keluarga: tidak ada masalah serupa. - Riwayat kebiasaan sosial: anak rewel saat makan, ibu cemas. - Harapan: ibu berharap anak mau makan makanan padat dan berat badan naik. - Bila peserta menanyakan asupan: anak hanya minum susu ± 4 kali/hari, tidak mau makan nasi atau lauk. - Bila peserta menanyakan BAK/BAB: normal, tidak ada keluhan. - KS duduk di samping anak dengan raut wajah cemas, anak digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien anak.
10	Setting station	Ruang Rawat Anak - Tempat tidur pasien - Manekin anak - KS berperan sebagai ibu pasien - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin anak

No.	Komponen	Isi
		2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Sarung tangan bersih 2. Handrub/hand sanitizer 3. Alat ukur antropometri (timbangan, pengukur tinggi badan, pita ukur lingkar kepala bila perlu) 4. Lembar grafik pertumbuhan WHO 5. Boneka/manekin anak 6. Lembar jawaban peserta Peran laboran: merapikan ulang alat setelah digunakan peserta, memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya.
12	Penulis	....
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI FEEDING RULES

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan terkait status gizi anak				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: handrub, sarung tangan bila perlu, leaflet edukasi, media visual (poster/flipchart), alat bantu makan (sendok, gelas, kursi makan anak)				
3	Mencuci tangan sesuai prosedur				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama anak, umur) dan orang tua				
7	Menyampaikan maksud, tujuan edukasi, serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan orang tua bertanya				
9	Menjaga privasi dan kenyamanan anak serta orang tua				
C	Tahap Kerja (sistematis)				
10	Melakukan hand hygiene sebelum memulai				
11	Menggunakan sarung tangan bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
12	Mengidentifikasi riwayat pemberian ASI/MPASI, pola makan, preferensi makanan, dan tanda klinis malnutrisi				
13	Mengidentifikasi kesiapan anak dan ibu menerima edukasi				
14	Mengatur posisi anak nyaman (kursi makan/semi-Fowler)				
15	Menjelaskan tujuan Feeding Rules (membentuk kebiasaan makan sehat, mencegah malnutrisi)				
16	Menjelaskan jadwal makan teratur (3x makan utama, 2x snack, durasi maksimal 30 menit)				
17	Menjelaskan pentingnya variasi makanan (karbohidrat, protein hewani, sayur, buah)				
18	Mendemonstrasikan cara pemberian makan kecil tapi sering (small frequent feeding)				
19	Menjelaskan cara menghadapi anak menolak makan (pause, coba ulang perlahan, tanpa paksaan)				
20	Menjelaskan tanda bahaya nutrisi: penurunan BB, edema, penurunan kesadaran, muntah profus, hipotermia				
21	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan Feeding Rules				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
22	Meminta ibu mendemonstrasikan kembali cara pemberian makan sesuai aturan				
23	Merapikan pasien dan alat bantu edukasi				
24	Melepas sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan				
D	Tahap Terminasi				
25	Menyimpulkan kegiatan edukasi				
26	Mengevaluasi respons ibu/pasien secara subjektif dan objektif				
27	Memberikan reinforcement positif				
28	Membuat kontrak waktu selanjutnya (follow-up edukasi)				
29	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
30	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi Feeding Rules, respons ibu/anak, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
31	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: NUTRISI ANAK DAN MASALAH PEMBERIAN MAKAN

III. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Menggali riwayat pemberian ASI/MP-ASI, pola makan, preferensi makanan, riwayat pertumbuhan, tanda klinis malnutrisi, perilaku makan anak					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan yang tepat (Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh) dan menyusun rencana keperawatan sesuai masalah nutrisi					2	
3	Implementasi keperawatan: edukasi pemberian makan	Menjelaskan strategi pemberian makan yang tepat, variasi nutrisi, frekuensi makan kecil tapi sering, cara membuat suasana makan menyenangkan, serta tanda bahaya					5	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					1	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: NUTRISI ANAK DAN MASALAH PEMBERIAN MAKAN

II. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus nutrisi.	Pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda malnutrisi.	Pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, menggali sebagian besar data penting, tetapi masih ada data terlewat.	Pengkajian lengkap, sistematis, relevan, meliputi riwayat ASI/MP-ASI, pola makan, preferensi, riwayat pertumbuhan, tanda klinis malnutrisi, perilaku makan anak, serta menyampaikan hasil dengan tepat.	2	
Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana keperawatan.	Diagnosis keperawatan tidak tepat sebagai prioritas, atau kurang sesuai dengan data. Rencana	Diagnosis cukup tepat sesuai masalah utama, rencana keperawatan cukup sesuai namun masih	Diagnosis prioritas tepat berdasarkan data kasus, rencana keperawatan lengkap, relevan, sistematis, sesuai kebutuhan anak	2	

		keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	kurang lengkap.	dengan masalah nutrisi.		
Implementasi Keperawatan: Edukasi Pemberian Makan	Tidak melakukan edukasi, atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko.	Edukasi terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, teknik belum tepat.	Edukasi cukup baik, sebagian besar langkah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik komunikasi.	Edukasi pemberian makan tepat, aman, sistematis, lengkap: variasi nutrisi, frekuensi makan kecil tapi sering, suasana makan menyenangkan, tanda bahaya, verifikasi pemahaman ibu.	5	
Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, tidak memperhatikan	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik,	Perilaku profesional cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyaman	Perilaku profesional konsisten: komunikasi terapeutik baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan/kenyamanan anak	1	

	keamanan/kenyamanan pasien.	persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	an, keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil.	dan ibu, teliti, hati-hati, responsif, etis.		

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus nutrisi.	Melakukan pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda malnutrisi.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting (riwayat makan, pertumbuhan, tanda klinis), tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi riwayat ASI/MP-ASI, pola makan, preferensi, riwayat pertumbuhan, tanda klinis malnutrisi, perilaku makan anak, serta mampu menyampaikan hasil dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas, atau diagnosis kurang sesuai dengan data.	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, menyusun rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta menyusun rencana

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	menyusun rencana keperawatan.	Rencana keperawatan sangat terbatas dan tidak relevan.	yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan anak dengan masalah nutrisi.
3. Implementasi: Keperawatan	Tidak melakukan edukasi, atau tindakan tidak sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan edukasi secara terbatas, banyak langkah penting tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, teknik belum tepat.	Melakukan edukasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik komunikasi.	Melakukan edukasi pemberian makan secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi penjelasan variasi nutrisi, frekuensi makan kecil tapi sering, cara membuat suasana makan menyenangkan, tanda bahaya, serta verifikasi pemahaman ibu.
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi,	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi,	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	atau keselamatan pasien.	kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan masalah pemberian makan
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Nutrisi Anak dan masalah pemberian makan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Anak dengan Nutrisi**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan pengukuran antropometri (BB, TB, LiLA) dan edukasi Feeding Rules pada anak dengan gizi buruk.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan prosedur klinik secara aman, tepat, sistematis, serta mampu mengintegrasikan komunikasi dan edukasi.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari keterampilan teknis mengukur BB/TB, tetapi juga dari kemampuannya menjelaskan hasil pengukuran kepada ibu dan menyampaikan rencana asuhan nutrisi.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sesuai capaian pembelajaran mata kuliah.	Anak usia 2 tahun dengan BB stagnan, hanya mau minum susu, tampak kurus, dan dicurigai gizi buruk.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan prosedur klinik secara utuh sejak persiapan alat, interaksi dengan pasien, pelaksanaan prosedur, hingga edukasi.	Mahasiswa menyiapkan timbangan dan pita LiLA, melakukan pengukuran dengan benar, mencatat hasil, kemudian menjelaskan kepada ibu tentang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Nutrisi
		status gizi anak dan strategi pemberian makan.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi persiapan alat, keterampilan teknis, ketepatan prosedur, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan pengukuran antropometri sesuai standar WHO, menjaga kenyamanan anak, serta memberikan edukasi Feeding Rules dengan bahasa sederhana.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas keterampilan prosedural mahasiswa secara langsung menggunakan format DOPS yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan hasil pengukuran dengan diagnosis defisit nutrisi dan menyusun rencana intervensi yang tepat.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam teknik pengukuran, tetapi perlu meningkatkan kejelasan penjelasan tentang tanda bahaya nutrisi.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam keterampilan prosedural.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan prosedur antropometri dan edukasi Feeding Rules secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus anak dengan gizi buruk, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori nutrisi, tetapi mampu menerapkan prosedur klinik dan edukasi secara langsung, aman, tepat, dan profesional.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 4. 1 Portofolio pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Nutrisi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nutrisi Anak
Hakikat portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu.	Portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian nutrisi, menetapkan diagnosis keperawatan, memberikan edukasi Feeding Rules, menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang dalam menangani anak dengan gizi buruk setelah mendapat masukan dari dosen/CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian edukasi Feeding Rules, DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan pengkajian antropometri pada anak stunting.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus anak usia 2 tahun dengan gizi buruk, BB stagnan, riwayat makan hanya susu, diagnosis defisit nutrisi, intervensi pemberian F-75,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nutrisi Anak
		edukasi Feeding Rules, evaluasi kenaikan BB.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda hipoglikemia, hipotermia, serta memastikan pemberian formula terapeutik sesuai prosedur.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen menunjukkan area kekuatan dan kelemahan mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu anak, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam plotting kurva pertumbuhan WHO.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti berulang dan berkesinambungan.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan konsistensi dalam asuhan nutrisi anak.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan konsistensi performa mahasiswa pada berbagai kesempatan praktik.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback, terlihat mahasiswa konsisten melakukan pengkajian nutrisi dan edukasi Feeding Rules.
Makna dalam OBE	Portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran benar-benar tampak dalam performa nyata.	Portofolio menunjukkan mahasiswa tidak hanya paham konsep nutrisi, tetapi konsisten menerapkannya dalam praktik klinik.

Tabel 4. 2 Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Nutrisi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nutrisi Anak
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang anak usia 18 bulan dengan gizi buruk, BB stagnan, hanya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Nutrisi Anak
		mau minum susu, dan menolak makanan padat.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan masalah defisit nutrisi, intervensi pemberian F-75, edukasi Feeding Rules, dan evaluasi kenaikan BB.
Isi laporan	Identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif/objektif, analisis masalah, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, pembelajaran.	Mahasiswa menuliskan riwayat makan, antropometri, diagnosis defisit nutrisi, intervensi nutrisi TKTP, edukasi Feeding Rules, evaluasi perbaikan nafsu makan.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, kemampuan evaluasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data BB stagnan dengan masalah nutrisi dan memilih intervensi tepat.
Nilai edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan refleksi praktik klinik.	Mahasiswa belajar bahwa pengkajian antropometri, riwayat diet, dan edukasi keluarga adalah bagian penting asuhan nutrisi.
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep nutrisi, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan utuh.

Tabel 4. 3 Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Nutrisi

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Anak dengan Nutrisi**
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi	Mahasiswa merefleksikan bahwa hipoglikemia dan hipotermia pada anak gizi buruk dapat berakibat fatal bila tidak dikenali.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Nutrisi
	masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien adalah bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti terlambat mengenali tanda hipoglikemia, dapat berdampak besar pada keselamatan anak.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah hipoglikemia, hipotermia, dan keterlambatan eskalasi bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi berbahaya.	Risiko: penurunan kesadaran, muntah profus, hipotermia, edema generalisata, kesalahan pemberian formula terapeutik.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda vital, mencatat intake-output, memberikan glukosa segera bila hipoglikemia, serta edukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian teliti, komunikasi jelas, dan pemantauan berulang adalah kunci menjaga keselamatan anak gizi buruk.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan anak.

E. RINGKASAN

Nutrisi dan Masalah Pemberian Makan pada Anak

Pada bab ini menekankan masalah nutrisi dan pemberian makan pada anak yang merupakan isu klinis yang kompleks, melibatkan faktor biologis, perilaku, dan lingkungan. Kondisi ini dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembang, fungsi kognitif, serta daya tahan tubuh anak bila tidak dikenali dan ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi adalah memastikan kecukupan asupan energi dan protein, mencegah komplikasi seperti hipoglikemia, hipotermia, dan infeksi berat, serta mendukung perilaku makan yang sehat melalui edukasi keluarga.

Pengkajian pada anak dengan masalah nutrisi tidak hanya mencakup pengukuran berat badan dan tinggi badan, tetapi juga penilaian riwayat pemberian ASI/MPASI, pola makan sehari-hari, preferensi makanan, tanda klinis malnutrisi (seperti edema, rambut tipis, kulit kering), serta faktor psikososial keluarga. Identifikasi faktor risiko seperti riwayat BBLR, kurangnya ASI eksklusif, status ekonomi rendah, dan sanitasi buruk juga penting untuk dilakukan secara sistematis.

Asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian status gizi menggunakan pendekatan ABCD (Antropometri, Biokimia, Klinis, dan Diet). Berdasarkan hasil pengkajian, perawat mengidentifikasi masalah prioritas seperti defisit nutrisi, risiko ketidakseimbangan nutrisi, atau gangguan perilaku makan.

Perencanaan asuhan keperawatan mencakup pemantauan status gizi, pemberian makanan tinggi kalori dan protein, penerapan Feeding Rules (jadwal makan teratur, tanpa distraksi), serta edukasi tentang tanda bahaya yang harus segera dilaporkan.

Implementasi tindakan keperawatan meliputi pemantauan berat badan harian, penilaian tanda klinis malnutrisi, anjuran variasi makanan sesuai usia, menjaga kebersihan lingkungan, dan pemberian edukasi yang mudah dipahami oleh keluarga.

Edukasi kepada orang tua menjadi bagian penting dalam asuhan, mencakup aturan pemberian makan, pentingnya gizi seimbang, dan pengenalan tanda bahaya yang memerlukan rujukan segera.

Evaluasi dilakukan dengan menilai perubahan kondisi anak, seperti peningkatan berat badan, perbaikan nafsu makan, berkurangnya tanda klinis malnutrisi, serta kemampuan orang tua dalam menerapkan strategi pemberian makan yang benar. Jika ditemukan tanda bahaya seperti penurunan kesadaran, muntah profus, hipotermia, edema generalisata, atau dehidrasi berat, diperlukan eskalasi segera kepada perawat penanggung jawab atau dokter.

Asuhan keperawatan anak dengan masalah nutrisi harus dilakukan secara cepat, tepat, terstruktur, dan berpusat pada keselamatan pasien. Mahasiswa keperawatan dituntut untuk mampu mengenali masalah klinik, memberikan intervensi dasar, melakukan edukasi keluarga, dan mengetahui kapan harus melakukan eskalasi. Hal ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran keterampilan laboratorium dan praktik klinik pada Keperawatan Anak.

Tabel 4. 4 Red Flags & Eskalasi Nutrisi Anak dan Masalah Pemberian Makan

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Penurunan Kesadaran (Lethargi/Somnolen)	Anak tampak sangat lemas, sulit dibangunkan, atau tidak bereaksi terhadap rangsangan nyeri.	Segera berikan bolus Dextrose 10% atau air gula lewat NGT, lalu rujuk.
Dehidrasi Berat & Syok	Mata sangat cekung, tidak ada air mata saat menangis, turgor kulit perut kembali sangat lambat (>2 detik), anuria >6 jam.	Berikan cairan khusus ReSoMal perlahan untuk mencegah gagal jantung, segera rujuk.
Gangguan Gastrointestinal Profus	Muntah setiap kali makan/minum (intoleransi total) atau diare berdarah (disentri).	Puasakan sementara (NPO), pasang jalur IV, mulai antibiotik spektrum luas, rujuk.
Hipotermia (<36,0°C)	Suhu aksila <36°C atau rektal <35,5°C. Kulit anak terasa dingin.	Lakukan Kangaroo Mother Care, hangatkan dengan lampu penghangat, segera berikan glukosa, rujuk.
Edema Generalisata (Anasarka)	Pembengkakan pada kedua punggung kaki menjalar ke wajah & tangan (Kwashiorkor).	Segera rujuk ke fasilitas rujukan, monitor ketat cairan & infeksi.

Form Checklist “Saya sudah bisa…”

Bab Nutrisi Anak dan Masalah Pemberian Makan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian nutrisi pada anak secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus nutrisi pada anak	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengkaji riwayat pemberian ASI dan MP-ASI	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengkaji pola makan sehari-hari dan preferensi makanan anak	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengkaji tanda klinis malnutrisi pada anak	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas terkait nutrisi	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar terkait nutrisi anak	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memantau status gizi dan pertumbuhan anak menggunakan grafik WHO	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang variasi makanan dan strategi pemberian makan	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menganjurkan frekuensi makan kecil tapi sering sesuai toleransi anak	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya terkait nutrisi dan pemberian makan pada anak kepada orang tua	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor terkait masalah nutrisi	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga terkait masalah nutrisi	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan anak terkait nutrisi	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat anak dengan masalah nutrisi	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Azadbakht, L., et al. (2021). Nutritional status and its relation to cognitive development in children: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 10(4), 112-125. doi.org

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2020). *Pedoman Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) untuk Mencegah Malnutrisi*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI.

Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Pedoman Teknis Standar Antropometri Anak dan Penentuan Status Gizi*. Direktorat Gizi Masyarakat.

Kerzner, B., et al. (2021). A practical approach to classifying and managing feeding difficulties. *Pediatrics*, 135(2).

Lestari, W., et al. (2022). Clinical manifestations and danger signs of severe malnutrition in Indonesian children. *The Lancet Regional Health - Southeast Asia*, 1(2), 100-115.

Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2019). Metabolic and immunologic consequences of stunting and wasting. *Paediatrics and International Child Health*, 34(4), 250-265.

Vandevijvere, S., et al. (2020). Socioeconomic inequalities in ultra-processed food consumption and child malnutrition. *Public Health Nutrition*, 23(16), 2871-2880.

World Health Organization. (2022). *Guideline: Management of severe acute malnutrition in infants and children*. Geneva: WHO Press.

Yusuf, M., et al. (2023). Nursing assessment in identifying red flags of pediatric nutritional emergencies. *Journal of Pediatric Nursing*, 58, e12-e20.

Yusuf, M., et al. (2023). The correlation between sanitation, hygiene, and stunting incidence in rural areas. *International Journal of Health Sciences*, 7(1), 45-58.

BAB 5

GANGGUAN SISTEM KARDIOVASKULAR PADA ANAK

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta pertumbuhan–perkembangan sebagai landasan pengambilan keputusan keperawatan.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3
CPL-2	Mampu melakukan pengkajian dan keterampilan klinik dasar keperawatan anak secara aman sesuai prinsip keselamatan pasien.	CPMK-2; CPMK-5
CPL-3	Mampu menerapkan proses keperawatan pada anak dan keluarga (analisis masalah, perencanaan, implementasi, evaluasi) secara sistematis dan berbasis bukti.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-4	Mampu berkomunikasi terapeutik, memberikan edukasi, serta berkolaborasi dengan anak, keluarga, dan tim kesehatan secara efektif.	CPMK-4; CPMK-6
CPL-5	Menunjukkan profesionalisme, etika, legal, dan sensitivitas budaya dalam pemberian asuhan keperawatan anak.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Mampu berpikir kritis, memanfaatkan bukti ilmiah dan dokumentasi, serta melakukan refleksi untuk peningkatan mutu dan pembelajaran sepanjang hayat.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, family-centered care, serta prinsip pertumbuhan–perkembangan, etika, dan keselamatan sebagai dasar asuhan.
CPMK-2	Melakukan pengkajian komprehensif anak 0–18 tahun (bio-psiko-sosial, perkembangan, keluarga) dan mendokumentasikan data secara sistematis.
CPMK-3	Menganalisis data pengkajian untuk menetapkan prioritas masalah/diagnosis keperawatan anak sesuai kebutuhan perkembangan dan bukti ilmiah.
CPMK-4	Merancang dan melaksanakan intervensi keperawatan anak (termasuk edukasi keluarga dan pencegahan komplikasi) yang aman dan berbasis bukti.
CPMK-5	Melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar pada kegawatdaruratan pediatrik/neonatal sesuai prinsip keselamatan pasien.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menunjukkan komunikasi terapeutik, konseling, advokasi, dan kolaborasi interprofesional dalam asuhan berpusat keluarga.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran asuhan, melakukan refleksi profesional, dan menyusun perbaikan rencana/peningkatan mutu berbasis data dan etika.

G. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Gangguan Sistem Kardiovaskular pada Anak	7.1 Menginterpretasi data kardiovaskular untuk mengenali gangguan perfusi, syok, atau gagal jantung pada anak.	7.2 Menetapkan prioritas asuhan dan monitoring respons secara sistematis.	CPMK-3	CPMK-4; CPMK-5

H. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Analisis kasus tertulis (case-based)	Ketepatan penetapan prioritas masalah/diagnosis yang didukung data serta rasional berbasis sumber kredibel.	15	Laporan analisis kasus
CPMK-4	Penugasan rencana asuhan + rencana edukasi	Kesesuaian tujuan SMART dan intervensi prioritas yang aman serta kelengkapan rencana edukasi (teach-back/indikator pemahaman).	15	Care plan; materi edukasi
CPMK-5	Simulasi kegawatdaruratan (skill station)	Ketepatan urutan penilaian awal (ABCDE), waktu pelaksanaan, dan ketepatan tindakan stabilisasi dasar sesuai algoritma.	15	Checklist simulasi; catatan performa

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Skor ketepatan konsep inti (persentase benar)	<60% benar; banyak miskonsepsi	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsep konsisten
1.2 Integrasi prinsip FCC dan perkembangan pada skenario	Jawaban tidak relevan/fragmentaris	Relevan sebagian; alasan kurang kuat	Relevan; alasan logis dan konsisten	Sangat relevan; sintesis jelas dengan ≥2 alasan kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Kelengkapan langkah pengkajian (item checklist)	≤60% item tercapai; ada kesalahan kritis	61–75% item tercapai; ada item penting terlewat	76–90% item tercapai; tanpa kesalahan kritis	>90% item tercapai; alur sangat terstruktur
2.2 Kualitas dokumentasi data (akurasi & sistematika)	Tidak sistematis; banyak data hilang	Cukup sistematis; ada kesalahan bermakna	Sistematis; kesalahan minor	Lengkap, jelas, akurat, tanpa kesalahan bermakna

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Validitas prioritas masalah/diagnosis terhadap data	Mayoritas tidak didukung data	Sebagian didukung data; inkonsisten	Sebagian besar didukung data yang relevan	Seluruh prioritas didukung data kuat dan konsisten
3.2 Kekuatan rasional berbasis bukti	Tanpa rasional yang dapat diuji	Rasional umum; sumber tidak jelas	Rasional jelas dengan 1 sumber kredibel	Rasional kuat dengan ≥2 sumber kredibel dan sintesis

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Tujuan SMART & indikator evaluasi	Tujuan tidak SMART; tanpa indikator	Sebagian SMART; indikator belum spesifik	SMART; indikator evaluasi jelas	SMART sangat jelas; indikator spesifik, realistis, terukur
4.2 Ketepatan intervensi & edukasi (keamanan & prioritas)	Tidak sesuai prioritas/berisiko	Sesuai namun kurang lengkap/kurang aman	Sesuai, aman, edukasi jelas	Sangat sesuai, aman, berprioritas; edukasi efektif (teach-back)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan urutan & waktu penilaian awal (ABCDE)	Urutan salah atau >8 menit	Urutan sebagian benar; 6–8 menit	Urutan benar; ≤6 menit	Urutan benar; ≤5 menit + mengenali tanda bahaya
5.2 Ketepatan stabilisasi & komunikasi tim terstruktur	Langkah penting terlewat; komunikasi tidak jelas	Stabilisasi dasar ada; komunikasi kurang runtut	Stabilisasi sesuai algoritma; komunikasi runtut	Stabilisasi tepat tanpa kesalahan kritis; koordinasi tim sangat efektif

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kualitas komunikasi terapeutik (teknik & respons)	Satu arah; tidak responsif	Teknik dasar ada; respons terbatas	Teknik tepat; empati terlihat; respons memadai	Sangat efektif; adaptif usia/budaya; kemitraan kuat
6.2 Kejelasan kolaborasi/rujukan & advokasi	Tidak mengidentifikasi kebutuhan kolaborasi	Mengidentifikasi; koordinasi tidak jelas	Koordinasi jelas dan terdokumentasi	Proaktif; rujukan tepat; advokasi & privasi terjaga kuat

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Evaluasi luaran berbasis data	Tidak menggunakan data	Data terbatas; tanpa interpretasi	Data cukup; interpretasi dan tindak lanjut jelas	Multi-data; interpretasi kritis; simpulan sangat jelas
7.2 Refleksi profesional & rencana perbaikan	Refleksi deskriptif; tanpa rencana	Ada rencana umum; tidak terukur	Rencana spesifik; sebagian terukur	Rencana spesifik, terukur, realistis; menautkan etika & keselamatan

A. Definisi

Gangguan sistem kardiovaskular pada anak merupakan suatu kondisi patologis yang melibatkan struktur maupun fungsi jantung dan pembuluh darah sehingga menyebabkan terganggunya sirkulasi darah dalam memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Sistem kardiovaskular berperan vital dalam mempertahankan homeostasis melalui distribusi oksigen, nutrisi, hormon, serta pembuangan produk sisa metabolisme. Oleh karena itu, setiap gangguan pada sistem ini akan berdampak langsung terhadap fungsi organ vital lainnya.

Pada populasi pediatrik, gangguan kardiovaskular memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor perkembangan anatomi dan fisiologi, seperti ukuran jantung yang lebih kecil, frekuensi jantung yang lebih tinggi, serta sistem kompensasi yang belum matang. Akibatnya, anak cenderung mengalami perburukan kondisi yang lebih cepat ketika terjadi gangguan kardiovaskular, sehingga diperlukan deteksi dini dan intervensi yang cepat serta tepat.

Secara umum, gangguan sistem kardiovaskular pada anak dapat mencakup berbagai kondisi, mulai dari kelainan struktural seperti penyakit jantung bawaan (congenital heart disease), hingga gangguan fungsional seperti gagal jantung, gangguan perfusi jaringan, dan syok. Penyakit jantung bawaan merupakan salah satu kelainan kongenital paling sering ditemukan pada anak dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas pada kelompok usia ini. Sementara itu, kondisi akut seperti syok merupakan keadaan kegawatdaruratan yang dapat mengancam jiwa dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani.

Dari sudut pandang fisiologis, gangguan kardiovaskular terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat atau ketika terjadi hambatan dalam aliran darah melalui pembuluh darah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen jaringan. Ketika perfusi jaringan menurun, sel-sel tubuh akan mengalami hipoksia yang dapat berlanjut menjadi disfungsi organ hingga kegagalan organ multipel. Pada tahap awal, tubuh akan mengaktifkan mekanisme kompensasi seperti peningkatan denyut jantung (takikardia), vasokonstriksi perifer, dan peningkatan kontraktilitas miokard. Namun, apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, mekanisme kompensasi tersebut justru dapat memperberat kerja jantung dan mempercepat terjadinya dekompensasi.

Dalam konteks keperawatan anak, pemahaman mengenai definisi gangguan sistem kardiovaskular tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengenali perubahan klinis secara dini. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian komprehensif terhadap status kardiovaskular

anak, termasuk pemantauan tanda vital, perfusi perifer, status kesadaran, serta output urin sebagai indikator perfusi organ. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan akurat, terutama pada kondisi kegawatdaruratan seperti syok.

Selain itu, pendekatan family-centered care dalam keperawatan anak menempatkan keluarga sebagai bagian integral dalam proses perawatan. Orang tua atau pengasuh perlu diberikan pemahaman mengenai kondisi kardiovaskular anak, tanda-tanda bahaya, serta pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Hal ini menjadi krusial karena banyak kasus gangguan kardiovaskular pada anak yang memerlukan pemantauan jangka panjang di rumah.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perkembangan teknologi diagnostik seperti ekokardiografi dan biomarker jantung telah meningkatkan kemampuan deteksi dini gangguan kardiovaskular pada anak. Selain itu, pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) dalam manajemen kardiovaskular pediatrik juga terus berkembang, sehingga meningkatkan angka harapan hidup dan kualitas hidup pasien anak dengan penyakit jantung.

Dengan demikian, gangguan sistem kardiovaskular pada anak dapat dipahami sebagai suatu spektrum kondisi yang kompleks, melibatkan interaksi antara faktor struktural, fungsional, dan kompensasi tubuh, yang memerlukan pendekatan multidisiplin serta penanganan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini menjadi landasan utama bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

B. Etiologi

Etiologi gangguan sistem kardiovaskular pada anak bersifat kompleks dan multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, infeksi, serta kondisi sistemik lainnya. Secara umum, penyebab gangguan kardiovaskular pada anak dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelainan kongenital (bawaan sejak lahir) dan kelainan didapat (acquired). Selain itu, terdapat pula faktor sekunder yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah.

1. Kelainan Kongenital

   Kelainan jantung bawaan (congenital heart disease/CHD) merupakan penyebab paling dominan gangguan kardiovaskular pada anak. Kondisi ini terjadi akibat gangguan perkembangan struktur jantung selama masa embriogenesis, khususnya pada trimester pertama kehamilan, ketika pembentukan organ jantung berlangsung secara aktif.

Secara embriologis, jantung berkembang melalui proses kompleks yang melibatkan pembentukan tabung jantung primitif, looping, serta septasi ruang jantung. Gangguan pada salah satu tahap ini dapat menyebabkan kelainan struktural seperti defek septum atau malformasi katup.

Beberapa jenis kelainan kongenital yang sering ditemukan meliputi:

a. Defek septum atrium (Atrial Septal Defect/ASD)
b. Defek septum ventrikel (Ventricular Septal Defect/VSD)
c. Patent Ductus Arteriosus (PDA)
d. Tetralogi Fallot
e. Transposisi arteri besar

Kelainan ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi:

a. Kelainan sianotik, ditandai dengan adanya pirau kanan ke kiri sehingga darah tidak teroksigenasi masuk ke sirkulasi sistemik
b. Kelainan non-sianotik, ditandai dengan pirau kiri ke kanan yang menyebabkan peningkatan aliran darah ke paru

Dari perspektif klinis, kelainan kongenital dapat menyebabkan gangguan hemodinamik sejak dini, seperti peningkatan beban volume atau tekanan pada jantung, yang pada akhirnya berujung pada gagal jantung apabila tidak ditangani secara adekuat.

Faktor risiko terjadinya kelainan kongenital meliputi:

a. Infeksi maternal (misalnya rubella)
b. Paparan obat teratogenik
c. Diabetes gestasional
d. Kelainan genetik (misalnya sindrom Down)

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran signifikan dalam perkembangan penyakit jantung bawaan, dengan keterlibatan berbagai mutasi gen yang memengaruhi pembentukan struktur jantung.

2. Kelainan Didapat (Acquired Heart Disease)

Selain kelainan bawaan, gangguan kardiovaskular pada anak juga dapat terjadi akibat kondisi yang berkembang setelah lahir. Kelainan didapat ini sering kali berkaitan dengan proses inflamasi, infeksi, atau gangguan metabolik.

a. Miokarditis

Miokarditis merupakan inflamasi otot jantung yang umumnya disebabkan oleh infeksi virus, seperti enterovirus atau adenovirus. Kondisi ini menyebabkan kerusakan sel miokard dan penurunan kontraktilitas jantung.

Secara klinis, miokarditis dapat berkembang menjadi gagal jantung akut dengan gejala yang sering tidak spesifik, seperti lemah, sesak napas, dan takikardia.

b. Kardiomiopati

Kardiomiopati adalah gangguan struktural dan fungsional otot jantung yang tidak disebabkan oleh kelainan koroner atau tekanan darah tinggi. Pada anak, kardiomiopati dapat bersifat:

1) Dilatasi
2) Hipertrofik
3) Restriktif

Kardiomiopati dilatasi merupakan bentuk yang paling sering ditemukan dan ditandai dengan dilatasi ventrikel serta penurunan fungsi sistolik.

c. Demam Reumatik

Demam reumatik merupakan komplikasi dari infeksi streptokokus yang tidak diobati dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan katup jantung (penyakit jantung reumatik), terutama pada katup mitral dan aorta.

d. Hipertensi Pediatrik

Meskipun lebih jarang dibandingkan pada dewasa, hipertensi pada anak dapat menyebabkan perubahan struktural jantung seperti hipertrofi ventrikel kiri, yang pada akhirnya memengaruhi fungsi jantung.

3. Faktor Sekunder dan Sistemik

Selain penyebab utama di atas, terdapat berbagai faktor sekunder yang dapat memengaruhi sistem kardiovaskular anak, antara lain:

a. Infeksi Sistemik

Infeksi berat seperti sepsis dapat menyebabkan syok septik yang ditandai dengan vasodilatasi sistemik dan penurunan perfusi jaringan.

b. Gangguan Metabolik

Kelainan metabolik seperti gangguan elektrolit, asidosis, atau penyakit metabolik bawaan dapat memengaruhi fungsi jantung secara langsung.

c. Toksisitas Obat

Beberapa obat, terutama kemoterapi seperti antrasiklin, diketahui memiliki efek kardiotoksik yang dapat menyebabkan disfungsi jantung jangka panjang pada anak.

d. Malnutrisi

Malnutrisi kronis dapat menyebabkan penurunan massa otot jantung dan gangguan fungsi kardiovaskular, sehingga meningkatkan risiko gagal jantung.

4. Interaksi Multifaktorial

Penting untuk dipahami bahwa dalam banyak kasus, etiologi gangguan kardiovaskular pada anak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Misalnya, anak dengan kelainan jantung bawaan dapat mengalami perburukan kondisi akibat infeksi atau malnutrisi.

Pendekatan etiologi yang komprehensif sangat penting dalam praktik keperawatan, karena akan memengaruhi:

a. Penentuan diagnosis keperawatan
b. Prioritas intervensi
c. Prognosis pasien

Implikasi dalam Keperawatan Anak

Dalam konteks keperawatan, pemahaman etiologi memiliki peran penting dalam mendukung clinical reasoning. Perawat tidak hanya dituntut untuk mengenali tanda dan gejala, tetapi juga memahami penyebab yang mendasari kondisi pasien.

Hal ini memungkinkan perawat untuk:

a. Mengidentifikasi faktor risiko sejak dini
b. Melakukan pencegahan komplikasi
c. Memberikan edukasi yang tepat kepada keluarga

Pendekatan berbasis etiologi juga mendukung praktik keperawatan berbasis bukti (evidence-based practice), di mana intervensi yang diberikan disesuaikan dengan penyebab utama gangguan.

C. Faktor Risiko

Faktor risiko gangguan sistem kardiovaskular pada anak merupakan berbagai kondisi atau karakteristik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Pemahaman terhadap faktor risiko ini sangat penting dalam praktik keperawatan anak, karena memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, serta intervensi yang lebih tepat sasaran.

Berbeda dengan populasi dewasa, faktor risiko pada anak tidak hanya berkaitan dengan gaya hidup, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi prenatal, genetik, pertumbuhan, serta lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan identifikasi faktor risiko pada anak harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada family-centered care.

1. Faktor Risiko Prenatal

   Faktor prenatal merupakan kondisi yang terjadi selama masa kehamilan dan berperan penting dalam perkembangan sistem kardiovaskular janin.

   a. Infeksi Maternal

      Infeksi selama kehamilan, seperti rubella, sitomegalovirus (CMV), dan toksoplasmosis, dapat menyebabkan gangguan perkembangan jantung janin. Infeksi ini dapat mengganggu proses organogenesis sehingga meningkatkan risiko terjadinya kelainan jantung bawaan.

b. Penyakit Ibu
   Kondisi medis pada ibu, seperti:
   - Diabetes gestasional
   - Hipertensi
   - Lupus

   dapat memengaruhi aliran darah uteroplasenta dan perkembangan organ janin, termasuk jantung.

c. Paparan Teratogen
   Paparan zat berbahaya selama kehamilan, seperti:
   - Alkohol
   - Obat-obatan tertentu
   - Radiasi

   dapat menyebabkan malformasi jantung.

   Penelitian menunjukkan bahwa paparan teratogenik pada trimester pertama memiliki dampak paling signifikan terhadap pembentukan struktur jantung.

2. Faktor Risiko Perinatal
   Faktor perinatal berkaitan dengan kondisi saat kelahiran dan periode segera setelah lahir.
   a. Prematuritas
      Bayi prematur memiliki sistem organ yang belum matang, termasuk sistem kardiovaskular. Hal ini menyebabkan:
      - Ketidakstabilan hemodinamik
      - Risiko gangguan perfusi
      - Kerentanan terhadap gagal jantung

   b. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
      BBLR berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kardiovaskular, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

   c. Asfiksia Neonatorum
      Kondisi kekurangan oksigen saat lahir dapat menyebabkan kerusakan jaringan, termasuk miokard, yang berdampak pada fungsi jantung.

3. Faktor Risiko Genetik dan Keluarga
   Faktor genetik memiliki peran signifikan dalam perkembangan gangguan kardiovaskular pada anak.
   a. Riwayat Keluarga
      Anak dengan riwayat keluarga penyakit jantung memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa.

   b. Kelainan Kromosom
      Beberapa sindrom genetik yang berkaitan dengan gangguan jantung:
      - Sindrom Down

- Sindrom Turner
- Sindrom Marfan

Mutasi gen tertentu diketahui berperan dalam pembentukan struktur jantung dan fungsi miokard.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan genomik mulai digunakan untuk mendeteksi risiko penyakit kardiovaskular sejak dini pada anak.

4. Faktor Risiko Lingkungan dan Gaya Hidup

   Meskipun lebih dominan pada dewasa, faktor lingkungan juga mulai berperan pada anak, terutama seiring perubahan pola hidup modern.

   a. Obesitas Anak

      Obesitas merupakan faktor risiko penting yang berkaitan dengan:

      - Hipertensi
      - Dislipidemia
      - Resistensi insulin

      Kondisi ini dapat menyebabkan perubahan struktur jantung seperti hipertrofi ventrikel kiri.

   b. Kurang Aktivitas Fisik

      Anak dengan aktivitas fisik rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolik yang berdampak pada sistem kardiovaskular.

   c. Pola Makan Tidak Sehat

      Konsumsi makanan tinggi lemak, gula, dan garam dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular sejak usia dini.

5. Faktor Risiko Penyakit dan Kondisi Medis

   a. Infeksi Berat (Sepsis)

      Sepsis dapat menyebabkan syok septik yang berdampak pada gangguan perfusi sistemik.

   b. Penyakit Kronis

      - Penyakit ginjal
      - Penyakit paru
      - Gangguan metabolik

      dapat memperburuk fungsi kardiovaskular.

   c. Terapi Medis

      Beberapa terapi seperti kemoterapi dapat menyebabkan efek samping kardiotoksik yang signifikan.

6. Interaksi Faktor Risiko

   Dalam praktik klinis, faktor risiko jarang berdiri sendiri. Sebagian besar kasus merupakan hasil interaksi beberapa faktor, misalnya:

   - Anak dengan kelainan kongenital + infeksi → risiko gagal jantung meningkat
   - Anak obesitas + kurang aktivitas → risiko hipertensi meningkat

Pendekatan ini menuntut perawat untuk berpikir secara holistik dan integratif dalam melakukan pengkajian.

7. Implikasi dalam Keperawatan Anak
   Pemahaman faktor risiko memiliki implikasi penting dalam praktik keperawatan, khususnya dalam:
   a. Pengkajian Risiko
      Perawat harus mampu mengidentifikasi faktor risiko melalui:
      - Riwayat kesehatan
      - Riwayat keluarga
      - Kondisi lingkungan
   b. Pencegahan Primer
      - Edukasi ibu hamil
      - Promosi kesehatan anak
      - Deteksi dini
   c. Pencegahan Sekunder
      - Monitoring anak berisiko tinggi
      - Skrining kesehatan jantung
   d. Edukasi Keluarga
      Pendekatan edukasi berbasis keluarga sangat penting untuk:
      - Mengurangi paparan faktor risiko
      - Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi
      - Mendeteksi tanda bahaya secara dini

D. Patofisiologi

Patofisiologi gangguan sistem kardiovaskular pada anak merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara gangguan struktur jantung, fungsi pompa, regulasi neurohormonal, serta respons kompensasi tubuh terhadap penurunan perfusi jaringan. Pemahaman patofisiologi menjadi sangat penting karena merupakan dasar dalam clinical reasoning, penentuan diagnosis keperawatan, serta penetapan prioritas intervensi, terutama pada kondisi kegawatdaruratan seperti syok dan gagal jantung.

1. Konsep Dasar Hemodinamik pada Anak
   Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mempertahankan curah jantung (cardiac output) yang adekuat guna memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Curah jantung dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu:
   - Frekuensi jantung (heart rate)
   - Volume sekuncup (stroke volume)

Pada anak, terutama bayi dan balita, frekuensi jantung merupakan determinan utama curah jantung, karena kemampuan meningkatkan volume sekuncup masih terbatas akibat maturasi miokard yang belum sempurna. Oleh karena itu, gangguan kecil pada frekuensi jantung dapat berdampak signifikan terhadap perfusi jaringan.

2. Mekanisme Dasar Gangguan Kardiovaskular
   Gangguan kardiovaskular pada anak umumnya berawal dari salah satu atau kombinasi kondisi berikut:
   a. Penurunan Kontraktilitas Miokard
      Terjadi pada kondisi seperti miokarditis atau kardiomiopati, di mana otot jantung tidak mampu berkontraksi secara efektif sehingga menurunkan curah jantung.
   b. Gangguan Preload
      Preload berkaitan dengan jumlah darah yang kembali ke jantung. Penurunan preload (misalnya pada dehidrasi atau perdarahan) akan mengurangi pengisian ventrikel dan menurunkan curah jantung.
   c. Gangguan Afterload
      Afterload adalah resistensi yang harus diatasi jantung untuk memompa darah. Peningkatan afterload (misalnya pada hipertensi atau vasokonstriksi berat) akan meningkatkan beban kerja jantung.
   d. Gangguan Aliran Darah
      Kelainan struktural seperti defek septum atau stenosis katup menyebabkan aliran darah tidak efektif dan mengganggu distribusi oksigen.
3. Mekanisme Kompensasi Tubuh
   Ketika terjadi gangguan perfusi, tubuh akan mengaktifkan berbagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan perfusi organ vital (otak dan jantung).
   a. Aktivasi Sistem Saraf Simpatis
      - Peningkatan denyut jantung (takikardia)
      - Peningkatan kontraktilitas jantung
      - Vasokonstriksi perifer

      Efeknya adalah peningkatan tekanan darah sementara, tetapi menyebabkan ekstremitas menjadi dingin dan pucat.
   b. Aktivasi Sistem Renin-Angiotensin-Aldosteron (RAAS)
      - Retensi natrium dan air
      - Peningkatan volume intravaskular
      - Vasokonstriksi

      Meskipun bertujuan meningkatkan perfusi, mekanisme ini dapat menyebabkan overload cairan dan memperburuk gagal jantung.

c. Pelepasan Hormon Antidiuretik (ADH)
   - Retensi cairan
   - Penurunan produksi urin

   Hal ini menjelaskan mengapa pada anak dengan gangguan kardiovaskular sering ditemukan oliguria.

4. Gangguan Perfusi Jaringan

   Ketika mekanisme kompensasi tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangan, maka terjadi gangguan perfusi jaringan.

   Prosesnya:

   a. Penurunan curah jantung
   b. Penurunan aliran darah ke jaringan
   c. Hipoksia sel
   d. Metabolisme anaerob
   e. Produksi asam laktat meningkat
   f. Terjadi asidosis metabolik

   Asidosis ini akan memperburuk fungsi jantung dan menyebabkan siklus yang semakin memperparah kondisi pasien.

5. Patofisiologi Syok pada Anak

   Syok merupakan bentuk ekstrem dari gangguan perfusi yang ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi.

   Tahapan Syok:

   a. Syok Kompensasi
      - Takikardia
      - CRT memanjang
      - Tekanan darah masih normal

      Pada tahap ini, tubuh masih mampu mempertahankan perfusi organ vital.

   b. Syok Dekompensasi
      - Hipotensi
      - Penurunan kesadaran
      - Perfusi sangat buruk

      Ini merupakan fase kritis yang memerlukan intervensi segera.

   c. Syok Irreversibel
      - Kerusakan organ permanen
      - Kegagalan multiorgan
      - Mortalitas tinggi

      Pada anak, hipotensi merupakan tanda akhir, sehingga deteksi harus dilakukan sebelum fase ini terjadi.

6. Patofisiologi Gagal Jantung pada Anak
   Gagal jantung pada anak terjadi akibat ketidakmampuan jantung memompa darah sesuai kebutuhan tubuh.
   Mekanisme utama:
   - Penurunan kontraktilitas
   - Overload volume
   - Overload tekanan

   Pada bayi, kondisi ini sering ditandai dengan:
   - Kesulitan menyusu
   - Berkeringat saat makan
   - Pertumbuhan terhambat
7. Perbedaan Patofisiologi Anak vs Dewasa
   Beberapa perbedaan penting:
   - Anak lebih bergantung pada frekuensi jantung
   - Cadangan kompensasi lebih terbatas
   - Perburukan kondisi lebih cepat
   - Hipotensi muncul terlambat

   Hal ini menuntut perawat untuk lebih waspada terhadap tanda dini seperti:
   - CRT memanjang
   - Takikardia
   - Perubahan perilaku
8. Implikasi dalam Keperawatan
   Pemahaman patofisiologi sangat penting dalam:
   a. Pengambilan Keputusan Klinis
      Menentukan apakah pasien berada dalam fase kompensasi atau dekompensasi
   b. Penetapan Prioritas
      Fokus pada:
      - Airway
      - Breathing
      - Circulation
   c. Monitoring
      Menilai respons terapi melalui:
      - CRT
      - Tanda vital
      - Output urin
   d. Pencegahan Komplikasi
      Intervensi dini dapat mencegah:
      - Syok
      - Gagal organ

9. Clinical Reasoning Pada Gangguan Kardiovaskular Anak
   a. Definisi Clinical Reasoning

      Clinical reasoning merupakan proses berpikir kritis dan sistematis yang digunakan tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk:

      1) mengumpulkan data,
      2) menganalisis kondisi pasien,
      3) menentukan masalah prioritas,
      4) mengambil keputusan klinis,
      5) serta mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi.

      Dalam gangguan sistem kardiovaskular pada anak, clinical reasoning menjadi sangat penting karena kondisi anak dapat berubah cepat dan tanda kegawatan sering kali muncul terlambat. Perawat harus mampu mengenali perubahan kecil yang dapat menjadi tanda awal penurunan perfusi.

      Clinical reasoning membantu perawat untuk:

      1) Mengenali tanda dini syok
      2) Menentukan prioritas tindakan
      3) Mengambil keputusan cepat
      4) Mencegah keterlambatan intervensi
      5) Meningkatkan keselamatan pasien

   b. Pentingnya Clinical Reasoning pada Anak

      Anak memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dibandingkan dewasa, antara lain:

      1) frekuensi jantung lebih tinggi,
      2) cadangan kompensasi terbatas,
      3) hipotensi muncul lebih lambat,
      4) kondisi dapat memburuk secara cepat.

      Oleh karena itu, perawat tidak boleh hanya berfokus pada tekanan darah, tetapi harus memperhatikan tanda awal gangguan perfusi seperti:

      1) takikardia,
      2) CRT memanjang,
      3) perubahan perilaku,
      4) penurunan produksi urin,
      5) ekstremitas dingin.

      Dalam praktik klinik, keterlambatan mengenali tanda awal syok dapat meningkatkan risiko:

      1) gagal organ,
      2) henti jantung,
      3) mortalitas.

c. Proses Clinical Reasoning

Clinical reasoning dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1) Pengumpulan Data (Cue Acquisition)

Perawat mengumpulkan:

a) data subjektif,
b) data objektif,
c) hasil observasi,
d) pemeriksaan fisik,
e) hasil monitoring.

Contoh data:

a) anak tampak lemas,
b) CRT 4 detik,
c) nadi cepat,
d) oliguria,
e) SpO_2 menurun.

2) Interpretasi Data (Cue Interpretation)

Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan:

- apakah perfusi adekuat,
- apakah terjadi kompensasi,
- apakah kondisi mengarah ke syok.

Contoh:

CRT memanjang + takikardia + ekstremitas dingin → menunjukkan perfusi jaringan menurun.

3) Identifikasi Prioritas

Perawat menentukan masalah paling mengancam nyawa berdasarkan prinsip:

ABCDE

A — Airway

Apakah jalan napas paten?

B — Breathing

Apakah oksigenasi adekuat?

C — Circulation

Apakah perfusi adekuat?

D — Disability

Apakah ada penurunan kesadaran?

E — Exposure

Apakah ada kondisi lain yang memperburuk?

4) Pengambilan Keputusan Klinis

Perawat menentukan:

a) tindakan segera,
b) kebutuhan kolaborasi,
c) prioritas monitoring.

Contoh:

Jika perfusi buruk ditemukan:

a) oksigen segera diberikan,
b) akses intravena dipersiapkan,
c) monitoring ketat dilakukan.

5) Evaluasi Respons

Setelah intervensi dilakukan, perawat mengevaluasi:

- CRT,
- nadi,
- SpO_2,
- kesadaran,
- urin.

d. Interpretasi Clinical Reasoning pada Tanda Klinis

1) Interpretasi CRT (Capillary Refill Time)

CRT merupakan indikator sederhana untuk menilai perfusi perifer.

Normal: < 2 detik

Abnormal: 3 detik

Makna klinis:

- perfusi jaringan menurun,
- vasokonstriksi perifer,
- kemungkinan syok kompensasi.

Clinical Reasoning

Jika CRT memanjang:

tubuh sedang mempertahankan perfusi organ vital dengan vasokonstriksi perifer.

Akibat:

- tangan dan kaki dingin,
- aliran darah perifer menurun.

2) Interpretasi Takikardia

Takikardia merupakan tanda awal paling sensitif pada syok anak.

Penyebab:

a) kompensasi penurunan curah jantung,
b) hipoksia,

c) demam,
d) nyeri,
e) hipovolemia.

Clinical Reasoning

Tubuh meningkatkan frekuensi jantung untuk mempertahankan cardiac output karena stroke volume anak terbatas.

Jika takikardia disertai:

- CRT memanjang,
- ekstremitas dingin,
- oliguria,

maka harus dicurigai: **gangguan perfusi atau syok.**

3) Interpretasi Oliguria

Oliguria:

- urin < 1 ml/kg/jam

Makna:

- perfusi ginjal menurun,
- aktivasi RAAS,
- retensi cairan.

Clinical Reasoning

Ketika perfusi menurun, tubuh memprioritaskan aliran darah ke:

- otak,
- jantung,

dan mengurangi perfusi ke ginjal.

Akibat:

- produksi urin menurun.

4) Interpretasi Perubahan Kesadaran

Gejala:

- rewel,
- gelisah,
- letargi,
- penurunan kesadaran.

Makna:

- perfusi otak menurun,
- hipoksia serebral.

Clinical Reasoning

Otak sangat sensitif terhadap hipoksia. Perubahan perilaku sering menjadi tanda awal gangguan perfusi otak.

e. Clinical Reasoning pada Syok Anak

Tahap 1 — Syok Kompensasi

Tanda:

1) takikardia,
2) CRT memanjang,
3) ekstremitas dingin,
4) tekanan darah masih normal.

Clinical Reasoning

Tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah melalui:

- vasokonstriksi,
- peningkatan denyut jantung.

Ini merupakan fase emas intervensi.

Tahap 2 — Syok Dekompensasi

Tanda:

- hipotensi,
- nadi lemah,
- penurunan kesadaran,
- oliguria berat.

Clinical Reasoning

Mekanisme kompensasi gagal mempertahankan perfusi sehingga organ mulai mengalami hipoksia berat.

Tahap 3 — Syok Irreversibel

Tanda:

- kegagalan multiorgan,
- asidosis berat,
- henti jantung.

Clinical Reasoning

Kerusakan organ sudah permanen dan mortalitas sangat tinggi.

f. Pengambilan Keputusan Klinis Cepat

Dalam kondisi kegawatdaruratan, perawat harus:

1) mengenali tanda dini,
2) menentukan prioritas,
3) melakukan tindakan segera,
4) melakukan eskalasi cepat.

Contoh

Jika ditemukan:

- CRT 4 detik,
- nadi cepat,

- SpO_2 90%,
- ekstremitas dingin,

Maka tindakan prioritas:

1) Berikan oksigen
2) Monitor tanda vital
3) Siapkan akses IV
4) Kolaborasi cairan
5) Laporkan segera

g. Clinical Reasoning Berbasis ABCDE

Komponen	**Pengkajian**	**Makna Klinis**
Airway	Jalan napas	Risiko obstruksi
Breathing	RR, SpO_2	Hipoksia
Circulation	CRT, nadi	Perfusi
Disability	Kesadaran	Perfusi otak
Exposure	Pemeriksaan umum	Faktor lain

h. Faktor yang Memperberat Gangguan Perfusi
Beberapa kondisi dapat mempercepat perburukan:

1) sepsis,
2) dehidrasi,
3) perdarahan,
4) demam tinggi,
5) malnutrisi,
6) kelainan jantung bawaan.

Perawat harus mampu mengenali faktor risiko ini sejak dini.

i. Kesalahan Clinical Reasoning yang Sering Terjadi
Kesalahan Umum

1) Menunggu hipotensi muncul
2) Tidak menilai CRT
3) Tidak memonitor urin
4) Menganggap anak stabil hanya karena sadar
5) Tidak melakukan reevaluasi

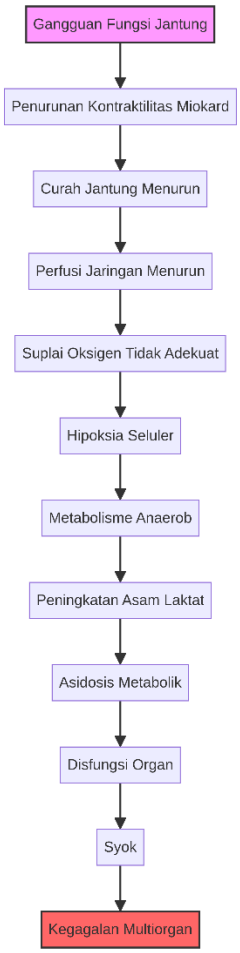
j. Implikasi Clinical Reasoning dalam Keperawatan
Clinical reasoning membantu perawat untuk:

1) meningkatkan akurasi pengkajian,
2) menentukan prioritas,
3) meningkatkan patient safety,
4) mencegah keterlambatan intervensi,

5) meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.

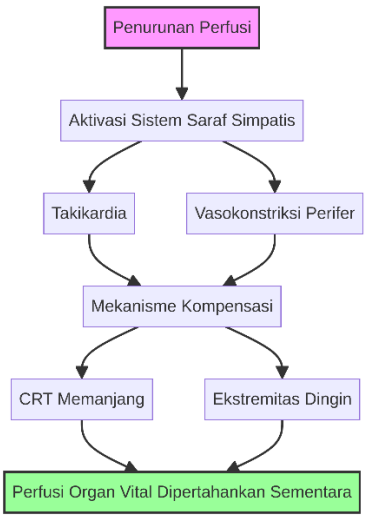
10. FLOWCHART GANGGUAN PERFUSI DAN SYOK

a. Flowchart Patofisiologi Gangguan Perfusi



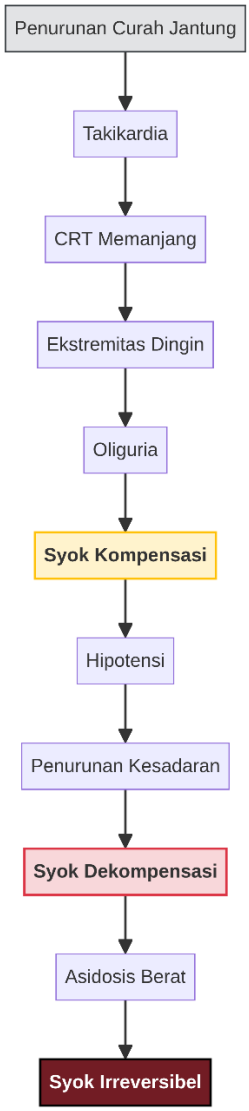
Gambar 5. 1 Flowchart Patofisiologi Gangguan Perfusi

b. Flowchart Mekanisme Kompensasi Tubuh



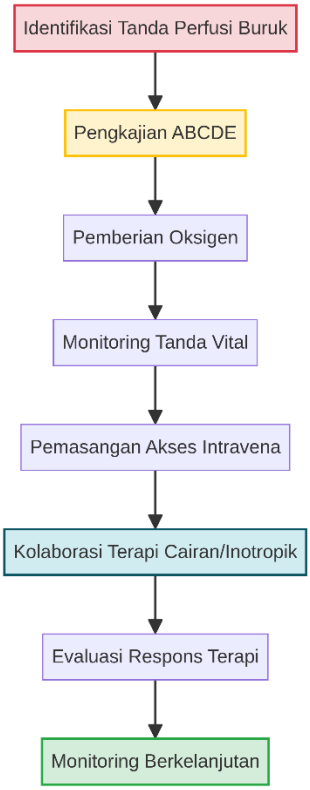
Gambar 5. 2 Flowchart Mekanisme Kompensasi Tubuh

c. Flowchart Syok Anak



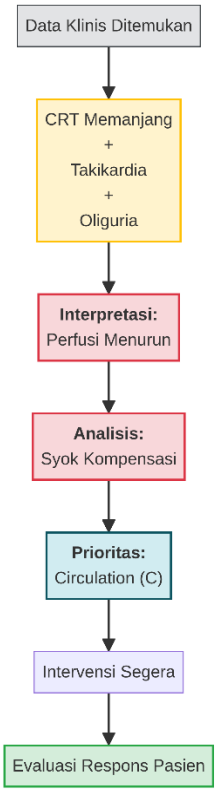
Gambar 5. 3 Flowchart Syok Anak

d. Flowchart Prioritas Penanganan Syok Anak



Gambar 5. 4 Flowchart Prioritas Penanganan Syok Anak

e. Flowchart Clinical Reasoning pada Syok



Gambar 5. 5 Flowchart Clinical Reasoning pada Syok

f. Implikasi Flowchart dalam Keperawatan
Flowchart membantu:
1) mempermudah pemahaman mahasiswa,
2) meningkatkan clinical reasoning,
3) membantu pengambilan keputusan cepat,
4) mendukung pembelajaran OSCE,
5) meningkatkan keselamatan pasien.

E. Klasifikasi

Klasifikasi gangguan sistem kardiovaskular pada anak bertujuan untuk mengelompokkan kondisi berdasarkan karakteristik tertentu sehingga memudahkan dalam diagnosis, penentuan prioritas asuhan, serta pengambilan keputusan klinis. Dalam praktik keperawatan anak, klasifikasi ini sangat penting untuk mendukung clinical reasoning, terutama dalam situasi kegawatdaruratan.

Gangguan kardiovaskular pada anak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan, yaitu berdasarkan etiologi, perubahan hemodinamik, kondisi klinis, dan fungsi jantung.

1. Klasifikasi Berdasarkan Etiologi
Klasifikasi ini membedakan gangguan berdasarkan penyebab utama.
   a. Kelainan Kongenital (Bawaan)
   Merupakan kelainan struktur jantung sejak lahir akibat gangguan perkembangan embrional.
   Contoh:
   - Defek septum atrium (ASD)
   - Defek septum ventrikel (VSD)
   - Tetralogi Fallot
   - Patent ductus arteriosus (PDA)

   b. Kelainan Didapat (Acquired)
   Terjadi setelah lahir akibat proses penyakit tertentu.
   Contoh:
   - Miokarditis
   - Kardiomiopati
   - Demam reumatik
   - Hipertensi pediatrik

2. Klasifikasi Berdasarkan Perubahan Hemodinamik
Klasifikasi ini sangat penting dalam praktik klinis karena berkaitan langsung dengan perfusi jaringan.

Tabel 5. 1 Klasifikasi Hemodinamik

Jenis Gangguan	**Karakteristik**	**Dampak Klinis**
Overload volume	Volume darah meningkat	Dilatasi jantung, gagal jantung
Overload tekanan	Resistensi meningkat	Hipertrofi ventrikel
Obstruksi aliran	Hambatan aliran darah	Penurunan curah jantung
Shunting (pirau)	Aliran abnormal antar ruang jantung	Gangguan oksigenasi

3. Klasifikasi Berdasarkan Kondisi Klinis
   Pendekatan ini paling sering digunakan dalam keperawatan karena berkaitan langsung dengan kondisi pasien.
   a. Gangguan Perfusi Jaringan
      Kondisi awal di mana aliran darah tidak adekuat, ciri-ciri ; CRT memanjang, Ekstremitas dingin dan Oliguria
   b. Syok
      Merupakan kegawatdaruratan akibat kegagalan sirkulasi.
      Jenis Syok:
      - Hipovolemik
      - Kardiogenik
      - Distributif
   c. Gagal Jantung
      Kondisi kronis atau akut akibat ketidakmampuan jantung memompa darah.

Tabel 5. 2 Klasifikasi Klinis

Kondisi	**Karakteristik**	**Tingkat Keparahan**
Perfusi tidak efektif	Perfusi menurun ringan	Awal
Syok kompensasi	Kompensasi masih adekuat	Sedang
Syok dekompensasi	Perfusi organ terganggu	Berat
Gagal jantung	Disfungsi pompa jantung	Kronis/akut

4. Klasifikasi Berdasarkan Warna (Warm vs Cold Shock)
   Klasifikasi ini penting dalam praktik kegawatdaruratan.
   a. Warm Shock
      - Kulit hangat
      - Vasodilatasi
      - Tekanan darah relatif stabil
   b. Cold Shock
      - Kulit dingin
      - Vasokonstriksi
      - Perfusi buruk

Tabel 5. 3 Perbandingan Warm vs Cold Shock

Parameter	Warm Shock	Cold Shock
Suhu kulit	Hangat	Dingin
CRT	Cepat	Memanjang
Nadi	Kuat	Lemah
Perfusi	Relatif baik	Buruk

5. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi Jantung
   a. Disfungsi Sistolik
      - Penurunan kontraktilitas
      - Curah jantung menurun
   b. Disfungsi Diastolik
      - Gangguan relaksasi jantung
      - Pengisian ventrikel terganggu
6. Klasifikasi Berdasarkan Derajat Gagal Jantung
   Sering digunakan untuk menilai tingkat keparahan.

Tabel 5. 4 Derajat Gagal Jantung Anak

Derajat	Deskripsi
Ringan	Tanpa gejala saat istirahat
Sedang	Gejala saat aktivitas
Berat	Gejala saat istirahat

7. Integrasi Klasifikasi dalam Clinical Reasoning
   Dalam praktik keperawatan, klasifikasi tidak digunakan secara terpisah, tetapi dikombinasikan untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh.
   Contoh:
   Seorang anak dengan, CRT 4 detik, Nadi cepat , Ekstremitas dingin

Dapat diklasifikasikan sebagai:

- Gangguan perfusi → menuju syok
- Syok kompensasi (cold shock)

8. Implikasi dalam Keperawatan dan OSCE
   Klasifikasi ini sangat penting untuk:
   a. Pengkajian
      Membantu perawat mengidentifikasi kondisi pasien dengan cepat
   b. Penentuan Prioritas
      Menentukan apakah pasien membutuhkan tindakan segera
   c. Simulasi OSCE
      Mahasiswa sering diuji untuk:
      1) Mengklasifikasikan kondisi pasien
      2) Menentukan tingkat keparahan
      3) Mengambil keputusan klinis

F. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis gangguan sistem kardiovaskular pada anak merupakan respon tubuh terhadap ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen jaringan. Manifestasi ini sangat bervariasi tergantung pada jenis gangguan, tingkat keparahan, usia anak, serta mekanisme kompensasi yang terjadi. Berbeda dengan dewasa, pada anak tanda dan gejala sering kali tidak spesifik dan berkembang cepat, sehingga perawat harus memiliki kemampuan observasi yang tajam untuk mengenali tanda dini sebelum terjadi kondisi kritis.

1. Prinsip Umum Manifestasi Klinis
   Manifestasi klinis pada gangguan kardiovaskular umumnya mencerminkan tiga kondisi utama:
   a. Gangguan perfusi jaringan
   b. Gangguan oksigenasi
   c. Kompensasi tubuh terhadap penurunan curah jantung

   Gejala awal sering bersifat ringan, namun dapat berkembang cepat menjadi kondisi berat seperti syok atau gagal jantung.
2. Manifestasi Klinis Berdasarkan Sistem
   a. Sistem Kardiovaskular
      1) Takikardia (tanda awal paling sensitif)
      2) Nadi lemah atau tidak teraba
      3) CRT memanjang (> 3 detik)
      4) Hipotensi (tanda lanjut)

      Takikardia pada anak sering menjadi indikator awal penurunan curah jantung sebelum muncul hipotensi.

b. Sistem Respirasi
   1) Takipnea
   2) Sesak napas
   3) Retraksi dinding dada
   4) Napas cuping hidung (pada bayi)

   Gangguan kardiovaskular sering menyebabkan kongesti paru yang memicu gejala respirasi.
c. Sistem Neurologis
   1) Gelisah atau rewel
   2) Letargi
   3) Penurunan kesadaran

   Perubahan status mental merupakan indikator penting gangguan perfusi otak.
d. Sistem Integumen
   1) Kulit pucat
   2) Sianosis
   3) Ekstremitas dingin
   4) Mottling (bercak kulit)
e. Sistem Renal
   1) Oliguria (<1 ml/kg/jam)
   2) Penurunan frekuensi BAK

   Output urin merupakan indikator penting perfusi ginjal.
f. Sistem Gastrointestinal
   1) Nafsu makan menurun
   2) Mual/muntah
   3) Hepatomegali

   Pada bayi sering ditemukan kesulitan menyusu.

3. Manifestasi Klinis Gangguan Perfusi

   Gangguan perfusi merupakan tahap awal sebelum berkembang menjadi syok.

   Tanda:

   a. CRT memanjang
   b. Takikardia
   c. Ekstremitas dingin
   d. Penurunan aktivitas

4. Manifestasi Klinis Syok
   Syok memiliki perkembangan bertahap yang harus dikenali secara dini.

Tabel 5. 5 Perbedaan Tanda Dini dan Lanjut Syok

Parameter	Tanda Dini (Kompensasi)	Tanda Lanjut (Dekompensasi)
Nadi	Cepat	Sangat cepat/lemah
CRT	Memanjang	Sangat memanjang
Kulit	Dingin/pucat	Sianosis
Kesadaran	Gelisah	Penurunan kesadaran
Tekanan darah	Normal	Menurun
Urin	Menurun	Sangat sedikit/tidak ada

5. Manifestasi Klinis Gagal Jantung
   Manifestasi gagal jantung pada anak berbeda tergantung usia.
   a. Bayi
      - Kesulitan menyusu
      - Berkeringat saat menyusu
      - Gagal tumbuh
      - Takipnea
   b. Anak Lebih Besar
      - Mudah lelah
      - Sesak saat aktivitas
      - Edema
      - Nyeri dada (jarang)

Tabel 5. 6 Manifestasi Gagal Jantung Berdasarkan Sistem

Sistem	Manifestasi
Respirasi	Sesak, takipnea
Kardiovaskular	Takikardia
Gastrointestinal	Hepatomegali
Sistemik	Edema, kelelahan

6. Red Flag (Tanda Bahaya) pada Anak
   Perawat harus segera bertindak jika menemukan:
   a. CRT > 3 detik
   b. Takikardia ekstrem
   c. Penurunan kesadaran
   d. Oliguria berat
   e. Sianosis
   f. Sesak berat

Tanda-tanda ini menunjukkan kondisi mengarah ke syok atau gagal jantung berat.

7. Perbedaan Manifestasi Anak vs Dewasa

Aspek	Anak	Dewasa
Tanda awal	Takikardia	Hipotensi
Kompensasi	Kuat tapi cepat gagal	Lebih stabil
Perburukan	Cepat	Lebih lambat

8. Implikasi dalam Keperawatan
   Manifestasi klinis menjadi dasar dalam:
   a. Pengkajian Cepat
      Perawat harus mampu melakukan, Observasi cepat (look, listen, feel), Penilaian CRT dan perfusi
   b. Penentuan Prioritas
      Tanda klinis menentukan apakah pasien:
      - Stabil
      - Risiko syok
      - Syok aktif
   c. Monitoring
      Pemantauan perubahan kecil sangat penting karena kondisi anak dapat berubah cepat.

G. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang pada gangguan sistem kardiovaskular anak merupakan komponen penting dalam menegakkan diagnosis, menentukan tingkat keparahan, serta mengevaluasi respons terapi. Dalam praktik keperawatan, pemahaman terhadap hasil pemeriksaan penunjang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi harus mampu diinterpretasikan secara klinis untuk mendukung clinical reasoning. Pendekatan pemeriksaan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi, dimulai dari pemeriksaan sederhana hingga pemeriksaan lanjutan sesuai kondisi pasien.

1. Prinsip Pemeriksaan Penunjang
   Tujuan utama pemeriksaan penunjang adalah:
   a. Mengidentifikasi penyebab gangguan kardiovaskular
   b. Menilai fungsi jantung dan perfusi jaringan
   c. Menentukan derajat keparahan
   d. Memantau perkembangan kondisi pasien
   Dalam kondisi kegawatdaruratan, pemeriksaan harus dilakukan cepat, tepat, dan tidak menunda tindakan resusitasi.

2. Pemeriksaan Laboratorium
   Pemeriksaan laboratorium memberikan informasi mengenai kondisi sistemik yang memengaruhi fungsi kardiovaskular.
   a. Hemoglobin (Hb)
   b. Elektrolit (Na, K, Ca)
   c. Analisis Gas Darah (AGD)
   d. Biomarker Jantung
3. Pemeriksaan Radiologi
   Foto Thoraks (X-ray)
4. Elektrokardiografi (EKG)
5. Ekokardiografi
6. Pulse Oximetry
7. Pemeriksaan Hemodinamik
8. Pemeriksaan Lanjutan
   a. CT Scan / MRI Jantung
   b. Kateterisasi Jantung

H. Komplikasi

Komplikasi pada gangguan sistem kardiovaskular anak merupakan konsekuensi lanjutan dari gangguan perfusi, disfungsi jantung, serta kegagalan mekanisme kompensasi tubuh. Komplikasi ini dapat terjadi secara akut maupun kronis, dan berpotensi menyebabkan peningkatan morbiditas bahkan mortalitas apabila tidak dikenali dan ditangani secara dini.

Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang komplikasi sangat penting untuk:

- Mendeteksi perburukan kondisi secara dini
- Melakukan monitoring ketat
- Mencegah terjadinya kegagalan organ
- Meningkatkan keselamatan pasien (patient safety)

1. Konsep Terjadinya Komplikasi
   Komplikasi terjadi akibat rangkaian proses berikut:
   a. Gangguan fungsi jantung
   b. Penurunan curah jantung
   c. Penurunan perfusi jaringan
   d. Hipoksia seluler
   e. Disfungsi organ
   Jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi, maka akan berkembang menjadi kegagalan multiorgan.
2. Komplikasi Akut
   a. Syok
   b. Aritmia
   c. Asidosis Metabolik

3. Komplikasi Kronis
   a. Gagal Jantung Kronis
   b. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan
   c. Gangguan Fungsi Organ
   d. Hipertensi Pulmonal
4. Komplikasi Sistemik (Multiorgan)
   Jika tidak ditangani, gangguan kardiovaskular dapat menyebabkan: Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS)
5. Tabel Ringkasan Komplikasi

Tabel 5. 7 Tabel Ringkasan Komplikasi

Komplikasi	Mekanisme	Dampak
Syok	Perfusi menurun	Kegagalan organ
Edema paru	Kongesti paru	Gagal napas
Aritmia	Gangguan listrik jantung	Henti jantung
Asidosis	Hipoksia	Disfungsi jantung
Gagal jantung	Disfungsi pompa	Kronis
Gangguan tumbuh	Energi tidak adekuat	Stunting

I. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan gangguan sistem kardiovaskular pada anak bertujuan untuk mempertahankan perfusi jaringan yang adekuat, memperbaiki fungsi jantung, serta mencegah komplikasi. Penatalaksanaan dilakukan secara komprehensif, meliputi tindakan kegawatdaruratan, terapi farmakologis, non-farmakologis, serta kolaborasi interdisiplin. Dalam praktik keperawatan, penatalaksanaan harus dilakukan secara cepat, sistematis, dan berbasis prioritas klinis, terutama pada kondisi kritis seperti syok dan gagal jantung.

1. Prinsip Umum Penatalaksanaan
   Prinsip utama meliputi:
   a. Identifikasi dini kondisi pasien
   b. Penentuan prioritas berdasarkan ABC (Airway, Breathing, Circulation)
   c. Stabilisasi hemodinamik
   d. Terapi penyebab (definitif)
   e. Monitoring berkelanjutan
2. Penatalaksanaan Kegawatdaruratan: Pendekatan ABCDE
   Pendekatan ABCDE merupakan standar dalam penanganan pasien anak dengan gangguan kardiovaskular.

a. Airway (Jalan Napas)
   Tujuan: memastikan jalan napas paten
   Tindakan:
   - Observasi adanya sumbatan jalan napas
   - Posisi head tilt–chin lift (jika tidak ada trauma)
   - Pemasangan airway adjunct bila diperlukan

   Implikasi klinis:
   Gangguan jalan napas akan memperburuk hipoksia dan mempercepat terjadinya syok.
b. Breathing (Pernapasan)
   Tujuan: mempertahankan oksigenasi adekuat
   Tindakan:
   - Berikan oksigen (nasal kanul/masker)
   - Monitor saturasi oksigen
   - Observasi tanda distress pernapasan

   Target: $SpO_2 \geq 95\%$
c. Circulation (Sirkulasi)
   Tujuan: mempertahankan perfusi jaringan
   Tindakan:
   - Monitor nadi, CRT, tekanan darah
   - Akses intravena segera
   - Resusitasi cairan (jika hipovolemia)
   - Pemberian obat inotropik (kolaborasi)

   Indikator keberhasilan:
   - CRT < 2 detik
   - Nadi kuat
   - Urin adekuat
d. Disability (Neurologis)
   Tujuan: menilai perfusi otak
   Tindakan:
   - Evaluasi kesadaran (AVPU/GCS)
   - Monitor perubahan perilaku
e. Exposure
   Tujuan: evaluasi menyeluruh kondisi pasien
   Tindakan:
   - Periksa tanda lain (ruam, trauma)
   - Jaga suhu tubuh

3. Penatalaksanaan Farmakologis
   Terapi farmakologis diberikan sesuai kondisi klinis.
   a. Diuretik
   b. Inotropik
   c. Vasodilator
   d. ACE Inhibitor
4. Penatalaksanaan Non-Farmakologis
   a. Oksigenasi
   b. Manajemen Cairan
   c. Nutrisi
5. Penatalaksanaan Berdasarkan Kondisi
   a. Gangguan Perfusi
   b. Syok
   c. Gagal Jantung

J. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan merupakan tahap awal dan paling krusial dalam proses keperawatan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara komprehensif guna mengidentifikasi masalah kesehatan pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular. Ketepatan pengkajian sangat menentukan kualitas diagnosis keperawatan, intervensi, serta luaran yang akan dicapai. Pada anak, pengkajian harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan perkembangan, serta melibatkan keluarga sebagai sumber informasi utama (family-centered care).

1. Tujuan Pengkajian
   Pengkajian bertujuan untuk:
   a. Mengidentifikasi gangguan perfusi dan oksigenasi
   b. Menentukan tingkat keparahan kondisi
   c. Mengidentifikasi faktor risiko dan penyebab
   d. Menjadi dasar dalam penetapan diagnosis keperawatan
2. Prinsip Pengkajian pada Anak
   a. Dilakukan secara cepat dan sistematis
   b. Mengutamakan kondisi yang mengancam nyawa
   c. Menggunakan pendekatan ABCDE
   d. Melibatkan orang tua sebagai informan utama
   e. Memperhatikan usia dan tahap perkembangan anak
3. Pengkajian Primer (Primary Survey — ABCDE)
   Pengkajian primer dilakukan pada kondisi kegawatdaruratan.
   a. Airway
      - Apakah jalan napas paten?
      - Ada sumbatan (lendir, muntah)?

- Suara napas tambahan?

b. Breathing
   - Frekuensi napas (takipnea?)
   - Pola napas (retraksi, cuping hidung)
   - Saturasi oksigen

c. Circulation (Fokus Utama Kardiovaskular)
   Komponen yang dikaji:
   - Frekuensi dan kualitas nadi
   - CRT (Capillary Refill Time)
   - Warna kulit (pucat/sianosis)
   - Suhu ekstremitas
   - Tekanan darah
   - Produksi urin

d. Disability
   - Tingkat kesadaran (AVPU/GCS)
   - Respons anak terhadap rangsangan

e. Exposure
   - Pemeriksaan menyeluruh
   - Tanda edema, hepatomegali

4. Pengkajian Sekunder (Secondary Survey)
   Dilakukan setelah kondisi stabil.
   a. Identitas dan Riwayat Kesehatan
      1) Usia (penting untuk interpretasi tanda vital)
      2) Riwayat penyakit jantung
      3) Riwayat keluarga
      4) Riwayat kehamilan dan persalinan
   b. Riwayat Keluhan Utama
      1) Sesak napas
      2) Mudah lelah
      3) Tidak mau makan/menyusu
      4) Berkeringat berlebihan
   c. Riwayat Penyakit Sekarang
      1) Onset gejala
      2) Durasi
      3) Faktor yang memperberat/meringankan
   d. Riwayat Nutrisi
      1) Pola makan
      2) Kesulitan makan
      3) Status gizi

5. Pemeriksaan Fisik Sistematis
   a. Inspeksi
      - Warna kulit (pucat/sianosis)
      - Pola napas
      - Aktivitas anak
   b. Palpasi
      - CRT
      - Suhu kulit
      - Edema
   c. Auskultasi
      - Bunyi jantung (murmur)
      - Bunyi napas tambahan
6. Pengkajian Berdasarkan Sistem

Tabel 5. 8 Pengkajian Kardiovaskular Anak

Sistem	Data yang Dikaji	Makna Klinis
Kardiovaskular	Nadi, CRT	Perfusi
Respirasi	RR, SpO_2	Oksigenasi
Neurologis	Kesadaran	Perfusi otak
Renal	Urin	Perfusi ginjal

7. Pengkajian Tanda Dini Syok
   a. Takikardia
   b. CRT memanjang
   c. Ekstremitas dingin
   d. Penurunan aktivitas
8. Pengkajian Berdasarkan SDKI
   Dalam pendekatan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), data diklasifikasikan menjadi:
   a. Data Subjektif
      - Ibu mengatakan anak lemas
      - Anak tidak mau makan
   b. Data Objektif
      - CRT 4 detik
      - Nadi cepat
      - Oliguria
9. Pengkajian Psikososial dan Keluarga
   - Tingkat kecemasan orang tua
   - Pemahaman keluarga terhadap kondisi anak

- Dukungan keluarga

10. Pengkajian Risiko
    Mengidentifikasi:
    - Risiko syok
    - Risiko gagal jantung
    - Risiko komplikasi

K. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan keputusan klinis mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang aktual maupun potensial. Pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, diagnosis keperawatan berfokus pada gangguan perfusi, oksigenasi, keseimbangan cairan, serta respon adaptasi tubuh terhadap penurunan fungsi jantung. Penetapan diagnosis keperawatan harus didasarkan pada hasil pengkajian yang komprehensif serta menggunakan pendekatan evidence-based agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.

1. Prinsip Penetapan Diagnosis Keperawatan
   Diagnosis keperawatan harus:
   a. Berdasarkan data subjektif dan objektif
   b. Menggunakan format PES (Problem, Etiology, Symptoms)
   c. Mengacu pada SDKI
   d. Disusun berdasarkan prioritas klinis
2. Diagnosis Keperawatan Utama (SDKI)
   Berikut diagnosis yang sering muncul pada gangguan kardiovaskular anak:
   a. Perfusi Jaringan Tidak Efektif
      Definisi:
      Penurunan sirkulasi darah yang mengakibatkan ketidakcukupan oksigen pada jaringan.
      Data Pendukung:
      - CRT > 3 detik
      - Nadi cepat/lemah
      - Ekstremitas dingin
      - Oliguria

      Etiologi:
      - Penurunan curah jantung
      - Syok
      - Gangguan aliran darah

Rasional Ilmiah:

Penurunan curah jantung menyebabkan aliran darah ke jaringan berkurang sehingga terjadi hipoksia seluler.

b. Curah Jantung Menurun

Definisi:

Ketidakmampuan jantung memompa darah secara adekuat.

Data Pendukung:

- Takikardia
- Hipotensi (tanda lanjut)
- Kelelahan
- Edema

Etiologi:

- Disfungsi miokard
- Overload volume
- Kelainan struktural

Rasional:

Gangguan kontraktilitas menyebabkan penurunan volume darah yang dipompa ke seluruh tubuh.

c. Pola Napas Tidak Efektif

Definisi:

Inspirasi dan/atau ekspirasi yang tidak adekuat.

Data Pendukung:

- Takipnea
- Sesak napas
- Retraksi

Etiologi:

- Edema paru
- Kongesti paru

Rasional:

Kongesti paru menyebabkan gangguan pertukaran gas.

d. Intoleransi Aktivitas

Definisi:

Ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas.

Data Pendukung:

- Mudah lelah
- Sesak saat aktivitas
- Takikardia

Etiologi:

- Penurunan suplai oksigen
- Gagal jantung

Rasional:

Keterbatasan suplai oksigen menyebabkan kelelahan.

e. Kelebihan Volume Cairan
Definisi:

Retensi cairan dalam tubuh.

Data Pendukung:

- Edema
- Hepatomegali
- Berat badan meningkat

Etiologi:

- Aktivasi RAAS
- Gagal jantung

Rasional:

Retensi cairan meningkatkan beban kerja jantung.

f. Risiko Syok
Definisi:

Berisiko mengalami kegagalan sirkulasi.

Faktor Risiko:

- Infeksi berat
- Dehidrasi
- Gangguan jantung

Rasional:

Gangguan perfusi dapat berkembang menjadi syok.

g. Gangguan Pertumbuhan dan Perkembangan
Definisi:

Keterlambatan pertumbuhan akibat kondisi kronis.

Data Pendukung:

- Berat badan tidak naik
- Nafsu makan menurun

h. Ansietas (Keluarga)
Definisi:

Perasaan khawatir orang tua terhadap kondisi anak.

Data Pendukung:

- Orang tua tampak cemas
- Banyak bertanya

3. Prioritas Diagnosis Keperawatan
   Prioritas ditentukan berdasarkan kondisi yang mengancam nyawa.

Tabel 5. 9 Prioritas Diagnosis

Prioritas	Diagnosis	Alasan
1	Perfusi jaringan tidak efektif	Mengancam nyawa
2	Curah jantung menurun	Dasar gangguan
3	Pola napas tidak efektif	Oksigenasi
4	Risiko syok	Potensi kegawatan
5	Kelebihan cairan	Memperberat kondisi

L. Luaran Keperawatan (SLKI)

Luaran keperawatan merupakan hasil yang diharapkan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Dalam konteks gangguan sistem kardiovaskular pada anak, luaran difokuskan pada perbaikan perfusi jaringan, stabilisasi hemodinamik, peningkatan oksigenasi, serta pencegahan komplikasi.

Penetapan luaran harus bersifat:

- Spesifik (Specific)
- Terukur (Measurable)
- Dapat dicapai (Achievable)
- Relevan (Relevant)
- Berbatas waktu (Time-bound)

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SMART goals dalam praktik keperawatan berbasis OBE.

1. Prinsip Penetapan Luaran (SLKI)
   Luaran keperawatan:
   a. Mengacu pada diagnosis keperawatan (SDKI)
   b. Menggunakan indikator objektif
   c. Memiliki target waktu yang jelas
   d. Dapat dievaluasi secara klinis
2. Luaran Utama: Perfusi Jaringan
   Nama Luaran (SLKI): Perfusi Jaringan
   Definisi:
   Kecukupan aliran darah ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolik.
   Indikator dan Target

Tabel 5. 10 kriteria hasil (outcome)

Indikator	Skala Awal	Target	Waktu
CRT	> 3 detik	< 2 detik	24 jam
Warna kulit	Pucat	Normal	24 jam
Suhu ekstremitas	Dingin	Hangat	24 jam
Nadi	Lemah	Kuat	24 jam
Urin	< 1 ml/kg/jam	≥ 1 ml/kg/jam	24 jam

3. Luaran: Curah Jantung
   Nama Luaran: Curah Jantung
   Indikator:
   - Frekuensi jantung normal sesuai usia
   - Tekanan darah stabil
   - Tidak ada tanda kelelahan

   Target: Stabil dalam 24–48 jam
4. Luaran: Status Oksigenasi
   Nama Luaran: Status Pernapasan
   Indikator:
   - RR normal
   - Tidak ada retraksi
   - SpO_2 ≥ 95%

   Target: Membaik dalam 24 jam
5. Luaran: Keseimbangan Cairan
   Nama Luaran: Status Cairan
   Indikator:
   - Tidak ada edema
   - Berat badan stabil
   - Input-output seimbang

   Target: Stabil dalam 48–72 jam
6. Luaran: Toleransi Aktivitas
   Nama Luaran: Toleransi Aktivitas
   Indikator:
   - Tidak sesak saat aktivitas
   - Tidak mudah lelah
7. Luaran: Status Neurologis
   Nama Luaran: Tingkat Kesadaran
   Indikator:
   - Respons baik

- Tidak ada penurunan kesadaran

8. Luaran: Edukasi dan Keluarga
   Nama Luaran: Pengetahuan Keluarga
   Indikator:
   - Orang tua memahami kondisi anak
   - Mampu menjelaskan tanda bahaya
   - Patuh terhadap terapi
9. Tabel Integrasi Diagnosis–Luaran (SDKI–SLKI)

Tabel 5. 11 Tabel Integrasi Diagnosis–Luaran (SDKI–SLKI)

Diagnosis	**Luaran**	**Indikator Utama**
Perfusi tidak efektif	Perfusi jaringan	CRT, nadi
Curah jantung menurun	Curah jantung	TD, HR
Pola napas tidak efektif	Status oksigenasi	RR, SpO_2
Kelebihan cairan	Status cairan	Edema
Risiko syok	Stabilitas hemodinamik	CRT, kesadaran

10. Penentuan Target Waktu
    Target waktu disesuaikan dengan kondisi:

Kondisi	**Target**
Akut (syok)	Jam
Subakut	24 jam
Kronis	Hari–minggu

11. Evaluasi Luaran
    Evaluasi dilakukan dengan:
    - Membandingkan kondisi sebelum dan sesudah intervensi
    - Menggunakan indikator objektif
    - Menentukan apakah target tercapai
12. Implikasi dalam Keperawatan
    Luaran membantu perawat:
    - Menilai keberhasilan intervensi
    - Menentukan modifikasi terapi
    - Meningkatkan kualitas asuhan

M. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mencapai luaran yang telah ditetapkan. Pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, intervensi difokuskan pada stabilisasi perfusi, peningkatan oksigenasi, optimalisasi fungsi jantung, serta pencegahan komplikasi.

Intervensi harus:

- Berbasis diagnosis (SDKI)
- Mengarah pada luaran (SLKI)
- Berdasarkan evidence-based practice
- Dilaksanakan secara sistematis dan prioritas

1. Prinsip Intervensi Keperawatan
   a. Prioritas ABC (Airway, Breathing, Circulation)
   b. Tindakan cepat pada kondisi kritis
   c. Monitoring berkelanjutan
   d. Kolaborasi interprofesional
   e. Pendekatan family-centered care
2. Intervensi untuk Perfusi Jaringan Tidak Efektif
   Nama Intervensi: Manajemen Perfusi Jaringan
   Tindakan:
   a. Monitor CRT secara berkala
   b. Monitor tanda vital (HR, RR, TD)
   c. Observasi warna dan suhu kulit
   d. Monitor output urin
   e. Posisi semi-Fowler
   Rasional:
   Monitoring perfusi membantu mendeteksi dini penurunan aliran darah sehingga intervensi dapat segera dilakukan.
3. Intervensi untuk Curah Jantung Menurun
   Nama Intervensi: Manajemen Curah Jantung
   Tindakan:
   - Monitor frekuensi dan irama jantung
   - Observasi tanda gagal jantung (edema, hepatomegali)
   - Batasi aktivitas
   - Kolaborasi pemberian inotropik

   Rasional: Pemantauan fungsi jantung penting untuk mencegah penurunan curah jantung yang lebih berat.
4. Intervensi untuk Pola Napas Tidak Efektif
   Nama Intervensi: Manajemen Jalan Napas dan Pernapasan
   Tindakan:
   - Monitor RR dan pola napas

- Berikan oksigen sesuai indikasi
- Posisikan semi-Fowler
- Observasi tanda distress napas

Rasional: Oksigenasi adekuat sangat penting untuk mencegah hipoksia jaringan.

5. Intervensi untuk Kelebihan Volume Cairan
   Nama Intervensi: Manajemen Cairan
   Tindakan:
   - Monitor intake dan output
   - Timbang berat badan harian
   - Observasi edema
   - Kolaborasi pemberian diuretik

   Rasional: Kontrol cairan mencegah overload yang dapat memperberat kerja jantung.
6. Intervensi untuk Risiko Syok
   Nama Intervensi: Pencegahan Syok
   Tindakan:
   - Monitor tanda dini syok
   - Siapkan akses intravena
   - Berikan cairan sesuai indikasi
   - Kolaborasi terapi emergensi

   Rasional: Deteksi dini syok dapat mencegah kegagalan organ.
7. Intervensi untuk Intoleransi Aktivitas
   Nama Intervensi: Manajemen Energi
   Tindakan:
   - Batasi aktivitas
   - Berikan waktu istirahat cukup
   - Observasi respon terhadap aktivitas

   Rasional: Mengurangi kebutuhan oksigen dan beban jantung.
8. Intervensi untuk Ansietas Keluarga
   Nama Intervensi: Dukungan Emosional
   Tindakan:
   - Berikan informasi tentang kondisi anak
   - Libatkan keluarga dalam perawatan
   - Berikan kesempatan bertanya

   Rasional: Edukasi meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kecemasan.
9. Intervensi Edukasi
   Nama Intervensi: Edukasi Kesehatan
   Tindakan:

- Ajarkan tanda bahaya (sesak, pucat, CRT memanjang)
- Edukasi kepatuhan terapi
- Gunakan metode teach-back

Rasional: Pengetahuan keluarga meningkatkan deteksi dini dan kepatuhan.

10. Tabel Integrasi SDKI–SLKI–SIKI

Tabel 5. 12 Integrasi SDKI–SLKI–SIKI

Diagnosis (SDKI)	**Luaran (SLKI)**	**Intervensi (SIKI)**
Perfusi tidak efektif	Perfusi jaringan	Monitor CRT
Curah jantung menurun	Curah jantung	Monitor HR
Pola napas tidak efektif	Oksigenasi	Oksigen
Kelebihan cairan	Status cairan	Monitor I/O
Risiko syok	Stabilitas	Resusitasi

11. Intervensi Prioritas (Kegawatdaruratan)
    Urutan tindakan:
    a. Oksigenasi
    b. Monitoring perfusi
    c. Akses IV
    d. Cairan
    e. Kolaborasi obat
12. Implikasi dalam Keperawatan
    - Cepat dan tepat dalam tindakan
    - Mengutamakan keselamatan pasien
    - Menggunakan clinical reasoning

N. IMPLEMENTASI

1. Prinsip Implementasi Keperawatan
   a. Berbasis rencana intervensi (SIKI)
   b. Dilakukan sesuai prioritas klinis
   c. Mengutamakan keselamatan pasien (patient safety)
   d. Didokumentasikan secara akurat
   e. Dievaluasi secara berkelanjutan
2. Tahapan Implementasi
   Implementasi dilakukan melalui beberapa langkah:
   a. Persiapan
      - Verifikasi identitas pasien
      - Persiapan alat dan lingkungan
      - Hand hygiene

b. Pelaksanaan
   - Tindakan keperawatan sesuai prioritas
   - Kolaborasi dengan tim kesehatan

c. Monitoring
   - Observasi respons pasien
   - Evaluasi perubahan kondisi

d. Dokumentasi
   - Pencatatan tindakan dan respons

3. Implementasi Berdasarkan Prioritas Klini
   a. Implementasi pada Gangguan Perfusi
      Tindakan nyata:
      - Mengukur CRT setiap 1–2 jam
      - Memantau warna dan suhu kulit
      - Memastikan posisi anak nyaman (semi-Fowler)
      - Menghangatkan ekstremitas bila dingin

      Contoh praktik:

      Perawat menemukan CRT 4 detik , segera meningkatkan frekuensi monitoring dan melaporkan ke dokter.

   b. Implementasi pada Gangguan Oksigenasi
      Tindakan:
      - Memberikan oksigen sesuai instruksi
      - Memastikan alat oksigen berfungsi
      - Memantau SpO_2 secara kontinu

      Praktik:

      Jika SpO_2 turun < 95%, perawat segera meningkatkan aliran oksigen dan evaluasi ulang.

   c. Implementasi pada Penurunan Curah Jantung
      Tindakan:
      - Monitoring HR dan tekanan darah
      - Mengurangi aktivitas anak
      - Mengamati tanda kelelahan

      Praktik:

      Anak tampak cepat lelah saat aktivitas , perawat membatasi aktivitas dan memberikan istirahat.

   d. Implementasi Manajemen Cairan
      Tindakan:
      - Mencatat intake-output
      - Menimbang berat badan
      - Mengobservasi edema

Praktik:

Jika urin < 1 ml/kg/jam → indikasi perfusi ginjal menurun → segera dilaporkan.

e. Implementasi Pencegahan Syok

Tindakan:

- Monitoring tanda dini syok
- Menyiapkan akses intravena
- Membantu pemberian cairan

Praktik:

Jika ditemukan takikardia + CRT memanjang → segera eskalasi ke tim medis.

4. Implementasi Kolaboratif

Perawat bekerja sama dengan:

- Dokter (terapi obat, cairan)
- Ahli gizi (nutrisi anak)
- Tim lain sesuai kebutuhan

Contoh:

Perawat membantu pemberian inotropik sesuai instruksi medis dan memonitor efeknya.

5. Implementasi Edukasi (Family-Centered Care)

Perawat harus:

a. Menjelaskan kondisi anak kepada orang tua
b. Mengajarkan tanda bahaya
c. Menggunakan metode teach-back

Contoh:

Perawat meminta orang tua mengulang tanda syok untuk memastikan pemahaman.

6. Implementasi dalam Kondisi Kegawatdaruratan

Dalam situasi kritis, implementasi harus:

- Cepat (< 5 menit)
- Tepat (berdasarkan ABCDE)
- Terkoordinasi

Contoh Skenario Klinik: Anak datang dengan CRT 4 detik Nadi cepat Ekstremitas dingin

Implementasi:

a. Berikan oksigen
b. Monitor tanda vital
c. Siapkan akses IV
d. Kolaborasi pemberian cairan

7. Implementasi dalam OSCE
   Mahasiswa dinilai berdasarkan:
   - Urutan tindakan (ABCDE)
   - Ketepatan intervensi
   - Komunikasi terapeutik
   - Keselamatan pasien
8. Indikator Keberhasilan Implementasi
   - CRT membaik (< 2 detik)
   - Nadi stabil
   - SpO_2 meningkat
   - Urin adekuat
   - Kesadaran membaik
9. Kesalahan Umum dalam Implementasi
   - Tidak mengikuti prioritas ABC
   - Terlambat bertindak
   - Tidak melakukan monitoring
   - Tidak melibatkan keluarga
10. Implikasi dalam Keperawatan
    Implementasi yang tepat akan:
    - Meningkatkan keselamatan pasien
    - Mencegah komplikasi
    - Mempercepat pemulihan
11. OSCE STATION KEPERAWATAN KARDIOVASKULAR
    a. Pengertian OSCE pada Keperawatan Kardiovaskular Anak
       Objective Structured Clinical Examination (OSCE) merupakan metode evaluasi keterampilan klinik yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa secara objektif dan terstruktur melalui simulasi kasus klinik.
       Pada gangguan sistem kardiovaskular anak, OSCE bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam:
       1) melakukan pengkajian cepat,
       2) mengenali tanda kegawatan,
       3) melakukan clinical reasoning,
       4) menentukan prioritas tindakan,
       5) melakukan komunikasi terapeutik,
       6) serta menjaga patient safety.
       OSCE sangat penting karena kondisi kardiovaskular anak sering bersifat emergensi dan membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

b. Tujuan OSCE Kardiovaskular Anak
   Mahasiswa diharapkan mampu:
   1) Melakukan pengkajian sistematis menggunakan ABCDE
   2) Mengidentifikasi tanda perfusi buruk
   3) Menentukan prioritas klinis
   4) Melakukan intervensi awal
   5) Melakukan komunikasi terapeutik kepada keluarga
   6) Menerapkan patient safety
   7) Mendokumentasikan hasil secara tepat
c. Kompetensi yang Dinilai
   1) Kompetensi Kognitif
      Mahasiswa mampu:
      a) memahami konsep perfusi,
      b) mengenali tanda syok,
      c) menentukan prioritas.
   2) Kompetensi Psikomotor
      Mahasiswa mampu:
      a) menilai CRT,
      b) memeriksa nadi,
      c) mengukur SpO_2,
      d) melakukan positioning,
      e) melakukan monitoring.
   3) Kompetensi Afektif
      Mahasiswa mampu:
      - bersikap profesional,
      - menjaga komunikasi terapeutik,
      - menunjukkan empati pada anak dan keluarga.
d. Prinsip OSCE pada Anak
   Pelaksanaan OSCE pada anak harus memperhatikan:
   - keamanan pasien,
   - kenyamanan anak,
   - pendekatan family-centered care,
   - komunikasi sesuai usia anak.

   Mahasiswa harus:
   - berbicara lembut,
   - menjelaskan tindakan,
   - melibatkan orang tua,
   - mengurangi kecemasan anak.

e. STATION 1

Pengkajian Perfusi pada Anak

1) Kompetensi

Mahasiswa mampu melakukan pengkajian perfusi jaringan pada anak dengan gangguan kardiovaskular.

2) Skenario Kasus

Seorang anak laki-laki usia 4 tahun dibawa ibunya ke IGD dengan keluhan tampak lemas, napas cepat, tangan dan kaki dingin. Data pemeriksaan: HR: 160x/menit, RR: 38x/menit , SpO_2: 92%, CRT: 4 detik suhu ekstremitas dingin. Mahasiswa diminta melakukan pengkajian dan menentukan prioritas tindakan.

f. Instruksi untuk Peserta

"Lakukan pengkajian sistem kardiovaskular pada pasien anak selama 7 menit. Tentukan prioritas masalah dan jelaskan tindakan awal yang perlu dilakukan."

g. Instruksi untuk Penguji

Nilai kemampuan mahasiswa dalam:

- pengkajian,
- interpretasi data,
- clinical reasoning,
- prioritas tindakan,
- komunikasi terapeutik,
- patient safety.

h. Alat dan Bahan

Alat yang Disediakan

- stetoskop
- pulse oximeter
- termometer
- jam tangan
- lembar observasi
- sarung tangan
- handrub

i. Langkah-Langkah Pengkajian yang Diharapkan

1) A. Persiapan

a) Hand Hygiene

Mahasiswa melakukan cuci tangan atau handrub sebelum kontak pasien.

b) Memperkenalkan Diri

Mahasiswa:

- menyebutkan nama,

- menjelaskan tujuan tindakan,
- melakukan identifikasi pasien.

c) Menjaga Keamanan dan Kenyamanan

- posisi anak nyaman,
- melibatkan ibu,
- menjaga privasi.

2) Pengkajian ABCDE

A — Airway

Mahasiswa menilai:

- jalan napas paten,
- ada/tidak sumbatan,
- suara napas tambahan.

B — Breathing

Mahasiswa menilai:

- frekuensi napas,
- retraksi,
- SpO_2,
- distress napas.

Interpretasi:

SpO_2 92% menunjukkan gangguan oksigenasi ringan.

C — Circulation

Mahasiswa menilai:

- CRT,
- nadi,
- warna kulit,
- suhu ekstremitas.

Interpretasi:

- CRT 4 detik
- nadi cepat
- ekstremitas dingin

menunjukkan perfusi buruk/syok kompensasi.

D — Disability

Mahasiswa menilai:

- kesadaran,
- respons anak,
- aktivitas.

E — Exposure

Mahasiswa melakukan observasi umum:

- sianosis,
- edema,
- tanda trauma,
- suhu tubuh.

j. Clinical Reasoning yang Diharapkan
Mahasiswa mampu menyimpulkan:

Masalah Utama

Perfusi jaringan tidak efektif.

Data Pendukung

- CRT memanjang
- takikardia
- ekstremitas dingin
- SpO_2 menurun

Analisis Klinis

Pasien kemungkinan mengalami syok kompensasi.

Prioritas

Circulation.

k. Intervensi Awal yang Diharapkan
Mahasiswa mampu menyebutkan:

1) Berikan oksigen
2) Monitoring tanda vital
3) Siapkan akses IV
4) Kolaborasi terapi cairan
5) Monitoring urin
6) Observasi perubahan kesadaran

l. Checklist Penilaian OSCE

No	Komponen Penilaian	Skor
1	Hand hygiene dilakukan	1
2	Memperkenalkan diri	1
3	Identifikasi pasien	1
4	Menilai airway	1
5	Menilai breathing	1
6	Mengukur SpO_2	1
7	Menilai CRT	2
8	Menilai nadi	2
9	Menilai suhu ekstremitas	1
10	Menentukan prioritas ABCDE	2
11	Mengidentifikasi perfusi buruk	2

12	Menentukan kemungkinan syok	2
13	Menentukan intervensi awal	2
14	Komunikasi terapeutik	1
15	Menjaga patient safety	1

Total Skor: 21

m. Critical Action

Mahasiswa dianggap gagal bila:

- tidak mengenali CRT memanjang,
- tidak mengenali takikardia,
- tidak menentukan prioritas circulation,
- tidak menyebutkan oksigenasi,
- tidak melakukan hand hygiene.

n. Kesalahan yang Sering Terjadi pada OSCE

Kesalahan Umum

1) Tidak menilai CRT
2) Hanya fokus pada tekanan darah
3) Tidak melakukan ABCDE
4) Tidak menentukan prioritas
5) Tidak melakukan reevaluasi
6) Tidak melibatkan keluarga

o. Evaluasi dan Feedback

Setelah OSCE selesai, mahasiswa diberikan feedback mengenai:

- ketepatan pengkajian,
- kemampuan clinical reasoning,
- prioritas tindakan,
- komunikasi terapeutik,
- patient safety.

p. STATION 2

Edukasi Tanda Bahaya kepada Orang Tua

Kompetensi

Mahasiswa mampu memberikan edukasi tanda bahaya gangguan kardiovaskular pada anak.

Skenario

Anak akan dipulangkan setelah perawatan gagal jantung ringan.

Mahasiswa diminta mengedukasi ibu mengenai:

1) tanda bahaya,
2) obat,

3) kapan kembali ke RS.

Poin Edukasi yang Diharapkan

Tanda Bahaya

- sesak,
- sianosis,
- anak sangat lemas,
- CRT memanjang,
- tidak mau makan,
- urin sedikit.

Kepatuhan Terapi

- obat diminum teratur,
- jangan menghentikan obat sendiri.

Monitoring Rumah

- napas,
- aktivitas,
- warna kulit,
- BAK.

Checklist Station Edukasi

Komponen	Skor
Memperkenalkan diri	1
Menjelaskan kondisi anak	2
Menjelaskan tanda bahaya	2
Menjelaskan obat	2
Menggunakan bahasa sederhana	1
Menggunakan teach-back	2
Komunikasi terapeutik	2

q. STATION 3

Dokumentasi SOAP Kardiovaskular

Kompetensi

Mahasiswa mampu mendokumentasikan hasil pengkajian dan evaluasi secara sistematis.

Data Kasus

- CRT 2 detik
- SpO_2 97%
- anak tampak aktif
- ekstremitas hangat

Dokumentasi yang Diharapkan

S : Ibu mengatakan anak tampak lebih aktif.

O : CRT 2 detik, SpO_2 97%, ekstremitas hangat.

A : Perfusi jaringan membaik.

P : Lanjutkan monitoring tanda vital dan observasi perfusi.

r. Implikasi OSCE dalam Pendidikan Keperawatan
OSCE membantu mahasiswa untuk:
1) meningkatkan keterampilan klinik,
2) melatih clinical reasoning,
3) meningkatkan kesiapan praktik,
4) meningkatkan kepercayaan diri,
5) mengintegrasikan teori dan praktik.

Pada keperawatan kardiovaskular anak, OSCE sangat penting karena kondisi pasien sering membutuhkan:
- pengkajian cepat,
- pengambilan keputusan cepat,
- intervensi prioritas,
- dan teamwork yang baik.

O. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan serta menentukan apakah luaran keperawatan (SLKI) telah tercapai.

Pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, evaluasi sangat penting karena kondisi pasien dapat berubah secara cepat. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara kontinu, objektif, dan berbasis indikator klinis.

1. Tujuan Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk:
   a. Menilai pencapaian luaran keperawatan
   b. Menentukan efektivitas intervensi
   c. Mengidentifikasi kebutuhan modifikasi rencana
   d. Menjamin keselamatan pasien
2. Prinsip Evaluasi
Evaluasi harus:
   - Berdasarkan indikator SLKI
   - Menggunakan data objektif dan subjektif
   - Dilakukan secara berkesinambungan
   - Didokumentasikan secara sistematis

3. Jenis Evaluasi
   a. Evaluasi Formatif
      Dilakukan selama proses asuhan berlangsung
      Contoh: monitoring CRT setiap jam
   b. Evaluasi Sumatif
      Dilakukan pada akhir periode perawatan
      Contoh: apakah perfusi sudah membaik
4. Parameter Evaluasi Kardiovaskular
   Parameter utama yang dievaluasi:

Parameter	**Indikator Normal**
CRT	< 2 detik
Nadi	Normal sesuai usia
SpO_2	≥ 95%
Urin	≥ 1 ml/kg/jam
Kesadaran	Baik

5. Format Evaluasi SOAP
   Format SOAP digunakan untuk mendokumentasikan evaluasi secara sistematis.
   S (Subjective) Data yang berasal dari pasien/keluarga
      Contoh:
      "Ibu mengatakan anak sudah tidak sesak"
   O (Objective) Data hasil observasi/periksaan
      Contoh:
      - CRT 2 detik
      - Nadi 110x/menit
      - SpO_2 97%
      - Urin adekuat
   A (Assessment) Analisis kondisi pasien
      Contoh:
      Perfusi jaringan membaik
   P (Plan)
      Rencana tindak lanjut
      Contoh:
      Lanjutkan monitoring tanda vital
6. Contoh Evaluasi Kasus
   Kasus: Perfusi Tidak Efektif
   S: Anak tampak lebih aktif
   O: CRT 2 detik, ekstremitas hangat, urin adekuat

A: Perfusi jaringan membaik

P: Lanjutkan observasi

7. Kriteria Hasil Evaluasi
   Evaluasi dapat dikategorikan menjadi:
   a. Tercapai
      Semua indikator terpenuhi
   b. Sebagian Tercapai
      Sebagian indikator membaik
   c. Tidak Tercapai
      Tidak ada perubahan atau memburuk
8. Tabel Evaluasi Luaran

Luaran	**Indikator**	**Hasil**
Perfusi	CRT	Membaik
Oksigenasi	SpO_2	Normal
Curah jantung	HR	Stabil

9. Evaluasi dalam Kondisi Kritis
   Evaluasi harus dilakukan lebih sering:
   - Setiap 15–30 menit (syok)
   - Setiap 1–2 jam (stabil)

P. Edukasi, Dokumentasi, dan Discharge Planning

Bagian ini merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan yang berkelanjutan, karena tidak hanya berfokus pada kondisi akut di rumah sakit, tetapi juga memastikan kelangsungan perawatan di rumah, meningkatkan kemandirian keluarga, serta mendukung patient safety dan kualitas pelayanan kesehatan.

1. Edukasi Kesehatan (Health Education)
   Edukasi merupakan proses pemberian informasi kepada pasien dan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam merawat anak dengan gangguan kardiovaskular.
   a. Tujuan Edukasi
      Edukasi bertujuan untuk:
      1) Meningkatkan pemahaman keluarga tentang penyakit
      2) Meningkatkan kepatuhan terhadap terapi
      3) Mendeteksi dini tanda bahaya
      4) Mencegah kekambuhan dan komplikasi
   b. Prinsip Edukasi pada Anak
      - Menggunakan bahasa sederhana
      - Disesuaikan dengan tingkat pendidikan keluarga

- Menggunakan metode teach-back
- Melibatkan orang tua secara aktif (family-centered care)

c. Materi Edukasi

1) Pemahaman Penyakit
   - Penjelasan tentang gangguan jantung anak
   - Penyebab dan perjalanan penyakit
2) Tanda Bahaya (Red Flag)

   Orang tua harus segera ke fasilitas kesehatan jika ditemukan:
   - Anak sesak napas
   - Bibir/kuku kebiruan (sianosis)
   - Anak sangat lemas
   - CRT > 3 detik
   - Tidak mau makan/minum
3) Kepatuhan Terapi
   - Minum obat sesuai jadwal
   - Tidak menghentikan obat tanpa konsultasi
4) Perawatan di Rumah
   - Istirahat cukup
   - Nutrisi adekuat
   - Menghindari kelelahan
5) Monitoring di Rumah
   - Mengamati napas
   - Aktivitas anak
   - Frekuensi BAK

d. Metode Edukasi
- Ceramah
- Demonstrasi
- Leaflet/media edukasi
- Teach-back

e. Evaluasi Edukasi

Edukasi dianggap berhasil jika:
- Orang tua mampu mengulang informasi
- Orang tua menunjukkan perilaku sesuai anjuran

2. Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi merupakan catatan tertulis yang mencerminkan seluruh proses keperawatan dan memiliki aspek legal, komunikasi, serta kualitas pelayanan.

a. Tujuan Dokumentasi
- Sebagai bukti legal

- Sarana komunikasi tim kesehatan
- Evaluasi kualitas asuhan
- Dasar audit dan akreditasi

b. Prinsip Dokumentasi
Dokumentasi harus:
- Akurat
- Lengkap
- Objektif
- Tepat waktu

c. Komponen Dokumentasi
Meliputi:
1) Pengkajian
2) Diagnosis
3) Intervensi
4) Implementasi
5) Evaluasi

d. Format Dokumentasi
SOAP
- S: Data subjektif
- O: Data objektif
- A: Analisis
- P: Rencana

e. Contoh Dokumentasi
S: Ibu mengatakan anak tidak sesak
O: CRT 2 detik, SpO_2 97%
A: Perfusi membaik
P: Lanjutkan monitoring

f. Kesalahan Umum Dokumentasi
- Tidak lengkap
- Tidak objektif
- Terlambat mencatat
- Tidak sesuai standar

3. Discharge Planning (Perencanaan Pulang)
Discharge planning adalah proses perencanaan pemulangan pasien yang bertujuan memastikan kelanjutan perawatan di rumah.

a. Tujuan Discharge Planning
- Mencegah kekambuhan
- Meningkatkan kemandirian keluarga
- Mengurangi readmisi

b. Komponen Discharge Planning
   1) Kondisi Pasien
      - Stabil secara hemodinamik
      - Tidak ada tanda kegawatan
   2) Edukasi Lanjutan
      - Obat-obatan
      - Aktivitas
      - Nutrisi
   3) Follow-Up
      - Jadwal kontrol
      - Rujukan bila perlu
   4) Dukungan Keluarga
      - Kesiapan keluarga merawat anak
      - Lingkungan rumah

c. Instruksi Pulang
   Orang tua harus memahami:
   1) Obat
      - Nama, dosis, jadwal
   2) Aktivitas
      - Batasi aktivitas berat
   3) Nutrisi
      - Makanan bergizi
   4) Tanda Bahaya
      - Sesak
      - Sianosis
      - Lemas

d. Contoh Discharge Planning
   Anak dengan gagal jantung:
   - Minum obat teratur
   - Istirahat cukup
   - Kontrol 1 minggu
   - Segera ke RS jika sesak

e. Evaluasi Kesiapan Pulang
   Pasien siap pulang jika:
   - Kondisi stabil
   - Orang tua memahami perawatan
   - Ada rencana tindak lanjut

4. Integrasi Edukasi dan Discharge Planning
   Edukasi merupakan bagian dari discharge planning yang berkelanjutan, dimulai sejak pasien masuk hingga pulang.
5. Implikasi dalam Keperawatan
   Perawat berperan dalam:
   - Edukator
   - Advokat pasien
   - Koordinator perawatan
6. Dokumentasi Keperawatan

   Dokumentasi keperawatan merupakan pencatatan tertulis maupun elektronik yang menggambarkan seluruh proses asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Pada anak dengan gangguan sistem kardiovaskular, dokumentasi memiliki peran krusial karena kondisi pasien dapat berubah cepat, sehingga diperlukan pencatatan yang akurat, real-time, dan terintegrasi.

   Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai catatan klinis, tetapi juga sebagai bukti legal, alat komunikasi antar tenaga kesehatan, serta indikator mutu pelayanan.

   a. Tujuan Dokumentasi Keperawatan
      Dokumentasi bertujuan untuk:
      1) Mencatat seluruh proses asuhan keperawatan secara sistematis
      2) Menjadi alat komunikasi antar tim kesehatan
      3) Menyediakan bukti hukum (legal aspect)
      4) Mendukung evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan
      5) Menjadi dasar audit dan akreditasi rumah sakit
   b. Prinsip Dokumentasi Keperawatan
      Dokumentasi harus memenuhi prinsip:
      1) Akurat (Accuracy)
         Data yang dicatat harus sesuai dengan kondisi pasien yang sebenarnya.
      2) Lengkap (Completeness)
         Semua aspek proses keperawatan harus terdokumentasi.
      3) Objektif (Objectivity)
         Berdasarkan fakta, bukan opini.
      4) Tepat Waktu (Timeliness)
         Dicatat segera setelah tindakan dilakukan.
      5) Sistematis (Systematic)
         Mengikuti alur proses keperawatan.

c. Karakteristik Dokumentasi Berkualitas
Dokumentasi yang baik memiliki ciri:
- Jelas dan mudah dibaca
- Menggunakan istilah medis/keperawatan standar
- Tidak menggunakan singkatan yang tidak baku
- Tidak menghapus/mengubah data tanpa prosedur

d. Komponen Dokumentasi Keperawatan
Dokumentasi harus mencakup seluruh tahapan proses keperawatan:
1) Pengkajian
   - Data subjektif dan objektif
   - Tanda vital
   - CRT, perfusi, kesadaran
2) Diagnosis Keperawatan
   - Menggunakan format SDKI
   - Ditulis lengkap (PES)
3) Perencanaan (Luaran & Intervensi)
   - Target (SLKI)
   - Intervensi (SIKI)
4) Implementasi
   - Tindakan yang dilakukan
   - Waktu pelaksanaan
   - Respons pasien
5) Evaluasi
   - Perubahan kondisi pasien
   - Pencapaian luaran

e. Format Dokumentasi Keperawatan
Beberapa format yang digunakan:
1) SOAP (Paling umum)

S (Subjective):

Data dari pasien/keluarga

O (Objective):

Data hasil observasi

A (Assessment):

Analisis kondisi pasien

P (Plan):

Rencana tindakan

Contoh SOAP (Kasus Kardiovaskular Anak)

S: Ibu mengatakan anak tampak lebih aktif dan tidak sesak

O: CRT 2 detik, SpO_2 97%, nadi 110x/menit, ekstremitas hangat

A: Perfusi jaringan membaik

P: Lanjutkan monitoring tanda vital dan observasi perfusi

2) SOAPIER

Lebih lengkap untuk praktik klinik:

- S: Subjective
- O: Objective
- A: Assessment
- P: Plan
- I: Implementation
- E: Evaluation
- R: Revision

Contoh SOAPIER

S: Anak tidak rewel

O: CRT 2 detik, urin adekuat

A: Perfusi membaik

P: Lanjutkan terapi

I: Monitoring vital sign setiap 2 jam

E: Kondisi stabil

R: Pertahankan rencana

f. Dokumentasi pada Kondisi Kegawatdaruratan

Pada kondisi seperti syok:

1) Dokumentasi harus dilakukan lebih sering (real-time)

2) Fokus pada:

- Waktu kejadian
- Tindakan yang dilakukan
- Respons pasien

Referensi

Aydin, S. I., et al. (2023). Pediatric heart failure: Current understanding and future directions. *Journal of Pediatric Cardiology*, 44(2), 123–135.

Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2022). Wong's Nursing Care of Infants and Children (12th ed.). Elsevier.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di Rumah Sakit. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes RI.

Muttaqin, A. (2020). Asuhan Keperawatan Klien dengan Gangguan Sistem Kardiovaskular. Jakarta: Salemba Medika.

Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2020). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC. Yogyakarta: Media Action.

PPNI. (2018). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI). Jakarta: DPP PPNI.

PPNI. (2018). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI). Jakarta: DPP PPNI.

PPNI. (2018). Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI). Jakarta: DPP PPNI.

Soetjiningsih & Ranuh, I. G. N. (2021). Tumbuh Kembang Anak (Edisi 3). Jakarta: EGC.

Suriadi & Rita Yuliani. (2020). Asuhan Keperawatan Anak. Jakarta: Sagung Seto.

Profil Penulis



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS.William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com
Motto: “Success begins with self-belief”

Profil Penulis



Dorce Sisfiani Sarimin, M.Kep., Ns., Sp.Kep.An.
lahir di Kalawara 13 April 1975. Lulusan Magister Keperawatan dan Ners Spesialis Keperawatan Anak Universitas Indonesia Jakarta, tahun 2013. Bekerja di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado Jurusan Keperawatan. Sebagai dosen sejak tahun 2000 dan pada tahun 2014 - 2018 menjabat sebagai Kaprodi D-III Keperawatan, 2018- sampai sekarang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana terapan Keperawatan Ners. Adapun Buku yang pernah diterbitkan adalah Dukungan keluarga pada Imunisasi Anak, Konsep Keperawatan Anak dan Buku Ajar keperawatan anak 1, Home Care, Bunga Rampai Keperawatan Anak I, Bunga Rampai Keperawatan anak 2, dan Konsep Caring pengalaman publikasi internasional dan nasional dalam area keperawatan anak baik pada jurnal bereputasi dan jurnal nasional terkakreditasi sinta. Pengalaman organisasi sebagai anggota perinasia sejak tahun 2012, organisasi IPANI : sebagai bendahara Tahun 2014 - 2017, Sebagai Koordinator pendidikan dan pelatihan 2017-2022 dan 2023 sampai sekarang sebagai Wakil Ketua bidang organisasi, Hukum dan Sistem Informasi. Pengurus AIPNI regional 8 sebagai anggota bidang pendayagunaan lulusan dan Uji Kompetensi tahun 2022 sampai sekarang.

Profil Penulis



Budiyati, S.Kp., Ns., M.Kep., Sp.Kep.An.
lahir di Pulutan Grobogan Jawa Tengah. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari jenjang Diploma 3 di Akademi Keperawatan Karya Husada Semarang lulus tahun 1994, S1 Keperawatan pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro lulus tahun 2001, Profesi Ners lulus tahun 2003. Mengikuti Program Akta Mengajar di Universitas Negeri Semarang tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia lulus tahun 2011 dan program Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia lulus tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 - 1998 sebagai perawat di RS Islam Sultan Agung Semarang. Menjadi ASN Dosen di Akademi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta mulai tahun 1998 – 2006. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Semarang pada Jurusan Keperawatan Program Pendidikan Diploma III Keperawatan tahun 2006 - 2016. Kemudian Program Pendidikan Profesi Ners mulai tahun 2016 - sekarang, dan mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Praktik Klinik Keperawatan Anak, dan Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar keperawatan tingkat regional, nasional, maupun internasional. Penulis juga sebagai pengurus Ikatan Perawat Anak (IPANI) Jawa Tengah mulai 2015 sampai sekarang. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: budiyati_mugi@yahoo.com
Motto: ""Hidup itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan waktu yang tepat"



Siti Robi'atus Sholiha, S.Tr.Kep., Ns., M.Tr.Kep.
Lahir di Banyuwangi, 5 Maret 1997. Penulis Meneyelesaikan studi Program Sarjana Terapan Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2019, kemudian melanjutkan studi ke jenjang Profesi Ners di Poltekkes Kemenkes Semarang dan selesai pada tahun 2023, lalu melanjutkan studi Program Magister Terapan Keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan selesai pada tahun 2024. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia Sidoarjo. Mengampu Mata Kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Dasar, dan Patofisiologi. Saat ini penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Profil Penulis



Sitti Herliyanti Rambu, S.Kep., Ns., M.Kes,
Lahir di Lalombaa, 30 Agustus 1990. Penulis Menyelesaikan studi Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners Tahun 2012, kemudian melanjutkan studi ke Jenjang Pasca Sarjana di Universitas Indonesia Timur dan selesai pada Tahun 2015. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen di STIKES Amanah Makassar, Mengampu Mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Anak. Saat ini Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Sinopsis

Buku Ajar *Keperawatan Anak* disusun sebagai sumber pembelajaran yang sistematis bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada anak secara komprehensif. Buku ini membahas keperawatan anak dengan pendekatan holistik, berpusat pada anak dan keluarga, serta memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak lahir hingga usia remaja. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar keperawatan anak dan *family-centered care*, yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam proses perawatan serta peran perawat dalam memberikan asuhan yang aman, empatik, dan profesional. Selain itu, buku ini menguraikan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0–18 tahun, meliputi aspek fisik, motorik, bahasa, kognitif, psikososial, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tumbuh kembang. Pembahasan juga dilengkapi dengan pengkajian komprehensif anak, mulai dari pengumpulan data kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian perkembangan, pengkajian nyeri, status psikososial, hingga komunikasi terapeutik yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak. Buku ini turut membahas kebutuhan nutrisi anak sesuai tahap usia, prinsip pemberian makan, masalah umum dalam pemenuhan nutrisi, serta peran perawat dalam memberikan edukasi kepada keluarga. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan pembahasan mengenai gangguan sistem kardiovaskular pada anak, mencakup konsep dasar, tanda dan gejala, pengkajian keperawatan, serta prinsip asuhan keperawatan yang tepat. Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mudah dipahami, aplikatif, dan relevan dalam mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan anak yang berkualitas, humanis, dan berpusat pada keluarga.

Buku Ajar Keperawatan Anak disusun sebagai sumber pembelajaran yang sistematis bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta praktisi kesehatan dalam memahami konsep dasar, prinsip, dan penerapan asuhan keperawatan pada anak secara komprehensif. Buku ini membahas keperawatan anak dengan pendekatan holistik, berpusat pada anak dan keluarga, serta memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak lahir hingga usia remaja. Materi yang disajikan mencakup konsep dasar keperawatan anak dan family-centered care, yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam proses perawatan serta peran perawat dalam memberikan asuhan yang aman, empatik, dan profesional. Selain itu, buku ini menguraikan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0–18 tahun, meliputi aspek fisik, motorik, bahasa, kognitif, psikososial, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tumbuh kembang. Pembahasan juga dilengkapi dengan pengkajian komprehensif anak, mulai dari pengumpulan data kesehatan, pemeriksaan fisik, pengkajian perkembangan, pengkajian nyeri, status psikososial, hingga komunikasi terapeutik yang disesuaikan dengan usia dan kondisi anak. Buku ini turut membahas kebutuhan nutrisi anak sesuai tahap usia, prinsip pemberian makan, masalah umum dalam pemenuhan nutrisi, serta peran perawat dalam memberikan edukasi kepada keluarga. Pada bagian akhir, buku ini menyajikan pembahasan mengenai gangguan sistem kardiovaskular pada anak, mencakup konsep dasar, tanda dan gejala, pengkajian keperawatan, serta prinsip asuhan keperawatan yang tepat. Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang mudah dipahami, aplikatif, dan relevan dalam mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan anak yang berkualitas, humanis, dan berpusat pada keluarga.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-17-0 (PDF)
9 786347 927170